

周建宣 吳盛榮 整理

吳光烈臨牀經驗集

廈門大學出版社

20165/14

目 录

俞 序

自 序

一、临证与治学

勤求古训	博采众方	1
师古不泥	衷中参西	2
突出特色	精在辨证	3
重在继承	贵在创新	4
注重食疗	发掘验方	5
立足科学	运用法则	7

二、临床经验录

麻黄汤治疗杂病的临证体会	12
临证应用小柴胡汤一得	18
大黄附子汤治疗痛证经验举隅	24
应用大黄甘草汤的经验	28
补中益气汤的临床应用	32
从归脾汤看临床异病同治	36
浅谈逍遥散及其临床应用	40
生姜鸡肉汤治验选介	44
吴茱萸之妙用	49

大黄临床应用琐谈	52
细辛临证应用之我见	57
细辛妙用浅谈	61
十味降脂汤治疗高脂血症	64
益气通脉汤治疗冠心病心绞痛	67
三伏灸综合疗法治疗慢性支气管炎、 支气管哮喘的临床观察	70
疏风定喘汤治疗过敏性哮喘	75
活血祛瘀汤治疗肋间神经痛	77
治疗胃脘痛经验总结	80
疏肝和胃汤治疗慢性胃炎	83
温胆和胃汤治疗胆汁返流性胃炎	86
绿豆羊肉汤治疗复发性口疮	88
灭滴汤治疗滴虫性肠炎	91
舒肝利胆汤治疗胆囊炎	93
运用活血化瘀法治疗胆石症	96
胆道驱蛔汤治疗胆道蛔虫病	99
治疗急腹症举隅	102
“阳明三急下”辨	108
中药治疗泌尿系结石	111
生地通淋汤治疗急性泌尿系感染	115
益气化瘀汤治疗前列腺肥大	118
银翘败酱汤治疗急性肾炎临床观察	121
补肾种子汤治疗男性不育症的临床体会	124
参苓白术散在妇科的临床应用	128
治疗痛经经验总结	132
中药治疗功能性子宫出血	135
生姜鸡肉汤治疗妊娠恶阻有良效	138

加味当归芍药散治疗胎位不正·····	140
孕宝治疗先兆流产、习惯性流产临床观察·····	142
固胎保孕饮治疗习惯性流产的临床观察·····	145
宫外孕治验·····	149
健脾和胃汤治疗小儿消化不良·····	153
健脾消积粉治疗小儿厌食症·····	156
消疳健儿散治疗小儿疳积的疗效观察·····	158
麦冬橄榄汤治疗小儿夏季热·····	161
民间中草药治疗脓肿验案三则·····	165
清里解毒汤治疗急性淋病·····	169
治疗软性下疳总结·····	172
中药治疗三叉神经痛·····	175
中药治疗肩周炎·····	178
中药治疗坐骨神经痛的临床体会·····	181
八味消毒饮治疗流行性腮腺炎(炸腮)·····	184
治疗麻疹的经验·····	187
再谈治疗麻疹的经验·····	191
白田乌草治疗白喉的经验介绍·····	193
茵陈银翘汤治疗急性肝炎·····	196
对急性黄疸型肝炎的诊疗经验·····	198

三、医案撷英

支气管炎·····	206
小儿痉咳·····	208
扁桃体炎·····	209
失 音·····	210
汗症治验两则·····	213

盗汗	217
头汗	219
足汗	221
产后血汗	223
心悸	225
渴饮不止症	227
胃热消谷善饥症(中消)	229
劳热	231
呕吐	233
便秘	235
粪后便血	237
眩晕	238
耳鸣、耳聋	240
舌痛	241
临诊偶拾	243
凝脂翳	246
嗜睡	248
严重失眠症	249
夜游症	250
隆闭(前列腺肥大)	251
泌尿系结石	253
淋病	255
血精	257
肠梗阻二例	258
肠痉挛	261
右肝管结石合并感染	263
寒积腹痛	265
交媾感寒腹痛	266

阴寒腹痛合并便秘·····	268
瘀血性头痛三例·····	270
闭经三例·····	274
倒经案·····	277
经行眩晕·····	278
崩漏(子宫功能性出血)·····	279
湿热带下(阴道滴虫)·····	281
青 带·····	282
滑 胎·····	283
胞宫虚寒不孕症·····	285
妊娠小便闭·····	287
乳泣治验·····	288
产后高热·····	290
产后腹痛、狂妄 ·····	292
厌食症·····	293
秋 泻·····	294
泄 泻·····	296
慢性淋巴结肿大·····	298
甲状腺瘤(肉瘤)·····	300
带状疱疹二例·····	302

四、验方拾萃

葱肾汤治尿浊、水肿症 ·····	304
椿杞猪肚汤治小便混浊·····	306
旱莲养阴汤治热淋·····	308
温肾固摄汤治遗尿·····	310
排石汤治疗泌尿系结石·····	312

梨榄清音汤治失音·····	315
大蓟解毒汤治喉蛾·····	316
剑胆消痈汤治肺痈·····	318
茵扁鸡肉汤治暑伤元气·····	320
香薷清暑饮预防盛夏伤暑、中暑·····	321
加籛童鸡汤治发育不良·····	323
振阳起勃汤治疗阳萎·····	325
胃痛四味饮治胃脘痛·····	327
红壳秫米糖粿治五更泄·····	328
益寿降压汤治高血压、高血脂症·····	330
苈莲安胎饮治习惯性流产·····	332
芪桂鳗鱼汤治荨麻疹·····	334
补血理痒汤治疗血风疮·····	336
马齿消肿汤治久年疔疮·····	338
败脓祛腐散治蝼蛄疖·····	339
雄连收毒散治缠腰火丹·····	340
樱苕消癆汤治瘰癧·····	342
整理后记·····	343

一、临证与治学

勤求古训 博采众方

吴老幼秉庭训，学有渊源。童年时期即在其父亲指导下习诵《医学三字经》、《药性赋》、《汤头歌括》、《医学实在易》等医学启蒙书，课余亦常侍诊父侧。对《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》、《本草经》等诸经典著作刻苦钻研，对历代的学术流派，也勤学深钻，吸取精华。尝谓中医学学术源远流长，学者务须勤求古训，探本求源，熟读经典，扎实基础，然后涉猎群书，执简驭繁。他认为四大经典著作乃中医之根基，是经过几千年的社会实践，千锤百炼而被公认的科学瑰宝，必须熟读、精研，才能深窥奥旨；举一反三，临床方能从容应付；左右逢源，达到学以致用目的。他不仅自己刻苦学习、博览群书，而且要求学生在学习经典著作上狠下功夫。特别是对于《内经》中最精要的篇章，应做到吟哦成诵，倒背如流。有了这个基础，再结合临床实践，细心体会，方能融会贯通，受益终身。

几十年来，他对《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》等诸家学说都能虚心钻研，孜孜以求，每有心得辄做札记。虽古稀之年，仍能手不释卷，勤学不辍，诚为当代名医之风范。

师古不泥 衷中参西

吴老博览群书，孜孜不倦，对《医林改错》、《医学衷中参西录》等颇为赏识，认为王清任、张锡纯氏，重科学，坚持实践第一，独创新精神，是值得学习的。吴老谆谆告诫后学，医者宜师古不泥，撷采诸家之所长，认真进行临床验证。尝云：古今医著汗牛充栋，学者务必由博返约，唯善是从。学无捷径，只有勤奋读书，不断实践，才能深得四诊的要旨。吴老在深入研究中医学学术的同时，亦能借鉴现代医学知识，补中医学之不足。他认为，医学研究必须坚持“古为今用，洋为中用”的方针，开展百家争鸣，力求百花齐放。中医和西医虽然同以患者的疾病为研究对象，但研究的方法和角度不同，各自掌握的事实和建立的理论体系不同，形成了两种并存的医学。我们可以利用两种医学摆事实、讲道理、取长补短、共同进步，从而加速传统的中医学向前发展，促进其与现代医学相结合。这样，既可充实和提高现代医学科学，又有利于符合客观规律的、新型的医学科学理论的形成。他还认为学习现代医学知识的目的要明确，决不能学西弃中，要用现代科学仪器检查，对照中医诊察方法，对疾病进行诊断，以丰富中医辨证内容，提高疗效。

吴老注重实践，主张理论与实践相结合。他认为“中医之所以

突出特色 精在辨证

吴老注重实践，主张理论与实践相结合。他认为“中医之所以历经千年而不衰，深为中国人民所信仰，关键在于它能为人民解除疾病痛苦”，“勤于实践是中医临床医生提高学术水平、丰富经验最重要的方法”。然中医要存在、要发展，就要保持自己的特色，才能千年不衰，中医的特色，突出点就是辨证论治。所谓“辨证”，主要是指辨识证候，证者，徵也、验也、信也、亦候也。证是机体病理变化的表现，中医通过对人体的耳、鼻、口、舌、眼、皮肤、毛发、爪甲等之气色变化及脉搏之动静的观察、诊视，找出疾病属性特征，以判断其性质的部位。故“证”即指望、闻、问、切四诊合参之诊断依据。候，是疾病发展的不同阶段表现。在辨证论治之中，他主张首先要辨出主证，掌握其特点，然后兼顾他证，其中特别要注意辨识真假，不要被假象所迷惑。只有这样才能辨证，才能为论治提供正确的依据。其次，特别强调辨病与辨证相结合。他认为辨病有利于了解病因及疾病发展变化的规律；辨证有利于从整体观念出发，全面分析疾病的病位、性质及邪正盛衰等情况，使诊断更加具体化、个体化，使治疗能够做到因人而异，用药精当。他不赞成偏执一舌、一脉或单一症状的诊病方法，强调要四诊合参，全面诊察，不要刻舟求剑，泥守一证一型。只有这样才能抓住疾病的本质，准确辨证，提高疗效。

重在继承 贵在创新

吴老常教诲青年中医说：祖国医学是一个伟大宝库，要博览群书，其目的是要把前人的经验、智慧继承下来，只有继承、创新才能发扬，否则发扬就是一句空话。吴老认为：振兴中医，首在继承，贵在创新。继承途径有二：一是文献整理与研究，对古典医籍应详加校正，疏义注释并予熟读和深思。此外，还要学习文、史、哲知识，把医书内外知识结合起来，以求领会中医理论之真谛，尤其是中医学术之内容由多学科所形成，必须进行学科研究，才能发掘其精髓而光大之。二是把理论研究和临床科研实际紧密结合起来。他认为临床是理论的发端、验证与归宿。因此，吴老特别强调经典理论与临床、科研与实践相结合。他坚决反对那理论脱离实践，只强调理论，反对或轻视实践的所谓纯理论之继承。这种现象是目前有些人研究中医经典理论的主要弊病，也是中医继承问题上的主要障碍和危险。

吴老既推崇张仲景，而对金元四大家以至清代陈修园、叶天士、王孟英等著作亦多钻研，临证不泥一家之说。他以自己的亲身经历和丰富的实践经验加以补苴罅漏，力图创新。并认为医不创新，不能适应时代要求，医学则无所发展。他常说：《内经》所言“无者求之”就是启迪后人在继承的基础上敢于提出新问题，解决新问题，从而不断丰富中医学术新内容。这样中医才会有旺盛的生命力，才能面向世界，面向未来。

注重食疗 发掘验方

吴老在长期的临床实践中感到,临床治病不能徒恃药物,应从护理、饮食方面加以配合,尤其应重视饮食疗法。他认为治病“在用药物治疗的同时,加强病人的饮食护理,至为重要。如饮食得宜,不仅能达到辅助药物治疗的目的,而且可以促进病人体力的复原,提高疗效,缩短疗程”。正如《内经》提出的“毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气”,在临床上仍有指导意义。他认为“饮食对温热病病人更为重要。因为患了温热病后,正气因抗邪而受到一定的耗损,大都表现食欲不振,胃纳呆滞,因此在药物治疗的同时,应当设法促进病人的食欲,以补充营养。营养既足,才能达到扶正祛邪的目的。尤其是温热病恢复期的病人,邪气虽尽,而正气未复,更须注意节制,应少食多餐,否则可使肠胃突然增加负担而引起‘食复’之变”。“胃痛病人,尤须注意饮食”。他主张“胃痛病人饮食不可过量,宜少食多餐,进食不可过冷过热,以利脾胃的消化、吸收。忌食生冷及难以消化食物,宜食易于消化而又富于营养的食物。剧痛时,宜流质饮食,如稀粥、藕粉、鲜奶之类。对肝郁气滞、食滞、血瘀所致的胃痛,忌食辛辣、酗酒,以免刺激胃脘,加重病情。如属寒邪胃痛,可进食少许辛辣食物以温中散寒,加强脾胃的运纳。”他认为“病人如注意饮食、配合治疗,则有利于早日康复”。

吴老认为发扬祖国医学遗产,主要的一条是收集整理祖国医学典籍上所未记载而散在民间具有独特疗效的单方、验方。他不满

足于自己的丰富学识和临床经验,不耻下问,经常“采方”访贤,发现一方,立即进行临床验证,为祖国医学增添异彩。如应用人骨丹治疗多发性脓肿,白刺苋治疗胆石症,一条根治疗早期肝硬化,金樱根治疗空洞型肺结核,黄花稔治疗牙槽脓肿等屡收良效。此外,还收集民间青草医李引锭先生用白田乌草配合中药治疗白喉的祖传秘方,经临床治疗 31 例,治愈率为 90.5%,充分说明民间青草药具有化险为夷之功,应引为重视。

立足科学 运用法则

热物理学是现代科学的前沿学科。其科学哲学的具体内涵从不同角度展示事物发展的本质。吴老的临证特点与治学方法,别具风格,科学方法内涵丰富,从热物理学、科学哲学的角度探源,可聚焦其精髓所在。

一、耗散结构理论与临证诊疗中心法则

由普利高津提出的耗散结构理论指出:在变化条件达到某一特定阈值时,量变可导致质变。系统(如人体)通过不断外界交换能量与物质,就可以从原来无序状态变为一种时间、空间或功能上的有序状态,这种非平衡状态下的有序是对应于平衡态的结构而提出的。普氏的这一理解深刻地揭示了现代科学的自然图景或自然本论形式的交换。在这一交换中,对称性破损取代了对称性在经典自然图景的地位,成为揭示宇宙演化的时间方向性与进化性之谜的钥匙。

人体是多层次结构的统一整体,是各种自然运动形式的统一体,是矛盾运动者的自动控制系统。吴老在临证治学中,牢牢地抓住促进机体的相对有序状态,即“阴平阳秘”这一中心法则。把临证调阴阳、补偏差、理五脏、顺五行贯穿于治学的全过程中。通过中药煎剂、中成药、心理治疗语言等的输入,使患者机体内部处于无序状态部位(系统或局部层次水平),经体内外的物质与或能量的交换,在一定时间、空间水平点上达到相对有序状态,患者从阴阳消

长、转化的不平衡态向暂时平衡态转化、病愈。如吴老以加味当归芍药散治疗胎位不正患者,根据阴平阳秘、冲任两脉调和则胞宫自无疾患的古训,结合“冲为血海”,“任主胞胎”理论,以生血来强壮冲任两脉,土过燥不能生物,故以当归、川芎、白芍滋之;土过湿亦不能生物,故以茯苓、白术、泽泻渗之。燥湿适宜,则中气足而血自生。血有源,冲任两脉盛,肾固胎安,胎位自转。

吴老在治学过程中,纠阴阳,补偏差是有层次的,于细微量变中见精神。临证中极端反对一方治百病,不变应万变的诊疗观,坚持临床辨证施治,有是证用是药是其临证具体特点。如用当归芍药散治疗胎位不正患者时,除主药当归、芍药外,有气结证者,应予陈皮、大腹皮下降胎气;肾气不足者,菟丝子、续断、寄生固肾安胎等随证加减用药。临证中,把复杂的辨证施治过程简单化,可能较容易被世人认知,但排除偶然性之后,疗效可想而知。吴师正是把握住一般事物机理与人体广义系统是变中有所不变、异中有同、自由中有约束、繁中有简的相对联系与转化,在临证中以阴平阳秘为中心,促进病体从无序状态向有序状态转化,进入惯性运行状态,从而逼近诊疗真理,疗效好。所谓“通过差异着的破缺的语言和图景的互补、协同、增殖,才真正逼近自然界”的哲学描述在吴老的治学中得到体现。

二、熵与临证的动态诊疗观及个体差异

熵,本身是一个热力学中的概念,它标志一种物理现象的无组织程度。普利高津在耗散结构理论中引入了这一概念。熵的变化可以分为两个部分:一是系统的不可逆过程导致熵增加,这项永远是正的;二是系统与外界交换物质与能量引起的熵流,这项可正可负。开放系统由于与外界的交流,具有正熵流的变化,负熵流的变化,负熵流的增减使总熵终处于变化之中,由此导致系统的整体稳

定性亦在变化。正是这种变化促使系统的平衡状态永远是相对的，而非平衡状态则是绝对的。系统的非平衡状态是使系统不断更新的唯一内在条件，是系统不断向前发展的动力，这正是耗散结构理论精华所在。

吴师在治学中强调动态诊疗观，细察患者在病程中证候的变化。他经常告诫：病症受其内在规律演变的制约，某些证候是在病症特定的时间、空间才能真切体现。因而临证资料的收集不可能一蹴而就，必须细察揣摩。在注重动态诊疗观的同时，吴师十分重视临证个体差异，强调因人制宜。具体来说，主要体现在如下几方面：

1、临证中强调八纲辨证为主，配合脏腑、六经、卫气营血、气血津液侧重不同的综合辨证。显然，人体系统、层次、局部的不平衡状态要在即定时空内以证候完全表现是偶然的，辨证察微、宏微观辨证，系统观察见精神是治学的关键。如以八纲辨证为例，吴师在病历体现上强调起码必须从三对纲领上，即病位、病性、属性等三方面体现。如常见的里虚寒证、里虚热证；里实寒证、里实热证，虽都为里证，但虚实、寒热相差有别。

2、临证中注意先天禀赋和后天调养的不同，年龄、性别、生活、社会环境不同等导致的个体差异。如吴师常告诫：老人血气衰少，生机减退，患病多虚证；实证者，攻伐防重下。小儿稚阴稚阳，气血未充、脏腑嫩娇，忌峻药，慎补剂。可见吴师的治学高筹就在于真切地把握了体内各种不平衡运动导致的同病在不同个体上证候异现。

3、在辨证精切的基础上，大胆启用“同病异治”，“异病同治”之法。如用麻黄汤治疗杂病的临证中，吴师将麻黄汤用于肩凝、失音、鼻渊、大便难、癃闭等现代中医分类相差甚远的疾病，疗效颇佳。当然正如吴师所述，上述病种并非麻黄汤所能概而治之，但只要临证辨证为感受同寒而成者，投之则可达异病同治之功。

当今，临床动态诊疗观及临证注重个体差异已构成临床流行

病学的重要内容,这从另一个角度说明吴师临证治学的真知灼见。

三、涨落现象与治学中的预见性思辨 及治疗中的因势利导法则

一个系统(如人体),由于内外部因素的作用,经常出现一种随时发生起伏的现象,称涨落。一般情况,由于系统内微观结构的平均调整作用(如人体的神经体液调节、经络调节、局部调节),涨落往往被减弱,不影响系统宏观变化。这种变化称微涨落。但是当变量达某一临界值时,涨落则被放大,促使系统宏观出现变化,称巨涨落。微涨落是一种破坏稳定性的干扰,易使系统离开定态,回到原来状态。但由于不断增加的微涨落而形成巨涨落时,则如同普利高津所有涨落导致新的有序,使系统由先前的不稳定状态迁移到新的有序稳定状态。

吴师治学中非常强调病史中“十问歌”的逐条落实,“四诊”检查的详尽。充分考虑患者即刻的病性、病位、属性,自然病程的发展趋势;给药后对患者病程的影响,在特定情况下,患者可能出现的证候错杂、转化、真假等变化。一接诊就必须对患者的转归有一种科学预见性思辨。在此基础上,充分注意方药的因势利导治疗效应,调偏补差,引导体内微涨落的形成壮大、周期缩短,短期内达巨涨落的阈值,使系统在新的起点上达到有序的稳态,病愈。如其在治疗急性黄疸型肝炎时,除了用药上注意湿热蕴结脾胃、薰蒸肝胆而导致肝失疏泄,胆失条达,给予清热祛湿的茵陈、大黄、栀子外,还科学预见性思辨到肝木本克脾土,苦寒辛燥之药易助虐伤脾,降低患者抵抗力,因而因势利导地运用。

1、煎药时,于祛湿药中加少量黄酒,取其辛窜之气,邪随气去而易除。

2、醋可入肝健脾,具活血化瘀之功,可少量助食。

3、重用柴胡，以其入肝胆之经，疏气解郁散火、宣畅气血，以防少阴之火、厥阴风木侮肺传脾。

4、苦寒泻下之药不可久用，中病即止。中后期注意培土健脾。充实脾气，无令得受肝之邪也”。

二、临床经验录

麻黄汤治疗杂病的临证体会

麻黄汤见于《伤寒论》，仲圣明确指出本方是用于治疗太阳伤寒证，体现了发汗散寒的治法，是辛温解表峻剂的代表方。笔者在临床实践中，认为凡属于感受寒邪而致的病证，投用本方均能收到异病同治之效。

肩 凝

谢某，女，51岁，金淘村人。1980年11月7日就诊。

患者右肩关节酸楚、抬举困难，不能梳理头发已5个多月。发病前曾被大雨淋过，随后即畏冷发热、头痛、身楚，经治疗后诸症消失，继而出现右肩关节酸楚、抬举困难逐步加重，屡治未效而来就诊。切脉弦缓，舌质淡，苔白稍腻，治宜通经活络，散寒利湿，方用麻黄汤加味：

麻黄 15 克	苡仁 15 克	白芍 15 克
甘草 9 克	桂枝 9 克	杏仁 9 克

秦艽 9 克 半夏 9 克 制川乌 6 克(先煎)

水煎热服,每日 1 剂。服后卧床休息,慎避风寒,取汗。另用食盐、米糠、生葱各适量,炒热酒喷布包,乘热外熨患部,每晚睡前 1 次。内服外熨相结合,连用一周而愈。

荨麻疹

叶某,男,6 岁,高田村人。1984 年 12 月 14 日就诊。

患者因肝炎在治疗中,几日来天气骤冷,突然遍身散发荨麻疹,并波及口唇眼睑已 5 天,发痒以入夜为甚,寤寐不安。西医以抗过敏药物治疗愈而复作,而求治于中医。诊脉缓,舌质淡,苔白,四肢不温,疹块淡白、扁平硬节、高出皮肤,一经搔抓立即由白转红。此乃小儿患肝炎后体虚,营卫失调,风寒客于腠理之间而发病。治宜疏风散寒助以益气。方用麻黄汤加味:

麻黄 6 克 黄芪 9 克 白芍 4.5 克
桂枝 4.5 克 荆芥 4.5 克 蝉衣 4.5 克
杏仁 3 克 甘草 1.5 克

水煎热服。复取微汗,慎避风寒,连服 5 剂而愈。

失音

洪某,女,48 岁,莲塘村人。1983 年 2 月 12 日就诊。

患者素有咳嗽史,每于感受风寒,则咳嗽加剧、继则声嘶甚至不能发音,近因气候骤冷而猝然失音已一周。痰白不多,口不干渴,脉濡,舌苔薄白。分析病因,盖肺为声音之门,患者既有咳嗽史,肺气本伤,现复感风寒之邪,肺气被遏而致失音。治宜疏风散寒、宣肺利窍。方用麻黄汤加味:

麻黄 12 克 杏仁 9 克 荆芥 9 克

前胡 9 克 桔梗 9 克 桂枝 6 克
蝉衣 6 克 甘草 6 克

水煎热服。慎避风寒，复取微汗，连服 3 剂而愈。

鼻 渊

潘某，女，66 岁，罗东村人。1983 年 12 月 8 日就诊。

患者右鼻不闻香臭伴流白色粘涕，前额胀痛不舒，迁延不愈已一年多，尤以气候转寒，症状遂即加重。脉浮细而缓，舌质淡红，苔薄白。此乃寒邪犯肺，《灵枢经·脉度篇》云：“肺气通于鼻，肺和则鼻能知臭香矣”。今肺受寒邪所壅，鼻窍不通，故嗅觉失灵，不闻香臭。治宜宣肺散寒通窍，方用麻黄汤加味：

麻黄 12 克 黄芪 15 克 苍耳子 15 克
白芍 9 克 辛荑花 9 克 白芷 9 克
杏仁 9 克 桂枝 6 克 甘草 6 克

淡煎取其气之轻清。以利药力上行直达病所，临睡前热服。并用生葱头削一切口，大小适宜，塞于鼻孔，左右交换。上方连服 6 剂，诸症悉痊。

冻 疮

吴某，女，38 岁，仑苍村人。1983 年 1 月 10 日就诊。

三年来每于严冬之际，手指、足趾外缘及耳翼，即呈红肿微痒，特别是用冷水洗衣服时，则指掌发红瘙痒不已而来求治。脉缓，舌质淡红，苔薄白。此乃寒邪侵袭，局部气血凝滞。治宜温阳散寒活血。方用麻黄汤加味：

麻黄 15 克 附子 15 克 黄芪 30 克
桂枝 9 克 红花 9 克 干姜 6 克

细辛 6 克 甘草 6 克

水煎日 1 剂,夜睡时热服。连服 8 剂而痊愈。善后嘱用当归、黄芪合鳊鱼炖服。1984 年 12 月 30 日因月经不调来诊,告曰:上述诸症今年未见复作。

大便难

王某,男,74 岁,大泳村人。1984 年 11 月 16 日就诊。

患者素有肺结核史,近因感受寒邪而加重,住我院传染科治疗。证见:咳嗽频作,痰多而白,气喘胸闷,神疲,纳呆,夜寐不佳,消瘦乏力,二个月来大便难,粪型条细、质软。脉滑,舌质淡,苔白滑。脉证合参,拟为寒邪外束痰浊阻肺。盖肺与大肠相表里,肺为寒邪外束痰浊所干,肃降不能,影响大肠传导而致大便难。治宜温寒肃降,佐以化痰。方用麻黄汤加味:

麻黄 6 克	黄芪 9 克	半夏 9 克
茯苓 9 克	桔梗 9 克	杏仁 9 克
桂枝 3 克	甘草 3 克	干姜 1.5 克
五味子 1.5 克		

水煎热服。慎避风寒,药服 3 剂,大便通畅。

隆 闭

吴某,男,36 岁,诗南村人。1984 年 2 月 15 日就诊。

患者以捕捉鱼虾为生,经常涉水淋雨,三日前突然畏冷发热,无汗,咳嗽声重痰白而稀,伴小便点滴不畅,小腹胀急疼痛不可按,痛苦难以言状,而延余诊治。脉浮,舌苔薄白,此乃风寒犯肺,肺气郁闭而致尿闭不畅。盖肺为水之上源,主“通调水道,下输膀胱”,今肺受风寒之邪所袭,宣肃失司,上源不清,通调无权,水不下输膀

脱,致下窍不利。治宜辛温宣肺,开上窍以启下窍之法。方用麻黄汤加味:

麻黄 15 克	桂枝 9 克	杏仁 9 克
甘草 6 克	怀牛膝 30 克	葱白 3 茎

水煎温服,1 剂尽而小便通畅。

痛 经

洪某,女,38 岁,龙江村人。1983 年 4 月 13 日就诊。

患者每于月经来潮之后,即有畏寒肢冷伴小腹冷痛。本次月经来潮前被雨淋过,经潮第二天寒战不发热,四肢冰冷,小腹拘急冷痛不可忍。形体消瘦,面色无华,语音低微,脉浮略紧,舌淡苔白。此乃素体虚衰,经期前复感寒邪,致寒凝气滞,下焦阳气失宣。治宜温经散寒,补气益血。方用麻黄汤加味:

麻黄 12 克	桂枝 9 克	杏仁 9 克
甘草 9 克	杭芍 9 克	当归 9 克
黄芪 15 克	吴茱萸 6 克	干姜 6 克

水煎热服。药服 1 剂,霍然而愈。

体 会

1、历代医家均认为麻黄为发汗药,非太阳表证而不敢用,同时用量也极轻,恐有引起大汗脱人元气之危险。笔者在临床实践中,认为应用麻黄,如能因时、因人、因病、活泼斟酌不拘于成见而用之,既不导致大汗亡阳之危险,且能收到良好的效果。如阴邪侵入,寒凝经脉之症,则无论冬夏,皆所最宜,又何过之有。笔者用于治疗肩凝、冻疮、痹证以及皮肤病,每用 15 克从未见弊端。

2、古方用麻黄必去节,以取其发汗之力较强。汤药用麻黄,皆

先将麻黄煮数沸，吹去浮沫，然后纳他药，盖以所浮之沫发性过烈，去之可以使其性归于和平也。今时用者，麻黄大抵皆不去节，亦很少先煎去沫。临床观察，虽未按古人之法，但疗效尚属不逊，亦未见发性过烈之弊。

3、麻黄汤为辛温解表之剂，服药以温服和热服为宜，服后慎避风寒，覆取微汗。这是本方服法之基本关键，中医强调正确之服法，对发挥药效具有重大之作用。正如徐大椿云：“方虽中病，而服之不得其法，则非特无效，而反有害”，诚不谬也。

● 原载于《福建中医药》，1987年第1期。

临证应用小柴胡汤一得

小柴胡汤载于《伤寒论》，系仲圣为和解少阳而设。笔者在仲圣关于“有柴胡证，但见一证便是，不必悉具”的教导下，用于治疗有柴胡证，但见一证的小腹剧痛，惊悸不寐，项背强痛，眩晕，乳痈等5个病例，收到满意的效果。现介绍如下：

一、小腹剧痛

患者傅××，女性，39岁，本县美林乡洋美村人。1984年3月17日夜，以腹痛剧烈就诊。

其丈夫代诉：他爱人三日前从漳浦归家，时值天气严寒，当晚房事之后，遂有畏冷，发热，微汗出伴小腹轻微拘急痛感，越早不以为意，参加农务活动，中午收工回来，寒热往来，头疼、身痛交作，入夜小腹剧痛难忍。诊见：痛苦病容，双手按住小腹，四肢逆冷，脉弦而紧，舌质淡红、苔微黄。拟诊房事感寒腹痛。治以温中救逆，散寒止痛。先用：生葱头、老姜各15克，捣如泥，加酒少许，合鸡蛋煎如饼，乘热敷于脐部，未几腹痛遂即缓解，但过后痛又复作，继用四逆汤加味：

制附子 6 克	桂枝 6 克	吴茱萸 6 克
干姜 3 克	炙甘草 4.5 克	

嘱服1剂。翌早复诊，诸症不减，反而口渴，烦躁不宁，考虑尚有寒热往来、头疼、身痛之少阳证。试治以和解少阳，辅以温中散寒，缓急止痛。方用小柴胡汤加味：

柴胡 12 克	黄芩 9 克	桂枝 9 克(后下)
生姜 3 片	红枣 5 枚(剖)	白芍 15 克
炙甘草 9 克	党参 9 克	半夏 9 克

嘱服 1 剂,以观后效。3 月 19 日三诊:药后腹痛除,诸症亦减,效不更方,嘱再服 2 剂,康复如常。

按 本例为交媾感寒太阳未罢,复感寒邪,邪犯少阳,不得转枢,阳气被遏而导致小腹剧痛。患者以当晚行房事,阳精被耗,气血虚弱,腠理不密,时值天气严寒,寒邪乘虚而入,故房事之后遂有畏冷、发热、微汗出伴小腹轻微拘急痛感。正气未复,越早天气严寒,又参加农业活动,太阳未罢,复感寒邪,邪犯少阳,阳气被阻,不得转枢,故中午收工回家,寒热往来,头疼、身痛交作,夜为阴时,是以入夜小腹剧痛。本例虽有四肢逆冷,但未见脉微细,非寒邪直中阴经之候,故用辛温救逆之四逆汤加味,不但腹痛不止,反而益增口渴,烦躁不宁,此乃误治也。后来考虑患者尚有寒热往来,头疼、身痛之少阳症,试治以和解转枢,振奋生机之小柴胡汤加缓急止痛之白芍,温中散寒之桂枝,由于对症治疗,1 剂见效,3 剂而收全功。说明辨证论治,差之毫厘,而失之千里。中医辨证应从整体观念出发,慎思明辨,治疗才能丝丝入扣。

二、惊悸不寐

郑××,女性,42 岁,本县美林乡省身村人。

1972 年 2 月 7 日初诊:病口苦、咽干、善怒、胸胁苦满,纳食不佳、情绪容易激动、厌烦嘈杂声音已 1 年多,近 3 个月来入夜则惊悸不寐,或睡梦纷纭,黄昏独自入房,则心惊惕惕,屡经治疗未见好转而来求治。查阅原病历已服过镇惊安神、补血养心之药未效。诊见憔悴病容,脉弦、舌质红、苔黄,综上症状。考虑为胆气久郁、壮火食气,阴津暗耗,心胆两虚。试治以和解少阳,方用小柴胡汤加味:

柴胡 15 克	枣仁 15 克	黄芩 9 克
半夏 9 克	党参 9 克	知母 9 克
炙甘草 6 克	生姜 3 片	红枣 4 粒(剖)

日服 1 剂，嘱服 7 剂。复诊时患者告曰：症除大半，效不更方，嘱继服 7 剂，共服 14 剂，而诸症消失。后因家事争吵，病又复作，仍以原方治之而愈，现体健如常。

按 本例为邪犯少阳，枢机运转不利，胆火久郁，灼伤津液，所谓“壮火食气”，故证见口苦、咽干、善怒、胸胁苦满，纳食不佳，情绪容易激动、厌烦嘈杂声音。《素问·六微旨大论》曰“少阳之上，火气治之”，说明少阳之病变多为火气，最易伤阴耗津。胆火久郁，不但灼伤本经之阴津，同时也会暗耗心血，形成心胆两虚。夜为阴时，阴津内耗，故入夜惊悸不寐或睡梦纷纭，黄昏独自入房则心惊惕惕。正如《沈氏尊生书》所说：“心胆俱怯，触事易惊，睡梦纷纭，虚烦不得卧”。本例用和解少阳之小柴胡汤为主，加清胆宁神之知母，养肝之枣仁治之，使胆气疏泄正常，枢机运转，生机旺盛而诸证悉除。由于辨证正确，治疗得当，故效如桴鼓。

三、项背强痛

苏××，女性，46 岁，本县码头镇诗南村人。

1985 年 8 月 23 日就诊，症见：项背强痛，转侧不灵，伴寒热往来，每日一发，寒轻热重，热来大饮不解其渴，不欲饮食已 4 天，经到××医院门诊，治以葛根汤连服 3 剂，汗出甚多，寒热往来未除，项背强痛益增，而求治。查问病史，去年患胆石症曾到福建医学院附属一院进行手术，素体虚衰，月经行期色淡，白带多而清稀，面色无华，脉弦而细，舌质淡、苔薄黄。症属少阳热重伤津，治宜和解，方用小柴胡汤：

柴胡 12 克	黄芩 12 克	半夏 9 克
---------	---------	--------

党参 9 克 炙甘草 6 克 生姜 3 片

红枣 6 粒(剖)

水煎服。1 剂而寒热解,3 剂尽,项背强痛除。

按 本例虽有涉及项背强痛太阳病葛根汤之症状。但寒热往来有间,热重于寒,热来大饮不解其渴,症属少阳热重伤津,而致项背强痛,转侧不灵,并非仲圣所谓:“太阳病,项背强几几,……葛根汤主之”之证,故治以葛根汤未效。由于汗出甚多,而津益伤,故项背强痛益甚。

患者素体虚衰,月经愆期而来,经色淡,且白带多而清稀,去年又手术胆石症,气血本虚,阴津被耗,加上寒热往来,热重于寒,益伤津液,况 4 日来不欲饮食,水谷不足以化精微而充津液。本例项背强痛乃津伤之故,但仍有寒热往来之少阳见证,当以和解少阳以转枢机,舒少阳之气,使生机旺盛,寒热自除,纳食自然增进,自无少阳之火气,以伤津液,项背强痛不待除而自除矣。方用小柴胡汤,1 剂见效,3 剂项背强痛除。

四、眩 晕

雷××,女性,58 岁,本县码头镇诗南村人。

1984 年 10 月 14 日就诊:5 日前患寒热往来,经治疗后,症已消失,昨天突然眩晕发作,如立舟之状,旋转不定,转头更甚,双目不敢睁开,呕逆频作,口苦,不欲饮食,经乡村医生用镇静药治疗,服后入睡,不知所苦,但醒后诸症如故。脉弦细数,舌质红、苔薄黄。拟诊为肝阳上扰清空而眩晕。治以天麻钩藤饮,连服 3 剂未见功效。又再邀余诊治,脉症如故,因思尚有口苦,不欲饮食之少阳症,试从和解肝胆,止眩降逆之法治之,方用小柴胡汤加味:

柴胡 12 克 黄芩 9 克 半夏 9 克

党参 9 克 炙甘草 6 克 生姜 3 片

红枣 4 枚(剖) 竹茹 2 粒 珍珠母 20 克
代赭石 20 克 双钩藤 15 克(后下)

水煎服。1 剂知,3 剂服完能下床协理家务。

按 本例寒热往来虽解,但口苦,不欲饮食,呕逆频作,脉弦细而数,舌质红、苔黄。仍属少阳火气为犯,因胆气未疏,故服天麻钩藤饮未能取效。在《内经》:“诸风掉眩皆属于肝”,“肝与胆相表里”的启示下,本例系厥阴风木,少阳相火相搏而致肝胆同病。肝胆之气不得下降而上逆,故眩晕旋转不定,治以和解肝胆,方用小柴胡汤为主,辅以止眩降逆之竹茹、珍珠母、双钩藤、代赭石,药服 3 剂而收全功。

五、乳 痛

吴××,女性,28 岁,本县仑苍镇仑苍村人。

1984 年 12 月 4 日就诊:产后左乳房红肿胀痛,寒热交作、头晕、目眩、口苦、咽干、舌燥,两胁痛甚已 8 天,经用青霉素肌注、红霉素口服,症状未见改善而求治。查问病史,发病前因家事争吵,当晚又食用姜、酒、麻油合煨之雄鸡,及后自感胸胁胀痛不舒,继而产生乳汁不通及上述诸症。脉弦,舌质红、苔黄,患部红肿灼热,痛不可按。治以小柴胡汤加味:

柴胡 15 克	大黄 9 克	野牡丹 15 克
蒲公英 15 克	黄芩 9 克	半夏 9 克
青皮 9 克	川楝 9 克	白芷 9 克
党参 6 克	木香 6 克	生姜 3 片
大枣 3 粒(剖)	甘草 3 克	

水煎服。连服 5 剂而诸症悉除。

按 乳头属肝经,乳房属胃经,两胁为肝胆经之分野,本例患者之发病,系来自情志不畅,肝气本已郁结,再加上食进辛热之姜,

酒、麻油、雄鸡等物，而致热毒内蕴，气血壅滞，发生两胁胀痛不舒、乳汁不流、乳房红肿疼痛，寒热交作、头眩、口苦、咽干、舌燥等症，肝与胆相表里，本例之主要矛盾在于肝胆之气郁结，故以小柴胡汤和解少阳之经，以舒肝胆之气为主，辅以清胃消肿、化瘀理痛之青皮、川楝、木香、白芷、大黄、蒲公英、野牡丹等药而奏效。

● 原载于《福建中医药》，1987年第5期。

大黄附子汤治疗痛证经验举隅

一、胆道蛔虫

陈某,男,16岁,学生。1993年12月10日初诊。

患者于4h前在上课时无明显诱因出现右上腹部突然疼痛,呈阵发性“钻顶”样疼痛,并反射至右肩部。剧痛时大汗出,肢末冰冷,呕吐3次,呕吐物先为食物残渣,继而吐出活蛔虫2条。呈粉红色。症状时作时休,体检:体温36.5℃,神清,呈痛苦病容,巩膜无黄染,腹肌稍紧张,剑突下右方有明显压痛,肝脾未触及,肠鸣音稍亢进,大便已数日不下。B超提示:胆道蛔虫症。舌质暗,苔白厚,脉弦。证属蛔虫内扰上窜胆道,扰乱腑气,疏泄失职,不通致痛。治宜理气通腑,驱蛔止痛。方用大黄附子汤加味:

大黄12克(后下)

附子9克(久煎)

细辛3克

白芍15克

甘草6克

水煎服,每日1剂。服药1剂后疼痛减轻,手足温和。2剂后,大便通,再进1剂便下蛔虫1条,诸症好转,正常上课。B超复查:胆道蛔虫已排出。

按 胆道蛔虫是肠内常见寄生虫病,系为蛔虫内扰而致。吴老根据六腑以通为用,通则不痛的原理,辨证论治。胆为六腑之一,喜通调,恶郁滞,蛔虫上窜胆道,胆腑阻滞不通而痛。故方用大黄,苦寒、能通能降,使虫体安静,且能促进胆汁分泌,使胆道收缩,有利于虫体排出;附子、细辛,大辛大热,温阳散寒安蛔,麻醉虫体;白

芍、甘草缓急止痛。药证合拍,故收效迅捷。

二、肾绞痛

刘某,男 48 岁,农民。1993 年 11 月 3 日初诊。

主诉:素有小便刺痛窘迫感,上午左肾区突发绞痛,疼痛为阵发性发作,并向左大腿内侧放射,继而出现肉眼血尿,面色苍白,头部冷汗,被动体位,舌体胖有齿痕,舌质暗淡、苔薄白、脉弦细。体检:左肾区叩击痛(+).尿检:红细胞(++)、白细胞(++).B 超提示:左输尿管下段可见一枚大小约 0.5cm×0.6cm 结石伴积水。证属肾气不足,湿浊互结。治宜温肾利水,通腑排石。方用大黄附子汤加味:

大黄 15 克(后下)	制附子 10 克	细辛 6 克
桂枝 6 克	白芍 15 克	石苇 15 克
金钱草 30 克	王不留行 30 克	炙甘草 9 克

水煎服。服药 6 剂,天天泻下,患者自觉症状明显好转。药已中病,守上方继服 6 剂,排出结石 1 枚,大小与 B 超相符,诸症亦随之消失。经 B 超复查,左输尿管结石消失。

按 吴老通过长期的临床实践,认为结石多为湿浊内生、久经煎熬而成。然而肾气不足,气化不利,湿浊凝结亦可形成结石。结石阻于水道,气化不畅,尿液排泄不利而疼痛,伤及血络则尿血。治疗本病其本在于肾虚,功能失调,其标在于湿热蕴结下焦,久积成瘀。根据“标本同治”的原则,吴老治疗上着重温肾利水,通腑排石。方中用附子、细辛、桂枝化气利水,温补肾阳;石苇、金钱草清热利水化石;白芍、甘草能舒张水道,缓解平滑肌痉挛;王不留行性走而不守以助下石;大黄通下逐瘀使结石排出体外。合而用之,共奏温阳利水,通腑消石之效。由于药证相符,功效亦著,故仅服 12 剂,结石排出,解除痛苦。

三、痛 经

李某,女,23岁,未婚。1994年1月8日初诊。

患者经来腹痛已3年之久,曾服温经汤及调经诸药收效甚微。自述平时身冷畏寒,四肢酸软无力,小腹常觉冷感,白带多而稀薄。每逢经期则小腹剧痛,痛时手足冰冷,经行量少而有血块,不能上班工作。腹痛喜温喜按,得按痛减。舌质淡红,苔薄白有齿印,脉沉细。证属寒邪凝滞,气血不畅,冲任不固。治宜温经散寒,养血通脉,化瘀止痛。方投大黄附子汤加味:

大黄 6 克	附子 10 克	甘草 6 克
细辛 4.5 克	当归 9 克	酒白芍 15 克
桂枝 9 克	丹参 12 克	乌药 9 克

水煎服,日1剂。嘱其在经前服用,药尽则痛大减,四肢见温,白带明显减少。嘱下次月经前再服3剂,诸症痊愈。随访1年,未见复发。

按 痛经可由多种原因引起,但其共同的病理基础为脏腑功能失调,导致气血运行不畅,以致子宫瘀血,胞脉不通,使子宫在经期不能正常发挥功能而产生痛经。本案之身冷畏寒,四肢酸软乏力,小腹冷感,白带多清稀,腹痛喜温喜按,得按痛减,舌淡、苔白齿印等一派寒凝气滞之象。故吴老投大黄附子汤以温经散寒,养血通脉;再加桂枝、乌药行气散寒;当归、丹参活血化瘀、通利血脉;酒白芍、甘草缓急止痛。全方共奏温经散寒,养血通脉,化瘀止痛于一体,药证合拍,则痛自止矣。

四、粘连性肠梗阻

刘某,男,70岁,退休工人。1993年9月12日初诊。

自诉:5年前因阑尾炎术后引起肠粘连而致肠梗阻,曾反复手术2次。近10天来腹胀疼痛、拒按,尤以右侧腹部明显,大便不下,曾用西药配合灌肠治疗效果不显,建议再次手术治疗,病人拒绝手术,而请教吴老用中医治疗。

诊见:上、中腹部胀满疼痛,尤以右侧腹部明显,大便秘结,已5天未解,四肢欠温,腹喜热敷,舌质暗淡、苔白腻,脉弦而沉。血常规:白细胞 $11 \times 10^9/L$ 。腹部X线透视诊为粘连性肠梗阻。吴老辨证为手术后经脉受损,阳虚脏寒,腑气不通。治宜温阳散寒,通腑泻实。方用大黄附子汤加味:

大黄 20 克(后下)

附子 10 克(久煎)

细辛 6 克

枳实 12 克

水煎口服1剂。药后3小时肠鸣及肠蠕动加快,矢气频作,腹胀痛减轻。2剂后,便下数枚燥屎及粪水,腹胀疼痛消失。随访半年未见复发。后常用此剂调理,迄今1年余,病情稳定。

按 粘连性肠梗阻属于祖国医学“关格”、“肠结”等范畴。此乃肠道痞塞不通,气滞血瘀,通降失调而致。吴老认为本案患者因年老体虚,加之多次手术,中阳之气竭乏,寒邪壅结在里,气机升降失常,故见腹胀疼痛便秘诸症。方用大黄通腑泻实;附子、细辛温阳散寒;枳实能调理、疏通气机,散结消痞,破气消积,并对胃肠有兴奋作用,使之蠕动节律有力。诸药合用,使腹部气血运行加速,寒邪得散,腑气通降正常,以达到腑通痛止之目的。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《福建中医药》,1995年第26卷增刊。

应用大黄甘草汤的经验

大黄甘草汤出自《金匱要略》，原文为：“食已即吐者，大黄甘草汤主之”。近代亦曾报告过用于神经性呕吐、厌食症、目赤肿痛等病效佳。大黄甘草汤是吴光烈老师临证常用之方。或单独应用，或稍事加味，所用病证较广泛。现介绍于下：

食已吐水

吴师运用大黄甘草汤治疗本病主证为：食已吐无味之水，头目眩晕、腹胀、有灼热感，精神困倦，面色苍黄，小便短赤，脉滑数，舌质红、苔黄少津。病因病机为：感邪或纳食不慎，胃受热邪干扰，脾气郁闭，升清降浊不能，水饮内停，胃气上逆而见吐水。方用性味苦寒之大黄“泻实祛邪，荡涤肠胃，推陈出新，通利水谷，调中化食，安和五脏”。（《本经》语）甘草补脾养胃，兼防大黄泻下太过。大黄 20 克，甘草用 4 克，用量比为 5：1。

紫 衄

吴师运用大黄甘草汤治疗本病主证为：皮肤紫癜反复呈现或并尿血，头痛耳鸣，大便干结，舌质红、苔黄厚，脉数。病因病机为：外感热邪或肝郁化火，血分热盛，血热络损，见紫癜并尿血。清·唐容川云：“大黄一味，即是气药，又是血药，止血不留瘀，尤为妙药”。

方用大黄清热泻下，引火下行，热去血安脉通。大黄性喜沉降，紫癜集中于上半身者，必酒炒，借酒性上升敷达。甘草协清热解毒，缓大黄急性。大黄用 20 克，甘草 5 克，两者用量比为 4 : 1。

唇舌疮

吴师用大黄甘草汤治疗本病主证为：唇舌颜面生疮，舌质红、苔黄，脉弦数。病因病机为：外伤蕴毒或过食肥甘厚腻，嗜酒失度，湿热痰阻，气血瘀滞而成。方用大黄行泻热通腑散结之功，期达行气活血，消肿化积。甘草协以疗疮解毒，消炎之功。两者配伍，攻守俱备，收效甚佳。大黄用 20 克，甘草 4 克，两者用量比为 5 : 1。酌情加味：清心导热用连翘、木通；清脾胃之郁热用知母、石膏。

胁 痛

吴师用大黄甘草汤治疗主证为：胸胁胀满，隐痛、纳油劳累忧郁加剧。伴口苦耳鸣，大便干结，小便短赤，脉弦数，舌红、苔黄厚燥。病因病机为：肝气郁结，经脉不利，郁而化火上攻。大黄此用为清肝泻火，顺气利胆，调中化食，安和五脏。甘草有缓急解痉止痛，并有和中之意大黄用 20 克，甘草 5 克，两者用量比为 4 : 1。

抗衰老作用

吴师应用大黄甘草汤的主证为：精神不振，腰膝酸软，眩晕耳鸣，健忘少眠，便秘，舌淡苔白或微黄，脉弦。此类患者不可妄攻，亦不可纯补，而宜攻补兼施，虚实同调。方用大黄以畅通腑气，清涤肠胃，祛浊化瘀，使胃肠保持通畅，加速糟粕瘀阻的及时排出。从而使精气化生，气血通畅，脏腑组织及时滋养，功能活动自然健旺。大黄

用量为 15 克,甘草用蜜炙,以加强补脾养胃,调和安神的功效。用量为 15 克,两者用量比为 1 : 1。应用中亦必考虑脏腑虚实现状,偏肾阳虚者加肉桂末 1.5 克冲服;阴虚者加玉竹 20 克煎服。

体 会

《金匮》记载大黄甘草汤的用量为:“大黄 4 两,甘草 1 两”。两者的用量为 4 : 1。吴师认为临床应用大黄甘草汤时,大黄与甘草的具体用量必须从病情、病程、病位及邪正虚实所表现的证候来考虑。如唇舌疮、紫癜中早期等邪盛实证者,大黄与甘草的用量比例必须加大,至少 4 : 1,充分体现君药大黄的悍利作用。通过清热通腑,平冲降逆,推陈出新,利于速战速决。病之后期下虚为主,卒中后遗症,抗衰老应用中,则大黄的用量不宜大,甘草量宜增,以防大黄峻利太甚再伤脾胃之气,增甘草之养脾和胃之功。两者用量比,为 1 : 1。甘草可蜜炙后用。

吴师在具体处方中还注重标明药物的炮制及煎法。如用于以攻邪祛实为主的病证中,强调大黄需用生药,以期充分发挥其“荡涤污浊,推陈出新”的功能,真正起到“一窍通而百窍皆通,大关通而百关皆通”的要药。用于体虚邪弥者,大黄宜酒制而防攻下太过伤正。用于病证后期、抗衰老作用时,甘草宜蜜炙,期增甘草的和中缓急、补脾养胃、扶正安神之功效。作为抗衰老而长期服用大黄甘草汤时,大黄不宜急停,以防机体反馈性调节而出现便秘。原文煎法为:“以水 3 升,煮取 1 升,分温再服”。吴师在具体运用中,强调邪实病证,需通腑泻下,清热逐瘀时,大黄宜后下,以防泻下成分蒽醌类物质破坏,从而影响其攻下之力。

在具体应用中,吴师加味慎重。如紫癜诊治中的加生地 20 克以滋阴凉血;白茅根 60 克以清热凉血。抗衰老应用中,阳虚为主加肉桂末 1.5 克冲服;阴虚为主,加玉竹 20 克协滋阴降火。总体要求

为宁少勿多，宁专勿杂，谨防喧宾夺主，这是我们临床的体会。

（周建宣 整理）

● 原载于《中医杂志》，1993 年第 2 期。

补中益气汤的临床应用

补中益气汤为甘温之剂的代表方,主要用于治疗内伤脾胃,脾胃气虚之证。吴师在临床实践中常碰到不少脾胃气虚的病人,根据不同症候,用本方随证化裁,取得显著成效。兹举验案数则如下:

一、口 疮

林某,男,35岁,工人。1993年5月20日初诊。

患者2年来,口舌生疮反复发作,严重影响进食及睡眠,以致身体逐渐消瘦。现口疮又复发近20天,曾服维生素B₂、硫酸锌、维生素C等,并外用冰硼散、赛霉胺等药物,效果欠佳,要求服中药治疗。证见:精神萎靡,体倦乏力,纳差便溏,查体见面色萎黄,口唇内侧上下粘膜可见多个豆粒大小之溃疡点,疮面色白,平坦,周围有红晕,舌质淡红,苔薄白,脉细弱。证属脾胃气虚,清气不升,阴火上乘所致;治宜健脾益气升清。方用补中益气汤加味:

黄芪 15 克	党参 12 克	白术 12 克
当归 9 克	升麻 6 克	柴胡 9 克
陈皮 9 克	干姜 3 克	甘草 6 克

水煎服。每日1剂,嘱服3剂。

二诊:服药3剂后,口疮疼痛明显减轻,疮面缩小,药已对症,原方再进5剂而愈。最近随访,自诉偶有复发仍以原方治之,随即消失。

二、便秘

刘某,男,65岁,农民。1993年6月10日初诊。

患者便秘已将5年,多次服用承气类中药,虽能通便于一时,但停药后仍大便不下,伴有便后腹胀、纳呆。近一个月来大便经常秘结,就诊时患者已6天大便不解,虽有便意,但临厕努则不出,努则汗出气短,精神疲倦,食减,舌淡苔白,脉弱。证属老年气虚下陷,清气不升,浊气不降。治当补中益气,升清降浊。方用补中益气汤加味:

黄芪 30 克	党参 15 克	白术 15 克
当归 15 克	陈皮 9 克	柴胡 9 克
升麻 6 克	甘草 6 克	枳壳 9 克
桔梗 9 克		

水煎服。服药3剂后,大便已下,腹胀减轻,纳食增加。嘱按原方继服10剂,后每两天大便一次,诸症悉除。

三、流涎

陈某,男,9岁,学生。1993年4月5日初诊。

患者因一个月前腹泻经治愈后,夜间睡眠常流口涎,湿透枕巾。诊见患者精神倦怠,面色㿠白,舌质淡,苔薄白,脉缓无力。此乃气虚不能摄津之症。治宜补中益气,固摄津液。方用补中益气汤加味:

黄芪 15 克	党参 12 克	白术 9 克
升麻 6 克	柴胡 6 克	陈皮 6 克
当归 6 克	益智仁 9 克	乌梅 3 克
炙甘草 3 克		

水煎服。连服 6 剂，诸症消失。随访一年未见复发。

四、心肌炎

黄某，女，38 岁，农民。1993 年 7 月 18 日初诊。

患者心慌气短，不思饮食伴身疲乏力，动则汗出，喘息已半个月。心电图检查诊为“心肌炎”。经西药治疗效果不显，要求服中药治疗。证见舌质淡红、苔薄白，脉细弱，属心脾两虚。治宜补益心脾。方用补中益气汤加减：

黄芪 20 克	党参 15 克	白术 10 克
陈皮 9 克	柴胡 9 克	升麻 6 克
当归 9 克	熟地 15 克	茯神 15 克
丹参 12 克	酸枣仁 15 克	甘草 6 克

水煎服。服药 6 剂，心慌气短，动则汗出、喘息明显减轻。又服 6 剂，诸症消失。心电图复查正常，随访至今未见复发。

五、慢喉暗

谢某，女，32 岁，教师。1994 年 1 月 10 日初诊。

患者慢性喉炎病史已将 4 年。近一周来经常声嘶、咽干、喉痒，精神疲乏，讲话费力。舌红少苔，脉细数。经间接喉镜检查：声带微红肿，闭合差。证属肺气耗伤，治宜补中益气，利咽开喉。方用补中益气汤加味：

黄芪 20 克	党参 15 克	白术 15 克
当归 9 克	炙甘草 6 克	陈皮 9 克
柴胡 9 克	升麻 6 克	人参叶 9 克
沙参 15 克	蝉退 6 克	诃子 6 克

水煎服。服药 3 剂，声嘶明显好转。仍守上方再服 3 剂，诸症

而愈。随访半年未再复发。

六、梅核气

吴某,女,30岁,工人。1993年10月11日初诊。

患者素体虚弱,近年来因家务繁忙,心情不快而头晕、心慌、纳食不香,倦怠乏力,精神不佳。动则气短,以深吸气为快,并伴有咽喉梗阻感,吞吐不利,纳食正常。舌质淡红、苔薄白、脉缓无力。证属脾胃虚弱、中气不足、升降失和、浊气上凑所致。治宜益气健脾,化浊降逆。方用补中益气汤加味:

黄芪 30 克	党参 15 克	白术 12 克
当归 9 克	升麻 6 克	柴胡 9 克
枳壳 6 克	沉香 6 克	半夏 9 克
茯苓 12 克	川朴 9 克	甘草 6 克

水煎服。每日 1 剂,连服 10 剂,而诸症痊愈。

体 会

补中益气汤为著名医家李东垣所创制,首载于《脾胃论》,具有调补脾胃,益气升阳之功。主要用于脾胃之虚所发生的多种病症。临床主要症状为精神倦怠,肢体乏力,面色萎黄或㿗白,饮食无味,气短懒言、自汗、动则喘促,舌质淡、脉虚无力。

上述病例,诊断虽不同,但表现均有脾胃虚弱、中气不足之共同证候。故均采用调补脾胃、升阳益气的补中益气汤治疗,收到良好的效果。这说明先做好证候的辨证、找出病机是处方用药的重要环节,同时也体现祖国医学“异病同治”、“脏腑相关”的治疗特点。

(吴盛荣 整理)

● 本文 1995 年 11 月荣获《实用中医药》杂志优秀论文奖。

从归脾汤看临床异病同治

归脾汤始载于宋代严用和《济生方》，由白术、茯苓、黄芪、炒枣仁、龙眼肉各 1 两，人参，木香各 0.5 两，炙甘草 2 钱 8 味药组成。明代薛立斋《校注妇人良方》中又增加当归、远志 2 药，功在益气补血，健脾养心之名方。主治思虑过度，劳伤心脾，气血不足之证。吴师宗归脾汤用意之旨，临证审证求因，运用该方加减化裁治疗失眠、紫癜、汗症、带下、崩漏、眩晕等疾病，疗效显著。兹举验案如下：

一、失 眠

刘某，女，52 岁，干部。1993 年 10 月 20 日初诊。

患者一个月前因工作紧张，劳倦太过，晨起头晕失眠，多梦易醒，甚则通宵不能入睡，纳呆食少，长期服用安定控制。近来诸症加剧，面色少华，舌质淡红，苔薄白，脉弦细，证属劳倦思虑太过，累及心脾，气血生化无源，心失所养而致。方用归脾汤加味治疗，以补心脾、益气血。处方：

黄芪 25 克	党参 15 克	当归 12 克
白术 15 克	茯苓 15 克	酸枣仁 15 克
远志 9 克	龙眼肉 15 克	木香 9 克
大枣 5 粒	夜交藤 15 克	炙甘草 9 克

水煎服。进 6 剂后睡眠有所好转，续用原方再服 6 剂，头晕神疲大减，能安静入睡，嘱继用归脾丸 5 研，日 2 次，每次服 9 克。半

个月后随访,诸症痊愈。近1年来睡眠安好。

二、紫 癜

黄某,女,15岁,学生。1993年8月13日初诊。

患者紫癜反复发作已两年余,长期服用西药强的松,三磷酸腺苷并肌注辅酶A等,无显著疗效。其瘀点色淡,压之不褪色,且以双下肢尤甚;伴神疲乏力,面色少华,头晕眼花,舌质淡胖、苔白,脉细弱。证属脾气虚弱,统摄无权。治宜益气摄血。方用归脾汤加减:

党参 15 克	黄芪 20 克	炒白术 15 克
当归 9 克	熟地 15 克	远志 6 克
酸枣仁 12 克	旱莲草 12 克	仙鹤草 9 克
紫草 6 克	炙甘草 6 克	

水煎服,每日1剂。服药6剂后,紫癜减少,面色少华好转。嘱按原方继服10剂,诸症悉除,病已痊愈。随访半年未见复发。

三、汗 证

陈某,男,53岁,工人。1993年11月5日初诊。

患者自述近一个月来盗汗,睡眠欠佳,伴有头晕腰酸,气短神疲。观其面色少华,舌淡苔薄白,脉虚细。此系心脾不足所致。投归脾汤加减以养心补血敛汗。处方:

黄芪 30 克	党参 15 克	白术 15 克
当归 9 克	炙甘草 9 克	酸枣仁 15 克
远志 9 克	熟地 15 克	五味子 9 克
龙骨 15 克	夜交藤 20 克	乌梅 3 粒
杜仲 15 克	牡蛎 15 克	

水煎服,每日1剂。连服6剂,盗汗止诸症痊愈。

四、带 下

吴某,女,28岁,工人。1993年12月10日初诊。

患者自述带下色淡黄、质稀、无臭味,绵绵不断已一年余。近段来加剧,伴有心悸健忘,面色萎黄,四肢酸软,夜寐欠佳,纳少便溏。舌淡、苔薄白,脉细。妇科检查:附件(一)。白带常规:无滴虫、无霉菌。证属:脾气虚损,不能运化水湿所致。治宜补益心脾,升阳除湿。处方:

党参 15 克	黄芪 15 克	当归 12 克
茯苓 15 克	白术 12 克	炒枣仁 15 克
远志 6 克	木香 6 克	淮山 15 克
苍术 9 克	芡实 15 克	白果仁 10 克
海螵蛸 15 克	升麻 6 克	

水煎服。服药3剂,带下明显减少,诸症亦减。药已中病,按上方再进6剂,带下止,诸症亦痊。

五、崩 漏

林某,女,32岁,农民。1993年7月10日初诊。

患者自述,经水淋漓不断,时多时少已半年。此次来月经势如山崩,色淡,质清稀,自觉头晕乏力,神疲懒言,面色㿠白,饮食减少,四肢乏力。舌质淡红、苔薄白,脉细缓。此系脾不统血所致。治宜健脾益气,养血止血。处方:

黄芪 30 克	当归 12 克	白术 15 克
党参 15 克	炒枣仁 15 克	远志 9 克
木香 9 克	茯苓 15 克	大枣 5 粒
龙眼肉 15 克	阿胶 15 克(融化另冲)	

水煎服。服药 4 剂后,经血减其大半,余症亦减轻。按上方再进 4 剂而血止。俾服归脾丸善后,旬余,身体渐复。随访一年未见复发,劳动如常。

六、眩 晕

李某,女,28 岁,工人,1994 年 5 月 10 日初诊。

患者眩晕反复发作已 2 年余。近半年来,心慌阵作,寐差,口唇麻木,熟睡后常自口角流出清水。伴月经提前,量多色淡。纳呆脘闷,便溏薄。诊见面色㿖白,少气懒言,舌质淡,苔薄白,脉细弱。辨证属气血亏虚型眩晕证。治宜补气养血,温脾摄涎而定眩晕。处方:

党参 30 克	黄芪 20 克	炒白术 15 克
当归 9 克	茯苓 15 克	炒枣仁 10 克
龙眼肉 15 克	木香 9 克	莲子肉 15 克
淮山 30 克	益智仁 15 克	苍术 9 克
乌梅 2 粒		

水煎服,每日 1 剂。服上药 6 剂后症状大减。守上方出入,调治半月告愈。

体 会

本文所举病例,虽病症各异,但其病因、病机大同小异,均有体倦、纳呆、心悸少寐、面色萎黄、舌淡、脉细弱等心脾两虚证。其主要的治疗法则都是以养心益脾、益气补血为主,皆以归脾汤治疗取得较好疗效。体现祖国医学异病同治之特色。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《时珍国药研究》,1996 年第 1 期。

浅谈逍遥散及其临床应用

逍遥散是宗《太平惠民和济局方》从张仲景《伤寒论》四逆散加减而成。为肝郁血虚脾弱之症而设。少阴病(第138条)“少阴病,四逆,其人或咳或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重者,四逆散主之”。《和剂局方》去枳实加当归、茯苓、白术、生姜、薄荷而成。具有疏肝解郁、健脾养血的作用,为调和肝脾之代表方。主要应用肝郁血虚脾弱所致的两胁作痛;头目眩晕,疲乏食少,或见寒热往来,或月经不调,少腹疼痛,乳房作胀。舌淡红脉弦而虚者。肝藏血,性喜条达,肝不藏血或肝血虚,而致头目眩晕。两胁为肝之分野,肝郁则胁痛,肝胆枢机失常,寒热往来之症随之而起。肝主疏泄,肝郁不能疏泄脾土,脾失健运,故疲乏食少。脾虚失运化生营血则不足,以致肝血愈空。肝脉循行绕阴器至少腹,故见月经不调,少腹疼痛。上述可见本方症以肝郁为主,凡是肝郁血虚脾弱者可根据出现不同症候以逍遥散加减均能获效。吴师临床上常应用本方治疗妇女月经不调,慢性肝炎,胆道疾患,乳房作胀,痛经、带下,高血压,神经衰弱,颈淋巴结核,甲状腺机能亢进等疾患,运用加减化裁,往往获得意外疗效。

逍遥散以柴胡疏肝解郁为主药,当归、白芍补血和营以养肝为辅药,茯苓、白术、甘草健脾补中为佐药,煨姜和中与当归、白芍同用并能调和气血,助薄荷少许以增强柴胡疏肝解郁的作用,二味均为使药,诸药合用成为疏肝,理脾,和营养血的常用方。

临床加减:肝气郁结甚者加香附、青皮;血热者加丹皮、生栀子;血虚月经不调、少腹疼痛者加生地或熟地;肝热,脾虚不明显者

去白术、茯苓、煨姜、薄荷加丹皮、栀子、黄芩；兼血瘀者加丹参、茜草、海螵蛸去煨姜、薄荷；脾虚兼湿者加重茯苓、白术、加苍术、藿香、厚朴；脾虚兼湿化热者加茵陈。

临床应用举例如下：

一、经期头痛

刘某，女，26岁，工人。月经来潮时头痛，以前额为重。两乳作胀，经期过后自然消失2年余。经多方治疗未效，于经期来潮半天就诊。证见患者右手紧捏双侧太阳穴，呈痛苦面容，眼睑晦暗，头晕目眩，胸胁胀闷，两乳胀痛，脉弦有力，舌质淡红、苔白。诊为肝郁气滞，七情内伤，升降失调，郁于清窍，清阳不运，阻滞经络，致发头痛。治宜调解肝郁。方用逍遥散加丹皮、栀子、香附、白芷。水煎服，每日1剂，连服6剂。服药后经期无头痛，经血通畅，于下次月经来潮前服上方3剂，头痛痊愈。随访2年头痛未复发。

按 经期头痛，多由肝郁气滞，七情所伤。肝主疏泄，性喜条达，肝郁变症丛生。据《内经》“木郁达之”之训，顺肝条达之性，升木郁遏之气。方中柴胡、白芍、当归疏肝气，养肝血，特别是柴胡其性升散，既能疏泄肝胆之本，又能清阳振举；茯苓、白术健脾利湿；丹皮、栀子清热凉血，泻火除烦；薄荷、菊花疏散风热，行气宽中；陈皮、香附理气、疏肝解郁；白芷通窍止痛，甘草调和诸药。全方共奏标本同治，临床不可不用。

二、带下

黄某，女，28岁，小学教师。患者因其祖母病逝，情绪抑郁，两胁胀满，暖气频频，便溏带下清稀，有时色黄如米泔，腰酸腿软，舌红苔薄，脉弦滑。此证属肝郁脾虚，湿热下注。治宜舒肝健脾，利湿

止带。方用逍遥散去当归加淮山、芡实、苡仁。连进4剂，带下大减，两胁胀满明显减轻，暖气消失。唯腰酸腿软，故守原方加女贞子、旱莲草。又服6剂，白带已止，诸证除。随访1年未见复发。

按 带证引起与肝经湿热相关，傅青主说“肝气欲上升，而湿欲下降，两相牵掣，以停住于中焦之间，而走于带脉，遂从阴器而出，‘逍遥散最能解肝之郁与逆’。郁逆既解，湿热难留，故投此方收到立竿见影之效。

三、乳房胀痛

陈某，女，27岁，营业员。主诉：月经不调，每次经前一周即感两侧乳房胀痛已将半年，反复发作，伴有头晕、胸闷、纳呆，舌质淡红、苔薄白，脉弦细。证属肝气郁结所致。治宜舒肝解郁，理气止痛。方用逍遥散加香附、蒲公英、王不留行、益母草。嘱其经前服药5剂，服药后自觉症状见减。守前方续进3剂，下次经前再服3剂，乳房胀痛消失，月经正常。

按 本例案系为肝气郁结，故拟疏肝解郁，理气止痛。以本方加香附疏肝理气，益母草散血通经，蒲公英、王不留行、通络散结。诸药合用，使气行则血行，经调即气血调和，诸症自愈。

四、痛 经

李某，女，19岁，未婚，学生。患者14周岁月经初潮，尚未发现痛经。自18岁起经期虽准，但临经下腹部剧痛，经血少，伴有黑色小血块，且乳房胀痛。近来发现经前鼻衄。脉弦，舌苔薄白。证属肝气郁滞，气血运行不畅所致。治宜疏肝理气，调和气血。方用逍遥散加香附、丹参、元胡、当归、川芎服药6剂而获效。

按 肝喜条达，其脉布于两胁乳房，循阴器绕少腹，倘若情志

不遂，必致肝气郁滞，气为血帅，气滞则血阻，影响冲任通泄，故值经期则乳房胀痛，下腹剧痛等症。气有余，便是火，郁气化火，迫血伤络故鼻衄。故方中用逍遥散加香附疏肝理气，调经止痛；丹参、当归、川芎活血化瘀；元胡活血行气止痛。由于药证合拍，故仅服6剂，而收全功。

体 会

逍遥散一方，渊源久长，临床应用颇为广泛，后世医家在临床中亦积累大量经验。以吴师之见，此乃临证中疗效显著之方。

（吴盛荣 整理）

● 本文1995年11月荣获全国基层医药优秀学术论文。

生姜鸡肉汤治验选介

生姜鸡肉汤系笔者自拟的处方,由童鸡(雌雄均可)一只,生姜60克、伏龙肝(灶心土)60克(煎取澄清液备用)等组成。具有补脾暖胃,扶羸益气之功。用法:将童鸡处死,去毛洗净,剖去肠杂,纳入生姜于腹中,置瓷钵内,然后加入伏龙肝澄清液酌量,食盐少许,盖密炖烂,取汤徐徐饮之,鸡肉也可与食。每日或隔二三日服一剂。本方用于治疗妊娠恶阻有良效,对于脾胃虚寒而引起之久疾不愈,治之也屡试不逊。现将治验选介如下:

一、消渴症

陈某某,男,62岁,1986年3月14日就诊。

患者口渴喜热饮、多尿、多食而不充肌肤已三年余,一年来症状有所加重,医用滋阴补肾以及甘寒之品屡治未效而求诊。证见:形体消瘦,面色无华,咽干舌燥、四肢乏力而欠温,大便完谷不化,偶或溏泻。脉沉缓无力,舌淡、苔薄白而干。化验:尿糖未发现,血糖(空腹)85毫克%。尿比重1.003,每日尿量3000毫升左右。拟属脾胃气虚,肾阳不振,治宜健脾益气、温补肾阳。方用生姜鸡肉汤加附子15克,肉桂4.5克(另炖),每二三日服一剂。连服3剂后,口渴除,四肢转温,诸症好转。效不更方,嘱再服3剂。同年12月3日,携其孙来院诊治,谓服上方后,诸症消失,劳动有劲。

按 本例系消渴病后期、阴损及阳,脾肾两伤,脾虚失运,不能化水为津液;肾阳不振,命门火衰,肾气失其蒸腾,故口渴、多饮、多

尿、尿多津益伤，是以患者形体日见消瘦以及出现上述一系列症状。方用生姜鸡肉汤补脾温胃，扶羸益气以升阳，加肉桂、附子、温阳补肾以生津。由于治疗得当，故效加桴鼓。

笔者治疗由于肾阳不振而失津之症，每于处方中加入附子、肉桂、屡收良效。盖以壮其少火，使微微生火，以鼓舞肾气，肾气充盈，则阳蒸阴化，津液自生。取其“少火生气”之义，正如釜底无薪锅盖干燥，釜底加薪枯笼蒸薄。先贤张景岳云：“善补阴者必于阳中求阴，则阴得阳升而泉源不竭”。然应用桂附治疗消渴，应审慎病之虚实，如无肾阳虚衰之征，用之则反其害益增其病矣。

二、久年咳嗽症

侯某某，男，54岁，1986年12月12日就诊。

咳嗽已10多年，痰多色白，动则气喘，遇寒更甚，近来有所加重，屡治未效而求诊。证见：面色皤白，声低不扬，口干欲饮，大便不实，小便清长，呕恶纳呆，脉沉缓。舌淡胖苔薄白，证属脾肺气虚，累及于肾，治宜健脾温阳，助以补肾。方用生姜鸡肉汤加肉桂4.5克（另炖）连服6剂而病除。

按 本例其本在于脾虚，脾不化湿，水湿内聚而生痰，上犯于肺，故咳嗽，痰多而白，声音不扬，病久累及于肾，故动则喘，小便清长，口干欲饮。治从补脾温阳着手，以制其生痰、理其咳嗽，实其大便、止其呕恶。脾运食欲自然增进，他脏之病自除。用生姜鸡肉汤以温补脾阳，加肉桂以补肾纳气定喘，且可鼓舞肾阳，壮其少火生气，升津液而治口干欲饮，用药得当，故6剂而愈。

三、水肿症

黄某某，女，73岁，1989年5月4日就诊。

浮肿已3年,始于下肢,按之没指,后遍及全身,近日来纳呆,呕恶,大便溏泄,小便短白,身体重着,步履艰难而求治。证见:精神萎靡,面色无华,倦怠懒言,全身营养不良,脉濡缓,舌淡苔薄。化验:尿常规未见异常,血浆蛋白降低。证属脾肾阳虚,水聚不运。治宜温补脾肾,化气行水,方用生姜鸡肉汤加附子15克、肉桂4.5克、黄芪30克。服3剂水肿渐消,继服3剂,诸症亦痊。

按 本例用生姜鸡肉汤补脾益气,温阳行水,加黄芪走表利皮肤之水邪,加附子、肉桂温补肾阳,使阳气得复,寒水得化,小便自利。药症合拍,故药仅服6剂,收效卓著。

四、痰饮症

郑某某,男,61岁,1988年12月29日就诊。

患者胸胁支满,泛吐痰涎,遇冷则加剧,已达4年余。近年来明显消瘦,不能劳动而来就诊。证见:面色无华,精神不振,声音低微,讲话稍喘,四肢乏力,背部时有冰冷感。脉滑而缓,舌淡胖,边有齿痕,苔白腻。证属脾肾阳虚,饮停中焦。治宜温阳化饮,方用生姜鸡肉汤加茯苓30克、白术15克、肉桂4.5克(另炖),嘱经常服用。患者来信云:服3剂后,痰涎显著减少,继服6剂,诸症消失,现已能参加轻微体力劳动。

按 本例为脾肾阳虚之痰饮症,但与脾之关系最为密切。经云:“脾为生痰之母”,脾失健运,则水湿潴留而为饮。脾病多虚多寒,故先贤有言:“虚则太阴”,脾虚常能导致他脏亦虚,脾健则他脏疾病也随之转归良好,故从温补脾阳着手,用生姜鸡肉汤加茯苓、白术治之,脾健则湿去而痰饮自除,辅以肉桂温补肾阳化气行水,则饮自消矣。

五、嗜卧症

吴某某,男,47岁,1987年5月5日就诊。

食后困倦嗜卧,如醉状已3年余,近一年来腹满,善饥而不欲食,四肢乏力,肌肉日见消瘦而来求治。诊见:精神萎靡,面色少华,声音低微,脉缓弱,舌淡苔白。证属脾阳不振,运化无权。治宜补脾益气,温运中阳。方用生姜鸡肉汤加黄芪15克,党参15克,取汤饮服,每2天服1剂,连服5剂,能纳食,精神振奋,诸症亦瘥。经随访二年未再复发。

按 本例为久病失养,脾阳不振,运化不良,谷气不行使然,故用生姜鸡肉汤加党参、黄芪补脾益气,温运中阳而收效。盖脾主运化,输布水谷精微为生化之源,五脏六腑,四肢百骸皆赖以养。脾阳不振,运化失职,生化乏源,五脏六腑、四肢百骸受养不足,因而出现嗜卧等一系列脾虚之症状。

六、寒胀症

戴某某,男,62岁,1989年12月4日就诊。

患者腹部胀满,不欲饮食,遇冷则更甚,不耐劳动已3年,屡用消导之剂治之未效。证见:面色㿖白,神疲倦怠,口淡,呕吐清涎时作,腹部喜按、喜温。证属中阳虚衰,寒气内盛,治宜温补中焦,祛寒消胀。方用生姜鸡肉汤加附子15克,肉桂4.5克,取汤与服,连服4剂,腹部胀满消失,能纳食,诸症亦随之改善。

按 本例遵经旨“虚者补之,寒者温之”之法,用生姜鸡血汤温补中焦,扶元益气,加附子、肉桂温阳去寒,药证相符,症除迅速。

七、便血症

吴某某,男,49岁,1988年3月26日就诊。

每于饥饿时胃脘部即隐隐作痛,喜按,得热饮则痛缓解已10多年。近两年来遇劳则时下漆黑色稀状粪,一个月来脘腹隐隐作痛加重,便漆黑样粪次数增加,伴头晕耳鸣,心悸,全身乏力,晨起就厕时突然晕倒而来求治,证见:面色无华,神疲懒言,脉细缓无力,舌淡苔薄。证属脾胃阳虚,统血无权。治宜温阳健脾,方用生姜鸡肉汤加白术15克,龙眼肉15克,附子15克,每日1剂取汤与服。连服5剂,大便正常。诸症亦瘳,嘱不定期,经常服用此汤,经随访1年,劳动正常未见复发。

按 本例为胃痛已久,脾气虚衰,失于统摄,气不摄血,血无所归,离于脉道而成便血,此血来自胃脘,故色黯黑为远血也。治以补脾摄血着手。方用生姜鸡肉汤扶羸益气,加附子、白术温阳健脾,以复健运之职,生血统血之功;加桂圆肉以养营血,使血能归经而收良效。

小 结

1、久病大多脾胃虚弱厌服药物,或见药而有呕恶之意。用食物疗法易为病人所接受,可达到扶正驱邪之目的。

2、拙拟生姜鸡肉汤治疗由于脾胃虚寒引起的慢性病,均收到异病同治之效。

3、古人云:“一方可以治百病”,“一病可以用百方”。医者贵在辨证准确,立法恰当,施治用药自可得心应手,临证不必拘泥于一方一药,而应对号入座。

● 原载于《福建中医药》,1990年第6期。

吴茱萸之妙用

吴师用吴茱萸灵活多变,别出心裁,有独具一格之建树。先生以吴茱萸为主药,治疗扁桃腺红肿溃疡、小儿夜啼症,小儿麦疥、胃肠积气如鼓、妇女阴痒、脱发、角膜溃疡等取得了显著的疗效。

一、扁桃腺红肿溃疡

余治一例扁桃体红肿溃疡,吞咽困难,连服养阴清肺汤加板兰根、桔梗数剂,未见效果,请教吴老他说:药对症,药性缓,欲速效可用吴茱萸研为幼末调醋涂于两足心,以引火下趋,此从治之义也。余用之果收良效。

二、小儿夜啼症

吴老曰:小儿夜啼上半夜发作属心火上炎,用吴茱萸研末调醋贴于足心,引火下趋;下半夜发作为脏寒,用吴茱萸研末调醋涂于脐部,盖以棉花、纱布、再用胶布封固,此温脏也。余临症用之,疗效确实不逊,实奥妙也。

三、小儿麦疥

麦疥为收割大小麦之季节,小儿全身皮肤痒搔不已,搔后皮肤发红,夜睡更甚,血出结痂,皮肤粗糙。西医为皮肤瘙痒症,吴老谓:此乃湿热毒邪,郁结肌肤,当用燥湿清热解毒治之,用吴茱萸 15

克、硫磺 10 克、冰片 3 克合为粗末布包、浸于茶油内加热，取起俟温，擦于患处，每天 1~2 次，不数天而愈。吴老谓：吴茱萸为辛温走散要药，其功宏、其效速，皮肤之黄水疮疹，湿疹等用之亦效。

四、胃肠积气如鼓

吴老曰：胃肠积气如鼓，不能饮食，辗转反侧不安，此寒凝气滞也。当用吴茱萸研末炒酒，乘热敷脐部，未几则见矢气频传。如不效，再用吴茱萸 15 克，半酒水煎汤灌肠，腹胀必消。余验之果神效也。

五、妇人阴痒

吴茱萸 15 克、明矾 15 克、食盐 10 克。水煎先薰外洗阴户，止痒甚效。吴老曰：湿能生虫，故阴痒，吴茱萸为燥湿杀虫之要药，湿去阴户自不痒也。

六、脱 发

吴××，女，30 岁，小学教师。因家庭不和，时常争吵，产后未几，夜不能寐，精神紧张，头发脱落大半，求诊吴老。诊脉舌未见异常，吴老曰：此与肝郁产后血亏有关，肝失条达，藏血功能失常，且血少无以营发，因而发落。

吴茱萸入肝、肾、脾、胃四经，最能开郁，使肝气条达，及温补脾肾。肾为先天之本，主藏精，其荣发也；脾为后天之本，生化水谷精微之源。吴老治以吴茱萸 10 克，辅以制首乌 15 克、旱莲草 15 克，党参 15 克、黄芪 15 克。连进 10 余剂后，果见新发如汗毛辈出。服一个月多，脱发止，新发生，满头乌黑。

七、角膜溃疡

刘××,女,40岁。素体亏虚,忧郁病容。患左眼凝脂翳角膜溃疡,羞明、流泪、疼痛、睫状充血,角膜部份溃浊。余治龙胆泻肝汤加减未效,请教吴老何也?吴老曰:素体亏虚,又有忧郁病容,《内经》云:“有诸内必须形于外”此乃体亏肝郁无疑。郁能化火,故呈现睫状充血等热象,但素体亏虚,虚则补之,故用龙胆泻肝汤苦寒直折未能奏效。吴老说:郁宜开达,郁去则火自平。虚则补之,则正自复而发生,嘱用吴茱萸12克,柴胡9克,当归9克,白芍15克煎汤服之,并取汤少许,微温擦患侧耳后青筋,至筋脉怒张,然后用消毒针放血,日1次,治疗未几,果溃疡愈合,视力恢复而告愈。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《中国武夷国际中医药学术研讨会论文汇编》
1993年7月于武夷山。

大黄临床应用琐谈

大黄气味俱厚,苦寒泄降,入脾、胃、肝、心包、大肠 5 经。《本经》云:“能荡涤胃肠,推陈致新,通利水谷,调中化食,安和五脏。”临床实践证明,凡是由于胃肠实热而引起之疾病,用之以荡涤积垢、清热泻火、推陈致新,确实骏快如神。正如《本草求真》谓:“可收定乱致治之效”。然用量应因人、因病、因时制宜,有胆有识灵活应用,始能收到良好效果。现将余带徒继承临床经验之验案,选介 5 则,说明大黄是一种很有前景之中药,值得深入研究。

痰 秘

陈某某,男,47 岁。1991 年 5 月 4 就诊。

诉胸胁痞闷不畅,痰多而稠,为时已数月,近日来又复感寒邪,咳逆喘满不得卧,头汗出,大便干结,口干舌燥,不欲饮食,脉弦数,舌质红、苔黄。门人侍诊分析:此乃肺中素有蕴热,壅阻肺气,以致肺气壅实不得宣降,清肃之令不行。近日又复感寒邪,表失疏泄,故胸胁痞闷不畅,咳逆喘满不得卧,头汗出、大便干结、口干舌燥、不欲饮食,皆为火热伤津,津液不布之故也。治以涤痰清火,拟用桑白皮汤(《景岳全书》),桑白皮、半夏、苏子、杏仁、知母、黄芩、山栀,可乎?请教于余。答曰:《诸病源候论》:“肺主于气,邪乘于肺则肺胀,胀则肺管不利,不利则气道涩。故上气喘息不通”,可在方中加葶苈子、知母共奏泻肺逐痰之功,使痰火得泄,肺气下降,以冀诸症俱平。然药服 3 剂症状依然,门人拟改弦易辙,余意药证合拍,可继服

3 剂,以观后效。剂尽不但未效,反而咳逆喘满加剧。门人问曰:将如何治之?答曰:《经云》:“肺与大肠相表里”,从脏腑表里关系治之,清泻大肠,使肺经实热从大肠下泄。方中加大黄 20 克,药后肠鸣腹泻数次,越口诸症顿减。药已中病,守原方大黄减至 15 克,再进 2 剂,果然腑通气得肃降而症愈。

舌 痹

郑某某,女,35 岁。1992 年 3 月 3 日就诊。

患者素健,夫妻不睦口角数日后出现舌尖麻痹不仁,至今已近 1 月。1 周来夜寐不宁,心烦易怒,头痛频作,耳鸣如潮声,口干而苦,大便干结,溺赤而涩,曾到某医院治疗未效而求诊。证见:脉弦数,舌尖红赤,苔黄,讲话时口中秽气熏人。门人诊为心火亢盛,肝火上逆,治以龙胆泻肝汤 3 剂后舌麻如故,诸症亦未减轻,而请教于余。问曰:何故也?答曰:审因论治,方用龙胆泻肝汤以清心泻火、疏肝利胆,药与症符,可续服 3 剂观察。剂尽舌痹仍不减。窃思患者素健,乃因夫妇不睦而诱发舌痹为主的一系列症状。此乃愤怒伤肝,肝气郁结,化火上冲,肝火上炎。心居上焦,五行属火,木火相生,舌乃心之苗,尖应心,热灼脉络,舌失濡养,故出现舌尖麻痹不仁。临床所见虚证及瘀证而出现舌痹不仁、五味不辨常有之,然本例并未见虚证、瘀证之征,此乃肝胆实火伤津灼络无疑。用龙胆泻肝汤苦寒直折未效,治以釜底抽薪为法,方中加生大黄 15 克以通腑涤热。药后腹中雷鸣,解出燥矢数枚,继为恶臭之粪便,舌痹略见减轻,方已对症,守进 2 剂,舌尖麻痹消失如常人,诸症亦瘥。门人大喜曰:此大黄之神功也。大黄为通腑泄热之圣药,凡有实热均可用之,腑通热泄,五脏安和,诸症愈矣。

暴 喑

孙某某,男,37岁。1992年3月4日就诊。

患者素有咳嗽,10余天前卒然声哑,不能发音,伴咳痰稠黄,大便干结,肛门灼热,小便短赤,口燥唇焦欲饮冷,脉数,舌质红、苔黄。门人诊为风热之邪犯肺,治以宣散清疏,方用银翘散加石膏、蝉衣、木蝴蝶,连服6剂未效而求教于余。门人问曰:何以未效也?答曰:此症诊为风热犯肺正确,风热之邪犯肺,气道受遏,肺气壅塞失其升降,清肃失司,以致声不能扬而音哑,所谓肺实不鸣也。正如叶天士所说:“金实则无声”,治以宣散清疏,药症切合,然大便干结、肛门灼热,此大肠实证,可在方中加入生大黄15克,盖取大黄通腑泄热,极其骏快,以冀腑通热泄,五脏安和而声扬。药服1剂,腑通果然奏效,再剂音哑大有好转。原方去大黄继服3剂,音哑基本正常。嘱停药观察,继用甘寒清热、润燥生津之香水梨、盐橄榄煎调适量之蜂蜜代茶频饮,以善其后。余之临床经验,凡肺经实证、热证,皆可泻下大肠,使热从大肠下泄,而气得速降,此《内经》“肺与大肠互为表里”之故也。

暴 聋

陈某某,男,45岁。1992年5月10日就诊。

患者平时饮酒厚味,素有湿热蕴聚。“五一”节又畅饮一番,突然耳聋而求治于门人。证见面赤头痛。口苦咽干,心烦易怒,大便秘结,夜不能寐,胸闷痰多而稠,脉弦数,舌质红,苔黄微腻。门人诊为痰火内聚,肝失疏泄;治以化痰清火,疏肝泄热;方用龙胆泻肝汤加川贝、半夏、大瓜蒌。服3剂后口苦咽干、心烦易怒有所改善,其它症状如故。门人侍诊案侧问曰:何故也?答曰:患者平素饮酒厚

味，上焦蕴有痰火，近又暴饮伤肝，肝胆火逆，上壅于耳，清窍失灵，故卒然耳聋，正如《中藏经》云：“肝气逆则头痛耳聋”，《古今医说》亦云：“痰火郁结，壅塞而成聋。”治以上方，药证恰切当取效。然不效者，泻火涤痰之力不及，可就原方加酒大黄 30 克，石菖蒲 10 克，葛花 10 克。门人质疑问曰：“大黄用量偏大，可碍机体否？”答曰：《内经》云“有故无殒，亦无殒也”，患者素嗜酒食厚味，久蕴热邪，故出现一派实热之象，大黄非用 30 克不能通腑泄热，杯水车薪无济于事，反而贻误战机。大黄酒制遵先贤李东垣之意，“若邪气在上，非酒不至，必用酒浸，引上至高之分，驱邪而下”，直达病所；石菖蒲主耳聋，出声音，祛痰浊用作引经；葛花散郁火，解酒毒。诸药相伍，服 1 剂后腹泻数次，耳聋微见效；继服 2 剂暴聋除，诸症亦愈，并无见碍也。门人喜曰：用药要有胆有识，慎思明辨。为医难，辨证难，用药更难。告曰：耳聋有虚实之分，暴聋多实，久聋多虚，至于虚证耳聋者，决非本方所宜，尤当审详。

呃 逆

陈某某，男，56 岁。1993 年 3 月 26 日就诊。

患者半个月来呃逆频作，不能自制，影响睡眠和休息，伴巅顶头痛，口中烦渴，大便难，小便赤涩。经多方就诊未效而求治。证见面赤体壮，呃声洪亮，脉洪数有力，舌质红，苔黄厚。细审患者素嗜酒食，非酒不能振作精神。门人诊为胃热内盛，郁久化火，胃火上冲，故呃声洪亮，冲逆而出。阳明热盛，故口干而渴，大便难，小便赤涩。脉洪数、舌质红、舌苔黄均为胃热内盛之象。治以清胃降逆，方用：

生石膏 20 克	竹茹 15 克	石斛 15 克
枇杷叶 15 克	麦门冬 15 克	半夏 15 克
陈皮 9 克		

连服 3 剂，诸症如故，而求教于余。告曰：方中为清胃降逆之品，药与证符，可也。然胃热久蕴非通腑泄热不能济其急，可在原方中加生大黄 20 克，石膏（打碎）加至 30 克（先煎）。服 1 剂后腹泻 5 次，呃逆渐平。继服 1 剂，诸症亦瘥。门人喜而问曰：何以如此速效？告曰：先贤李东垣谓石膏为除胃热要药，然石膏甘辛而淡，质重之品，用量宜重，更由于是矿物药，性味不易煎出，必须打碎先煎，方能取效。大黄专入胃，其性急，荡涤胃肠，推陈致新，极其骏快，因腑通热泄，呃逆告止，巅顶头痛亦除，诸症消失。然虚呃决非此所宜，临证遣方用药最宜谨慎。

● 原载于《福建中医药》，1994 年第 4 期。

细辛临证应用之我见

细辛性味辛温，入足少阴肾温经之主药，兼入心肺肝胆脾诸经，不但能散寒、燥湿、祛风止痛，而且有温肺化饮之力。如能熟读经书，则运用无穷。现选介治验4则，说明细辛尚有杀虫止痒，温胆除惊，润燥通便，温通经络之功。

阴门奇痒(滴虫性阴道炎)

苏某某，女，34岁。

外阴部发现红色丘疹，瘙痒不堪已2年。经治愈后，常因怒郁或劳役过度而复作。现因抓破后分泌淡黄色液体，阴道亦奇痒如虫爬，并时有味臭之黄带流出，寝食不安，胸闷不畅，口干且苦，小便赤涩。诊其舌质红，苔黄腻、脉滑数。此乃肝经郁火，湿热下注为患。治宜清利湿热，杀虫止痒，最宜结合外治直达病所，以取速效。药用：

细辛 15 克	蛇床子 10 克	地肤子 10 克
黄柏 6 克	苍术 6 克	川椒 6 克
明矾 6 克	硫磺 6 克(为末布包)	

水煎乘热先熏阴部后坐浴，早晚各处理1次。

另用细辛10克，青黛5克，冰片1克为细末，于睡前用鸡肝或猪肝切成指头粗细，外端用线扎紧，蘸药粉塞入阴道，翌晨从线端取出。

用上药后第1天显效，第3天阴痒止，诸症亦瘥，连用15天巩固。

固疗效，随访年余未见复作。

按 本例外阴奇痒症(滴虫性阴道炎)乃因肝经郁火,湿热下注所致。先贤徐春甫语云:“妇人阴痒,多属虫蚀所为,始因湿热不已”。可知湿热能生虫蚀于阴中,用大量细辛,取能入肝、胆二经,且味辛而厚、最能燥湿以除虫而止痒;再辅以黄柏、地肤子、明矾清热燥湿;川椒、蛇床子、硫黄,杀虫止痒,诸药合用具用燥湿、清热、杀虫止痒之功。由于用药得当,故收立竿见影之效。笔者经验:如阴中轻痒,熏洗则已,不必再加鸡肝蘸药末外塞阴户;如果剧痒不已,在熏洗药物中加入鲜猪胆汁适量,取效最速。

胆虚惊痫

李某某,男,6岁。

患者家属代诉:小儿平时睡即惊觉少寐,神思不安,5日前突然高热。经治疗后热退,继而出现惊叫急啼,惊惕不已,痰声漉漉,牙关紧闭,四肢抽搐,头颈强硬,伴神识昏迷,两目上窜,时作时止。经门人吴某用双钩藤、硃砂、石菖蒲、天麻、枣仁、僵蚕、全蝎、远志等药治之无效,而携来求治。

诊见:体虚神倦,余症同前,脉弦细、舌质淡、苔薄白而滑。此乃风寒之邪郁闭,痰蒙心包,为胆虚惊痫之症。从上方加入细辛1味,连服3剂,神清、抽搐告止,诸症亦除。

按 本例小儿平时睡即惊觉少寐、神思不安,乃属胆虚,续而突然出现一系列惊痫之征,此系风痰闭阻故也。门人治用安神镇惊豁痰息风之药,可谓药症合拍,其所未能见效,风寒之邪未除故也。细辛味辛而厚,性温而热,辛散温通功力宏,最能驱除风寒之邪而祛痰。故加入细辛1味能收全功,说明细辛也有温胆除惊之功效,且迅捷也。

大便秘结

陈某某,男,47岁。

经常性6~7天大便1次,粪质干燥而硬,排粪困难,经当地医生用脾约麻仁丸治之未效,而求治。证见:面色㿠白,神疲气怯,四肢不温,喜热恶寒,口中和,小便清长,脉沉迟而细,舌胖苔白。此阳虚阴凝,运送失常,温运无力而致。治宜温通开秘,方用肾气丸加肉苁蓉治之。服数剂未见疗效。先贤成无己有云:“细辛能润肾燥……通便涩,故于原方加入细辛9克。服3剂后大便正常,日排1次。

按 本例为阴盛阳衰、阴寒内盛,导致阳气衰微的病理,此火屈于水而致,非脾约也,故用麻仁丸治之未效。加入细辛1味以入肾润燥,盖取其辛以除寒,温以燥湿,则阴得解不凝矣,而大便自通。《内经》云:“肾苦燥、急食辛以润之”,即在此意。古人云:“差之毫厘,则失之千里。”“一味之别,则疗效迥异”。故辨证论治是中医之精髓。

不孕症(输卵管闭塞不通)

孙某某,女,29岁。

育1女,已7周岁,至今未再怀孕。男方检查一切如常,本人每于月经前后小腹冷痛,腰腿酸软,经某医院妇产科检查诊断为输卵管闭塞不通,先后经数家医院治疗未效而求诊。

证见:精神不振,面色无华,四末不温,脉沉细,舌质淡胖,舌边齿痕,苔薄白。症属下焦虚寒,湿滞胞宫。治宜温肾通络,散寒化湿。药用

细辛 15 克	王不留行 15 克	补骨脂 10 克
吴茱萸 10 克	小茴香 6 克	肉桂 9 克(另炖)

连服 15 剂,同时并用艾条熏灸关元穴,每日 1 次。经本院输卵管通水检查报告,通水良好,翌月妊子,足月顺产 1 男婴。

按 本例为输卵管闭塞不通之不孕症,根据其临床症状属于下焦虚寒,湿滞胞宫,导致胞脉闭阻不通,采用大剂辛温之药以直达病所而取效。方中重用细辛,盖取其为足少阴肾温经之药,味辛而厚,性温而热,除寒燥湿,通经开窍,攻效最捷,诸药合用则阴得解,而不凝矣,胞脉通畅而孕成也。

综上 4 例均用细辛而显效,盖因细辛味辛而厚,性温而热,功力宏大,在表之邪可解,在里之邪可除。余临床 50 余载,凡火屈于水而致之阴盛阳衰诸疾,每用 9 克以上,收效迅捷,且未见不良后果。《本草求真》载:“所用只宜数分,过则气塞命倾”。《本草纲目》有:“若用末不可过钱,多则气闭塞不通者死。”现代药物研究表明“细辛含有挥发油,经动物实验证明,可使中枢神经系统先兴奋后麻痹,继而渐渐呼吸,随意运动减弱,反射消失而死于呼吸麻痹。”随着临床实践经验之不断总结,成都中院学院主编之《中药学讲义》每次用量定为 1.6 克至 6.5 克,大大超过前人所用量。

前人之经验,近代药物学家研究之成果,应当引以为戒。然辨证论治是中医学的精髓,剂量之大小应因人因病而异,不必拘泥于书本千篇一律。

● 原载于《福建中医药》,1992 年第 6 期。

细辛妙用浅谈

一、烦躁失眠

林某,男,38岁。

经常性烦躁失眠已多年,余用酸枣仁汤屡治未效,而请教吴老。证见:精神抑郁,多怒善巩,胁肋时胀,季肋引痛连阴部,口中和,四末冷,脉细弦,舌质淡胖、苔薄白。吴老曰:可在原方加细辛9克。连服1周,果然睡眠转佳,诸症亦随之改善。余问曰:何以速效,吴老曰:细辛能润肝燥,条畅肝木,以生气血,故也。

二、耳鸣目昏

孙某,男,41岁。

耳鸣如蝉声,目昏如物遮已半年。戴眼镜也不能解决其视力,伴有胸闷多痰,胁痛不舒,食欲不振,肢体倦怠。诊见:面色㿔白,忧郁病容,脉濡细,舌质淡、苔薄白。治用补中益气汤加细辛9克,连服10剂,耳鸣、目昏告愈,诸症亦除。

吴老云:细辛能入肾经,兼入肝、脾,其辛散温通开窍之力甚宏,且能条畅肝木,以生气血,而使耳聪目明。益以补中益气汤以补脾、胃,而升清阳,使生化有源,水谷精微上注耳目而聪明。因药证合拍,是以效如桴鼓。

三、风 痉

李某,男,42岁。

突然昏倒,身背强直,筋脉拘急,不能俯仰,口噤不开,便溺俱出如痾状,每次发作须2~3小时始能清醒,1日1~2次,或数日1次,反复无定,已将八个月而求治。证见:面色无华,神倦乏力,脉沉迟,舌质淡、苔薄白。余诊为正虚邪实之风痉也,为风寒痰湿之邪壅滞经络而致病。方用小续命汤治之将一个月未见效,而请教吴老。吴老云:细辛为足少阴温经之药,且能开窍润肝燥,治督脉之病,脊强而厥有奇效。凡邪入至阴,腰脊强直之症,用之甚验,可在原方加细辛9克。患者连服10剂而收全功,随访2年,未见复作。

四、婴儿腹胀

吴某,男,初生7天。

突然腹胀如鼓,二便不通,啼哭不安,不能哺乳。民间女医视婴儿腹胀如蜘蛛,诊断为蜘蛛疝,治之未效而求诊。婴儿出生于寒冬腊月,由农村老接生员接生,操作迟纯,延长了接生时间。因婴儿“脏腑娇嫩”、“形气未充”、“稚阴稚阳”。故吴老诊断为寒邪所伤。考虑到婴儿初生不耐服药,将细辛10克,研为细末,调鸡蛋煎如饼,俟温敷于脐部。当晚二便通畅,腹胀渐消,不啼哭,能哺乳,果收良效。

五、手指拘挛

林某,女,39岁。

每逢寒冬则手指拘挛,展伸困难,入夜更甚,不痛不痒,双手乏

力,提物艰辛,眠食如常,二便通畅,脉沉弦,舌质淡、苔白。吴老云:此寒邪为病,经曰:“寒能收引”。细辛气味雄厚,能温经通络,散发寒邪之力宏大,且能横走。用细辛 30 克,水、酒、醋各 200 毫升合煎,乘热先薰患部,俟温后浸洗之,每日 1~2 次;另用细辛 60 克,浸于米酒 1000 毫升中,1 周后澄清过滤,每夜睡时温服 30 毫升,慎避风寒。酒服未尽已取效,尽剂手指活动如常,劳动自如。

结 语

1、细辛性味辛温,足少阴经之主药,考诸药理学记载,兼入心肺肝脾诸经,临床大多用于治疗风寒、风湿头痛,痰喘咳逆上气,风湿痹痛,齿痛、鼻渊等症。然吴老用药灵活多变,不受书中所囿,用治烦躁失眠、耳鸣目昏、风痉、婴儿腹胀、手指拘挛等病例,取得满意的效果。

2、细辛据《本草求真》载:“所用只宜数分,过则气塞命倾”。随着临床实践之不断总结,用量已有所增加,如成都中医学院主编之《中药学讲义》一次用量为 5 分~2 钱。

3、现代药物研究表明,细辛含有挥发油,经动物实验证明,可使中枢神经系统先兴奋后麻痹,继而渐渐呼吸,随意运动减弱,反射消失,而死于呼吸麻痹。

4、药学家研究之成果,应该肯定,然辨证论治是中医之精髓,治疗疾病,应该慎思明辨,对症用药。如《内经》云:“有故无殒,亦无殒也”。是用药之指导思想。凡是风寒邪入至阴重症,见吴老每用 9 克以上,疗效显著且未见弊端。可见临床辨证最为重要,不必受书本所约束。祖国医学始能发扬光大。

(吴盛荣 整理)

● 本文入选第四届全国基层中医中西医结合学术研讨会交流,1995 年 5 月。

十味降脂汤治疗高脂血症

高脂血症是指血浆脂质中一种或多种成份超过正常值高限的病理表现,属于祖国医学的气虚、痰浊、血瘀之范畴。大量研究表明,本症是发生动脉硬化、冠心病以及脑血管疾病的重要危险因素。吴师自1992年5月~1995年5月间,用自拟“十味降脂汤”治疗高脂血症125例,进行临床疗效观察,取得满意疗效。现报告如下:

一、临床资料

病例来源:本组125例均系来自门诊病人,其中男性85例,女性40例;年龄最大者75岁,最小者40例,平均年龄为55岁;病程最短者半年,最长者15年。125例中,胆固醇增高者65例,高甘油脂52例,高脂旦白38例。有高血压病史者55例,最长病史为20年;有高脂血症病史42例,最长病史15年;冠心病47例,糖尿病10例。

诊断依据:凡经化验检查血脂明显高于正常,即空腹血清胆固醇 $>5.7\text{mmol/L}$ (220mg%),甘油三脂 $>1.8\text{mmol/L}$ (160mg%),脂旦白 $>15.54\text{mmol/L}$ (600mg%),年龄 >40 岁者,均属高脂血症。

二、治疗方法

自拟“十味降脂汤”组成:

山楂 30 克	枳实 12 克	半夏 9 克
首乌 30 克	黄精 20 克	当归 9 克
丹参 15 克	桑寄生 15 克	决明子 15 克
大黄 9 克		

水煎服。1 日 1 剂。服药一个月为一疗程。一般一至两个疗程即见效。

加减：胸闷、胸痛者加栝蒌 20 克、薤白 15 克；心悸、失眠者加酸枣仁 15 克、远志 6 克；眩晕、呕吐者加半夏 12 克、天麻 15 克；头晕胀者加菊花 6 克、川芎 9 克；胁痛者加白芍 15 克、元胡 9 克；耳鸣者加磁石 15 克、蝉蜕 6 克。服药期间停用有降脂作用的西药及中成药。

三、治疗结果

疗效标准：凡治疗前经检验测定有一项或两项血脂高于正常值，治疗一个或两个疗程后均降至正常范围，且临床症状明显好转或消失为显效；治疗前有两项血脂增高，治疗后有一项降至正常范围，其他症状减轻或好转为有效；治疗后血脂增高或均未降至正常范围或仅有回升者为无效。

疗效结果：125 例患者中有 62 例获显效，54 例有效，9 例无效。总有效率为 92.8%。

四、典型病例

李某，男，68 岁，离休干部。1994 年 10 月 25 日初诊。

主诉：头晕伴有右侧肢体麻木两天。患者有高血压病史已 10 余年，平素头晕脑胀，烦躁易怒、口苦、纳呆、少寐。近日来眩晕加重，且出现右侧肢体麻木，心悸、气短，舌质淡红、苔薄黄，脉弦。血

压:24/14.2kpa,胆固醇 6.76mmol/L,甘油三脂 2.6mmol/L,高脂旦白 38mg/DL、肝功能、血糖检查均正常。诊断为“高脂血症”。经用自拟“十味降脂汤”加天麻 15 克、菊花 6 克、川芎 9 克,治疗一个月后,临床症状消失,血脂正常。胆固醇 5.10mmol/L,甘油三脂 1.22mmol/L。半年后复查,病情稳定,血脂均在正常范围内。

体 会

1、高脂血症是老年常见疾病之一。目前,随着人民生活水平的提高,年龄有逐渐趋向中年趋势,但仍以 50~60 岁者为最多。

2、高脂血症与动脉硬化的形成和发展有密切关系,因此,及时降低过高的血脂对于防治冠心病、粥样硬化症和脑血管意外等病有重要意义。综合其病因病机,中医认为多由于脏气虚衰,饮食不节,七情劳倦所伤而形成的正虚邪留的本虚标实证。在高脂血症的形成发展过程中,与脾、胃、肝、肾的关系尤为密切。脾胃功能失调,升降失司,痰浊内生,瘀血阻滞是其关键所在。方中以山楂、枳实、半夏消导利气化瘀逐痰;首乌、黄精、桑寄生滋补肝肾,并有较强的降血脂作用;丹参、当归、半夏养血活血、行瘀通脉;决明子清肝胆郁热,通畅腑道;大黄活血通便,清热解毒。诸药合用,具有消痰降浊,祛脂降压之功效。据现代药理研究也证实上述药物有降低血清胆固醇和血脂的作用,同时对减轻动脉粥样硬化、消除病灶、抑制胆固醇吸收也有一定的效果。

3、治疗期间,除服药外,生活调剂尤为重要。因此,治疗中必须强调保持心胸开朗,精神畅达,饮食力求清淡,切忌油腻肥厚和暴食狂欢。此外,应加强体育锻炼,以促进气血循环通畅,代谢旺盛。

4、本组治疗结果表明,本方治疗高脂血症具有疗程短,降脂作用明显,无副作用,有效率高的特点。因此值得临床推广应用。

(吴盛荣 整理)

益气通脉汤治疗冠心病心绞痛

冠心病心绞痛是内科临床常见病,多发于中老年。近年来有逐渐增高趋势,它严重地危害人民的健康。为了探索中医药治疗本病的有效方法,吴师自1994年以来,用自拟益气通脉汤治疗本病25例,取得了满意疗效。现总结如下。

一、临床资料

本组25例,男性15例,女性10例;年龄最小者45岁,最大者75岁,平均年龄55岁;病程最短者1个月,最长者15年;属初发型劳累性8例,稳定型劳累性者10例,恶化型劳累性者2例,自发性心绞痛5例。诊断标准根据1980年第一届全国内科学会议心血管会议修订的冠心病心绞痛的诊断标准为依据。

二、治疗方法

自拟益气通脉汤组成:

黄芪30克	党参15克	川芎12克
丹参15克	桂枝9克	威灵仙15克
红花6克	郁金9克	石菖蒲15克
当归9克	炙甘草6克	

胸痛甚加元胡9克、香附9克;心悸失眠加炒枣仁15克、远志6克;头晕加天麻12克、钩藤15克;阴虚加麦冬15克、五味子6

克；痰浊加陈皮 9 克、半夏 9 克；血脂高加草决明 15 克、山楂 30 克；腹胀纳差加厚朴 9 克、鸡内金 9 克

水煎服。每日 1 剂。心绞痛发作时临时口服消心痛，严重者加西药静脉滴注，一个月为一疗程。

三、治疗结果

1、临床显效：临床症状消失，心电图 ST—T 缺血型改变恢复正常或大致正常。

好转：临床症状明显改变，心电图 ST—T 缺血型改变好转。

无效：临床部份症状消失或无改变，心电图 ST—T 缺血型改变无好转，或虽有好转但反复或出现加重。

2、结果：服药 1 个月，显效 8 例，好转 14 例，无效 3 例，总有效率 88%。

四、典型病例

· 陈某，男，65 岁。1994 年 5 月 20 日初诊。

患者胸闷刺痛反复发作已五年余，曾在某医院检查：心电图提示：冠状动脉供血不足。诊断为冠心病心绞痛。多次服用中药汤剂及西药治疗，效果不明显，胸闷刺痛发作时，需含化硝酸甘油片才能缓解。1 周来因劳累、情绪不畅，胸闷刺痛加重，发作次数频繁，伴心悸气短，纳食减少，心烦不寐。查心电图提示：ST 段 $V_1V_2V_3$ 水平下移 $0.075\sim 0.12\text{mv}$ ，T 波 $V_1V_2V_3$ 倒置，T 波 $V_4V_5V_6$ 低平。符合冠心病恶化型劳累性心绞痛。刻诊：观其舌暗淡。边有瘀斑，苔白腻，脉沉细而结代。辨证属气虚血瘀，痰浊阻胸。治宜益气通脉为法。方用益气通脉汤加减：

黄芪 30 克 党参 15 克 川芎 12 克

丹参 15 克	桂枝 9 克	红花 6 克
石菖蒲 15 克	郁金 9 克	威灵仙 15 克
酸枣仁 15 克	远志 6 克	内金 9 克

水煎服。服药 3 剂,胸闷痛明显改善,复查心电图:ST 段 $V_1V_2V_3$ 水平下移 $\leq 0.05\text{mv}$, T 波 $V_1V_2V_3$ 低平, T 波 $V_4V_5V_6$ 直立。药已中病,仍守上方服 20 剂后,诸症悉除。心电图恢复正常。为巩固疗效,嘱继续守方治疗一个月,两天服 1 剂。随访半年,病情稳定,工作正常。

体 会

冠心病心绞痛属中医“胸痹”、“心痛”等范畴。其病因的发生与寒邪内侵,情志失调,饮食不节,年老体虚有关。其病机有虚实两方面,虚为心脾肝肾亏虚,功能失调;实为寒凝、气滞、血瘀、痰阻、痹遏胸阳,阻滞心脉。吴师根据临床体会,认为本病发生的根本原因是正气虚,病理关键是气滞血瘀,痰浊阻胸,心脉不畅所致。故治疗应从益气通阳,活血化瘀,化痰降浊,理气宽胸入手。益气为治本,活血降浊行气为治标,标本兼治,攻补同施。方中用黄芪补气为益气升阳之要药,合党参益气补心健脾,以达扶正固本作用;当归养血活血、补血生新;川芎、红花、丹参活血祛瘀,生血通络;郁金、石菖蒲开窍解郁,行气逐痰,通阳散结;威灵仙宣通五脏,行十二经、消痰破积;桂枝能壮心阳,通利血脉;炙甘草既可补气,又可调和诸药。诸药合用,使心气足,血脉充,瘀血除,胸痹得愈矣。

(周建宣 整理)

三伏灸综合疗法治疗慢性支气管 炎、支气管哮喘的临床观察

我国慢性支气管炎(慢支),支气管哮喘(支哮)的发病率均达2~3%,慢支50岁以上发病率高达10~15%,根据中医理论,“冬病夏治”,治疗慢支、支哮的总结甚多。为进一步提高临床疗效,吴师选择夏季初、中、末伏三个庚日,以穴位艾炷灸法(三伏灸)为主,配合穴位中药敷贴(药贴),内服中药,三法一体进行综合治疗,收获甚满意。现总结如下:

一、临床资料

本组63例慢支、支哮患者按文献诊断标准确诊。分布为慢支42例,其中急性发作期(急发)25例。慢性迁延期(慢迁)17例。支哮急性发作期(急发)21例。性别分布:男女之比约为1:1(31/32);年龄分布:16~40岁36人(57.14%),40~60岁15人(23.81%),大于60岁12人(19.05%);病程分布:发病持续1~5年18人,超过5年者45人,长期反复发病为主。地理分布:沿海居民与山区居民进入本研究组比为:1:9.6(5/48);山区患者明显大于沿海地域。患者临床辨证,分型:采用固定医师,按寒热标准进行辨证。寒证患者51人,热证患者12人。寒证喘息者为主。

二、治疗方法

1. 穴位隔药灸。(1)取穴:双侧是太阳膀胱经的肺俞、脾俞、肾俞、膏盲穴。督脉的大椎穴。奇穴的喘息穴。(2)隔药灸的药物组成:

白芥子 30 克	元胡 30 克	麻黄 30 克
甘遂 30 克	冰片 15 克	白芷 15 克
粘香 15 克	皂角 15 克	细辛 15 克

上药研末姜汁和为泥构成。(3)灸以补法,无瘢痕,间接法,连灸 3 壮,灸后局部炎热、充血、红晕,表皮与真皮分离之感为宜。

2. 穴位敷贴。(1)取穴:任脉的天突穴。(2)敷贴药组成:公丁香、木鳖子各 1.5 克。研成粉,姜汁合为泥。(3)每次灸后穴贴 12 小时。

3. 中药内服。每次灸后继服煎剂 5 剂,日 1 剂,共 15 剂。寒证患者以射干麻黄汤为主加减,热证患者以定喘汤为主加减。灸后蛤蚧研末冲服 1 对,连服 3 对。

三、观察方法

1. 临床疗效观察:(1)疗效标准:慢支以文献标准,急发及慢迁型均分为临床控制(临控)显效,无效 3 个级别,支哮按文献也分为临控,显效,无效 3 个级别。(2)观察时间:急发期观察时间一个月;慢迁期为一年。

2. 实验室指标观察:慢支及支哮急发型 35 例测定疗程前后(1 个月)的血清免疫球蛋白,(Ig)G、A、M(单向免疫扩散法)值,并做配对 t 检验统计处理。C-反应蛋白(C-RP)定性试验及周围血像值,嗜酸性细胞绝对计数。

四、结 果

1、临床疗效：

慢支及支哮急发期与慢支慢迁期的临床疗效见表一所示。前者总有效率为 86.96%，后者为 94.12%。卡方检测，两组疗效无显著性差异。故本法的短期(1 个月)与长期(1 年)疗效基本相同。辨证分型，寒、热喘证之间的疗效亦未见明显差异($X^2=2.82; P>0.05$)。

表一，慢支支哮急发期与慢支慢迁期疗效比较〔例 (%)〕

支哮慢支急发期与慢支慢延期疗效结果

表一

〔例 (%)〕

组 别	例数	临控	显效	无效	总有效率
急发期	42	22 (47.83)	18 (39.13)	6 (13.04)	△ 86.96
慢迁期	17	10 (58.83)	6 (35.29)	1 (5.88)	94.12

△两组疗效比较 $P>0.05$

2、实验室指标情况：

①慢支支哮急发期 35 例治疗前后血清 IgG、A、M 数据变化如表二所示。IgG 治后数值增高有显著意义($t=2.547; P<0.05$)。IgM 升高亦有显著意义($t=2.111; P<0.05$)。IgA 变化无显著意义。

表二慢支支哮急发期患者治疗前后对部份体液免疫值的影响
($\bar{X} \pm s, g/l$, 下同)

急发期患者治疗前后对部份体液免疫数值的影响

表二

($\bar{X} \pm S$, g/L, 下同)

	例数	IgG	IgA	IgM
治疗前	35	15.73 ± 2.02	3.53 ± 0.85	1.33 ± 0.26
治疗后	35	16.68 ± 1.26	3.49 ± 0.28	13.9 ± 0.11
P		<0.05	>0.05	<0.05

②慢支支哮急发期 35 例中,嗜酸细胞绝对计数,患者 68.8% (24/35) 大于正常值。白细胞计数大于正常值上限者 40.0% (14/35); 分类中,中性比例大于正常上限占 20.8% (8/35)。C- RP 阳性者占 25.31 (6/35)。

讨 论

冬病夏治的三伏灸综合疗法是根据慢支、支哮冬春季多发病设立,符合《内经》“不治已病治未病”的原则。本组临床资料具如下特征:病程长的成年人为主,辨证寒证病人占多数,慢支病者占多数,临床感染周围血象等指标不明显者占多数。上述特征基本符合近年文献报导的喘息病患者的群体分布特征。本法治疗的临床疗效较满意,因而值得进一步研讨、简化、推广。

本法治疗的作用机理,应该包括如下几方面:

1、灸法中,《本草正》指出:“艾叶具温中,行血中之气”作用。取穴中吴师主要集中在阳经取之,配以具“阳脉之海”的督脉及“阴脉之海”的任脉取穴。隔贴药亦以温热药为组成,共起鼓舞阳气温经通络,行气活血效应。

2、口服药以辨证给药为基础加服蛤蚧粉。以提高本疗法的临

床疗效。

3、喘息病机理研究证明温热,活血化瘀药,有改善血小板功能作用,从而中断变态及释放异常。

4、本组 68.8% 患者嗜酸细胞直接计数值增高。西欧及我国的临床资料均说明 60~70% 的喘息者与整体或气道超敏状态相关。本疗法治后,患者 IgG、M 值增高有显著意义。IgG 能固定补体、本身就是有效的调理素,具封闭抗体作用。可干扰抗原与 IgE 结合,使 I 型超敏反应脱敏。IgM 可帮助网状内皮系统清除血清中的细菌及颗粒。因而本疗法与提高机内环境稳态,减少对刺激原应激的超敏有关。

(周建宣 整理)

● 原载于《泉州中医》,总第 20 期。

疏风定喘汤治疗过敏性哮喘

笔者运用吴师自拟方“疏风定喘汤”治疗过敏性哮喘 35 例,取得较好的疗效。现简介如下:

一、药物组成

麻黄 6 克	杏仁 9 克	荆芥 9 克
薄荷 6 克	防风 9 克	地龙 6 克
蝉衣 6 克	僵蚕 9 克	苏子 9 克
乌梅 6 克	甘草 6 克	

水煎服。每日 1 剂,早晚分服。

随症加减:若有热象加黄芩、鱼腥草;鼻痒多嚏加苍耳子、辛夷花;咯痰不畅或胶结成块者加桔梗、冬瓜仁;干咳无痰加百合、冬花;痰稠不畅加象贝母、瓜蒌皮;痰液清稀色白带有泡沫,形寒肢冷者加干姜、桂枝;胸闷加枳壳、郁金;泛恶加半夏、竹茹;气虚加太子参、党参;阴虚加北沙参、麦冬、知母;瘀血加丹参、红花、苏木。

二、病 例

吴×,男,35 岁。1992 年 5 月 18 日初诊。

患者有哮喘史已将 10 年,每入秋冬季发作频繁,发则昼轻夜重,不能平卧,随即自服安茶碱以平喘,虽暂时可以缓解,但反复发作,现已加重一星期。症见鼻痒,多嚏,喘息气促,咳痰不多伴有胸

闷气促，喉间有哮鸣声，舌质暗淡、苔薄黄，脉弦细。检查：双肺呼吸音粗，布满哮鸣音。此乃风寒犯肺、肺气壅塞、肺失宣肃所致。方用疏风定喘汤加减：

麻黄 6 克	杏仁 9 克	荆芥 9 克
薄荷 6 克	防风 9 克	蝉衣 6 克
乌梅 6 克	僵蚕 9 克	苏子 9 克
地龙 6 克	黄芩 9 克	苍耳子 9 克
辛夷花 9 克	甘草 6 克	

水煎服。服 3 剂后，气喘渐平，咳嗽减少，已能平卧，仍宗上方续服 3 剂，喘平，哮鸣音消失，诸症痊愈。

体 会

过敏性哮喘起病急，变化迅速，其临床主要表现为突然作喘，多嚏，鼻痒，眼痒，皮肤痒，咽痒等。与风邪的致病特点有密切相关。根据发病先兆和伴随的过敏表现，故临床着重于“疏风”为治疗原则。自拟疏风定喘汤以疏散风邪，宣肺化痰，止咳平喘。方中由疏风宣表达邪和虫类搜风通络之品组成，共奏风熄浪平，喘定咳止之效。根据现代药理研究，大多疏风药具有抗过敏的作用，可降低机体对过敏原的敏感性，缓解支气管的痉挛，对提高机体免疫功能也有一定的疗效。但疏风药辛散发散，虫类药又有走窜之性，只可短期应用，症消即止，不可久服，以免劫阴耗液。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《疑难杂症治验》，中国医药科技出版社出版，1995 年第 1 版。

活血祛瘀汤治疗肋间神经痛

肋间神经痛是临床上的常见病之一，属于祖国医学“胁痛”、“腹痛”之范畴。吴师近一年来运用自拟“活血祛瘀汤”治疗本病 60 例，取得较显著疗效。现总结如下：

一、临床资料

本组 60 例，其中男性 45 例，女性 15 例；发病年龄最大 52 岁，最小 20 岁，平均年龄为 35 岁；发病部位多在前胸部，无固定的痛点，有反复发作特点，且疼痛剧烈；病程，自发病起至来就诊，时间最短的 2 天，最长者 15 年以上。

二、治疗方法

活血祛瘀汤组成：

柴胡 9 克	川楝 12 克	丹参 9 克
赤芍 15 克	泽兰 9 克	地龙 6 克
穿山甲 9 克	制乳香 6 克	制没药 6 克
甘草 9 克		

水煎服。每日 1 剂。随证加减：肝气郁结者加青皮 9 克、香附 9 克、郁金 9 克；肝阴不足者加生地 15 克、白芍 10 克；瘀血重者加桃仁 9 克、红花 6 克；大便秘结者加大黄 10 克、元明粉 6 克。

三、治疗结果

治愈(肋间疼痛消失,症状缓解,随访一年未复发)32例;显效(肋间疼痛基本消失,症状缓解,一年内反复发作2~3次,经治疗好转)25例;无效(经治疗未见明显好转)3例;总有效率为95%。

四、典型病例

李某,男,45岁,工人。右侧胁肋部疼痛间发已将3年余,曾在某院治疗,诊为肋间神经痛。本次起病已5天,肋间持续疼痛如针刺,并引背胀。5~6肋间压痛明显,痛处固定不移,曾服西药止痛片未见明显好转,而求治于中医。诊见:患者痛苦病容,面色无华,伴有胸闷不舒,脉弦,舌质淡红,舌边有紫斑。证属肝气郁滞,瘀血阻络。治以活血祛瘀汤加郁金9克、香附9克、青皮9克。服药3剂,疼痛明显减轻;继服5剂,肋间疼痛缓解,诸症消失。随访1年未见复发。

体 会

肋间神经痛多与肝经疾患有关,因肝居胁下,其经脉布于两胁,故肝脏受病,往往出现肋间疼痛一症。如《灵枢·五邪篇》中载:“邪在肝,则两胁中痛”。根据临床体征与症状,究其病机一般均因情志不畅,气机郁结而成胁肋疼痛。若气郁日久,则导致气滞血凝,瘀血停积,阻塞胁络,则使胁肋疼痛加剧。故吴师自拟活血祛瘀汤以活血祛瘀为主,兼以疏肝行气通络为组方原则。方中以丹参、赤芍、泽兰、乳香、没药活血祛瘀止痛;穿山甲、地龙长于走窜,通经达络,行血散瘀;柴胡、川楝解肝胆之郁结,理气止痛;甘草缓急止痛,

调和诸药。诸药合用,俾使瘀去、气行、络通,则胁肋疼痛自平。

(吴盛荣 整理)

● 本文 1995 年 12 月荣获全国基层医药优秀论文。

治疗胃脘痛经验总结

吴师业医迄今已 50 余年,擅治内科杂病,尤以治疗胃脘痛见长,余随师继承,获益良多。现将老师近 2 年来运用家传秘方“胃宝”治疗胃脘痛 150 例,临床总结如下,以飨同道。

一、临床资料

本组病例,均为门诊病例,其中男性 95 例,女性 55 例。年龄最大者 65 岁,最小者 15 岁。病程最短为 1 年,最长为 20 年,以 3~5 年为多。全部病例,均经钡餐透视或胃镜检查确诊。其中胃溃疡 48 例,十二指肠球部溃疡 52 例,慢性浅表性胃炎 28 例,慢性萎缩性胃炎 10 例,复合性溃疡 12 例。临床主要症状,大多具有不同程度的胃脘疼痛,喜温喜按,食后腹胀,及食后痛减,神疲肢倦,反酸呃逆,暖气,大便溏或结,舌质淡红或有齿印,苔薄白,脉沉细或弦细。

二、方剂组成及用法

组成:

公丁香 3 克	川椒 6 克	木香 9 克
沉香 6 克	血蚶 10 粒(煨)	延胡索 9 克
五灵脂 9 克	砂仁 6 克	白豆蔻 6 克
白术 9 克	大黄 15 克	白芍 15 克
何首乌 12 克		

上药晒干,各味另研,用200目筛斗筛过,然后混合收贮备用。

用法:1日3次,早、中、晚空腹时服。新痛每次用6克,盐开水调服;久痛用9克,老酒调服(如不敢服老酒用开水也可),为避免复发,应连续服用1个月或2个月,病情复杂者坚持3个月以上。服药期间停止使用其它胃药。忌食生冷以及辛辣刺激性食物。

三、疗效判定标准及结果

痊愈:服药2个月后,症状、体征均消失,胃镜复查溃疡面愈合者。好转:症状和体征明显减轻或消失,胃镜复查溃疡面有明显缩小。无效:症状和体征无改善者。

治疗结果:本组150例,痊愈115例,好转29例,无效6例。总有效率为96%。

四、病案举例

黄某,男,35岁,工人。

患者有胃病史已15年,伴有反酸、暖气及胃脘部灼热感,曾服多种治胃病药无效。经胃镜检查诊断为胃及十二指肠球部溃疡,欲作手术治疗,后因住院困难加上患者畏惧手术,而来我院求诊。刻诊:胃脘疼痛,饥则尤甚,得食则舒,多食则腹胀暖气,喜按喜热饮,舌苔薄白,舌质淡红,舌边有齿印,脉细弦。方用“胃宝”治之,服药第3天即显著止痛,2周后疼痛消失,临床其他症状均明显减轻,劳动有劲。为巩固疗效,嘱继服2周后,诸症痊愈。胃镜复查炎症消失,溃疡面已愈合。经随访,身体健康,未再复发。

体 会

胃脘痛是临床最常见的疾病之一。病程长,反复发作,并发症又多,对人民健康危害极大。“胃宝”系吴老祖先历代临床应用,疗效显著,秘而不传。吴老本人临床50余年屡试屡验,不仅对缓解症状满意,而且对溃疡面的恢复愈合有良好促进作用。方中公丁香、川椒温中散寒;沉香、木香、延胡索、五灵脂理气化瘀;白术、砂仁、白豆蔻健脾和胃;再益以大黄推陈致新,通利水谷,调中化食,安和五脏;血虻治积年胃脘瘀血疼痛;白芍养阴和营,益气止痛;首乌补血能治腹脏一切痼疾。诸药相伍,中的病机,故对远近之胃、十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性萎缩性胃炎以及复合性溃疡者,均有良好的效果。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《吉林中医药》杂志,1994年第2期。

疏肝和胃汤治疗慢性胃炎

慢性胃炎是一种病势缠绵的常见病、多发病,西药疗效不甚满意。吴师自 1989 年 10 月至 1992 年 10 月采用自拟“疏肝和胃汤”治疗慢性胃炎 84 例,获得较好的效果。兹介绍如下:

一、临床资料

1、一般资料:本组 84 例中,男性 39 例,女性 45 例;年龄:20 岁以下 5 例,20~30 岁 24 例,31~50 岁 45 例,50 岁以上 10 例。病程最短半年,最长 15 年。平均 6 年。大部份病例均经多种西药治疗效果不佳而改用中药。

2、临床表现:主要表现为胃脘部疼痛、胀满或灼痛伴有口苦、暖气、嘈杂、大多伴有食欲不振,乏力、大便干或便溏。舌质红、苔薄白,脉弦或弦数。

3、诊断依据:全部病例治疗前均经纤维胃镜或者 X 线钡餐透视确诊。其中慢性浅表性胃炎 58 例,慢性萎缩性胃炎 26 例。

二、治疗方法

自拟“疏肝和胃汤”组成:

柴胡 9 克	杭芍 15 克	枳壳 9 克
白术 12 克	陈皮 9 克	半夏 9 克
郁金 9 克	元胡 9 克	山楂 12 克

川连 6 克 甘草 6 克

水煎服。每日 1 剂，分 2 次服。

加减法：脾虚甚者加党参、茯苓；胃阴不足去郁金加麦冬、石斛；呕吐酸水加乌贼骨、白蔻；黑便出血加白芨；便秘加大黄。治疗时间 30 天为一疗程，疗程结束后复查胃镜。

三、疗效标准

显效：症状和体征完全消失，胃镜复查粘膜炎症消失。

好转：自觉症状和体征消失，胃镜复查粘膜炎症减少。

无效：自觉症状无改善，甚至加重。

四、治疗结果

84 例中痊愈 55 例占 65.4%；有效 24 例占 28.5%；无效 5 例占 6.1%，总有效率 93.9%。

五、典型病例

陈某，男，48 岁。1991 年 7 月 15 日初诊。

自诉胃脘部胀满伴有时烧心反酸已将 10 年史，经某医院胃镜检查确诊为“慢性胃炎”。服用“维酶素及乐得胃”等药治疗，效果不显，症状反复发作。近 1 年来因工作不顺出现胃脘胀痛、连及两胁，时有嗳气，呕恶、口干、便秘，舌质红、苔薄白，脉弦细。综观脉证，证属肝气郁结，横逆犯胃；治宜疏肝和胃，理气止痛之法。方用自拟方加白蔻、大黄，每日 1 剂。服药 5 剂后，胃脘部胀痛，嗳气均减轻，大便通，惟感口干，纳差。按前方去大黄、郁金加麦冬、石斛以养胃阴而生津，连服 15 剂，症状消失，续服 5 剂巩固疗效。后经胃镜检查

恢复正常,随访2年,诸症悉平。

体 会

慢性胃炎是以上腹部胀痛或不适为主症,常伴有嗝气、泛酸、嘈杂、食欲不振等症。属于祖国医学“胃脘痛”、“肝胃气痛”、“胃痞”等范畴。其病位在中焦脾胃。本病病机多由忧思郁怒,肝木横逆犯胃或饮食劳倦、损伤脾胃之气所致。如《素问·六元正纪大论》说:“木郁之发,民病胃脘当心而痛,上支两胁,膈咽不通,食欲不下”。《素问·至真要大论》说:“厥阴司天,风淫所胜,民病胃脘当心而痛”。说明胃病与木气偏胜,肝胃失和有关。故治疗上以疏肝理气和胃之法为基本大法。方中柴胡、枳壳、陈皮疏肝理气解郁;白芍、甘草酸甘化阴,缓急止痛;郁金、元胡活血止痛;半夏、川连辛开苦降,一寒一温,能泻肝、降胆、止呕;白术、山楂健脾和胃。综观全方,共奏疏肝理气,健脾和胃之功,故收获满意。

吴师治疗慢性胃炎有多年实践经验,除正常服药外,还必须向患者宣传加强饮食管理,勿食生、冷、粗、硬、辛、辣食物,尤其要忌高度酒。饮食应宜清淡,易消化,有营养的食物。这样相辅相成,可以帮助治疗,提高疗效。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《顽痼杂病症治秘要》,亚洲出版社出版,1993年第1版。

温胆和胃汤治疗胆汁返流性胃炎

胆汁返流性胃炎是胃镜发现的一种征象,可因原发性或继发性幽门功能紊乱引起的胆汁或碱性肠液返流入胃,使胃粘膜呈慢性炎症,目前尚无理想的治疗方法。吴师近年来运用自拟“温胆和胃汤”治疗 45 例,取得一定的疗效。现小结如下:

一、临床资料

患者 45 例,男 31 例,女 14 例。年龄最小 20 岁,最大 52 岁,平均年龄 35 岁。病程最短为 2 个月,最长为 10 年。本组病例均有慢性胃病史或脘腹痞满、嘈杂暖气,泛酸、恶心或呕吐、口苦纳呆、胃脘部压痛,舌质淡红或绛红、苔白腻,脉弦细或弦缓者居多。经纤维胃镜检查有明显胆汁反流,病理活检证实为慢性胃炎。

二、治疗方法

本组病例治疗均用自拟“温胆和胃汤”为基础方(陈皮 10 克,半夏 10 克,茯苓 12 克,枳实 12 克,黄芩 9 克,竹茹 9 克,甘草 6 克)。

加减法:胃脘痛甚者加元胡、五灵脂;腹胀者加川朴、莱菔子;呕吐者加代赭石,旋复花;泛酸者加海螵蛸,瓦楞子;暖气者加香附,苏梗;湿重者加苍术、白蔻仁;胃寒者加吴茱萸;脾虚者加党参,白术;胃阴亏者加白芍,乌梅;纳呆者加神曲、山楂。

水煎服。每日1剂,分2次服,连服15天为一疗程。疗程结束复查胃镜以评定疗效。

三、治疗结果

疗效标准:自觉症状消失或显著改善,胃镜检查未见胆汁返流或明显减少为显效。自觉症状基本消失或明显改善,胃镜检查:胆汁返流减少为好转。虽有症状改善或自觉症状无好转,胃镜检查:胆汁返流无变化,为无效。本组45例中,显效32例,好转11例,无效2例,有效率为95.5%。

按 胆汁返流性胃炎的临床表现与祖国医学的“呕胆”颇为符合。《灵枢·四时气论》曰:“善呕、呕有苦……邪在胆,逆在胃,胆液泄则口苦,胃气逆则呕苦,故曰呕胆。”胆汁以通为用,以降为顺。“肝赖脾气,胆从胃降”,若因情志郁结,饮食劳倦,损伤脾胃,使脾气不升,胃气不降,肝气失疏,胆气不降,上逆犯胃。因此治当和胃,调气机,降逆气,清痰热之法。方中用二陈汤祛湿化痰,和胃降逆。黄芩、枳实、竹茹清胆胃之热,降胆胃之逆,从而使逆乱气机升降复常,清升浊降胆胃通调,则病症自除。

(吴盛荣 整理)

- 本文1991年12月荣获《时珍杯》全国医药学术论文大奖赛三等奖。

绿豆羊肉汤治疗复发性口疮

我院于 1980 年 5 月至 1983 年 12 月用自拟的绿豆羊肉汤治疗复发性口疮多例,均取得较好效果。

典型病例

例一 林××,女性,38 岁,南安县东田中心小学教师。1980 年 5 月 21 日初诊。

复发性口疮愈而复发已 20 多年,患部呈烧灼样疼痛,特别是说话、吃饭、咀嚼时疼痛更甚,接触酸、咸食物刺激则疼痛难忍,每于失眠或教学紧张时而加重。曾经多方求医,屡服西药及清心导热、滋阴降火的中药均未获效。现由于病程长,体质衰。证见纳呆食少,头晕目眩时作,神倦懒言,面色少华。诊其脉沉缓而弱,唇口淡,苔少,口唇内侧上下粘膜可见圆形及椭圆形的溃疡点 4 个,小的直径约 1.5 毫米,大的 3 毫米左右,边缘整齐,溃疡面平坦,覆有微黄色或灰白色的一层,周围有红晕。证属脾阳虚衰为本,内蕴毒热之邪为标;治宜温阳健脾,佐以甘寒解毒。方用绿豆羊肉汤治之。

羊肉 120 克、绿豆 30 克、生姜 5 克、大枣 10 粒,加水适量炖烂取服,每日 1 剂,嘱服 3 剂。

6 月 10 日患者因肾炎来我院治疗,顺谈其复发性口疮,服上方 3 剂后,药对证,效如神,为巩固疗效,自己连进 5 剂而告痊。最近随访,自诉偶有复发仍以原方治之,随即消失。

例二 陈××,男性,46 岁,南安县检察院干部。1982 年 11 月

7日初诊。

患者自1969年以来,复发性口疮反复发作,经多方治疗未获效,患部灼热刺痛,尤以说话饮食为甚,有时则不敢进食。每于工作劳累或失眠而诱发或加重病情。此次发作已达一周余,现神疲懒言,纳呆食少,面色㿔白,脉沉迟,舌质淡胖,苔薄白,舌中微黄,下唇内侧粘膜有黄豆大的溃疡点3个。证属脾阳不足,内蕴热毒之邪;治宜温养脾土为主,佐以甘寒解毒。方用绿豆羊肉汤治之。

处方:羊肉120克、绿豆30克、生姜5片、大枣10枚,加水炖烂取服,日服一次,病愈停服。

11月15日复诊:患者谓:服上药先后六次,症愈未见复作。遂嘱停药观察。

1984年4月3日,因感冒来诊,告曰:口疮经治疗后至今未见复发。

讨论及体会

1、复发性口疮是一种常见口腔病。《圣济总录》指出:“胃气弱,谷气少,虚阳上发而为口疮”,《疡医大全》谓:“口疮因胃虚谷少”;是引起本病的原因,至于在治疗上,朱丹溪说:“口疮服凉药不愈者,因中土虚”;明清医学家如张景岳,龚廷贤,喻嘉言,沈金鳌等对口疮服凉药无效,应用甘温治法取效的记载也屡见不鲜;薛立斋医案选录口疮治验十三例,其中所用药均偏于甘温,慎于苦寒。

2、笔者在临床实践中,认为脾胃之虚愈甚,则口疮愈易发作,病程愈长,消烁阴津则愈厉害。故体内必蕴积热毒之邪,这是本病的关键所在。但其本在于虚,其标在于热毒之邪。故脏腑病变为本,局部病变是标。根据治病必求于本的原则,在治疗上以甘温调补脾胃为主,辅以甘寒清泄热毒之邪,方用自拟绿豆羊肉汤治之。其用意为羊肉系血肉有情之品,以形补形,气味甘温,专入脾。即《内

经》所谓“形不足者，温之以气，精不足者，补之以味”；生姜温中散寒；大枣为安中之药，以增强补益脾胃之功。盖脾胃为“后天之本，营血化生之源”，脾虚得治，则诸虚俱愈矣。绿豆取其甘寒，既资脾胃又能解久病内蕴热毒之邪。合而用之，而收全功。

3、本方系以药物和营养食物相配合的别开生面的扶正驱邪治法，具有调节机体功能增强抗病能力的作用。临床使用以来，未见弊端。

本证以老年人及妇女为多，这与体质虚衰及家务操劳过度可能有关。在临床观察中，本病的患者常因过度疲乏，睡眠不足而诱发，故在日常生活中应注意劳逸结合。

● 原载于《福建中医药》，1985年第2期。

灭滴汤治疗滴虫性肠炎

吴师自拟的“灭滴汤”治疗滴虫性肠炎 25 例,获得满意的疗效。现简介如下:

一、一般资料

25 例均为门诊病例,其中男性 12 例,女性 13 例。8~10 岁 12 例,10~14 岁 10 例,14 岁以上者 3 例。病程最短为 5 天,最长为 11 天,平均为 6 天。

二、治疗方法

基本方:

木香 6 克	槟榔 6 克	百部 6 克
甘草 6 克	苦参根 9 克	石榴皮 9 克
乌梅 3 克		

加减法:肠胃湿热者加葛根、黄芩、藿香、车前子;湿盛困脾者加苍术、白术、苡仁、陈皮;脾胃虚弱者加茯苓、淮山、莲肉、砂仁等。

用法:每日 1 剂,水煎取汁,早晚分服。5 天为一疗程,疗程间休息 3 天,再进入下个疗程,一般一至二疗程,即可痊愈。以上为 10 岁左右儿童剂量,临床时可根据具体情况增减。

三、治疗结果

治疗 25 例,均获痊愈,服 5 剂而愈者 15 例;服 8 剂而愈者 7 例;服 10 剂而愈者 3 例。

四、病例介绍

王××,男,10 岁。1989 年 10 月 5 日初诊。腹痛已一个多月,经常反复发作,近 7~8 天来加剧,伴有腹泻,大便黄色稀溏,有时带有浓血粘液便,1 日 5~6 次。舌质淡红、苔薄黄,脉弦数。大便化验满视野见肠滴虫。

处方:

木香 6 克	槟榔 9 克	苦参根 9 克
黄芩 9 克	葛根 9 克	石榴皮 9 克
茯苓 9 克	陈皮 6 克	白术 9 克
莲肉 9 克	乌梅 3 克	百部 6 克

5 剂,每日 1 剂,早晚分服。服药 5 剂后,腹痛、腹泻止,诸症消失。大便化验检查一切正常。

按 滴虫性肠炎,是农村常见肠道传染病,以小儿为多见,属祖国医学“虫泻”之范畴。临床主要表现为腹痛,反复发作伴腹泻。大便化验有肠滴虫。治疗时若忽视肠滴虫的存在,单用清热利湿之剂,往往徒劳无功。故本方治疗时以灭虫为主,清热利湿为辅。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《东方医药杂志》,1992 年第 5 卷第 4 期。

舒肝利胆汤治疗胆囊炎

现将老师 1990 年 5 月～1993 年 12 月运用舒肝利胆汤治疗胆囊炎 225 例总结如下。

一、临床资料

本组 225 例中,男性 95 例,女性 130 例;发病年龄最小者 15 岁,最大者 68 岁,其中 30～50 岁为多见;病程最短者 5 天,最长者 2 年;疗程最短者 8 天,最长者 25 天。临床表现主要有右上腹部持续性疼痛,阵发性加剧,并向右肩背放射,伴口苦咽干,纳呆,或有不同程度的发热、畏寒、恶心呕吐,部份病例出现黄疸。体检:右上腹腹肌紧张,胆囊区压痛,个别病例可触及肿大的胆囊,脉象多为弦滑或弦数,舌质红、苔黄腻。B 超检查均提示:胆囊增大,胆壁增厚,胆囊收缩功能减弱,部份病例伴有结石。

二、治疗方法

舒肝利胆汤组成:

金钱草 15 克	赤芍 15 克	苡仁 15 克
茵陈 15 克	大黄 12 克	白术 12 克
川楝 12 克	柴胡 9 克	蒲黄 9 克
五灵脂 9 克	黄芩 9 克	鸡内金 9 克
枳壳 9 克	青皮 9 克	木香 6 克(后下)

胆草 6 克 元明粉 6 克(另冲)

每日 1 剂。水煎 2 次分服。

加减用药:若身热口渴者,加银花、连翘、石膏、天花粉;湿重者增加苡仁、白术之量;腹痛甚者,加重元胡之量;恶心呕吐者,加半夏、竹茹、生姜;纳差者,加神曲、山楂;黄疸甚者,加重茵陈、金钱草、生大黄之量;有胆石者,加重鸡内金之量,再加冬葵子、急性子、王不留行;有蛔虫者,加槟榔、使君子。

三、治疗结果

临床治愈(症状和体征完全消失,B 超复查胆囊大小正常,胆囊收缩功能恢复正常者)170 例;好转(症状和体征基本消失,B 超复查胆囊收缩功能改善者)48 例;无效(症状和体征无改善者)7 例。总有效率为 96.8%。

四、病案举例

刘某,女,35 岁,农民。1992 年 12 月 3 日初诊。

患者右上腹部经常疼痛已近 3 个月,伴有低烧 37.5℃左右,纳差、厌油腻、恶心,大便 2 天~3 天 1 次。患病后按胃痛治疗,服中药 10 余剂,未见明显效果,求诊于吴老。诊时右上腹疼痛,时而加剧,痛引肩背,伴有畏冷发热、呕吐胃内容物及黄水,口苦咽干,脉弦滑数。舌质红、苔厚黄。体验:体温 37.8℃,右上腹腹肌紧张,胆囊区压痛(+),肝脾未触及。B 超提示:胆囊壁厚 0.5cm,未见明显强点回声。诊断为胆囊炎。证属肝胆湿热型,治宜疏肝利胆、清利湿热。方用舒肝利胆汤加竹茹 9 克,半夏 9 克,生姜 3 片,每日 1 剂。服上方 3 剂后,诸症减轻。药已中病,再守原方,继服 6 剂,低烧亦除,不再厌油腻,食欲大增。1 个月后,患者因其他事来院,顺

告曰:服上方9剂,诸症消失,一切正常。为慎重起见,嘱再行B超检查,胆囊壁未见增厚。

体 会

吴老认为胆囊炎的病位在胆,主要病理变为肝胆气滞、湿热蕴结。虽然涉及肝胆脾胃等脏器,但以肝胆为主,故吴老在治则上着重以疏肝利胆、清利湿热为法。

舒肝利胆汤系吴老临床50余年之经验方,不仅可治疗急慢性胆囊炎,而且凡是由于肝胆湿热、气滞瘀结而致的急性黄疸型肝炎、胆石症以及胰腺炎等用之均收到显著之疗效。方中柴胡、枳壳、青皮、木香、川楝、疏肝理气,解肝胆之郁,最能条畅肝木,推陈致新以生气血,有助于肝胆功能的改善;蒲黄、五灵脂、赤芍理气行血而止痛,可明显缓解平滑肌痉挛,为痛引肩背必用之要药;金钱草、茵陈、黄芩、胆草能增加胆汁分泌,为利胆退黄之圣药,尤其是茵陈能消除残存肝胆之病毒,改善消化功能;大黄、元明粉荡除积秽、清热利湿、活血化瘀;鸡内金消石顾护脾胃;苡仁、白术补脾利湿,增进食欲,且能产生肝糖元,提高机体抗病能力,与苦寒之剂配伍,可免害胃之弊。诸药合用,使肝气疏、湿热去,则病自愈。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《湖北中医杂志》,1995年第1期。

运用活血化瘀法治疗胆石症

胆石症是临床上常见病、多发病。虽然新的治疗方法和药物不断问世,但治疗上的困难依然存在。老中医专家吴光烈主任医师,从事临床工作 50 余年,造诣颇深,擅治内科杂症,尤以治疗胆石症见长。现将老师近年来运用活血化瘀法治疗的胆石症 96 例,总结如下:

一、临床资料

本组 96 例均为门诊病人,男性 42 例,女性 54 例;年龄最小 18 岁,最大 65 岁,平均 40 岁;病程最短为 1 个月,最长为 15 年。其中胆囊结石 45 例,胆总管结石 28 例,肝内胆管结石 23 例。临床表现均具有不同程度的右上腹或上腹部疼痛,时轻时重,并痛引肩背,腹胀便秘,口苦纳呆,厌油恶心,上腹部压痛,舌质红、苔黄,脉弦,或有皮肤、巩膜黄染等。

二、治疗方法

方药组成:

金钱草 30 克	海金沙 15 克	鸡内金 9 克
柴胡 9 克	陈皮 9 克	青皮 9 克
当归 9 克	桃仁 12 克	郁金 9 克
赤芍 15 克	三棱 12 克	莪术 12 克

大黄 15 克(后下) 王不留行 30 克

水煎服。每日 1 剂,15 天为 1 疗程。

加减法:恶心呕吐者加代赭石 30 克,半夏 9 克;发热者加银花 12 克,蒲公英 15 克;胁痛明显者加元胡 10 克,川楝子 10 克;腹胀甚者加大腹皮 15 克,川朴 10 克;气虚者加黄芪 15 克,党参 15 克。

三、疗效观察

1、疗效标准:痊愈:临床症状及体征全部消失,B 超检查结石全部排出者。好转:临床症状及体征减轻,B 超检查结石有部份排出或结石缩小,未排出者。无效:治疗后症状、体征及结石状况无变化者。

2、治疗结果:治疗 96 例,治愈 64 例,好转 26 例,无效 6 例,总有效率为 93.75%。服药时间最长为 3 个月,最短为 10 天。

四、典型病例

洪某,男,35 岁。1992 年 11 月 2 日初诊。

患者阵发性右上腹痛已 4 年,今早突然右上腹绞痛,并向右肩背放射,恶心呕吐,伴有脘腹胀闷,进食油腻食物尤甚,小便黄,脉弦。查体:体温 36.9℃,血压 17/12kPa,神志清楚,急性痛苦面容,皮肤巩膜轻度黄染。腹肌稍紧张,右上腹明显压痛,肝脾未触及,双肺呼吸音清,未闻及干湿罗音。B 超提示:胆囊内多发性结石,最大约 0.8×1.0 厘米。经用上方治疗 15 剂后,症状、体征全部消失,B 超复查:未见结石。随访半年,未复发。为巩固疗效,嗣后嘱患者用金钱草 30 克,王不留行 30 克,大枣 10 枚,水煎代茶常服。

体 会

1、胆石症为急腹症之一,属于祖国医学的“黄疸”、“胁痛”、“胆痹”等范畴。其发病因素多由饮食不节、情志失调、外邪侵袭或蛔虫上扰等导致肝胆疏泄功能失常,以致气血郁滞,胆道瘀阻,湿热久羁,胆液受其煎熬,日久沉积,结为砂石。

2、吴老认为血瘀是本病的关键,根据“久病入络”、“久病必瘀”之理论,以活血化瘀为治疗原则。活血化瘀能调畅气血,活血通络,化瘀通腑,从而恢复胆腑的通降功能。“通则不痛”,由于气血通畅,胆道通降功能加强,就有利于胆道中湿热瘀毒的排泄,进而促进胆腑功能恢复。方中当归、赤芍、三棱、莪术、桃仁、郁金具有较强的活血化瘀作用;大黄既能活血又能通里攻下;内金消石化积;柴胡、青皮、陈皮疏肝理气;金钱草、海金沙利胆排石;王不留行性走而不守以助下石。合而用之,共奏活血化瘀,疏肝利胆排石之功效,因而用本方治疗胆石症疗效显著。有研究表明,赤芍、郁金、桃仁、三棱、莪术等活血化瘀药能改善全身和局部的血液循环,具有抗炎消肿,抗病原微生物,解痉止痛,协调奥狄氏括约肌功能,促进胆汁分泌,乃至调节免疫功能等多种作用。因此用本方治疗胆石症可消除胆道炎症,扩张胆道,加强排泄功能,促进胆石排出与溶解,具有良好的疗效。

3、通过临床观察,此方应用无痛苦,服用方便,费用低廉,无任何毒副作用,疗效显著,很适合在基层医疗单位推广使用。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《山西中医》,1994年第3期。

胆道驱蛔汤治疗胆道蛔虫病

笔者自 1993 年以来运用吴师自拟胆道驱蛔汤治疗胆道蛔虫病 52 例,疗效显著。现报告如下:

一、临床资料

本组 52 例,男 25 例,女 27 例;年龄最小 5 岁,最大 40 岁;以 8~20 岁居多数。发病时间最短 1 天,最长为 5 天。

诊断标准:突发上腹正中剧烈绞痛,病人辗转不安、不得卧;疼痛呈阵发性,可向背部及右肩胛区放射;间歇期短,但不疼;可伴有恶心,呕吐或吐蛔,少数患者因胆道感染或蛔虫阻塞可有发热或轻度黄疸。体征主要是上腹部剑突下有轻度触痛,无腹肌紧张。“B 超”检查,可见胆总管或左右肝管内显示蛔虫光带。粪检发现有蛔虫卵。

二、治疗方法

胆道驱蛔汤组成:

茵陈 20 克	乌梅 10 克	柴胡 9 克
杭芍 15 克	枳实 15 克	槟榔 12 克
苦楝根皮 20 克	木香 9 克	

水煎服。每日 1 剂(小儿减量)。

随症加减:痛剧者加元胡 9 克、五灵脂 9 克;伴见胆囊炎者加

金钱草 20 克、黄芩 9 克；呕吐甚者加竹茹 9 克、半夏 9 克；发热者加银花 6 克、连翘 9 克；脾胃虚弱者加党参 15 克、白术 12 克；消化不良者加焦三仙各 15 克；腑气不通者加大黄 12 克（后下）、芒硝 6 克。

三、治疗结果

痊愈 38 例，经治疗 1~3 天，临床症状与体征消失，大便排出蛔虫。好转 12 例，经治疗 3 天，临床症状与体征缓解，大便有或无排蛔。无效 2 例，治疗 3 天，临床症状与体征无改善，大便无排蛔，转其他疗法。总有效率为 96%。

四、典型病例

刘某，女，20 岁，工人。1993 年 12 月 5 日初诊。

患者自诉：右上腹疼痛 2 天，开始时心窝部疼痛为阵发性，有时如刀割样，拒按，每次持续 10 分钟始缓解，伴有恶心呕吐胃内容物并吐出蛔虫 1 条，痛止如常人。体检：腹软，上腹部与剑突下明显压痛。B 超提示：胆总管扩张内可见蛔虫光带回声。诊断为胆道蛔虫，经西药解痉，消炎及支持疗法，疗效欠佳，要求服中药治疗。诊见舌质淡，苔薄黄，脉弦数。投吴师自拟胆道驱蛔汤，2 剂后腹痛消失，于次日排出蛔虫 6 条，症状与体征消失，诸症痊愈。

体 会

胆道蛔虫病是由于肠道蛔虫上窜钻入胆道引起的一种常见急腹症，属于祖国医学之“蛔厥”、“胃脘痛”、“胁痛”的范畴。本病多由于脾胃虚弱，饮食不节所致。吴师根据“蛔虫闻甘即起，闻酸即止，

闻苦即定，见辛则头伏而下”的理论，故方用胆道蛔虫汤的茵陈苦寒，乌梅酸涩，为驱蛔安蛔之良药。据现代药理证明茵陈具有利胆汁、麻痹蛔虫的作用；乌梅能使胆囊收缩，促进胆汁分泌的作用；再加苦楝根皮性味苦寒，长于杀虫；枳实、杭芍性苦味酸，缓急止痛；槟榔性温味苦，具有驱虫、通便；柴胡、木香疏肝利气，可解除平滑肌奥狄氏括约肌痉挛，有利于蛔虫从胆道中退出。诸药合用，共奏利胆、杀虫、缓急止痛之功能，使蛔虫排出体外，从而达到治疗之目的。本方药味具有简、便、廉等特点，而且疗程短，疗效可靠，特别适合农村推广使用。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《中国中医急症》，1995 第 4 卷。

治疗急腹症举隅

吴光烈老中医对危重急腹症的治疗有独到之处。兹整理数则，以供同道参考。

一、急性阑尾炎

例一 江某某，女，28岁，农民。1988年3月20日初诊。

患者首胎妊娠已5个月，病前无明显诱因，昨天突然右侧下腹部呈持续性剧痛伴发热恶寒、恶心呕吐，经当地治疗未见明显好转而入院。体温38.8℃，脉搏95次/分，呼吸25次/分，呈急腹症病容，精神萎靡，腹肌紧张，右下腹压痛明显和反跳痛，肝脾未触及。血常规：白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，中性88%、淋巴12%。西医诊断为急性阑尾炎，决定手术治疗。患者及其家属考虑怀孕恐影响胎儿而不同意，当晚转请吴老用中药治疗。诊见除上述症状外，大便秘结已3日不通，舌质黯红、苔厚黄、脉弦数。此乃热结大肠、气滞血瘀之故。当以攻下清热，调气去瘀，助以安胎为治。方用大黄牡丹皮汤加味：

冬瓜仁 15 克	败酱草 15 克	元明粉 15 克(冲)
生地 15 克	虎杖 15 克	大黄 15 克(后下)
银花 9 克	连翘 9 克	丹皮 9 克
桃仁 9 克	木香 9 克	白术 9 克
黄芩 9 克		

水煎服。药服1剂，大便泻下数次，腹痛明显减轻。唯体温持

续不降,按上方银花、连翘各加至15克,继服2剂,腹痛基本消失,体温降至37.2℃,血常规检查正常。再守上方去大黄、元明粉加当归、白芍各9克,续服3剂,诸症痊愈。嘱注意饮食调理。后经追访,足月顺产1男婴,母子皆安。

按 本例以大黄牡丹皮汤攻下逐瘀,加银花、连翘、虎杖、败酱草、生地凉血泄热,木香调气止痛,白术、黄芩安胎等药物治之,取得了良好的疗效,可谓慎思明辨,发《内经》:“有故无殒,亦无殒也。”之要旨。吴老认为,大黄、元明粉为通里逐秽治疗腑实证之要药,凡毒热炽盛,瘀结腑实伴有高热、急腹症之疼痛,用之皆效,但用量要高于平常,若杯水车薪,无济于事。

二、急性肠梗阻

例二 林某某,男,42岁,工人。1988年5月25日初诊。

患者于2年前行胆道手术。近3天来便秘、腹胀、腹痛伴恶心呕吐,腹部高度胀气,肠鸣音亢进,有气过水声,舌红少津、苔厚黄,脉滑数。腹部透视提示:肠管高度充气,见梯状液平。西医诊断为急性肠梗阻。吴老辨证为瘀热内结、腑气不通,应予通里攻下,理气化痰。

处方:

枳实 12 克	炒莱菔子 12 克	大黄 15 克(后下)
桃仁 12 克	川朴 12 克	元明粉 15 克(冲)
赤芍 10 克		

水煎服。服1剂后,大便通畅,腹满痛明显好转。效不更法,守上方去元明粉,大黄减至10克,再进1剂,腹痛、呕吐均消失。继以健脾理气之香砂六君子汤调治3剂,一切如常。

按 肠梗阻临床表现以痛、胀、呕、闭四大症为特征,类似祖国医学的“肠结”、“关格”。吴老认为本病多因饮食不节、湿浊内阻或

气滞血瘀而致胃气失降、大肠传导失职,而产生大便秘结、呕吐、腹痛等症。根据六腑为“传化之腑”,其功能“泻而不藏”、“降而不升”,以通降下行为顺的生理特点。吴老治以理气化痰、通里攻下为基本大法,方中重用大黄、元明粉,意在急下泻热,通腑开结。吴老强调病机既明,治疗宜速战速决,不可迁延失误。本方为泻实之剂,久服能伤正气,泻下痛止,说明急流挽舟已成,应予转舵,改用香砂六君子汤善后,而收全功。

三、急性胰腺炎

例三 陈某某,男,35岁,炊事员。1988年8月5日初诊。

患者因饮酒过度,突发上腹部阵发性剧痛并反射到肩背伴有发热恶寒,恶心呕吐、口苦、大便秘结,舌质红、苔厚黄,脉弦滑。检查:尿淀粉酶 1024 单位,血象:白细胞 $23 \times 10^9/L$,中性 85%,淋巴 15%。体检:体温 38℃,巩膜无黄疸,心肺无异常发现。肝脾未触及,腹部稍饱满,左上腹部压痛明显。西医诊断为急性胰腺炎。中医辨证为肝郁气滞,湿热内蕴,治宜疏肝理气,清热通下。处方:

生地 15 克	白芍 15 克	大黄 15 克(后下)
柴胡 9 克	枳壳 9 克	元明粉 15 克(冲)
丹皮 12 克	元胡 12 克	木香 12 克

水煎服。服 1 剂后,大便泻下 3 次,腹痛明显减轻。药已中病,守上方去元明粉,继服 3 剂,诸症悉除。复查血象和尿淀粉酶正常。

按 吴老认为本病多由肝郁气滞、湿热内蕴中焦,涉及胰腺为主要病机,以疏肝理气,清热通下为法。方中以大黄、元明粉荡涤阳明实热积滞,急下以止痛,合丹皮、生地、白芍既可养阴扶正又能通过大黄推陈出新之作用,防止热毒炽盛而产生留瘀之弊。柴胡、枳壳、元胡、木香疏肝解郁,调气理痛,尤其是木香、元胡为理气止痛要药,用量要大于他药。

四、胆囊炎、胆石症

黄某某,男,45岁,农民。1988年8月12日初诊。

自诉:右上腹部阵发性疼痛反复发作已有8年病史。今早起床突发右上腹绞痛并向右肩背放射,口中苦,善太息,恶心呕吐伴有脘腹胀闷,大便秘结,小便黄赤,巩膜黄染,舌质红、苔薄黄,脉弦。体检:体温 37.5℃,右上腹明显压痛,肝脾未触及,B超提示为胆囊炎,胆石症。中医辨证为肝胆湿热,气滞瘀结,治宜清热利湿,理气化瘀,通下排石。处方:

柴胡 15 克	蒲黄 15 克	五灵脂 15 克
金钱草 15 克	茵陈 15 克	大黄 15 克(后下)
王不留行 15 克	桃仁 9 克	元明粉 15 克(冲)
赤芍 9 克	川楝 9 克	青皮 9 克
胆草 9 克	黄芩 9 克	枳壳 12 克
木香 12 克	甘草 6 克	

水煎服。服药 6 剂,天天泻下,患者自觉症状明显好转。守上方继服 6 剂,诸症消失。经 B 超复查:胆囊炎已除,未见阳性结石存在。为巩固疗效,嘱患者用金钱草 30 克,王不留行 30 克,黄芪 15 克,党参 15 克,大枣 10 粒,水煎代茶连服半个月。1 年后,再行复查,未见复发。

按 吴老通过长期的临床实践,认为结石乃湿浊内生,久经煎熬而成。胆性刚,喜疏泄,六腑以通为用,治以清热利湿,理气化瘀,既可泻热排石,又可疏肝理气,调和木土,但中病则止,以免伤正。本病反复发作已 8 年,本虚标实,故善后用党参、黄芪、大枣以扶正,金钱草清热利湿,王不留行性走而不守以利排石。煎代茶服,既可增强体质,又可防止胆石症之复发。

五、宫外孕

陈某某,女,31岁,工人。1989年4月15日初诊。

自诉:停经已42天,昨天突然右下腹部呈持续性剧痛伴有呕吐腹泻,阴道流血淋漓,经当地医生诊断为蛔虫痛,给服驱虫药及止痛药未见排出蛔虫,腹痛症状仍未改善。检查:贫血外观,体温37.4℃,血压:16.0/9.33kPa,右下腹部有压痛及反跳痛。妇科检查:外阴已产式子宫颈糜烂(Ⅲ°),色紫,宫体后位,右侧宫房有一肿物约4cm×4cm,质硬,移动性差,有压痛感,后穹窿部穿刺,抽出黯红色血液3ml,不凝固,妇产科诊断为“陈旧性宫外孕”。经用抗感染药物结合对症治疗,症状仍未改善,当即邀请吴老会诊,决定用中药保守治疗。诊见脉弦数,舌质黯红,舌苔厚黄。证属气机不运,瘀血内结。根据“痛则不通,通则不痛”的理论,治宜行气活血,消坚散结,缓急止痛。处方:

大黄 15 克(后下)	当归 15 克	生地 20 克
桃仁 9 克	白芍 9 克	川芎 9 克
香附 9 克	丹皮 9 克	生蒲黄 9 克
丹参 9 克	五灵脂 9 克	

水煎服。服药1剂,大便泻下数次,右下腹部疼痛减轻,阴道流血明显减少。药已中病,原方继服2剂,右下腹部疼痛告止,包块转软。仍守原方去大黄、桃仁加黄芪、党参各15克、大枣6枚,嘱服3剂,诸症消失。后给当归9克,黄芪54克,嘱配血肉有情之性物炖服,作为善后调理。随访1年,正常参加劳动,一切良好。

按 祖国医学无宫外孕之称。但按其临床表现属于“胎漏”、“症瘕”之范畴。其病机吴老认为主要是瘀血内聚、经脉流行不畅而致宫房包块腹部剧痛、阴道流血淋漓不尽。根据“急则治其标,缓则治其本”的原则,治以破坚散结,缓急止痛,而不急于固涩止血之

法。一俟腹痛缓解,阴道流血量减少,说明药中病机,脉络气血运行通畅,即遵《内经》之旨,“大积大聚其可犯也,衰其大半而止”,方中即逐渐减去活血祛瘀之品,而增入补血之剂,达到破中寓补,攻邪而不伤正,是勿犯虚虚实实之戒。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《福建中医药》,1992年第3期。

“阳明三急下”辨

《伤寒论·辨阳明病脉证并治》中第 252 条、253 条、254 条等条文,均有“急下之”三字,后人称为“阳明三急下”。现剖析如下:

第 252 条云:“伤寒六七日,目中不了了,睛不和,无表里证,大便难,身微热者,此为实也,急下之,宜大承气。”

钱璜云:“六七日邪气在里之时也,外既无发热恶寒之表证,内又无谵语腹满等里邪,且非不大便而曰大便难,又非发大热而身仅微热,势非甚亟也,然目中不了了,是邪热伏于里而耗竭其津液也。”

《医宗金鉴》云:“目中不了了而睛和者,阴证也,睛不和者,阳证也,此热结神昏之渐,危急之候,急以大承气汤下之,泻阳救阴,以全未竭之水可也。”

陆渊雷云:“病有脑症状者为危候。由脑病而引起植物性神经之症状反射,常紊乱心机能,或竟令停息也。目中不了了,睛不和者,脑病之外候,脑神经纤维出于脑后之下面者,十有二对,其系于目者四对,曰视神经,曰动眼神经,曰滑车神经,曰外展神经,故脑病之外候,常见于目,古人不知神经系统病,但见睛不和都为危候。推大其故,乃为五脏六腑之精皆上注于目耳。脑病由于热铄津伤者,宜以承气汤急下存阴。《金匱》以本方治瘵,亦即此意也。无表里证,盖谓无少阳半表半里之证,不禁攻者。”

上述各家对本条文的理解,均认为热邪内铄津枯之危候。所谓“不了了而睛不和”者,汪苓友解释说:“不了了者,病人之目视物不明也;睛不和者,乃医者视病人睛光或昏暗,或散乱,是为不和。”陆

氏用现代医学加以阐述,对后学者更有启发。我们在临床实践中所见之脑病,在阳亢阴竭的危险阶段,大多具有两目直视、转动不灵之状。《内经》云:“热病日不明、热不已者死”,和“视其目色想知病之存亡也”。即说明两目之神色,对内脏的变化有其密切关系。故凡病危,察其两目,可知预后之吉凶,对临床具有极其重要的诊断意义。文中“大便难”三字细推其意,乃燥热不从下泄,热潜在里,故外见身微热。分析本条所述之证候,乃阳明腑实,热炽伤津,上扰清窍,故宜大承气汤急下存阴。仲师宗《内经》病在上取之下的治则,治疗此证,我们临床遇此病候,亦宗此法,均获显效。

第 253 条:“阳明病,发热汗多者,急下之,宜大承气汤。”

尤在泾云:“发热汗多者,热盛于内,而津液迫于外也,不下则热不除,不除则汗不止,而阴乃亡矣,故宜急下。然必有实满之证,而后下,不然则是阳明白虎汤证,宜清不宜下矣。”

钱璜云:“潮热自汗,阳明胃实之本证也,此曰多汗,非阳明自汗可比矣。里热炽盛之极,津液尽泄,故当急下,然必以脉证参之,若邪气在经,而发热汗多,胃邪未实,舌苔未乾,厚而黄黑者未可下也。”

陆渊雷云:“阳明病,谓胃实可下之证也,否则发汗多与白虎证何别?程氏、《金鉴》等谓虽无内实,亦宜急下救阴,非也。本有可下之证,复发热汗多,则胃愈燥,津愈竭,故宜急下。”

尤钱二氏之说,皆认为本条发热汗多系热邪入腑,内热炽盛,津液迫于外也,宜急下以救阴,不然将有津枯之危也。并告诫后学,在辨证时宜注意经证与腑证之分,不能盲从。陆氏认为本条阳明病指胃实可必有胃家实的腑证在内,故仲师用大承气汤急下救阴,以防液脱阴亡之危险。笔者在临床上每见到阳明腑实可下之时,再见到发热汗多,阳亢阴竭之候,遵仲师之训,以大承气汤急下之,多获良效。

第 254 条:“发汗不解,腹满痛者,急下之,宜大承气汤。”

尤在泾云：“发汗不解，腹满痛者，病去表之里而盛于里矣。夫正气与邪气相击则痛，治之者如救斗然，迟则正被伤矣，故亦宜急下。”

成无己云：“发汗不解，热邪传入腑，而成腹满痛者，传之迅速，是须急下之。”

尤、成二氏之说，均谓发汗不解，腹满痛者为热邪传腑，宜急下之，以免伤正。阳明病本有若发汗则躁之戒，又有汗多急下之法，今其病发汗不解，则知其汗之误矣。再见到腹满痛者，当知此为实，邪入阳明腑实，燥屎内结无疑矣，宜急下之。本条文字简短，然含义甚深，宜细玩之。此处的腹满痛与 66 条厚朴生姜半夏甘草人参汤之汗后腹满痛不同，此为实，彼为虚，临床宜细加审辨，庶不致误。

总之，从“阳明三急下”证治剖析看来，不难理解仲师急下之意，其主要为急引阳明火热之邪从大便而出，使津液不致尽劫，为釜底抽薪，急下存阴之法；不然，若不及时制止，则必危险立至，仲师故曰“急下之”，以示其不可容缓也。

后人对“三急下”之证另有看法，如高士宗、张含韶、张隐庵等认为阳明三急下之证，乃由悍然之气使然，非仅胃肠之燥实，因此不一定痞、满、燥、实、坚悉具，然后可用大承气汤下之。笔者在临床实践中认为有腑气不通、里热不下而导致阳亢阴竭，胃燥津枯的见证，就宜因势利导，急下存阴。但大承气汤为峻下剂，中病则止，以免伤正，仲师对此有明训，给后人以很大的启发。

● 原载于《仲景学刊》，1982 年第 2 期。

中药治疗泌尿系结石

吴光烈主任中医师用中药治疗泌尿系结石,屡收良效。笔者就近几年来侍诊左右,将其治疗 32 例,整理报告如下:

一、一般资料

32 例中,男性 26 例,女性 6 例;年龄最大者 52 岁,最小者 20 岁;20~40 岁者 15 例,41~50 岁者 10 例,50 岁以上者 7 例。本组病例均以 X 线拍片及 B 超提示有阳性结石为诊断依据,其中肾结石 5 例,输尿管结石 18 例,膀胱结石 9 例。结石直径大于 0.9 厘米 5 例,0.5~0.8 厘米 20 例,0.5 厘米以下 7 例。

二、基本方药

金钱草 30 克	滑石 30 克	内金 9 克
牛膝 30 克	海金沙 15 克	车前子 15 克
桃仁 15 克	熟地 15 克	冬葵子 15 克
甘杞 12 克	木通 9 克	木香 9 克
桂枝 9 克	附子 9 克	

每日 1 剂,水煎 2 次,上下午分服。

加减法:有血尿者加白茅根、大蓟各 15 克;腰痛者加杜仲、狗脊各 12 克;小腹胀痛者加青皮 9 克、川楝 12 克;尿频涩痛者加石苇、瞿麦、扁蓄各 15 克;体虚者加黄芪、党参各 15 克。

服药期间,每日用金钱草 60 克、王不留行叶 30 克,煎代茶大量饮服。

三、治疗结果

32 例,治愈 22 例(自觉症状消失,结石排出,X 线及 B 超复查结石阴影消失);有效 8 例(症状体征消失,结石部份排出,X 线及 B 超复查仍有部份结石存在);无效 2 例(症状减轻,结石未排出)。治疗时间最短者 6 天,最长者 30 天,平均 16 天。

四、病案举例

例一 黄某某,女,45 岁,1988 年 10 月 15 日初诊。

主诉:排尿时常中断,尿频余沥不尽而疼痛。近因家务过于劳累,今早突然下腹部呈阵发性剧痛并放射至尿道口,坐立不安,汗出肢冷,小便频数,尿后段为血性,而来求治。脉细数,舌如常。尿检:蛋白微量,红细胞(卅),X 线腹部平片报告:可见膀胱内有 1.0×1.2 厘米结石阴影。提示为“膀胱结石”。拟属瘀热互结石淋症,治宜清热化瘀,通淋排石。处方:

金钱草 30 克	滑石 30 克	牛膝 30 克
海金沙 15 克	车前子 15 克	桃仁 15 克
石苇 15 克	瞿麦 15 克	扁蓄 15 克
白茅根 15 克	冬葵子 15 克	熟地 12 克
甘杞 12 克	木通 9 克	木香 9 克
桂枝 9 克	附子 9 克	内金 9 克

嘱服 10 剂,每日 1 剂。

服至 6 剂,突然尿道涩痛,欲溺不出,少顷排出结石 1 粒,小便畅通如注,诸症消失。翌日经 X 线拍片复查,膀胱清晰未见结石阴

影。为防复发,嘱用金钱草 60 克,王不留行叶 30 克,水煎代茶作为饮料,连服半个月。经随访未见复发。

例二 黄某某,男,53 岁。1988 年 11 月 25 日初诊。

主诉:素有小便刺痛窘迫感,2 天前突然左侧腰部剧烈绞痛并向会阴部放射,继而出现肉眼血尿,左腰部有明显叩击痛。尿检蛋白(++),红血球(+++),白血球(+). X 线拍片发现左肾中下段有 0.6×0.8 厘米和 0.6×0.9 厘米之结石阴影,确诊为“左肾结石”。舌质红、苔黄腻,脉弦数。证属湿热瘀阻,结石内蕴;治宜清热利湿,化瘀排石。处方:

金钱草 30 克	牛膝 30 克	滑石 30 克
冬葵子 15 克	海金沙 15 克	车前子 15 克
白茅根 15 克	大蓟 15 克	熟地 15 克
杜仲 12 克	狗脊 12 克	甘杞 12 克
桃仁 9 克	桂枝 9 克	附子 9 克
内金 9 克	木通 9 克	木香 9 克

水煎服,每日 1 剂。同时嘱每日用金钱草 60 克,王不留行叶 30 克,水煎代茶大量饮服。

服至 10 剂,X 线平片复查见结石下移至输尿管,药已中病,原方再服 6 剂后排出结石 2 枚,大小与 X 线拍片阴影相符,证状亦随之消失。为巩固疗效,嘱用补益气血和调理脾肾之品,以善其后。随访至今未见复发。

体 会

1、泌尿系结石属于祖国医学“石淋”、“砂淋”、“血淋”等范畴。发病的主要因素是肾和膀胱气化功能失职及平素嗜酒多食甘肥辛辣之食物,或因情志抑郁、工作劳累引起气滞血瘀,湿热蕴结于下焦,日积月累,尿中浊质逐渐凝结而成砂石。

2、砂石阻塞于泌尿系统的通道滞而不通则腰疼剧烈,尿频尿急而涩痛;结石伤及血络则尿血。吴老认为本病其本在于肾虚,功能失调,其标在于湿热蕴结下焦,久积成瘀。根据“标本同治”的原则,故拟方既着重清利湿热,化瘀排石为其常法,又注重肾虚扶正,平补水火,使排尿功能趋于正常。方选金钱草、冬葵子、海金沙、内金利水通淋化石;滑石、车前子,利尿而不伤阴;木通清心导赤,泻火通淋;桃仁清热化瘀;木香理气止痛;牛膝引药下行,使结石滑利而下;桂枝、附子温补肾阳,又可调和寒凉之品,使久服不致伤胃;熟地、甘杞补益肾阴而治本。共奏清热利湿,通淋排石,化瘀行滞,水火平补之功。现代药物学研究亦证明:滑石有利尿和抗菌消炎之作用,是主治石淋之要药;牛膝引导结石下行之作用强于其它药。吴老对二药用量常在30克左右,在临床上未见弊端。

3、本病早期多为实热症,应以清利湿热,通淋排石为主,切忌恣意进补,因气得补而愈胀,血得补而愈涩,热得补而愈炽,这对排石都是不利的。但病程日久可致脾肾亏虚,应在清热利湿、通淋排石之基础上兼补脾肾之虚,切不可拘泥“淋症忌补”之说。此外吴老强调每日应嘱病人用金钱草和王不留行叶煎汤代茶大量饮服和跳跃活动,以有利于清除尿中之杂质及促进结石分离和下行。盖取金钱草为排石名药,王不留行叶以性走而不守为著称。当结石排出后,可继续服用一些补益气血、调理脾肾之药物,以促进机体功能的恢复。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《福建中医药》,1990年第4期。

生地通淋汤治疗急性泌尿系感染

吴师自 1992 年以来,采用自拟“生地通淋汤”治疗急性泌尿系感染 96 例,收到了较好的疗效。现报告如下:

一、一般资料

本组 96 例中,男性 28 例,女性 68 例;年龄最小 15 岁,最大 65 岁;以 18~48 岁之间为多。已婚 72 例,未婚 24 例。病程短者为 3 天,最长者达 5 年。其中急性膀胱炎 38 例,急性肾盂肾炎 42 例,慢性肾盂肾炎急性发作 16 例。

二、临床表现

本组病例均具有不同程度的尿频、尿急、尿痛、小腹痛或兼有腰痛身热、肾区叩区击痛。舌苔薄黄 45 例,黄腻 26 例,薄白 15 例,剥苔 10 例;脉象滑数 46 例,细数 37 例,弦细 13 例。尿常规检查:白细胞(+)以上,红细胞少许。血常规检查:白细胞计数在 $10 \times 10^9/L$ 以上占 40 例。

三、治疗方法

生地通淋汤:

生地 15 克

旱莲草 30 克

白茅根 30 克

车前子 15 克 石苇 15 克 扁蓄 15 克

甘草 6 克

水煎服。急性期每日 2 剂,待症状稳定后改为每日 1 剂。

随症加减:发热者加银花、菊花;血尿者加小蓟草、蒲黄;少腹胀闷者加乌药、枳壳;尿浊者加萆薢、苡米仁;便秘者加大黄;气虚者加黄芪、党参;血虚者加当归;舌苔黄或苔剥者加麦冬、沙参;腰痛甚者加杜仲、牛膝。

四、疗效标准

痊愈:临床症状与体征完全消失,尿常规检查三次以上恢复正常。

好转:临床症状与体征基本消失,尿常规检查三次基本正常。

无效:经服本方 3~5 剂后,临床症状与体征改善不明显,或在治疗期间时轻时重反复发作。

五、治疗结果

治疗时间最短为 5 天,最长为 20 天。急性膀胱炎 38 例;治愈 16 例,显效 20 例,无效 2 例。急性肾盂肾炎 42 例;治愈 29 例,显效 10 例,无效 3 例。慢性肾盂肾炎急性发作 16 例;治愈 6 例,显效 7 例,无效 3 例。总有效率为 91.7%。

体 会

1、泌尿系感染的发病与性别及年龄有关。本组病例中,男性少于女性,多发于 18~45 岁间中青年人,说明中青年人发病率高,其中尤以妇女最易感染,提示由于女性生理特点,注意生活卫生对防

止泌尿系感染的发生有极重要的意义。

2、本组病例,属于热淋的湿热型,在治疗时,除着眼湿热蕴结膀胱,还应审察正气之盛衰。若体壮邪实者,治疗应在清热利湿,利水通淋;若正虚邪实者,治当扶正祛邪,祛邪务必尽矣,以利于康复并防止其复发。方中生地、旱莲草清热凉血养阴;石苇、扁蓄、车前子清利湿热、利水通淋;白茅根清热利尿,且能凉血止血;甘草清热泻火,甘缓和中。诸药合用,共奏清热泻火,利水通淋之效。

3、本方为苦寒清热之品,且剂量偏大,中病则止,以免损伤脾胃。如治疗时间长,需加党参、白术、陈皮、砂仁等和胃醒脾之品,以减轻或消除上述副作用。此外,对慢性患者,并经常反复发作者,病久伤正,肾气亏损,必须扶正祛邪,应在本方中加入黄芪、升麻、党参、故纸、杜仲等补气升提、益肾扶正之品,对改善机体的全身状况,提高抗病能力,防止复发起了一定的作用。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《医学理论与实践》,1994年7卷增刊。

益气化瘀汤治疗前列腺肥大

吴师自 1993 年 2 月～1994 年 5 月运用自拟益气化瘀汤治疗前列腺肥大 42 例,收效满意。现报告如下:

一、临床资料

本组 42 例均为门诊病人,年龄最大 80 岁,最小 40 岁,其中 40～50 岁 12 例,51～60 岁 10 例,61～70 岁 15 例,71 岁以上 5 例。病程一年以内 12 例,1～3 年 15 例,3～5 年 10 例,6 年以上 5 例。临床主要症状,均有程度不等的进行性排尿困难及排尿次数增多,有时中断或点滴状并伴有腰酸乏力等症。全部病例作直肠指诊及 B 超探查,均确诊为前列腺肥大。

二、治疗方法

基本方为:

黄芪 30 克	白术 15 克	白芍 15 克
穿山甲 15 克	王不留行 15 克	车前子 15 克
牛膝 15 克	三棱 15 克	乌药 9 克
琥珀 3 克(冲)	桔梗 9 克	丹参 15 克
荔枝核 12 克	甘草 6 克	

随症加减:尿道灼热涩痛加扁蓄 30 克、瞿麦 30 克;血尿加炒蒲黄 9 克、白茅根 15 克、生地 15 克;肾阳虚加肉桂 6 克、淫羊藿 15

克;肾阴虚加鳖甲 15 克、女贞子 12 克。

水煎服,每日服 1 剂。15 天为一疗程,每疗程间隔 3~5 天。

三、治疗结果

痊愈(主要症状和体征消失,肛诊和 B 超检查前列腺正常,随访 3 个月以上无复发者)14 例;好转(症状明显好转,肛诊和 B 超检查前列腺明显缩小)23 例;无效(症状无改善,肛诊和 B 超检查前列腺无缩小)5 例。总有效率为 88%。

四 病案举例

王某,男,68 岁,离休干部。1993 年 10 月 20 日初诊。

患者排尿困难、排尿次数增多已三年。近 10 余天加重,伴有腰膝酸软,头晕乏力。舌暗红、苔薄黄,脉细数。B 超检查提示:前列腺肥大。肛诊前列腺中度增大,表面光滑质地韧,中间沟变平。辨证为年老气虚,血瘀热阻所致。治当益气软坚、祛瘀通闭。处方:

黄芪 30 克	白术 15 克	白芍 15 克
穿山甲 15 克	荔枝核 15 克	王不留行 15 克
丹参 15 克	三棱 15 克	乌药 9 克
车前子 15 克	牛膝 15 克	桔梗 9 克
琥珀 3 克(冲)	甘草 6 克	肉桂 6 克(冲)
淫羊藿 15 克		

水煎服,每日 1 剂。服上方 15 剂后,排尿无痛苦感,排尿次数明显减少。为巩固疗效,继服上方一个月,症状完全消失。B 超复查前列腺正常,肛诊检查前列腺中间沟变浅,临床治愈。嘱常服六味地黄丸,调理善后。随访一年,未见复发。

体 会

前列腺肥大,大多发生于 50 岁~70 岁之间,多以尿频、尿急、尿痛为主证,严重的可以出现尿闭症状。本病属于祖国医学的“癃闭”范畴。其病因多为年老中气虚弱,肾气亏损,气滞血瘀,膀胱气化不利所致。正如《景岳全书·癃闭》中所说:“夫膀胱为藏水之府,而气之化水,由水以达气,故有气斯有水,水之水也,由水以达气,故有水始有溺,经曰气化则出矣!”气虚无以行血,必致血液运行不畅而结聚于精室,瘀血日久,必然化热,瘀热互结而致前列腺肥大。因此,本病气虚为本,血瘀热结为标,故治当标本同顾,过补则瘀热难去,过攻则正气更亏。本方吴师重用黄芪、白术补中益气,使气行则血行,瘀去即不伤正;穿山甲、丹参、三棱、荔枝核活血化瘀,软坚散结;王不留行、乌药理气疏导,性善走串直达病所;牛膝散瘀血,引药下行;琥珀、车前子利水通淋,散瘀血;白芍、甘草缓急止痛;桔梗以宣肺提壶揭盖通调水道。诸药合用,共奏益气软坚,祛瘀通闭之功。由于药中病机,故收到立竿见影之效。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《中国中医急症》,1995 年第 4 卷。

银翘败酱汤治疗急性肾炎临床观察

“银翘败酱汤”系家父吴光烈主任中医师自拟之验方，用于治疗急性肾炎，屡收良效。笔者自1992年6月～1995年6月运用此方于临床，疗效显著，故不揣浅陋，总结报告如下：

一、临床资料

本组100例中，男62例，女38例；年龄最小5岁，最大52岁，以10～35岁之间为多。全部病例均经化验检查确诊，病初皆有不同程度的上呼吸道感染病史及浮肿、蛋白尿、血尿等症状。其中尿有颗粒管型者40例，高血压者35例。

二、治疗方法

银翘败酱汤：

银花 6 克	连翘 9 克	败酱草 15 克
蝉衣 6 克	丹参 12 克	白茅根 15 克
冬瓜子 15 克	麻黄 6 克	黄芪 15 克
益母草 15 克	苡仁 15 克	

水煎服，每日1剂。15天为一疗程。

随症加减：水肿甚者加大腹皮、五加皮；尿红细胞多者加仙鹤草、旱莲草、地榆炭；腹胀纳少者加炒卜子、神曲、陈皮；血压高者加夏枯草、石决明、珍珠母；腰痛者加川断、杜仲；口干舌红者加生地、

麦冬。

注意事项：服药期间忌食肥甘油腻及辛辣之品。除药物治疗外，注意休息，低盐饮食。预防感冒等也是必不可少的。

三、治疗结果

治愈 65 例(症状消失、浮肿消退，血压正常，血、尿常规检查均正常)；好转 32 例(症状基本消失，浮肿消退，尿旦白 $+$ ~ $++$)；无效 3 例(症状、体征无明显好转，尿检无显著改变)。总有效率为 97%。

四、典型病例

黄某，男，15 岁，学生。1994 年 8 月 25 日初诊。

患者 10 余天前发热、恶寒、鼻塞咽痛，在当地医院按感冒给予西药治疗 3 天后，发热退，眼睑面部出现浮肿，继而全身皆肿，小便量少，咽喉红肿疼痛，不思饮食，舌质红、苔薄黄，脉浮数。尿检：蛋白 $++$ 、红细胞 $++$ 、白细胞 $++$ 、颗粒管型 $+$ ；血常规：Hb120g/L、WBC $12 \times 10^9/L$ ，血压：18.6/12kPa。诊断为急性肾炎。证属：外感风邪，肺气失宣，水道不利所致。方用：银翘败浆汤服 10 剂后，水肿消退，尿量增加，咽喉红肿消失。血压：13.20/9.2kPa，血常规：WBC $8.5 \times 10^9/L$ ，药已对症，效不更方，按上方继服 6 剂，症状消失，浮肿消退，血、尿化检正常。随访 1 年未复发。

体 会

急性肾炎即急性肾小球肾炎的简称，属于祖国医学的“风水”、“水肿”之范畴。笔者认为本病之发生机理为风热伤肺，肺气不宣，通调失职，水湿潴留于肌表则发为水肿。现代医学认为本病是一种

与溶血性链球菌感染有关的一种免疫疾病。方中银花、连翘、败酱草清热解毒,经现代药理研究有抑菌作用;麻黄发汗、平喘、利水;蝉衣宣肺解表,据药理分析有减少蛋白尿的功效;益母草利尿消肿;丹参活血祛瘀生新;黄芪益气固表,利水消肿,据现代药理证实黄芪有明显的免疫促进活性,不但可减蛋白尿,并且能够降低全血及血浆比粘度,使红细胞电泳增快;白茅根、冬瓜子清热利水,凉血活血;苡仁健脾补肺、清热渗湿。全方具有宣肺解表,清热利湿,祛风行水之功效。使风、热、瘀、湿诸邪外出,从而控制感染,减轻肾小球内的水肿、充血等炎性改变,改善微循环,增加肾脏本身的血流量,降低毛细血管的通透性,减少蛋白质的漏出、达到利尿消肿、降蛋白、止血尿的目的。由于药证相符,故临床疗效显著。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江西中医药》,1996 年增刊。

补肾种子汤治疗男性不育症的临床体会

补肾种子汤系吴光烈主任中医师临证 50 余年的经验方,用于治疗男性不育症,疗效卓著。现将老师 1990 年 5 月~1992 年 12 月,用其方治疗男性不育症 62 例,取得显著的疗效,总结如下,以飨同道。

一、临床资料

本组 62 例均系婚后同居 2 年以上不育者,女方检查正常,男方检查精液常规异常。年龄:23~30 岁 42 例,31~35 岁 12 例,35~40 岁 8 例。病程:结婚 2~3 年者未育 38 例,4~5 年者 16 例,6 年以上者 8 例。临床症状与体征:全部病例中,除不育外,绝大多数没有明显自觉症状,只有少数患有腰膝酸软,神疲乏力,记忆力减退,失眠多梦,尿频、尿黄、尿道不适,舌质偏淡、苔黄腻,脉沉细或弦细。

二、治疗方法

基本方:

菟丝子 15 克

甘杞子 15 克

复盆子 15 克

五味子 15 克

故子 15 克

巴戟天 15 克

淫羊藿 15 克

仙茅 15 克

熟地 20 克

首乌 15 克

天冬 15 克

山茱萸 15 克

黄芪 15 克 党参 15 克

随证加减：阳事不举者加益智仁 15 克、酸枣仁 12 克；精子活动弱者加附子 6 克、肉桂 6 克；畸形精子多者加桃仁 9 克、地鳖虫 6 克；精液中有脓细胞者加黄柏 9 克、知母 12 克；湿热者加土茯苓 15 克、败酱草 15 克；肝郁者加柴胡 9 克、郁金 9 克、川楝 12 克；腰膝酸软者加杜仲 12 克、寄生 12 克。

水煎服，每日 1 剂，早晚分服。服药一个月为一疗程，疗程间歇一周后再继续第二疗程，一般连续 2~3 疗程可见效。每疗程进行精液检查一次，治疗期间嘱尽量节制房事。

三、疗效标准

服药后，症状和体征完全消失，精液检查正常或孕育者为痊愈。

服药后，症状和体征消失，精液检查各项指标明显提高者为好转。

连续治疗四个疗程，症状和体征无改善，精液检查未恢复正常者为无效。

四、治疗结果

早泄 14 例，治疗后其妻受孕 9 例；精子数量减少 26 例，治疗后增多 22 例，其妻均受孕；精子活动率差 16 例，治疗后活动率好转 13 例，其妻均受孕；不射精 6 例，治疗后可射精，且都受孕。总有效率为 80.64%。

五、典型病例

林某,男,32岁。结婚已6年不育,经多方治疗未效,而求治于吴老。女方检查正常,性生活正常。男方精液常规检查:精子量约2.5毫升、乳白色、清稀;精子计数0.25亿,活动率25%,活动力差,畸形精子20%。伴有头晕眼花、腰膝酸软、精神疲乏、舌淡苔白、脉沉细。经用基本方加附子、肉桂、杜仲、寄生治疗一个疗程后精子计数0.4亿,活动率45%,活动力一般,畸形精子10%。诸症减轻。药已中肯,效不更方,再续原方治疗2个月再检查:精子计数0.6亿,活动率70%,活动力良好,畸形精子5%。后因其他病来诊告曰:其妻经B超检查已怀孕4个月,高兴万分。

体 会

1、男性不育症是临床较为常见的疾病,虽然证候较复杂,但究其病本多在于肾。本组62例,按中医理论辨证,多系肾精亏损。早泄者多属肾精偏亏;精液异常者为脾肾亏虚;不能射精者为肾气偏虚。一般属于虚证。根据“虚则补之”的原则,治疗当以补肾填精,益气健脾为主,同时还要注意补肾要阴阳同补。吴师以“五子衍宗丸”为基础,再加上数十年的临床实践体会,拟方为“补肾种子汤”。方中淫羊藿、肉苁蓉、巴戟天、仙茅、甘杞子、菟丝子、故子、复盆子入肾经,能温肾壮阳,鼓动肾气以提高生精功能;黄芪、党参补脾益气,促进精液运行;熟地、首乌、天冬滋阴填精补气,以阴中求阳;五味子、山茱萸能补肾固精。诸药合用,共奏补肾壮阳,添精补髓之功效。全方立论,寓于“善补阳者,必于阴中求阳,阳得阴助而生化无穷。”

2、男性不育症患者,绝大多数都有沉重的思想负担,医者应耐

心,做好其思想工作,使之树立信心,认真治疗,消除焦虑和紧张情绪。还要动员其妻体贴、安慰、鼓励丈夫。此外,对不射精病人尚有部份属性交技巧问题,宜给予性知识的咨询指导。

3、在治疗方面必须坚持服药,服药一个月复查一次,根据病情,灵活加减,随机应便,切不可随意改弦易辙,而影响疗效。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《第一届全国疑难杂症诊治学术研讨会论文集》,南开大学出版社出版,1994年8月第1版。

参苓白术散在妇科的临床应用

参苓白术散载于《太平惠民和剂局方》，为治疗脾胃虚弱常用的方剂。其组方药物为：人参、白术、扁豆、茯苓、甘草、山药、莲肉、桔梗、薏苡仁、砂仁等。方中以人参、白术、茯苓、甘草、山药健脾益气；扁豆、莲肉、薏苡仁健脾化湿；砂仁和胃理气；桔梗开提肺气，载药上行。吴师在临床上常用此方治疗子肿、妊娠恶阻、经行泄泻、室女闭经等脾胃虚弱之证，疗效卓著。现录数案如下：

一、子 肿

陈××，女，31岁。1985年4月10日初诊。

患者妊娠3月后，出现面目四肢浮肿，胸闷气喘，四肢不温，口淡无味，恶心呕吐，大便稀溏。舌质淡红胖嫩，边有齿痕，苔薄白，脉缓滑。此乃脾阳不振，水湿停聚。治宜温中健脾，渗湿利水。方用参苓白术散加减。处方：

党参 12 克	白术 10 克	茯苓 15 克
桂枝 6 克	芡实 9 克	淮山药 15 克
砂仁 6 克	莲肉 12 克	扁豆 15 克
大腹皮 15 克	陈皮 9 克	防己 9 克
生姜 3 片		

3剂，水煎服，1日1剂。

4月14日复诊：服上药3剂后，浮肿明显减轻，手足转温，大便转为正常，但仍有口淡无味，恶心呕吐。嘱按原方加藿香10克，

芳香化浊，以止恶呕。继服4剂，浮肿消失，恶呕已除，诸症痊愈。

按 妇女怀孕3~7月，头面、四肢发生水肿、小便短少，称为子肿。引起子肿的原因，主要是肺脾肾三脏功能失调。因肺主通调水道，脾主蒸化水液，肾主二便司开合。《内经》曰：“诸湿肿满，皆属于脾”。这说明脾虚湿泛为其主因。故治疗时，以健脾渗湿为主，佐以安胎。本案重点在于温补脾阳，健脾渗湿利水，故能取得了满意的疗效。

二、妊娠恶阻

林××，女，25岁。1984年10月5日初诊。

患者受孕已将3个月，近段来出现恶心呕吐不食，口淡乏味，倦怠嗜卧，伴有头晕。舌淡苔白润，脉象缓滑乏力，证属脾虚不运，胃失和降所致。治宜健脾养胃，降逆止呕。处方：

党参 12 克	白术 10 克	茯苓 15 克
砂仁 9 克	淮山药 15 克	扁豆 12 克
陈皮 9 克	木香 9 克	半夏 10 克
甘草 6 克	生姜 3 片	大枣 3 粒

水煎服，日1剂。

10月8日二诊：服上方3剂，恶心呕吐即止，再守原方3剂，胃纳转佳，诸症消除。

按 妊娠病，在“三月前调脾胃，五月后宜壮腰肾”，是前人在临证中总结出来的一般规律。本案此即由于脾不健运，胃气不降，及随逆气上冲，自应以健脾养胃为主，佐以降逆止呕，故用参苓白术散加木香理气和滞，半夏、生姜降逆止呕。共凑补脾胃而降逆气，使恶阻得止。

三、经行泄泻

陈××,女,32岁。1985年3月15日初诊。

主诉:患者病历三载,每逢月经来潮,即发泄泻,日3~4次,虽经治疗,但时愈时患。月经周期32天,4天干净,量多、色淡、面色萎黄,饮食不思,神疲肢软,并伴有带下淋漓,腰酸背痛,舌胖苔白,脉缓无力。脉症合参,为脾肾阳虚,湿聚中焦。治拟健脾温肾,化湿调经。处方:

党参 12 克	白术 30 克	淮山药 25 克
薏苡仁 15 克	白芍 12 克	茯苓 10 克
苍术 10 克	柴胡 12 克	巴戟 10 克
陈皮 9 克	炙甘草 6 克	

6剂。水煎服,1日1剂。

3月22日复诊:药后纳谷增加,带下正常,诸症亦痊。嘱每月经前一星期,服上方3剂,如此调治3个月而愈。经随访一年余,未见复发。

按 经行泄泻多呈周期性发作,可发于经前或经期,经后则自愈。其因不外脾气虚弱,或脾肾阳虚。因脾主运化,而肾为胃之关,主司二便,经行时脾肾更虚,遂致泄泻。临床见证,虚多实少。《傅青主女科》指出:本证以脾虚为主,其论治主以健脾,辅以温肾升阳除湿。与本案药证合拍,故三载之疾治而迅捷。

四、室女闭经

刘××,女,17岁。1984年5月4日初诊。

患者月经初潮12 $\frac{3-5}{26-30}$ 天,色量正常。自述近3月经水突然

未讯,面色萎黄,精神疲倦,伴有食少便溏,腹胀,口淡无味。舌质淡,舌苔白腻,脉沉细。四诊合参,此乃脾虚中阳不振之证,治宜补脾和胃,益气养血。拟予参苓白术散加当归、川芎、熟地。嘱服4剂,文火煮,温服,1日1剂。

5月8日复诊:进药4剂,经水即潮,量少,色暗红,诸症有所改善。又继服原方,隔日1剂,调治1周。次月,经水如期而临,色量正常,随访1年,均按期而至。

按 本案由于脾虚不能运化,则生化之源不足,渐至冲任失养,血海空乏,无血可下,故成闭经。正如《兰室秘藏》云:“妇人脾胃久虚,或形羸气血俱衰,而致经水断绝不行”。因此,在治疗上以补脾益气,养血调经为主。故以参苓白术散加当归、川芎、熟地养血调经。由于药症相符,故经血自调。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《河北中医杂志》,1990年第6期。

治疗痛经经验总结

现将老师 1989 年 5 月～1993 年 5 月运用自拟通经汤治疗痛经 120 例,总结如下,以飨同道。

一、临床资料

本组 120 例中,20 岁以下 35 例,20 岁～29 岁 50 例,30 岁～35 岁 20 例,35 岁以上 15 例;年龄最小 14 岁,最大 45 岁;未婚 95 人,已婚 25 人;病程最短半年,最长 10 年。

根据行经腹痛的程度和临床表现,将痛经分为轻、中、重三度。轻度:经行小腹疼痛明显,但能坚持工作,无全身症状,有时需要止痛药。中度:经行小腹疼痛难忍,伴有腰部酸痛、恶心呕吐、四肢不温,难以坚持工作,必需服止痛药。重度:经行小腹疼痛难忍,坐卧不安,伴有腰部酸痛、面色苍白、冷汗淋漓、四肢厥冷、呕吐腹泻,服大量止痛药也无明显缓解。本组病例均为中、重度痛经,排除子宫器质性病变,月经周期基本正常,全部采用中药治疗。

二、治疗方法

通经汤组成:

柴胡 9 克	香附 9 克	陈皮 6 克
郁金 9 克	当归 9 克	赤芍 12 克
元胡 9 克	小茴香 6 克	乌药 7 克

益母草 15 克 丹参 9 克 甘草 6 克

水煎服。每日 1 剂，早晚服下。于经前 5 天开始服药，6 剂为 1 疗程。连续服用 3 个月经周期。加减法：小腹剧痛难忍者，加五灵脂、蒲黄以理气活血止痛；小腹冷痛者，加附子、艾叶以温经散寒止痛；经质粘稠者，加丹皮、黄芩、败酱草以清热凉血化瘀；经色紫暗有血块者，加三棱、牛膝以活血化瘀止痛；腰骶酸胀者加菟丝子、川断、杜仲以益肾强腰；经前乳房胀痛甚者，加橘核、瓜蒌实以疏肝理气通络；恶心呕吐者，加吴茱萸、半夏、生姜以和胃降逆止呕。

三、治疗结果

痊愈（经行腹痛及伴随症状消失，停药后连续 3 个月经周期未复发者）65 例；好转（经行腹痛及伴随症状减轻，连续 3 个月经周期未腹痛者）51 例；无效（经服药 3 个疗程，痛经未见改善者）4 例。总有效率为 96.7%。其中服药 1 个疗程获效者 50 例，2 个疗程获效者 46 例，3 个疗程获效者 20 例。

四、病案举例

洪某，女，25 岁，教师，未婚。1992 年 11 月 23 日初诊。有痛经史 8 年。14 岁月经初潮，每次月经来潮前小腹胀痛，时轻时重，剧痛时不能站立，卧床翻滚，冷汗淋漓，四肢厥冷，恶心呕吐，不欲进食，月经量或多或少，色紫暗，有血块，胸胁及两乳房作胀，烦躁，舌质紫暗，边有瘀点，苔薄白，脉沉弦。屡服西药治疗不效。现月经来潮，上症复现，而求诊于吴老。吴老审证求因，辨证为气滞血瘀痛经。治宜活血化瘀，行气止痛。方用自拟通经汤加蒲黄、五灵脂各 9 克，附子、艾叶各 6 克，橘核 12 克。服药 3 剂，诸证减轻。下次月经前守方服药 5 剂，疼痛痊愈，诸症消失。经随访，至今未再复发。

讨 论

痛经为妇科常见病、多发病。其发病原因,吴老认为主要是脏腑功能失调,导致气血运行不畅,以致子宫瘀血,胞脉不通,而产生痛经。根据祖国医学“不通则痛”之理论,吴老在治疗上着重以“通”为主,同时注意到理气。方中以柴胡、陈皮、香附、郁金疏肝解郁,调经理气;当归、赤芍、元胡、丹参、益母草活血化瘀,行气止痛;小茴香、乌药行气散寒;甘草补脾益气,缓急止痛,又能调和诸药。诸药合用,相得益彰,使肝舒气调,血脉通畅,痛经自消。

本方主要适用于气滞血瘀寒凝之痛经,现代医学之膜样痛经、子宫内膜异位症、慢性盆腔炎等所致痛经,均可在本方基础上加减治疗。

· (吴盛荣 整理)

● 原载于《国医论坛》,1995 年第 1 期。

中药治疗功能性子宫出血

吴师自 1991 年 4 月至 1993 年 4 月运用中医药疗法治疗功能性子宫出血 46 例,取得满意疗效,现总结如下。

一、临床资料

本组 46 例,年龄最小 15 岁,最大 58 岁,其中 15~20 岁者 12 例,21~28 岁者 18 例,29~38 岁者 10 例;39 岁以上者 6 例。全部病例均经妇科检查内外生殖器无明显器质性病变,并排除肿瘤、炎症、妊娠、外伤或全身出血性疾病引起出血。病程最短者 5 天,最长者为 2 年。临床表现为经血非时而下,量少淋漓,或量多如崩,血色红或暗红,或夹血块,质稠。伴见五心烦热,或有潮热,口干,头昏腰酸,夜寐不安,小便黄,大便秘结,舌红少苔,脉细数或弦细数。

二、治疗方法

基本方组成:

黄芪 20 克	党参 20 克	白术 20 克
白芍 15 克	续断 15 克	桂圆肉 15 克
乌贼骨 15 克	茜草 15 克	黑黄芩 9 克
黑栀子 9 克	仙鹤草 15 克	地榆炭 15 克
煅龙骨 15 克	煅牡蛎 15 克	阿胶 15 克(溶冲)
益母草 15 克	川七粉 2 克(另冲)	

水煎服,每口服 1 剂。

加减法:气虚不摄者加人参、升麻;血热妄行者加黄芩、地骨皮;肝气郁结者加柴胡、郁金;气滞者加香附、枳壳;肾虚不固者加杜仲、枸杞子;少腹疼痛者加蒲黄、五灵脂;纳差者加陈皮、砂仁。

三、治疗结果

痊愈(经量、经期、周期恢复正常,停药后仍然维持 3 个月经周期以上者)25 例;好转(经量、经期、周期虽恢复正常,但停药后的不能维持 3 个月经周期)19 例;无效(连续治疗 1 个月未见好转者)2 例。总有效率为 95.6%,其中服药最短为 3 剂,最长为 35 剂。

四、典型病例

黄某,女,18 岁,未婚。1992 年 5 月 20 日初诊。

患者 14 岁月经初潮,但周期不准,3~4 个月不等。本次月经来潮后,起初颜色较深,血量亦多,半个月后血量减少,但缠绵不愈,历时已将 50 余天。经西医诊断为青春期功能性子宫出血,曾服西药 1 个月(用药不详)不见好转,而要求服中药治疗。

症见面色无华,腰酸足软,身倦乏力,月经淋漓不断,色淡质薄,不思饮食,失眠健忘,舌淡苔少,脉细数无力。血常规检查:WBC $4.5 \times 10^9/L$,Hb6.0g/L,血小板: $15 \times 10^9/L$,RBC $4.0 \times 10^{12}/L$ 。B 超提示:子宫及附件未见异常。中医诊断:崩漏(气虚型)。证属冲任不固,脾胃虚弱,气血两亏。治宜固冲任、健脾胃、补气血。处方:

黄芪 20 克	党参 20 克	白术 20 克
白芍 15 克	续断 15 克	桂圆肉 15 克
乌贼骨 15 克	茜草 15 克	黑黄芩 9 克

黑栀子 9 克 地榆炭 15 克 阿胶 15 克(溶冲)
煅龙骨 15 克 煅牡蛎 15 克 川七粉 2 克(另冲)
益母草 15 克 陈皮 9 克 砂仁 6 克

日 1 剂,水煎 2 遍,早晚分服。服药 3 剂血量明显减少,余症亦减,效不更方,守上方再服 3 剂,诸症痊愈。并嘱其下次经期再服药 3 剂,巩固疗效。如法治之,恢复月经周期,诸恙亦除。随访至今,未再复发。

体 会

功能性子宫出血属祖国医学“崩漏”之范畴。本病的发生主要是肾气虚亏,脾失统摄,导致冲任二脉虚损,不能制约经血,故经血从胞中非时而下,妄行无度。吴师根据祖国医学塞流、澄源、复旧的治崩漏之法,在临床治疗中,首先应予益气摄血,固冲止血之法,以塞流、澄源,然后再以健脾益肾,养血调经法复旧。方中重用黄芪、党参、白术大补元气,即补血先补气,气旺血自生;白芍、桂圆肉、续断补肝肾、调冲任、养血摄血;仙鹤草、地榆炭、茜草凉血止血;黑黄芩、黑栀子、清热凉血;乌贼骨、牡蛎、龙骨收敛止血;阿胶养血止血;益母草、川七止血散瘀。诸药合用,益气固冲止血,标本兼顾,止血而不留瘀,故临床用于治疗功能性子宫出血,取得理想疗效。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《全国医学论文选》,新华出版社出版,1994 年 8 月第 1 版。

生姜鸡肉汤治疗妊娠恶阻有良效

本人近几年来用自拟的生姜鸡肉汤治疗妊娠恶阻共计 205 例,效果满意。

205 例中,初孕者 73 例,第二孕次者 60 例,第三孕次者 72 例。恶阻见于妊娠一个月后 84 例,2 个月后 68 例,3 个月 53 例。服药 1~2 剂 87 例,3~4 剂 112 例。4 剂后未见效者 6 例。有效率为 97% 强。未见效 6 例,随访结果,皆因病情迁延失治,导致体质虚甚。其中 1 例中断妊娠,3 例合并呃逆及虚寒性胃脘痛,2 例分娩后见胎儿发育不良。

生姜鸡肉汤用生姜(带皮切片)60 克,伏龙肝 60 克(煎取澄清液备用),童鸡(雌雄均可)1 只。将童鸡处死,去毛洗净,剖去内脏,纳生姜于腹中,置瓷钵内,然后加入伏龙肝澄清液适量,食盐少许,盖密炖烂,取汤徐徐饮之,鸡肉也可与食。每日或隔日服 1 剂。

病案举例

例一 陈某某,28 岁,家庭妇女。1980 年 4 月 13 日就诊。妊娠为第二次怀孕,停经已 45 天,尿妊娠乳胶试验阳性。证见恶闻食气,食入即呕吐,呕吐物为痰涎水液,口淡,嗜食酸咸之物。倦卧床第,形体消瘦不能自持。诊其脉滑而缓,舌淡苔白,证属脾虚湿阻,中阳不振,浊气失降。治宜扶羸益气,温中化浊,降逆止呕。方用自拟生姜鸡肉汤,每 2 日服 1 剂,连服 3 剂,呕吐止,能纳食,嘱加强营养,补偿体质消耗。足月分娩男婴,发育良好。

例二。吴某某,22岁,职工。1985年11月12日就诊。孕妇为首孕,停经已61天,尿妊娠乳胶试验阳性。证见不思饮食,恶心呕吐,喜啖酸菜,乳房发胀,倦怠乏力,嗜卧,初认为可不药而愈,及至消瘦不能下床而来院求治。诊见面色苍白,神疲倦言,语音低微,脉怠缓,舌淡苔白。证属脾胃虚惫,中阳不振,和降失司,浊气上逆。治宜温补中焦,降逆止呕,方用生姜鸡肉汤,一剂知,二剂已,连服3剂,能下床料理家务。

体 会

1、本病俗称为“病儿”,多发生于妊娠1~3个月左右,《内经》云:“冲为血海”,“妊主胞胎”,说明妊娠与冲任二脉密切关系。其生理特点为妊娠以后,血海之血专供养胎,血分遂感不足,相应的是气分有余,而冲脉之气也随之旺盛,冲脉隶于阳明,其气上逆而犯胃,胃失和降而出现恶阻。本病虽是孕妇常见之疾病,但常被忽略,如迁延失治不仅耗损母体气血,甚至影响胎儿的发育,故应重视。

2、从个人临证所见,本病的发生与年龄、职业、孕次无关,然多见于脾胃素虚的孕妇。体质愈虚,反应愈早,而且也较剧烈相应的服药次数也较多,说明本病与体质盛衰有关。本方是遵《内经》“损者益之”之旨,以辛甘温之剂,补其中而升其阳。方中生姜性味辛温,系土中之根,秉地火之味而归于根,且因其味较胜,能化浊降逆,故孙真人视为呕家之圣药。伏龙肝久经火炼,土味之甘已转为辛,土气之和已转为温,故其性味辛温。万物非土不生,人身五脏六腑非脾胃不养。本品能补脾胃,且能护胎。鸡肉甘温补脾缓胃,扶羸益气,三者合用,有补脾温胃,降逆止呕、益气生血之功,不但恶阻能平而且体质也随之增强。

● 原载于《福建中医药》,1988年第5期。

加味当归芍药散治疗胎位不正

胎位不正是妇产科的常见病。我院自 1977 年 9 月至 1982 年 12 月应用加味当归芍药散共治 217 例,收到满意的效果。现报告如下:

一、治疗对象

本文 217 例胎位不正的孕妇均系我院妇产科胎检时确诊为臀位、横位及斜位等胎位不正,其临床诊断以检查孕妇腹部胎儿先露的部位方位以及胎心为依据,如发现先露部位为臀、肩、胎方位为左、右骶前或左、右肩前均为胎位不正的征象。这些胎位不正的孕妇,大部分都通过膝胸卧位或用其它方法处理无效,妊娠 7 个月后,胎儿仍是臀位、斜位、横位而转来用中药治疗。

二、方药与用法

酒当归 9 克	焦白术 9 克	杭白芍 9 克
白茯苓 9 克	盐泽泻 9 克	酒续断 9 克
桑寄生 9 克	菟丝子 9 克	大腹皮 9 克
酒川芎 6 克	紫苏叶 6 克	陈皮 6 克

每剂水煎 2 遍,分早晚空腹时服,日进 1 剂,连服 3 剂。停药 2 天后再行复查,胎位如未转正,继服 3 剂。经服 9 剂后胎位仍未转正者为无效。

三、疗效观察

1、初产妇 87 人：

①妊娠七个月 20 人，其中服药 3 剂，胎位转正者 18 人；服药 6 剂后，胎位转正者 2 人。

②妊娠八个月 21 人，其中服药 3 剂后胎位转正者 19 人；服药 6 剂后，胎位转正者 2 人。

③妊娠九个月 46 人，其中服药 3 剂后胎位转正者 38 人；服药 6 剂后，胎位转正者 8 人。

2、经产妇 130 人：

①妊娠 8 个月 85 人，其中服药 3 剂后胎位转正者 65 人；服药 6 剂后，胎位转正者 19 人；服药 9 剂后胎位转正者 1 人。

②妊娠 9 个月 45 人，其中服药 3 剂后胎位转正者 31 人；服药 6 剂后，胎位转正者 10 人；服药 9 剂后，胎位转正者 2 人。服药 3 剂后第 4 天分娩，足先露 1 人；经服 9 剂无效臀位分娩 1 人。

体 会

经云：“冲为血海”“任主胞胎”，由此可知胞宫的功能与冲任二脉的关系非常密切。冲脉之精血充盛，才能保证胞宫正常生理功能的活动。冲任二脉调和则胞宫自无疾患。冲任二脉亏虚势必影响胎儿在胞宫内的位置改变。

笔者根据这个理论，以生血来强壮冲任二脉，维持冲任之生理功能。血生于中土，土过燥不能生物，故以当归、川芎、白芍滋之；土过湿也不能生物，故以茯苓、白术、泽泻渗之。湿燥适宜，则中气治而血自生。更助于苏叶、陈皮、大腹皮下降胎气，菟丝子、续断、桑寄生固肾安胎，诸药合用使生血有源、冲任脉盛、肾固胎安，胎儿得养，因而胎位自转正常。

● 原载于《福建中医药》，1984 年第 4 期。

孕宝治疗先兆流产、习惯性流产临床观察

一、临床资料

本组 160 例年龄最小者 20 岁,最大者 35 岁,平均为 30 岁。其中 20~25 岁 102 例,26~30 岁 45 例,31~35 岁。第 1 次堕胎者 58 例,第 2 次堕胎者 49 例,第 3 次或 2 次以上者 53 例。妊娠时间:45~60 天者 54 例,61~80 天者 45 例,81~100 天者 35 例,101 天以上者 26 例。临床表现均有停经史和不同程度的早孕反应,化验检查纯尿妊娠乳胶试验阳性者,或超声波检查为活胎,而且阴道少量出血,或有腰酸、下腹痛坠感等症状。

二、治疗方法

“孕宝”组成:

米蒸党参 15 克	土炒白术 12 克	莲肉 15 克
黑杜仲 12 克	盐黄芪 15 克	苎麻根 15 克
菟丝子 15 克	醋艾叶 15 克	酒当归 15 克
酒川芎 15 克	阿胶 15 克(蛤粉炒)	

上药晒干,各味另研,用 200 目筛斗筛过,然后混合,每 500 克药粉用蜂蜜 500 克,煮至蜂蜜捞起放于水中如龙眼干肉,放于石臼中杵至出胶,制作为丸,每丸重 9 克,然后微温烘干,收贮备用。

用法:早、中、晚饭后,每次服 1 丸(9 克),1 日 3 次,开水或米

汤送服,2周为一疗程,服药期间禁食寒凉、辛热、泻下及犯胎之品。

三、治疗结果

160例中,经治疗阴道出血停止,腰酸腹痛明显消除或减轻,B超检查胎儿存活,有胎心胎动,妊娠足月分娩者154例;通过治疗,其症状不能控制而流产者6例。总治愈率为96.3%。

四、病案举例

例一 吴某,23岁。1990年10月5日初诊。自述怀孕已将60天,纯尿妊娠乳胶试验阳性。2天前因工作劳累时有阴道少量出血。色淡伴有腹部隐痛及下坠感。经乡村医生打针服药,疗效不佳,而求诊于吴老。诊见:面色苍白,舌质淡红、苔薄白,脉沉弱。中医诊为“胎漏”、“胎动不安”,西医诊为“先兆流产”。证属肾气虚弱、冲任不固所致。方用“孕宝”治疗。用药3天,诸症大减,阴道出血已止,又投药3天,诸症消失而愈。后顺产一女婴,身体健壮。

例二 陈某,25岁。1992年1月15日初诊。自述连续流产已3胎,第2、3胎均为5个月孕期,无明显诱因,现已停经4个月,昨天发现阴道不时少量出血,色鲜红,质稀薄,腰酸,少腹绵绵作痛有下坠感伴有头晕,耳鸣,神疲倦卧,面色苍白,纳少,腹胀便溏,舌质淡、苔薄白,脉沉缓。诊断为“习惯性流产”。证属脾胃虚衰,肾气不固,冲任失养,胎系不牢。服用“孕宝”一疗程后,阴道流血消失,诸症亦瘥。为巩固疗效,嘱每月服药3天以固胎保育,后足月顺产一男婴,母子均安。

体 会

1、妇人连续流产3次或3次以上者,称为“习惯性流产”,祖国医学称为“滑胎”。妊娠期阴道不时下血或少量下血,腹部下坠之感或兼腹痛、腰酸痛称为“先兆流产”,祖国医学称为“胎动不安”。吴老认为引起滑胎、胎动不安的原因很多,其主要原因多与肾脾虚弱,气血亏损有关。因胎孕的形成,主要靠母体先天之肾气的盛实,而长养胎儿则在于母体后天之脾胃生化的气血供养,所以妊娠从胚胎乃至分娩,须由母体先天肾气和后天脾胃互相资生,才能使胞络牢固,胎有所养。肾为冲任之本,脾为气血生化之源,故对本病的治疗,除应以补肾外,还必须并用健脾之品,使肾与脾,先天与后天相互促进,以固胎元。

2、“孕宝”系吴老第六代祖传秘方,结合其50余年临床验证,选择地道药材,依法炮制,用传统医学方法结合现代科学新技术研制而成。历代沿用名为“保胎丸”,至吴老命名为“孕宝”。方中诸药配伍,具有益气健脾,养血滋阴,补肾益精,充髓壮骨,和胃安胎之功能,故对先兆流产、习惯性流产可收到立竿见影之效,确实是孕家之宝。

3、吴老强调,凡滑胎、胎动不安,母体必须受到耗损而虚衰,影响系胎的功能,故在流产后尽量避孕1年,在此期间进行调理,以固肾气滋补冲任,以保下次胎孕正常,怀孕后必须节制房事,至为重要。正如《女科证治》所谈的“保胎以绝欲为第一要策”。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《河北中医》,1994年第3期。

固胎保育饮治疗习惯性流产的临床观察

“固胎保育饮”系我县中医院吴光烈老中医自拟治疗习惯性流产的经验方,笔者近年来用该方治疗 22 例,取得显著的效果。现报告如下:

一、临床资料

本组 22 例,年龄为 20~40 岁之间,其中 21~32 岁者 12 人,32 岁以上者 10 人。流产均为 3 次以上。妊娠在 3~5 个月孕期以内有 15 人,5~7 个月孕期 7 人。所有病例孕期均有阴道流血、下腹部疼痛及腰酸等症状。

二、方剂组成及用法

组成:

莲子肉 12 克	苈麻根 12 克	糯米 12 克
杜仲 12 克	白术 9 克	菟丝子 9 克
砂仁 6 克	黄芩 6 克	桑寄生 6 克
白银 2 枚		

用法:每月 3 剂,每剂水煎 2 次,早晚空腹分服。服至超过流产月数为止。肾虚者方中加重菟丝子、杜仲;脾虚者加重白术、莲子肉;血热者加重黄芩、苈麻根;阴道流血较多者,加地榆炭、艾炭、阿胶;体质虚甚者,加黄芪、党参。

三、治疗结果

22 例经治疗后 21 例足月顺产,其中 1 例于 8 个月孕期,无原因早产一男婴夭亡。

四、病案举例

例一 洪某某,女,25 岁,安溪县人。1985 年 1 月 14 日就诊。

婚后 4 年,曾先后流产 3 胎,均为 3~4 个月孕期。此次停经将 60 天,3 天前不明诱因突然出现阴道流血,经当地医生用黄体酮、维生素 E 等治疗无效,而求诊于我院。证见阴道流血、色鲜红、量多,伴有下腹部疼痛、腰酸、头晕眼花、手足心热,舌红、苔薄黄,脉沉细数。拟属肾虚血热之症,治宜补肾安胎,清热止血。处方:

杜仲 15 克	菟丝子 15 克	苎麻根 15 克
莲子肉 12 克	糯米 12 克	白术 9 克
黄芩 9 克	地榆炭 9 克	阿胶 9 克(另包溶化)
桑寄生 9 克	砂仁 9 克	艾炭 6 克
白银 2 枚		

水煎服,3 剂。

1 月 17 日二诊:服上药 3 剂后,阴道流血大减。继服 3 剂。

1 月 20 日三诊:阴道流血告止,诸症亦痊。嘱按原方每月连服 3 剂,服至六个月孕期后,足月顺产一男婴。

例二 吴某某,女,28 岁,南安县人。1985 年 5 月 5 日初诊。

自述连续流产已 4 胎,第一胎为三个月孕期,第二、三胎均为五个月孕期,第四胎为六个半月孕期。每次迭经中西药保胎治疗无效,至今尚无子女,甚感苦闷。就诊时停经已四个月,昨天发现阴道少量出血、色淡红、质稀薄,伴腰酸,下腹坠胀感,恶心、纳差、腹胀

便溏、神疲倦卧，面色苍白，舌淡苔薄，脉沉缓。证属脾阳虚衰，肾气不固，冲任失养，胎系不牢之故。治拟健脾固中，补肾安胎。处方：

党参 15 克	白术 15 克	莲子肉 15 克
糯米 15 克	杜仲 12 克	黄芪 12 克
苎麻根 12 克	砂仁 6 克	桑寄生 6 克
黄芩 6 克	菟丝子 9 克	白银 2 枚

水煎服，3 剂。

5 月 8 日二诊：服上药 3 剂后阴道流血消失，原方继服 3 剂，以巩固疗效。

5 月 11 日三诊：未再阴道流血，诸症亦瘥。嘱每月按原方服 3 剂以固胎保育，足月顺产一男婴，母子均安。

体 会

1、妇人连续流产达 3 次以上者，称为习惯性流产。祖国医学称为“滑胎”。其病机与先天肾气的盛衰及后天脾胃的强弱有密切的关系。因胎孕的形成主要靠母体先天之肾气的盛实，而长养胎儿则在于母体后天之脾胃生化的气血供养。所以妊娠从胚胎乃至分娩，须由母体先天之肾气和后天之脾胃，互相资生，才能使胞络牢固胎有所养。肾为冲任之本，脾为气血生化之源，故对本病的治疗，除应以补肾外，还必须并用健脾之品，使肾与脾，先天与后天相互促进，以固胎保育。方中莲子肉补脾且清君相之火而固涩；苎麻根清热止血安胎；糯米、白术、砂仁健脾和胃；杜仲、菟丝子、桑寄生固肾；黄芩、白银清热安胎。诸药合用，既补先天之肾，又健后天之脾，兼清热而安胎，自无流产之虞。

2、因连续流产三胎以上，母体必须受到耗损而虚衰，影响系胎的功能。因此治疗本病应强调提前预为调补脾肾，即在下次妊娠之间要注意调理。同时怀孕后必须节制房事，避免重体力劳动及消除

恐怖流产的精神负担。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《福建中医药》,1989 年第 3 期。

宫外孕治验

“宫外孕”，又称“异位妊娠”，是妇科常见急腹症之一，从临床症状与体征表现，系属于祖国医学“经闭腹痛”、“血结成症”的范畴。临床以经闭突然一侧下腹部剧痛，内出血或阴道出血，盆腔包块，甚至休克为特征。我院妇产科于1982年5月至11月采取中西医结合以中医中药为主共治疗4例，使病人免于手术的痛苦而达到治愈，收到满意的效果。实践证明，中医中药也能治疗急腹症。现略举两例就正于同道贤达，作为引玉之砖。

例一 刘××，31岁。住院号：106848

1982年5月12日午夜以阴道流血、右下腹部撕裂样剧痛为主症而入院。

自诉：素禀虚衰，停经已36天，右下腹部突然撕裂样剧痛、伴阴道流出黯红色无异味的血液持续不绝，恶心呕吐，里急后重等症。检查体温37℃，脉搏78次/分，呼吸20次/分，血压90/60mmHg，神志清楚，表情痛苦淡漠、面色苍白、口唇青紫、冷汗淋漓、四肢厥冷，右下腹可触及包块推之不移，揉之不散，疼痛拒按。妇产诊断为“宫外孕”即予输血止血，抗休克、抗感染等急救措施和对症治疗，经20多小时后症状缓解，但腹痛仍不止，阴道流血不绝。14日晨决定用中药进行治疗，请予会诊：脉细微，舌质淡胖、舌边有齿痕、舌尖有瘀点、苔薄白。证属气虚血瘀，治宜益气活血、行瘀止痛。处方：

黄芪 15 克	当归 9 克	川芎 9 克
赤芍 16 克	桃仁 9 克	香附 9 克

红花 6 克 五灵脂 9 克 生蒲黄 9 克

苡仁 15 克 冬瓜仁 15 克

水煎服,2 剂。

5 月 16 日二诊:自觉腹痛减去大半,阴道流血也明显减少,食欲有所增进,精神也较前好,脉舌同上。药已中病,因患者体质素弱,遵《内经》训:“大积大聚,衰其半而止”。巩攻伐太过伤其正气,故原方去桃仁、红花,辅以党参、白术各 15 克、生姜 3 片、大枣 3 枚。以扶正气,嘱服 3 剂。

5 月 19 日三诊:下腹部尚有轻微隐痛,阴道流血量极少,包块转软,可按,嘱续服 2 剂。

5 月 21 日四诊:下腹部痛及阴道流血均已告止,包块基本吸收,食欲正常,诸症若失,要求出院,给补益心脾之归脾汤嘱服 6 剂。善后调理用党参 15 克、茯苓 15 克、白术 10 克、黄芪 15 克、当归 6 克、淮山 5 克、生姜 3 片、大枣 3 枚,合牲物炖服。最近随访未见复作,无任何不适,正常上柜台工作。

例二 陈××,31 岁。住院号:114624。

1982 年 11 月 8 日以下腹部持续性疼痛,伴阵发性加剧阴道流血为主症而入院。

自诉:停经 39 天,突然左下腹部持续性剧痛伴呕吐腹泻。经当地医生诊断为蛔虫痛给予驱虫后,拉出蛔虫体 3 条,但症状仍未改善,甚而出现阴道流血淋漓不绝,大便秘结,咳嗽或大便时左下腹部疼痛更甚。

检查:体温 38.2℃,脉搏 117 次/分,呼吸 20 次/分,血压 120/70mmHg,神志清楚、痛苦病容,面色苍白、时欲昏晕。妇检:外阴道已产式,宫颈糜烂(Ⅲ)、色紫,宫体后位,左侧宫房有一肿物约 4×5cm、质硬、移动性差、有压痛感,后穹窿部穿刺抽出黯红色血液 4ml、不凝固,妇产科诊断为“陈旧性宫外孕”,给予抗感染药物结合对症治疗。腹痛及阴道出血仍未见改善,当天下午四时决定用中

药治疗,请予会诊:脉弦数,舌质黯红、舌苔黄厚,证属瘀热内阻,治宜清热通下、行瘀理痛。处方:

大黄 15 克	生地 20 克	当归 15 克
桃仁 9 克	川芎 9 克	赤芍 9 克
元胡 12 克	煅乳香 9 克	五灵脂 9 克
生蒲黄 9 克	煅没药 9 克	

水煎服,2 剂。

11 月 10 日二诊:大便已解,左下腹疼痛减轻,阴道流血也明显减少,脉舌同上。药已中病,原方继服 2 剂。

11 月 12 日三诊:左下腹部疼痛告止,包块转软,阴道流血已止,脉弦,舌质红、苔黄。以上方去大黄、桃仁、煅乳没加黄芪 15 克、党参 15 克、白术 12 克、嘱服 3 剂。

11 月 15 日四诊:食欲如常、包块缩小且无压痛,自感无任何不适,要求出院,给当归 9 克、黄芪 12 克、党参 12 克、白术 10 克、怀山 10 克、茯苓 15 克、生地 15 克。嘱配合牲物炖服,作为善后调理。最近随访无所痛苦,正常参加农业劳动。

上述二例患者均属祖国医学“症积”的范畴,其病因病机虽不同,然主要矛盾都为瘀血内聚经脉流行不畅,而致宫房包块腹部剧痛、阴道流血淋漓不绝,故前贤有“通则不痛、痛则不通”和“瘀血不去、新血不得归经”之说。根据“急则治其标、缓则治其本”和“辨证求因、审因论治”的原则,先抓主流,治以破坚散结、祛瘀止痛,而不急于固涩止血之法,一俟腹痛缓解,阴道流血量减少,说明药中病机,脉络气血运行通畅,即遵《内经》之旨,“大积大聚,不可犯也,衰其大半而止”,方中即逐渐减去活血祛瘀之品,而增入补血之剂,达到破中寓补、攻邪而不伤正,是毋犯虚虚实实之戒。

“症积”之形成,《内经》所谓:“壮者气行则已,怯者着而成病”,说明其发病机制与正气不足有关,故善后调理以补益心脾之药配以血肉有情之牲物炖服,使其补益血气之力更甚,达到血旺以生气

载气，气旺以帅血生血。其所以要从补益心脾入手者，盖《内经》云：“心为君主官”，“心主身之血脉”，“心者神之舍也”，说明心是人体主要脏器，生命活动的主宰，是运行血液的原动力，所有一切的精神意识思维都归之于心的功能。根据前贤的经验，补心能焕发五脏六腑之机能，促进气血运行通畅，精神充沛，思维敏捷。又脾胃为水谷生化之源，五脏六腑、四肢百骸皆赖以养，古人对脾土非常重视，《内经》有土为万物之母，喻加言有“执中央以运四旁”之论。从现代学说，补脾可以盛旺消化系统之生理，调节代偿功能，促进胃肠消化吸收。由于调理得法，故患者恢复迅速，出院未几，就正常参加工作或农业劳动。前贤所谓：“心脾健、则血自充”之说，诚不谬也。

● 原载于《泉州中医》，1984 年第 1 期。

健脾和胃汤治疗小儿消化不良

小儿消化不良临床较为常见,吾师近几年来采用自拟“健脾和胃汤”,治疗本症 200 例,取得较好疗效,现报道如下。

一、临床资料

本组 200 例中,年龄最小为 60 天,最大为 8 岁;病程最短为 5 天,最长为 2 个月。临床均有泄泻、呕吐、发热见症。大便呈绿色或蛋花样,镜检可见脂肪球及不消化物,偶有白细胞。便次 1 日最少 6~7 次,最多 20 多次。多数患儿曾用西药治疗未见效果,而要求用中药治疗。

二、方药组成

车前子 6 克	山楂炭 6 克	苍术 6 克
泽泻 6 克	茯苓 6 克	砂仁 3 克
木香 4.5 克	槟榔 4.5 克	罂粟壳 2 克
甘草 3 克		

加减:外感发热、呕吐者加藿香 5 克、半夏 5 克;湿热较重,腹痛便不爽或带有浓沫、舌苔薄黄质红者加葛根 3 克、黄芩 3 克、白头翁 3 克;伤食者加炒麦芽 6 克、鸡内金 3 克;脾阳虚者加炮姜 2 克、附子 3 克;脾虚下陷、久泻脱肛者加黄芪 9 克、升麻 5 克、诃子 3 克;伤阴者加乌梅 3 粒。水煎浓缩成 200ml,1 日多次少量频频服

完。(上方系3岁左右小儿之用量。)

三、治疗效果

临床治愈165例,好转30例,无效5例。其中服药3~5剂泄泻即止者125例;服5~7剂泄泻止,病情好转者46例;服7~10剂病情减轻者24例。总有效率为97.5%。

四、典型病例

刘某,男,3岁。1992年10月20日初诊。其母代诉:患儿肠鸣泄泻已将6天,泻出不消化谷物、酸臭味伴有腹胀,日7~8次。曾用西药乳酶生、氟哌酸等治疗,均不见明显效果,而要求服中药治疗。诊见:患儿精神萎靡,纳差呕吐,肠鸣,泄泻。大便如水样伴有不消化谷物,酸臭。粪检:脂肪球(+++),白细胞少许,苔白腻,脉数。证属:饮食内停,内生湿热,脾胃损伤,运化失司所致。方用自拟“健脾和胃汤”加味。处方:

车前子6克	山楂炭6克	苍术6克
泽泻6克	茯苓6克	砂仁3克
木香4.5克	槟榔4.5克	罂粟壳2克
藿香3克	半夏4克	甘草3克

服药3剂,泄泻即止,大便成形。但仍有腹胀呕吐,肠鸣,嘱按原方继服2剂,诸症消失,精神转佳。

体 会

小儿消化不良属祖国医学“泄泻”、“呕吐”、“疳积”之范畴。由于小儿脏腑娇嫩,形气未充,故无论感受外邪,还是内伤乳食,均可

导致脾胃的运化功能失调而发生泄泻。方中用车前子、泽泻能通水道，使邪浊从小便出；山楂炭、砂仁消乳化石，和中开胃；苍术、茯苓燥湿健脾；木香、槟榔调中宣滞，行气消积；罂粟壳涩肠止泻；甘草调和诸药。综上合参，具有健脾和胃，涩肠止泻之功。

本文 200 例患儿绝大部分都是在用西药治疗无明显好转情况下，运用健脾和胃止泻治疗，所以一般病程较长，病情较重。但小儿脏气清灵，只要辨证确切，用药得当，有时服药 1~2 剂亦能取得显著疗效，转危为安。

（吴盛荣 整理）

- 原载于《临床专病治验辑要》，中国中医药出版社出版，1994 年 9 月第 1 版。

健脾消积粉治疗小儿厌食症

厌食症是小儿临床常见症之一。临床上以食欲不佳或不欲食，痞满恶食，暖腐吐酸或吐泻酸臭乳食为其主要特征。吴师近年来用自拟“健脾消积粉”治疗小儿厌食症 32 例，获得较好疗效。现简介如下：

一、一般资料

本组 32 例，其中男性 18 例，女性 14 例；年龄最小 3 岁，最大 12 岁；病程长者达 2 年，短者近一个月；疗程最短为一星期，最长为 20 天。

二、方药组成及配制

淮山药 120 克	苡仁米 120 克	芡实米 100 克
山楂 60 克	神曲 60 克	麦芽 60 克
槟榔 60 克		

上药共研为细粉，混合拌匀，用开水或米汤调服，每日 3 次，每次 9 克，（此为 3 岁小儿量，可根据患儿年龄和患病轻重的差异而增减）。10 天为一疗程。

三、疗效观察

服用一疗程后，食欲增加，食量正常者 25 例；食欲稍增加，但

• 156 •

食量尚未达正常者 6 例,无明显好转者 1 例。

四、病案举例

例一 刘××,男,3岁。1988年3月12日初诊。患儿其母代诉:食欲减退已半年,伴有经常腹胀,时有呕吐。检查:发育正常,营养欠佳,形体消瘦,面色苍白,腹部胀满,舌红苔薄白,脉细弱。此乃脾胃虚弱,治宜养脾健胃,消食化滞。方用健脾消积粉。每日3次,每次9克,米汤调服。服药一疗程后食欲大增,腹胀已消,面色转红,诸症痊愈。

例二 吴××,男,8岁。1988年4月1日初诊。厌食已一年余,若稍进饮食,大便中夹有不消化谷物,伴有腹胀,大便溏,面黄肌瘦,四肢软弱无力。舌质红、苔白、脉沉细。证属脾胃气虚,治宜健脾益气 and 胃。方用健脾消积粉,每日3次,每次15克,开水冲服。服一星期后,食欲增加,大便转为正常。为巩固疗效,嘱继服一星期,后复查食欲正常,诸症痊愈。最近随访,一切正常,未见复发。

按 厌食症是小儿最常见的疾病,因小儿脾胃虚弱,脏腑娇嫩,如果喂养稍有不当,饮食无节制,纵食肥甘厚味,生冷瓜果及不易消化的食物,最易损伤脾胃,脾胃愈虚则愈难运化,形成恶性循环,终成气血虚惫,以致形成纳呆、食欲不振、肌肉消瘦、腹胀泄泻、贫血等症。本方用淮山药养胃生津、补气、助消化;苡仁米健脾除湿,补土升阳;芡实健脾固涩等为主;再加山楂、神曲、麦芽、槟榔消食化滞,行气消积为辅。全方具有健脾养胃,消食化滞,行气消积,善补后天之本,故为治疗小儿厌食症之良方。本方药物无副作用,小儿乐意服用,长期服用有益无害。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《河北中医》,1990年第1期。

消痞健儿散治疗小儿疳积的疗效观察

吴师自 1990 年 6 月至 1992 年 10 月,在门诊试用自拟“消痞健儿散”治疗小儿疳积 120 例,进行了临床疗效观察,取得了显著的疗效。现简介如下:

一、一般资料

120 例患儿中,男性 64 例,女性 56 例。其中 1~2 岁者 20 例,2~3 岁者 32 例,3~5 岁者 28 例,5~7 岁 26 例,7~10 岁 14 例。年龄最小 1 岁,最大 10 岁。临床症状均出现不同程度的形体干枯羸瘦,气血不荣,头发稀疏,精神疲惫,腹部胀大,青筋暴露或者腹如舟状,饮食异常等为其主要特征。

二、方药组成

自拟“消痞健儿散”方:

白术 20 克	党参 20 克	神曲 25 克
山楂 25 克	麦芽 15 克	谷芽 15 克
陈皮 15 克	槟榔 15 克	使君子 30 克
砂仁 15 克		

上药共研成细末,制成散剂,早晚各服 1 次,开水冲服,或加白糖拌匀冲服。1 岁内儿童每次服 2 克,1~3 岁每次服 3~5 克,3~5 岁每次服 7 克,5 岁~10 岁每次服 10 克。10 天为一疗程。

三、治疗效果

痊愈(经治疗 1~2 个疗程,症状完全消失者为痊愈)80 例;好转(经治疗 2 个疗程,临床症状有所改善者为好转)35 例;无效(经治疗 2 个疗程,症状无改善者为无效)5 例。总有效率为 96%。

四、病案举例

陈某,男,5 岁,1991 年 8 月 12 日初诊。

患儿 3 个多月来,面色萎黄,毛发枯槁,形体消瘦,精神不振,不思饮食,腹如舟状,大便完谷不化,小便有时如米泔,舌质淡红,唇淡苔腻,脉濡细。证属禀赋不足、脾胃气虚所致,治宜消疳益气健脾。方用:自拟“消疳健儿散”。治疗 2 个疗程,诸症消失。后经随访一年余,体健活泼。

体 会

“疳积”是中医儿科四大证之一。包括“积滞”和“疳证”,是两个性质不同又相互联系的疾病。内伤乳食过久,停聚不化,气滞受阻,伤及脾胃,经久不愈而成积;积久不消,迁延失治,脏腑气血运化失调,气液亏损,渐至身体羸弱,转化而成疳,故有“无积不成疳”之说。虽各异而其源一,唯病情证候有轻重深浅不同。本病与现代医学的小儿消化不良,营养吸收不良,某些肠寄生虫病,多种维生素缺乏等综合性病症相似。其病因病机主要由于饮食不节或嗜食肥甘生冷等不易消化食物,损伤脾胃,致使运化失职,升降失调,水谷精微化生不足,气血生化失源,脏腑肌肤皮毛失养而成。《幼幼集成》云:“夫疳之为病,亦小儿患候,……皆真元怯弱,气血衰之所致也。”

究其病源,莫不由于脾胃。”故吴师拟“消疳健儿散”,以健脾益气,开胃进食,消食导滞,去积杀虫之功效,而取全功。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《首次全国农村中医药学术交流会论文集》,中国自然科学出版社出版,1993年12月第1版。

麦冬橄榄汤治疗小儿夏季热

小儿夏季热乃小儿夏秋季的常见疾病。我院中医科自1980年7月至1984年8月,用自拟的麦冬橄榄汤治疗单纯性的小儿夏季热40例全部获愈。现报道如下:

一、临床资料

全部病例发病都在暑夏季节,具有发热不退,手足心热,尤以脑后尤甚;口渴引饮,虚烦,少汗或无汗,小便清长,并分别伴有夜寐不宁,精神萎靡,时作呵欠,喜卧冷地等小儿夏季热的典型症状。40例中,男性39例,女性1例;年龄最小为5个月1例,9个月1例,其余都在2~4岁之间;体温最低为38℃,最高为39.5℃;病程最短为15天,最长为3个月;服药最短为3天,最长为12天体温恢复正常。

二、方剂的组成及用法

麦冬15克,盐橄榄1~2枚,田蛙1只(田蛙即田里的水蛙,《本草纲目》亦名:田鸡、青鸡、青蛙,《中国药学大辞典》拉丁学名为*Rana, esculenta*)。将田蛙洗净,剖去肠杂,纳入麦冬,盐橄榄于田蛙腹中,外以针线缝牢,加水适量,炖汤取服,日服1~2剂均可。病程长,体质虚弱者加西洋参炖服;口渴引饮甚者用鲜丝瓜皮,大枣煎作饮料。

三、病案举例

例一 王××,男性,2岁。1980年8月5日初诊。

其祖父代诉:小孙前年患过夏季热,近半个月来又复发,体温持续在38℃左右,旦暮无异,口渴、少汗、多尿、纳食不佳,入夜则烦躁不安,经治疗未效而来我院中医科就诊。证见:手足心热,脑后肤热灼手,脉浮数乏力,指纹色赤,舌唇干红、苔微黄而干。此乃暑热伤阴,治宜清暑益气,养阴生津。方用麦冬橄榄汤,每日1剂,嘱服3剂。

家属9月25日来院告曰:患儿服药后,热退,纳佳。为巩固疗效,又续服数次,经随访未再复作。

例二 黄××,男,3岁,南安县美林公社西埔大队人。1983年7月15日初诊。

其母代诉:小儿发热已达3个月,体温持续38~38.5℃左右,喜卧冷地,口渴多饮、无汗、多尿、纳食不佳,入夜则烦躁不安,经当地医疗所治疗,热仍未解而来我院中医科就诊。证见:精神萎靡,形体羸瘦,手足心热,脑后肤热独甚,脉细数,重按无力,唇舌干红、少津乏苔。此乃暑热伤阴,元气亏损。治宜清暑养阴,培元固本,方用麦冬橄榄汤加西洋参2克,每日1剂,嘱服3剂,间用鲜丝瓜皮15克,红枣5粒,煎作饮料。

7月17日复诊:其母告曰:服上方2剂后,口渴止;3剂服完就不再卧冷地。嘱再服3剂。

7月23日三诊:热退诸症消失,纳食增进,嬉戏如常。为巩固疗效,嘱再进3剂。今年夏季随访,小儿身体健康,未见复作。

例三 陈××,男,5个月,本县仑仑公社,大泳大队人。1984年8月2日初诊。

其祖母代诉:小孙发热已一个多月,体温持续在38~38.8℃

之间,哭则汗出,但热不解,口渴引饮,以午后及入夜为甚,小溲频而清长,经××医院治疗11天,热仍未解,而来我院中医科求治。证见:患儿精神萎靡,形体羸瘦,手足心热,脑后肤热灼手,指纹红,唇舌干红、少津乏苔。此乃暑热伤津耗气,治宜清暑益气,养阴生津。方用自拟的麦冬橄榄汤加西洋参1.5克炖服,每日1剂,连服3剂。

8月5日复诊:体温降至 $37\sim 37.5^{\circ}\text{C}$,口渴引饮及多尿均明显减少。药已中病,效不更方,嘱继服3剂。

8月9日三诊:患者体温正常,诸证悉痊。为巩固疗效,嘱再继服3剂。

11月12日,患者之祖母因病来诊,谈及其小孙体健如常,情况良好。

体 会

1、根据小儿夏季热发病季节及典型的临床症状,系属于祖国医学“暑热症”、“疰夏”的范畴。《内经》云:“其在天为热,在地为火,……其性为暑”,说明了暑邪来自炎热的季节。小儿阴阳稚弱,气血未充,真元不足,腠理不固,其营内卫外功能未臻完善,容易感受暑邪而发病。暑热犯肺,肺失其主皮毛开启之功,故少汗或无汗;暑热内蕴,伤及肺胃,故口渴引饮纳少;暑必伤气,气虚下陷,不能化水为津液,遂致水液下趋,故尿清长。汗少热更甚,尿长津益伤,故形体日见羸瘦。

2、本病暑邪最易伤津耗气,治宜清暑益气,养阴生津为法,忌用苦寒重伤胃气,又忌辛燥温肺,耗津助热。笔者根据其发病机制,多年来用自拟的麦冬橄榄汤治疗屡收良效。本方中田蛙味甘性寒,味甘能补虚损,性寒能清暑热,为血肉滋补之品;麦冬甘寒润肺,养胃生津,调中益气;橄榄入肺胃,生津止渴,其性味酸甘涩平,加盐

制作,不但可去其酸涩之味,益增养阴、健胃、凉血、润燥之功。三药合用,具有清暑益气,养阴生津,培元固本之效。且此药味道鲜美,小儿易于接受服用,是营养食物与药物相结合,别开生面的扶正祛邪之方。

3、对本病的复发问题,笔者经作了随访,凡是儿童身体健壮的,翌年夏季未见复发。患有疳积病的复发率最高,说明了暑邪是一种外因,更主要的是患儿体质虚弱,虚则抗邪之力不足,是本病的内因。因此,加强对儿童病后及平时身体的调摄是非常重要的。故《内经》有“正气内存,邪不可干”和“邪之所凑,其气必虚”之说,诚不谬也。

● 原载于《福建中医药》,1986年第1期。

民间中草药治疗脓肿验案三则

民间中草药遍地皆有,用之不竭,取之不尽,深受广大人民群众所喜爱。现将治疗脓肿验案三则介绍如下,以飨同道。

一、算盘子根(又名山桔子)治疗多发性疖肿

多发性疖肿系暑邪蕴于肌肤、郁久化热成毒,每当盛暑之时发于儿童之头面部。初呈锥形隆起,焮红硬肿,继则疼痛发作,尖端破溃流脓,此愈彼起,可连达10余个,枕部不可近床。余临床每用算盘子根配合猪头皮炖服,不但现症可愈,翌年可免复发,诚民间之验方也。

处 方

算盘子根 15~30 克,猪头皮适量,食盐少许,加水炖汤,早晚分服,每日1剂,可连服4~5剂。

典型病例

林××,男性,7岁。3年来每当夏季头面部即长疖子,多则10来个,肿硬疼痛。破溃后流出稠脓,此愈彼起须待秋凉后始渐平息。今夏仍再发作,经用抗生素治疗效果不佳而就诊。证见:患儿头面部有3个疖子已化脓将愈,还有5个疖子大小不等,焮红肿硬,触之疼痛不已。脉弦、舌质红、苔黄。药用算盘子根15克合猪头皮炖

服,每日1剂,连服5剂,红肿消散。经随访,翌年夏季未见复发。

注 算盘子又名山桔子,为常绿小灌木。茎直立、多分枝,表面灰褐色,叶互生、矩圆形或矩卵形,先端钝尖,叶面除中脉外近秃净,叶背披短柔毛,全缘、短柄。夏秋叶腋间开黄绿色的花,花后结球状蒴果,外有纵沟,胞背裂开,露出种子四、五颗。生长于山野路旁干燥地。其性味功能苦平,有小毒。散瘀活血、清热消炎。

用猪头皮之义有二:一是按中医传统取其以头治头。二是猪头皮有毒,取其以毒攻毒从治也。

二、黄花稔根(又名雪米草)治疗牙槽脓肿

牙槽脓肿系牙槽部感受风热毒邪而致。红肿硬结疼痛,张口困难,有因牙齿之病而发作,也有单独感染,治疗失当,常可导致化脓,缠绵难愈。用黄花稔治疗,可免除溃烂的痛苦。

处 方

内服:黄花稔根45克、陈旧乌贼干(墨鱼干)1只,绿豆15克,食盐少许,加水炖汤,每日1剂。上下午分服,可连服3~5剂。

外涂:取黄花稔鲜叶适量,合饭粒捣烂,调涂患部,每日1次。

典型病例

林某某,女,40岁。无原因右牙槽硬结红肿已4天,张口困难,不能咀嚼,明显压痛,畏冷发热,口干欲饮,大便干结,小便短赤,但全身情况及精神尚好。脉弦数,舌质红、苔黄。此属毒热壅盛,气血阻隔;治宜清热解毒,消肿散结。方用黄花稔根绿豆乌贼汤内服3剂,外用黄花稔鲜叶合饭粒捣涂患部,共治疗5天而愈。

注 黄花稔又名雪米草,为亚灌木草本,高2~3尺,茎直立,

上面分枝,稍生柔毛,叶卵形,先端渐尖,基部浑圆,边缘有锯齿,具短柄,互生。秋冬季叶翼抽短花柄,开黄色花,萼管绿色近球形,花后结果实如肾形。生长于山地,旷野,园地,路旁。其功能消痈解毒;陈旧乌贼干(墨鱼干)通血脉疗疔疮恶肿;绿豆清热解毒。三药合用具有清热解毒,消痈散结,其效如神。

如夏天皮肤容易破溃化脓,用黄花稔根部 15~30 克合猪瘦肉炖汤取服具有良效。

三、入骨丹(又名茜草根、血见愁)治疗臀痈

臀痈(又名筋痈)发于臀部皮下肌肉间之急性脓疡,常因湿热,火毒蕴结而成。其病位深,范围大,此伏彼起,可连续发生数个,俗谓“痈母煮痈子”是也。患部红肿热痛,患侧步行困难。肿块成脓后不易自溃,脓液稠厚而多。疮口深,容易形成大块肌肉坏死,收口缓慢。民间中草药入骨丹配合外灸治疗屡收良效。

(外灸法:用艾条点燃后薰于患部,每日 1~2 次。)

典型病例

刘某某,男性,30 岁。左臀部初起有一小肿块,不痛不痒未引起注意,及后范围逐步扩大红热肿痛明显,患肢步行困难,畏冷发热。近一周来肿块化脓中软,难溃,周围又再发作三个小疙瘩,肿硬疼痛,寝食难安。脉弦数,舌质红、苔黄。证属热毒蕴结,治宜清热解毒,活血散瘀。药用入骨丹 60 克,猪头皮适量,食盐少许,加水炖汤早晚分服。另用艾灸臀部肿块。先从最初发现的肿块灸起,然后逐处如法照灸。内服与外灸相结合,连续处理三天后,将溃的肿块流出稠脓甚多,红肿渐消,其它小肿块发展告止,疼痛消失。如法继续治疗 5 天,已溃疮口愈合,其它小疙瘩消失。

注 入骨丹系多年生草本植物。根赤褐色,不整齐之圆柱形。茎细弱,四棱,沿棱生细小逆刺下部老茎呈木质化。叶四片轮生,叶片卵圆形或长卵形,先端钝尖,基部心形或圆形,边缘密生小逆刺。花腋生或顶生,花小黄白色,球形浆果成熟呈红色。生于山坡,溪旁,山路旁,灌木丛林中。其功能清热解毒,祛瘀排脓。用于疔痈有特效。《本经》云:久服益精轻身。(中药房随处可购)。猪头皮有毒,取其以毒攻毒,此从治之义也。

● 原载于《中国民间疗法》,1994年第6期。

清里解毒汤治疗急性淋病

吴师 1990 年 5 月至 1992 年 8 月用自拟“清里解毒汤”治疗急性淋病 58 例,取得显著的疗效。现简介如下:

一般资料

本组病例中,男性 42 例,女性 16 例;年龄最小 18 岁,最大 55 岁,以 20~45 岁为最多。未婚 6 例,已婚 52 例;夫妻感染 13 例,个体商贩 20 例,供销人员 23 例,司机 7 例,工人 5 例,农民 3 例。诊病时间最短为 2 天,最长为 10 天,大多为 5 天内就诊。

全部病例均符合淋病诊断标准,临床均有不同程度的尿频、尿急、尿痛、尿滴沥、尿道口红肿并有脓性分泌物流出;女性均有外阴瘙痒,白带多而腥臭味,外阴部充血,尿道口、阴道口有脓性分泌物。

实验室经直接涂片检查均可见淋病双球菌。男女病例舌苔多黄腻、舌质红,脉弦数。

治疗方法

自拟“清里解毒汤”

白花蛇舌草 30 克	土茯苓 30 克	大黄 15 克(后下)
生地 15 克	炒穿山甲 12 克	皂刺 12 克
银花 12 克	连翘 12 克	黄连 9 克

木通 9 克 车前子 20 克 甘草 6 克

每日 1 剂,水煎 2 遍,早晚分服;第 3 遍煎汤浸洗患部,每次浸洗 15 分钟。7 天为 1 疗程。服药期间禁房事、忌辛辣肥甘食物、戒酒热之品。

治疗结果

疗效标准:痊愈:症状与体征全部消失,化验检查一切正常,随访一年未发者;好转:症状与体征消失或明显改善,化验正常,但停药后 6 个月内有复发者;无效:症状和体征无改善,化验一直不正常。

结果:58 例中,经 1 疗程治愈 35 例;2 疗程治愈 15 例;3 疗程治愈 5 例;其余 3 例经治疗无显著效果而改用西药及打针治疗。总有效率为 94.8%。

典型病例

张某某,男,23 岁,已婚,供销人员,1990 年 10 月 13 日初诊。

患者自诉于 10 天前到外地搞供销工作,在外与异性发生关系。5 天后发生尿频、尿急、尿痛、尿滴沥,尿道口红肿并有脓性分泌物流出,经某医院采集尿道涂片检查发现有淋病双球菌。经用西药治疗效果不佳,而求诊于吴老。诊见舌质红、苔黄腻、脉弦数伴有口苦便干。根据其病症状符合急性淋病。证属下焦热毒,湿浊壅盛所致,治拟清热解毒,利湿化浊,祛瘀通淋为其治疗大法。方用自拟“清里解毒汤”治疗,7 天后而告痊愈,随访未再复发。

讨 论

急性淋病是由于性交不洁而引起的泌尿系统传染病,临床上并非少见,属于祖国医学“淋症”、“白浊”之范畴。吴老认为本病病机系冶游感受恶秽之邪,邪毒蕴结下焦,以致膀胱气化不利,化生湿热而引起。故清热解毒、利湿化浊、祛瘀通淋为其治疗大法。方中重用白花蛇舌草、土茯苓清热解毒,量虽大未见副作用;生地、银花、连翘、黄连清下焦湿热,泻火毒;大黄泻火通便,可使邪从大便而出;木通、车前子利水通淋,可使邪从小便而去;穿山甲、皂刺托里清热,散瘀败毒;甘草调和诸药,止茎中疼痛。综观全方,清利结合,相辅相成,二便通利,邪有出路,故收获甚捷。

本组 58 例,有冶游史 45 例,说明洁身自爱非常重要。本病不是终生免疫的疾病,不洁性交之后,仍可感染,应劝告患者不再重患,以免危害健康。

吴老经验,上方也可兼治其他性病,然处方用药,贵在知常达变,随证灵活加减。他强调治病要谨守病机,见微知著,就不要轻易改方,以免影响疗效。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《实用中西医结合杂志》,1994 年第 7 卷。

治疗软性下疳总结

吴师在 1989 年 2 月至 1992 年 4 月用其家传验方“清里解毒汤”(内服)、“四味扫毒膏”(外敷)治疗软性下疳 45 例,取得显著的疗效。现总结介绍如下:

一、临床资料

本组 45 例,男性 32 例,女性 13 例;年龄 20 岁~25 岁 33 例,26~35 岁 8 例,36 岁~40 岁 4 例;未婚 5 例,已婚 40 例;有冶游史 40 例,夫妻感染 5 例;个体户 10 例,供销人员 12 例,司机 8 例,工人 8 例,待业人员 3 例,其他人员 4 例;全部患者在不洁性交后最短 7 天,最长 40 天出现症状,其中发于冠状沟者 14 例,龟头 1 例,包皮系带 10 例,包皮口 7 例,大阴唇内侧 6 例,小阴唇内侧 4 例,阴道 1 例,阴蒂 2 例;溃疡部均有黄色的脓性分泌物和轻重不同的疼痛感。所有患者均在其他医院采集溃疡面渗出液检查发现链球菌(+),用西药治疗效果不满意而来就诊。

二、治疗方法

内服清里解毒汤,外敷四味扫毒膏,7 天为 1 个疗程。

清里解毒汤处方:

大黄 15 克	生地 15 克	银花 15 克
连翘 15 克	穿山甲 9 克	皂刺 9 克

黄连 9 克 木通 9 克 白花蛇舌草 30 克

土茯苓 30 克 甘草 6 克 车前子 20 克

水煎,前两煎混兑,早晚分服。第三遍煎汤洗患部。

四味扫毒瘡处方:煅番木鳖仁 5 克,煅儿茶 9 克,三仙丹 6 克,冰片 3 克。合为细末,调鸡蛋油外搽,早晚各 1 次。

鸡蛋油制法:取新鲜鸡蛋 1~2 个,加水煮熟后去壳及蛋白,将蛋黄捏碎后置勺子内,微火烤至蛋黄焦黄,油即炸出,收储备用。

三、疗效观察

本组 45 例,41 例于治疗后 2~3 天患部疼痛减轻或消失,5~7 天溃疡部基本不流脓液,14 天后痊愈;其他 4 例因到外省搞供销工作,无从随访。

四、典型病例

孙某,男,25 岁。1989 年 3 月 8 日就诊。

患者于 1 个月前到外地搞供销工作,与异性发生关系。半个月后冠状沟有脓疮形成,继后破溃,溃疡面越来越大,有黄色脓性分泌物,疼痛难忍,右侧鼠蹊淋巴腺肿大。经某医院采集溃疡表面渗出液检查,发现链球菌(+).西药治疗效果不佳,而来我院门诊治疗。根据其症状,符合软性下疳。用清里解毒汤和四味扫毒瘡内服,外用相结合,治疗 2 周后告愈。随访未再复发。

体 会

软性下疳属祖国医学“妒精疮”、“疳疮”、“杨梅疮”之范畴,由不洁性交而感染,好发于男性阴茎的冠状沟、包皮口和包皮系带以

及女性的大小阴唇内侧、前庭、阴蒂、阴道等处。初起小疮不痛或微痛，渐渐蔓延、溃破、流出脓性分泌物，剧痛不已。如果久治不愈，其毒素可侵入骨髓、关节或脏腑，遗害匪浅。

清里解毒汤和四味扫毒瘡系吴光烈老中医家传验方，在旧社会用于治疗梅毒引起之疾患名噪四方。近几年来性病抬头，用之疗效仍如当年。

四味扫毒瘡具有解毒、消肿、止痛、生肌之功，用于疮口破溃者，见效神速，一般用2~3天后疼痛就可消失，1周后疮口溃烂即可愈合。吴老强调临证应坚持口服清里解毒汤2周，以托里清热、散瘀败毒，如此可免除毒邪蕴藏于脏腑，酿成后患。

以上两方，也可兼治其他性病。然处方用药贵在知常达变，随证灵活加减。吴老强调治病要谨守病机，不要轻易更方，以免影响疗效。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《国医论坛》，1994年第1期。

中药治疗三叉神经痛

三叉神经痛是一种常见病,而治疗非常棘手的疾病,其临床主要表现是头面部阵发性剧痛,患者极难忍受。吴师近2年来运用祖国医学辨证施治的方法,用中药治疗本病25例,取得满意效果。现介绍如下:

一、一般资料

25例患者均经西医诊断确诊,其中男14例,女11例;年龄18~35岁8例,36~45岁12例,46岁以上5例;病程最短者5天,最长者5年;发病无明显季节性。全部病例均在门诊治疗,并追踪观察半年以上。

二、治疗方法

1、中药基本方组成:

川芎 20 克	当归 12 克	白芍 15 克
柴胡 9 克	白芷 9 克	全蝎 9 克
地龙 6 克	蜈蚣 2 条	细辛 6 克
羌活 9 克	防风 6 克	甘草 6 克

2、加减:热者加金银花6克,黄芩9克,石膏30克;大便秘结者加大黄12克(后下);目痛者加菊花10克,木贼草9克;眩晕者加钩藤15克,龙骨、牡蛎各15克;阴虚者加生地15克,玄参15

克,石斛 9 克;体质虚弱者加黄芪 15 克,当归 9 克。

三、治疗结果

本组 25 例中,除 3 例症状缓解未继续治疗外,22 例均痊愈,追踪半年无复发。治疗时间最长为 3 个月,最短为 6 天。

四、典型病例

陈某,女,32 岁,工人。1993 年 10 月 15 日初诊。

患者左侧面颊部剧烈疼痛,连及左目和左上齿,阵发性疼痛,发作频,痛如刀割,痛时伴有目流泪,口流涎,昼夜不安。曾在当地乡村医生就诊,服去痛片、颅痛定,注射安痛定等均无效。检查:表情极为痛苦,左侧面部不能触摸,皮肤粗糙,色素沉着,舌质淡红、苔黄腻,脉浮弦。证属寒邪阻滞经络,气血运行不畅所致。药用:

川芎 20 克	当归 12 克	丹参 15 克
白芍 15 克	柴胡 9 克	白芷 9 克
全蝎 9 克	地龙 6 克	蜈蚣 2 条
细辛 6 克	羌活 9 克	防风 6 克
菊花 10 克	木贼草 9 克	

服药 3 剂后,疼痛大减,精神好转,饮食增加,继服 5 剂,疼痛消失,追访半年未见复发。

体 会

本病属祖国医学偏头风、偏头痛之范畴。根据中医风善行而数变,头为诸阳之会,为髓海所在,五脏六腑之气皆会于此之理论。故外感时邪,脏腑内伤,均可发生头痛。由于风邪内客,瘀阻血脉,脉

络受阻,造成不通则痛。方中重用川芎取其辛温上行祛风止痛,活血化瘀之效;细辛、白芷、羌活、防风、柴胡散风止痛,直达病所;柴胡既和解少阳又作引经之用;川芎、白芍、当归行气调经;全蝎、蜈蚣、地龙辛温,走窜之力最速,可搜风通络,散瘀止痛,内而脏腑,外而经络,凡气血凝聚之处皆可用之;甘草调和诸药。全方共凑祛风通络、活血止痛之功,故取得临床效果。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《山东中医学院学报》,1995 年增刊。

中药治疗肩周炎

肩关节周围炎简称肩周炎,中医谓之“漏肩风”、“肩凝”、“冻结肩”等,多发于中老年人,尤以 50 岁左右为甚。临床表现初起常感肩部酸痛,后疼痛延向颈项及上肢,肩关节运动不利日渐加重,上举,后伸,内收,内旋等动作均受阻,肩部肌肉有痉挛或萎缩等特征。它给病人带来很大的痛苦。吴师在临床上运用中药治疗 60 例肩周炎患者,取得较好的疗效。现总结如下:

一、临床资料

本组 60 例中,男性 24 例,女性 36 例;年龄 40~50 岁 8 例,51~60 岁 36 例,60 岁以上 12 例;病程最短为半个月,最长为 8 年。

诊断依据:肩关节酸痛,夜间加重,活动明显受阻,肩周压痛明显,压痛点大多在两处以上。

二、治疗基本方组成

黄芪 30 克	党参 20 克	山茱 20 克
杜仲 15 克	鹿角霜 12 克	寄生 15 克
桑枝 12 克	桂枝 6 克	当归 9 克
羌活 9 克	地龙 6 克	伸筋草 15 克
生姜 5 片		

水煎,加酒少许温服。每日 1 剂,分 3 次服完。10 剂为 1 疗程。

加减：寒甚剧痛者加细辛、川乌、草乌、良姜；风痹游走不定，手臂麻木者加防风、灵仙；患肢屈伸不利者加木瓜、丝瓜络；气血虚弱者加鸡血藤；病程长久不愈者加防己、萆薢、千年健。

三、疗效标准与结果

疗效标准：治愈（肩关节疼痛消失，功能活动正常，经半年以上随访未见复发）；显效（肩关节疼痛基本消失，活动明显改善，偶有轻微疼痛，但能正常工作）；好转（肩关节功能有改善，疼痛减轻，压痛点尚存在，夜间有时疼痛）；无效（经服药 1 疗程，肩关节疼痛如故，功能活动无改善）。

治疗结果：本组 60 例，治愈 24 例，显效 20 例，好转 12 例，无效 4 例。总有效率为 93.3%。

四、典型病例

吴某，男，52 岁，工人。1993 年 10 月 5 日初诊。

主诉：右肩部酸痛，活动受限已月余，曾用强的松龙加 1% 普鲁卡因封闭 2 次，未见好转。近日加重，夜间痛甚，梳头、洗脸及穿脱衣均困难。检查：右肩部无红肿变形，关节活动受限，不能上举、外展、后旋，右肩关节处呈弥漫性压痛。诊断：右肩关节周围炎。证属肝肾气血亏损，络脉闭阻所致。治宜补益肝肾，活血通络。处方：

黄芪 30 克	党参 20 克	山茱 20 克
杜仲 15 克	鹿角霜 12 克	寄生 15 克
桑枝 12 克	桂枝 6 克	羌活 9 克
当归 9 克	地龙 6 克	鸡血藤 15 克
伸筋草 15 克	生姜 5 片	

服药 10 剂后疼痛明显减轻，肩关节活动相继好转。药已中病，

按上方续服 10 剂后肩部症状全部消失,肩关节功能基本恢复,伸展自如。随访一年,未见复发。

体 会

肩关节周围炎的发病机制,现代医学认为是一种退行性病变引起的无菌性炎症,病灶部位为肩关节周围软组织。祖国医学一般认为内因气血不足,外因风寒湿入侵而发为痹证。故一般治法多从行气活血,驱风散寒入手。《素问》曰:“七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极”。50 岁以上的人,肝肾亏虚是其生理现象。肝主身之筋膜,肾主身之骨髓,故肝肾亏损之人,一旦感受风寒湿邪或扭伤,即发生筋骨病。因老年人均有不同程度的肝肾亏损,故本病多见于老年人。其发病机制是肝肾亏损为本,风湿痹阻、经络凝滞为标。因此,在治疗上着重以补益肝肾为主,活血通络,祛风散寒为辅。立足治本,兼顾其标。方中用黄芪、党参、山茱、杜仲、鹿角霜,寄生补益肝肾、强健筋骨;当归、羌活、伸筋草、地龙活血行气、引经通络止痛;桂枝、桑枝、生姜祛风散寒;再加酒能行药势,对通利血脉,祛风除湿,温经蠲痹方面亦起到积极作用。诸药合用,共奏补益肝肾,温经和营、祛风利湿、活血通络之功。

在治疗过程中,应注意保暖和适当休息,同时积极进行恰当的功能锻炼,也是恢复功能必要的条件。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《河北中医》,1995 年第 2 期。

中药治疗坐骨神经痛的临床体会

吴师自 1990 年 6 月～1993 年 12 月运用自拟“补肾通络汤”治疗坐骨神经痛 52 例，收到满意的效果。现总结报告如下：

一、临床资料

本组 52 例均为门诊患者，男 38 例，女 24 例；年龄最大者 65 岁，最小者 22 岁；其中以 25～45 岁居多；病程最短者半年，最长者 12 年。全部病例直腿抬高试验均为阳性或弯腰试验阳性，在腰骶臀部都有明显压痛感。临床自腰部或臀部起，向下沿坐骨神经分布区域呈自发性放射疼痛，甚者坐卧不安为主要特征，轻者影响工作，重则生活难以自理。

二、治疗方法

补肾通络汤组成：

川续断 15 克	杜仲 15 克	狗脊 12 克
补骨脂 15 克	牛膝 15 克	鸡血藤 15 克
丹参 12 克	独活 9 克	千年健 15 克
威灵仙 15 克	当归 9 克	川蜈蚣 2 条
全蝎 6 克		

水煎服。每日 1 剂，水煎两遍，早晚各服 1 次。服用本方时停用其他一切药物。

随证加减：若兼湿重者加木瓜、防杞、苡仁；兼风寒者加桂枝、附子；兼湿热者加炒苍术、黄柏；阳虚者加肉苁蓉、巴戟天；刺痛明显者加制乳香、制没药；气虚者加黄芪、党参。

三、治疗结果

痊愈(症状及体征完全消失,肢体活动自如,同正常人一样参加工作)31例;好转(疼痛基本消失,但步行过久或劳累后仍有轻度疼痛,休息后疼痛可自行消失,日常生活能自理)18例;无效(症状及体征与治疗前相比无变化或加重)3例。总有效率为94.2%。

四、病案举例

黄某,男,42岁,农民。1992年10月23日初诊。

患者左侧腰骶部疼痛已3年余,每因气候变化、劳累时加剧,经多方调治时轻时重,近一个月来加重。就诊时检查:步行艰难,腰部疼痛并沿左侧下肢坐骨神经分布区域(大腿后侧,小腿后外侧及足背外侧)呈放射性疼痛,活动明显受限,卧床不起。查直腿抬高试验阳性;腰部X线平片阴性。舌质淡红、苔薄白、脉沉细无力。诊断为“坐骨神经痛”投“补肾通络汤”治疗15天后疼痛明显好转,已能下地活动,直腿抬高试验阴性。药已中病,嘱按原方继服15剂,疼痛已止,活动自如,已能参加正常工作。随访至今未再复发。

体 会

坐骨神经痛是临床常见病症,好发于成年人,青壮年多见,常为单侧性,并有男多于女的趋势。本病属于祖国医学的“痹症”范畴。其病因多由营卫失调,腠理不密,风寒湿邪内侵,正气为邪所

阻、不能宣行，气血凝滞，久而成痹。从坐骨神经痛部位腰臀及下肢看，肝肾不足在发病中占重要因素。方中以川续断、杜仲、狗脊、补骨脂补益肝肾，强筋壮骨；制川乌、威灵仙、独活、千年健祛风除湿，散寒止痛；当归、鸡血藤、丹参养血和营、活血通络；再配虫类之品全蝎、川蜈蚣以“搜剔”经络筋骨间之邪气，并且虫类药物含有动物异体蛋白，对于增加机体免疫功能，提高机体抗病能力有特殊作用；牛膝祛瘀止痛，引药下行，直达病所。诸药合用，具有补益肝肾，搜风通络，活血止痛之功效。由于配伍严谨精当，故收到立竿见影之效。

（吴盛荣 整理）

- 原载于《华夏优秀医论》，内蒙古人民出版社出版，1995年第1版。

八味消毒饮治疗流行性腮腺炎(痄腮)

流行性腮腺炎是由流行性腮腺炎病毒所致的急性传染病,好发于冬春两季,尤以儿童传染发病为多见。以腮腺肿大、疼痛、发热等典型临床表现为主症。吴师应用自拟的“八味消毒饮”治疗 60 例,疗效良好。现总结如下:

一、临床资料

60 例中,男 38 例,女 22 例;年龄最小 3 岁,最大 52 岁;5~15 岁 45 例,5 岁以下 8 例,15 岁以上 7 例。全部病例均符合《实用内科学》诊断标准,有典型的腮腺肿大,疼痛、发热等症状。两侧腮腺肿大的有 25 例,一侧肿大有 35 例,兼颌下腺肿大疼痛者有 20 例,兼有恶心呕吐症状者有 12 例,有睾丸肿痛者 8 例。血常规检查:白细胞总数增高者 25 例,淋巴细胞增多者有 32 例。

二、治疗方法

自拟八味消毒饮组成:

蒲公英 15 克	板兰根 15 克	银花 10 克
连翘 12 克	牛蒡子 15 克	黄芩 9 克
大青叶 12 克	桔梗 12 克	

随症加减:高热者加柴胡 9 克,天花粉 10 克、石膏 15 克;腮部漫肿硬结不散者加夏枯草 15 克,昆布 15 克;口渴者加元参 15 克、

鲜芦根 15 克; 恶心呕吐者加半夏 9 克、川连; 睾丸肿痛者加桔核 15 克、荔枝 15 克、川楝 12 克; 大便秘结者加大黄 15 克(后下)。

水煎服, 每日 1 剂。

三、治疗结果

60 例疗效均痊愈。本组腮腺肿大均在服药 3 天内消失, 同时体温下降为正常; 睾丸肿痛在服药 5 天内消失; 颌下腺肿需服 5~7 剂始能痊愈。治愈时间最短为 2 天, 最长为 7 天, 平均为 4.5 天。

四、典型病例

例一 刘某, 男, 8 岁, 学生。1993 年 12 月 2 日初诊。

家长代诉: 2 天前因发烧, 右侧耳下部肿痛到某院就诊。检查: 血常规: 白细胞 $6 \times 10^9/L$, 中性 0.50, 淋巴 0.50。诊断为急性腮腺炎。经服用病毒灵、扑感敏, 2 天无效而来我院求诊。诊见: 发热、体温 $39^\circ C$, 两侧腮腺肿大, 右侧合并颌下淋巴结肿大, 局部触痛, 张口或咀嚼时疼痛更甚, 纳减, 大便干结, 舌质红, 脉数。治以清热解毒、消肿散结。方用自拟八味消毒饮加大黄 9 克(后下)、天花粉 9 克、石膏 15 克。每日 1 剂, 水煎服。

服 2 剂后复诊: 体温降至 $36.5^\circ C$, 患处红肿硬结明显消散, 大便干结消失, 但仍纳食减少。恐寒凉药过之损伤脾胃, 嘱按原方去石膏、大黄加山楂 12 克、麦芽 12 克。连服 2 剂, 诸症痊愈, 饮食如常。

例二 陈某, 男, 52 岁。1994 年 8 月 5 日初诊。

患者 3 天前发现左侧耳垂前酸胀不适, 微肿。初起不引起重视, 后肿胀明显, 酸胀、疼痛、晨起更明显, 纳食则疼痛加重, 而来我院就诊。查见: 左侧耳垂前腮腺部位漫肿明显, 不红、边缘不清, 触

之酸痛明显,体温 38℃。血常规检查:白血球 $7.8 \times 10^9/L$,中性 60%,淋巴 40%。诊断为“急性腮腺炎”。方用八味消毒饮,治疗 5 天,诸症消失。

体 会

流行性腮腺炎属于祖国医学的“痄腮”、“大头瘟”之范畴。中医治疗“痄腮”具有悠久的历史,内治外治,方法众多,取得了一定效果。祖国医学认为本病是由于感受风热时毒,与素体积热蕴结,阻遏少阳、阳明两经,火热上攻而致。故吴师应用大量的清热解毒药,如蒲公英、板兰根、大青叶、银花、连翘清解温热毒邪。其中蒲公英清热解毒、消肿散结;大青叶退热凉血解毒;板兰根、桔梗凉血解毒,清热咽喉;银花既可清透疏表,又能解血分热毒;连翘轻清上浮,可治上焦诸热,尤能解毒消痈散结;黄芩苦寒清火解毒;牛蒡子透泄风热。上述诸药合之,共奏清热解毒,消散热结之功,故收效迅捷。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《湖南中医杂志》,1996 年增刊。

治疗麻疹的经验

去年冬季麻疹屡有发现,笔者见吴老用药得心应手、立起沉痾,特请吴老谈有关治疗麻疹之临证经验,并整理如下。

一、麻疹之源

吴老曰:先贤有云“麻疹之源,或曰父母欲毒所致,或曰胎母饮食过厚受毒于胎所致”。余业医 50 余载,欲毒之说固无明据,可能出于臆测。然每见农家孕妇饮食清淡,生子出疹稀少而平顺;富豪孕妇恣食厚味,生子出疹稠密而多端。说明,饮食淡,则气血清,而胎毒轻,出麻疹稀少;饮食厚,则气血浊,而胎毒重,出麻疹稠密。由此可见,麻疹之源受毒于胎母血秽,似有一定之关系。

吴老曰:本病传染力强,其主要途径为上呼吸道,多见于儿童,故发病主要在肺经,肺家见证独多。如发热咳嗽、鼻流清涕、眼胞肿、眼泪汪汪、羞明、面肿腮赤,口颊粘膜上有粟粒型灰白点为特征。另有患儿可伴耳冷、骶冷、臀尖冷、手足中指冷症状。

凡麻疹流行季节,小儿发热数天不退,是否欲出麻疹可视其耳后,如有红丝赤缕出现即为麻疹之征。若不明显,可用纸捻照法,即用竹纸做成纸捻饱蘸芝麻油或花生油均可。窗户俱遮闭,以火点燃纸捻于两颧照之,以目斜视,如皮内可见疹子隐隐,即出疹无疑。

二、麻疹之调护

吴老曰：当时令出疹之时，小儿或有发热稍缓，其热或作或止，其疹点未见，正疑似之际，且勿急于服药，但须禁风寒、禁荤腥食物调护而已。不可过早投以寒凉解毒清热之剂，因疹毒发自五脏，勃勃欲出，其势必不可阻遏。多用寒凉解毒清热之剂，可阻遏麻疹欲出其势，气血不能送毒于皮肤，反而使毒邪内陷而有害，应予注意。此外麻疹欲出，内脏空虚，热气一蒸，毛孔俱开，当慎风寒。但室内空气宜流通，衣服勿令过暖、过寒。虽天气炎热，亦勿令赤体或单衣当风取凉；虽天气严冷，亦勿令重棉叠褥，使热气壅遏。至于饮食，勿过饱、过饥，勿食生冷、饮凉水，猪头肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鱼腥兼葱蒜、韭薤与醋酸等物，均宜忌之。盖生冷伤脾，凉水寒胃，猪首发毒，牛肉黑斑，羊肉助痰，鸡肉生风，鱼腥动火，葱蒜、韭薤秽浊，醋酸收敛。饮食宜清淡，少食多餐为好。

三、麻疹之治疗

吴老曰：麻疹之治疗，主要为宣表其毒于内而已，所谓“形出毒解即无忧”。尽管病情复杂多变，解毒之治则不变，勿忘疹毒必须透解，选方用药就不致迷失方向，即使疹毒内陷，亦不足虑也。此为吴老治疗麻疹之常法。

1、初热期：吴老曰：疹毒将欲向外发泄之征兆，必须因势利导，使之顺利透发。切不可用药令其大汗，以免损耗元气，也不可妄用攻下而以虚其里，亦不可骤用寒冷，使内热被郁而导致疹毒内陷。如能把好这一关，并加强护理，就可迅速获愈。麻疹欲出未出之时，治宜宣毒发表为法，方用宣毒发表汤，药用升麻、粉葛、防风、桔梗、荆芥、薄荷、甘草、连翘、前胡、木通、淡竹叶、牛蒡子。若天气大热加

黄芩,天气大寒加麻黄,体虚加党参、黄芪。

2、见形期:麻疹为热毒透泄发于皮肤,红肿太甚者,治宜清热解毒为法,方用化毒清表汤,药用牛蒡子、连翘、天花粉、地骨皮、黄芩、黄连、山梔、粉葛、元参、知母、桔梗、前胡、木通、甘草、薄荷、防风。若口渴加麦门冬(去心)、滑石,大便秘结加大黄。吴老强调,麻疹非热不出,有适度之发热,说明机体抗邪力旺则易驱毒外出,切不可妄用退热之剂,以免妨碍疹毒外透。若热度过高,应防并发症发生。可根据病情辨证施治。

3、麻疹变证、逆证之发生:吴老曰:多因气血不和、络脉壅塞不通,疹毒郁滞于五脏。见形期疹子如能顺利透发而出,疹毒就可随之消散。如疹毒不能顺利从外透解而内陷于里,则变为逆证,就可危及患儿生命。此时宜迅速解除内陷之毒。若高热烦躁、咳嗽喘促、面赤唇绀、疹点紫黯或隐没,为热毒闭肺(并发肺炎),治宜宣肺透邪、清热解毒,方用麻杏石甘汤加黄芩、紫草、黄连、牛蒡子、连翘;若腹泻频繁或下痢脓血、里急后重,为热毒流注大肠(合并肠炎或痢疾),治宜清热导滞为法,方用清热导滞散,药用黄连、黄芩、白芍、枳壳、山楂、厚朴、槟榔、当归、甘草、连翘、牛蒡子、青皮、葛根,红痢加红花、地榆、泻而不畅加炒大黄;若高热神昏抽搐、疹色紫黯而稠密成片,为热入心营(合并脑炎),治宜清凉解毒为法,方用清瘟败毒饮或加牛黄丸、紫雪丹,以开窍镇痉;若面色苍白、唇现青紫、昏睡肢厥、脉微,为元气虚弱、毒邪内陷、内闭外脱(合并心力衰竭),治宜益气回阳、活血透疹,方用补中益气汤合参附汤。总之,只要明确解毒为主要治法,见症从心,药随病更,活法自可应手。

4、麻疹后期:疹点按出疹时之顺序依次消退、体温逐渐下降,为疹透毒解之象。此期患儿稚弱之体、阴津被耗,宜用养阴清肺汤治之。农家常用白茅根合冬瓜煎汤代茶频饮,以恢复其元气,具有科学意义,诚可取也。

四、用药权宜

吴老曰：疹有缓急，治宜权变。先宜谨始，尤当慎终。宜谨始者，不妄用解热发汗之法；慎终者何也，盖人之一身气血而已，麻疹還元之后，五脏真气被耗，虽有余毒未尽，而正气极虚，须用凉药解毒者，必须以酒或黄土炒制，以免损伤脾胃，切不可因麻疹既沉，无复他虞，而遂漫不轻心，变生他症。治麻疹与治他病一致，病深而药浅，终无见功；病浅而药深，反而增剧。以本药治本病，病去便当另行别议。遇变证则用变药，即所谓药随病更。进升麻于未见疹点之先，身无壮热勿用三黄、石膏。内热未除误用辛燥之药，如丁香、肉桂，可导致目疾。便溏胃虚勿用芩、连，发热下泻勿急止，气粗腹胀伴便秘可通。咳嗽有痰，切勿乱投半夏。热冲作呕，且教莫入干姜。发表散邪，重柴葛而轻桂枝。疏通实热，微枳实而甚大黄。解毒热，芩、连、栀子。快斑疹，紫草、荆、防、牛蒡、连翘。咽痛，元参、桔梗能治。膀胱不利，木通、车前可医。止呕吐，砂仁、藿香。定惊搐天麻、僵蚕。润肺止咳而定喘，用五味子、杏仁。消食行滞，用山楂、枳实。去血中之毒，牡丹皮为圣药；去气中之毒，地骨皮为良药。天花粉消痰清胃且敛肺气，以发声音，为上品。利肌肤、祛风、止痒，僵蚕效如神。总之，清热解毒为常法，补法不宜早，温药宜慎用。能明此者，思过半矣。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《中医函授通讯》，1993 年第 5 期。

再谈治疗麻疹的经验

一、疹出不现，急用胡荽透疹法

凡麻疹之候，发热后3天，疹子应该出现，若隐于皮肤之间，必是皮毛受风邪所闭。吴老曰：本病应引为重视，疹子欲出不出，乃热毒之邪内陷，必然发喘，危亡立至。当此之时，应急用鲜胡荽（干胡荽亦可）适量，切碎布包，置于杯罐内，加酒盖密煮沸，取起乘热熨擦皮肤，从项背胸腹至足令遍，卧床保暖，切忌风寒外袭。吴老云：“此法为疏散风邪，透疹外出之良法。”疹子透发，疹毒就可随之消散，所谓“形出毒解即无忧”。盖取胡荽性味辛温香窜，内通心脾，外达四肢，能辟一切不正之气，凡疹出不透或患者素体虚弱及疹出期天时阴寒，用此法治之，疹能发之，效验非常。50余年来，吴老用此法透疹，活人无数。

去年冬，余诊一麻疹患儿，男，9岁。发热3天，面部见疹后遂即隐没，高热面赤，鼻干，喘急，神志朦胧，病情危急，嘱急用胡荽透疹法处理。越日复诊见面部、胸腹部疹子密集，体温渐降，神清，鼻翼煽动缓解，可谓神方也。

二、疹后声哑，宜用蔗梨冬瓜汤治之

吴老曰：“疹后之症责之肺经，肺主皮毛，故疹后切忌风寒，凡麻疹后出现咳嗽声嘶之症，皆因体弱风寒犯肺，肺气失宣，耗伤肺津故也。宜用雪梨（香水梨亦可）、甘蔗头、冬瓜糖各适量，水煎代茶

频服,即可逐渐痊愈。盖因雪梨性味甘寒,有治风热、润肺凉心、消痰降火、解毒之功,如生梨已尽,则取梨干代之;甘蔗头性味甘寒,生津润燥,取其头部入土,秉地气生金之义,有生津润肺,健脾消痰止嗽之效,妙不可言;冬瓜性味甘寒,加沙糖制作为冬瓜糖,有润肺气、助脾胃、生津润燥、止嗽消痰之效。三者合用,共奏润肺生津,补脾清热之功效。此为吴老临床实用之验方也。余侍诊见吴老用之皆效。本方余用治成人久嗽、失音也屡试不爽。

三、疹毒入眼,治以清毒拔翳为法

余治 1 例男性,4 岁,麻疹后双眼赤肿而痛,不能开,屡用龙胆泻肝汤内服兼外洗,不但无效,反而加重,而请教吴老何也?吴老曰:此乃疹毒入眼,更甚者可有翳膜遮蔽,不能视也,如不及时调治,可导致终身失明。麻疹是有形,疹毒是无形,而无形甚于有形,故麻疹后更应该引为重视。吴老再三说明,麻疹期间,因饮食护理不当,或治疗失误,均可发生此症。治宜清毒拔翳为法,可以清毒拔翳汤从容治之,使其毒气自退而元气不损。吴老告诫,切不可用寒凉峻攻之药,伤其元气;亦不可轻用凉药点洗,以致失明。余谨遵教诲,患者服 3 剂后,果然赤肿渐消不痛,眼能张开;继服 3 剂,随之痊愈,实灵验也。由此充分说明,继承老中医学术经验,至为重要。

现附清毒拔翳汤及随症加减、服法:黄连(酒炒)、当归(酒炒)、天花粉、牛蒡子(打碎)、草决明、桔梗、甘草、白蒺藜炒研去刺各 1.5 克,川芎、羌活、防风、柴胡、生地(酒洗)、薄荷、山栀(酒炒)各 1 克,生姜 1 片。水煎,食后饮服。大便秘者加酒炒大黄 4.5 克,微利之,服 1~2 剂乃去之。吴老曰:此方疗效显著,毒轻者不过 10 剂可愈,毒重者服数十剂始能获效,应耐心治疗,千万不可半途而废。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《国医论坛》1995 年第 5 期。

白田乌草治疗白喉的经验介绍

白田乌草是本县草药医李引定先生(已故)祖传的喉科秘方,在党的重视祖国青草药的鼓舞下而贡献出来。经本县国专医院于1959年2月至4月白喉流行期间收治31例患者,进行临床观察,治愈率为90.5%,收到满意的疗效。为进一步证实和体验,充分发挥民间青草药治疗急性传染病的作用。我们于1960年冬季至1963年9月用白田乌草治疗白喉92例,同样收到良好的效果。现介绍如下:

一、临床资料

92例中,男性48例,女性44例;年龄最小的为8个月,最大的为9岁,大多数是2~4岁的小孩。

诊断标准 临床诊断以咽喉伪膜,流行季节,接触史,白喉杆菌检出和临床典型症状,体征等为依据。

临床分型 根据病情分为轻、重、恶化三型进行治疗观察。

1、轻型:一般发病在3~5天,咳嗽有犬吠声,轻度呼吸困难,咽喉部发现伪膜,但神志清楚,体质尚好,发热不高,给予白田乌草服用,并配合吹喉散。

2、严重型:除上述症状外,伴有疲倦,拒食,面色苍白,高热汗出,营养较差,用上述治疗并给一般支持疗法(如配合青霉素、葡萄糖、维生素乙、丙或樟脑水、可拉明等)。

3、恶化型：多呈吸人性呼吸困难，回缩病征，即给予气管切开。

疗效观察 收治 92 例，治愈 84 例，治愈率 91.3%，死亡 8 例，死亡率 8.7%。死亡 8 例中，4 例中毒症状明显（其中 2 例于入院 3 小时内死亡，2 例 5 小时内死亡）；3 例病情严重，行气管切开，均不到一天死亡；1 例伴发严重肺炎及颈淋巴腺肿胀，抢救无效，终因心肌梗塞死亡。

二、治疗方法

使用方法：系采生白田乌草新鲜茎叶一两（或手捻一把），用凉开水洗净，捣碎绞汁，加等量蜂蜜作一次量置瓶内备用。每于饭后服 1 次，如果病情严重，即刻给服 1 次，夜半再加 1 次。

吹喉散：羌蚕、胆矾、枯矾、青黛、川连、朱砂、甘草粉各 3 克，合研细末装入瓶中，密封备用。患者入院即刻吹喉 1 次，以后每 3~4 小时再吹一次，1 日 3~4 次；吹时用一小管子（如毛笔杆大小，另一端劈成斜面）挑入小量药散多次吹喷于咽喉部，直到患者呕吐、流鼻涕为止，然后口服草药汁。患者每于喷药后，吐出粘液性分泌物和伪膜，因之呼吸困难症状随之改善。

三、典型病例

苏××，女性，5 岁。发热、咳嗽、疲倦、声音嘶哑已 3 天，喉痛拒食，呼吸困难而入院。

检查：体格发育一般，神识清楚，呼吸急促，咳嗽呈犬吠声，体温 39.6℃，哭吵不安，咽两侧及悬雍垂有灰白色条状样的伪膜，喉分泌液检出白喉杆菌，心跳速。肺呼吸音粗糙伴有干性罗音。入院后发生阵发性的呼吸困难危急万分，一面作气管切开术准备，以防万一；一面急用吹喉散吸入，并立即内服白田乌草汁，注射青霉素，

立见好转,因而免施手术。继用白田乌草汁 4 次后,于次日查房时咳 2 次,咳出脂肪样伪膜 2 条约 2cm 长,检查咽部两侧,伪膜已大部份脱落,扁桃腺呈充血现象,呼吸困难消失,能进食安眠。继续以白田乌草治疗 5 天,检查咽部伪膜全部脱落,喉液无发现杆菌,而痊愈出院。

结 语

使用白田乌草配合吹喉散治疗白喉 92 例,初步观察,效果尚属满意,治愈率达 91% 以上,与 59 年国专医院使用本药治疗白喉 31 例治愈率为 90.5%,效果进一步提高,更加肯定本药的疗效确实。

三例病情严重的患者,作气管切开,均在一天内死亡,以后类似病例,似应考虑,尽量发掘祖国医药遗产,采用解白散之类配合治疗,以进一步提高疗效。

白田乌草,系我县的上名。考《中国药用植物图志》,《福建民间草药》第一集,《闽北本草》第一集,《泉州本草》第一集,《闽东本草》第一集等,学名均为鳢肠草,俗名对面乌、墨头草、墨烟草、旱莲草、莲子草、节节乌、墨菜等。属菊科的一年生草本植物。此草生于田岸路旁,沟沿湿地,园边篱下。开花果实很多,成熟呈黑色,实形如莲旁,断之有汁,片刻即呈黑色。

本草根据有关资料记载及我县临床应用,性平,味甘酸,无毒,富有消炎解毒作用。应用本草治疗白喉,具有药源丰富,容易采集,使用简便,奏效迅速、确切,和减轻病家经济负担等优点,值得推广应用。

● 本文于 1985 年省青草药经验交流会上宣读。

茵陈银翘汤治疗急性肝炎

茵陈银翘汤系我院老中医吴光烈主任医师自拟治疗急性黄疸型肝炎和无黄疸型肝炎的经验方。近几年来,笔者应用于临床治疗100例,取得了显著疗效。现介绍如下:

一、基本方组成及用法

茵陈 15 克	银花 9 克	连翘 12 克
板兰根 15 克	虎杖 15 克	栀子 9 克
滑石 15 克	车前子 12 克	大黄 12 克(后下)
五味子 6 克	甘草 9 克	

水煎服,每日1剂,一个月为一疗程。

加减法:目黄、身黄、尿黄甚者加黄柏、黄芩;肝区闷痛者加玄胡、郁金;呕吐者加竹茹、砂仁;脾胃虚弱者加白术、淮山药;纳呆者加神曲、山楂、腹胀者加陈皮、莱菔子。

二、治疗结果

本组100例中,急性黄疸型肝炎62例,经治疗一个月后,痊愈54例,好转6例,无效2例。无黄疸型肝炎38例,经治疗一个月后,痊愈33例,好转4例,无效1例。

三、典型病例

刘×,男,28岁,工人。1991年10月12日就诊。

患者于10日前恶寒、发热、头晕、恶心、呕吐、胃脘部不适,经

服药治疗有些好转,但仍感体倦乏力、小便如茶样。5 天后发现目黄及全身皮肤深度黄染,伴右肋部胀闷痛,大便秘结而求诊于我院。

诊见:精神萎靡,巩膜及皮肤黄染,舌质红、苔黄腻,脉弦数。体检:肝在右肋下 2 公分,表面光滑,质地软,明显压痛,脾未触及。肝功能检查:黄疸指数 50 单位,谷丙转氨酶 200 单位以上。西医诊断急性黄疸型肝炎。中医辨证为阳黄,湿热内蕴。治宜清热解毒,利湿退黄。方用茵陈银翘汤加郁金、陈皮,治疗 20 天后,症状及黄疸均消失,复查肝功能均正常。随访一年,未再复发。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《时珍国药研究》,1993 年第 3 期。

对急性黄疸型肝炎的诊疗经验

急性黄疸型肝炎,属祖国医学黄疸病“阳黄”的范畴,是常见的传染病之一。近来城乡发病相当严重,对人民的健康和劳力的损害甚大。祖国医学对本病的治疗具有丰富的临床经验,如能早期发现,及时正确治疗,是可以恢复健康的。现将吴师的治验整理如下:

一、谈急性黄疸型肝炎的病因病机及其辨证的重要性

本病系由肝炎病毒所引起的。其病理机制各家均认为是人体抗邪机能不足,外邪侵袭,饮食失节,湿热蕴结于脾胃,熏蒸于肝胆,而致肝失疏泄,脾失健运,脾胃肝胆功能紊乱又加重湿热内蕴,迫使胆汁郁滞循血液浸淫于肌肤而致发黄。故《内经》有“湿热相交,民病疸”。充分说明了发病的机理主要是“肝热脾湿”,给我们指出了治疗的方向。

黄疸病的体征,西医往往认为是一个症状,而中医则认为是另外一个独立的病征。黄疸体征是肝脏损害的信号警报,主要不在于黄疸,而是在于肝脏的病变。《内经》所谓“有诸内者,必形于外”。

“阳黄”病虽较浅,但疗法繁复,治疗失当,也会造成恶果。先贤喻嘉言治黄疸病,订律三条:“黄疸得之外感者,误因补法,是谓实实,医之罪也;黄疸病得之内伤者,误因攻法,是谓虚虚,医之罪也;阴黄病误从阳治,袭用苦寒,倒行逆施,以致极重不返者,医之罪也。”这是非常珍贵的告诫,说明古人对辨证是非常认真,差之毫厘,则失之千里。孙思邈也说:“人命至重,贵于千金,一方济之,德

逾于此。”指出了对于治疗疾病,要有一丝不苟的作风,应以人命为重。

二、谈肝脏的生理病理特点

1、肝属木,木郁化火,肝郁成热。脾为仓廪之官,又为湿土之脏,行津液而运化水湿。《内经》病机有“诸湿肿满皆属于脾”,由此可以概括热重型的病变在于肝(包括胃热),湿重型的病变在于脾。

但根据患者素禀的强弱,感邪的轻重,季节的不同,热重湿重都可以互相转化,并不是孤立不变,绝对平衡的。故治疗时应认真辨证,有的放矢,才能打中要害。

2、脾为后天之本,营血生化之源。由于肝病疏泄失职,则伤及脾,所以肝炎患者伴有纳呆脘痞,二便不调,胁痛腹痛,四肢乏力等症。故《难经》云“见肝之病,则知肝当传之与脾,故先实其脾气,无令得受肝之邪也。”给我们指出了在治疗中要始终注意脾胃的运化,能纳食则正气足,精神充沛。《内经》所谓:“得谷者昌”及“正气存内,邪不可干。”这对促进肝炎的早日恢复健康具有重要意义。

三、谈有关治疗的问题

1、本病以病因来说是湿热内侵,从脏腑来说,病变在于肝胆。根据治病必求于本的原则,应该辨证求因,审因论治,紧抓肝胆湿热之要害,以清热利水泻下为正治法,特别是利水法最重要,故《金匮》云:“诸病黄家,但利其小便。”

2、肝为风木刚脏,易于化火;脾为中土,喜燥恶湿。在治疗用药不宜过于刚燥,又不能过于滋腻,对热重型要注意清热护阳,对湿重型要注意化湿助阴。否则,清热太过会损其阳,湿更难化;利湿太过会重伤阴液,使热更盛。所以在治疗中不宜过于刚燥,又不能过

于油腻。肝喜条达,但疏泄不可太过,太过也会伤阳耗气,应该中病则止。

虽有积聚而体质未衰者,始可用攻破之剂,如体质衰弱,又非攻破不可,则宜在攻破药中加入补气益血之参、芪、归、芍之类,攻补兼施庶不伤正气。证见小便清长,欲自利腹胀满,虚寒现象明显者,就不宜再用寒凉之药。尤其对小儿及脾胃素虚之人,应当谨慎,以免损伤脾胃。

3、湿热黄疸,一般可用下法,但应注意体质,中病则止,不可猛进从事,以免伤正,影响抗病机能。如果黄疸湿重,缠绵难愈,吴师常在祛湿药中加入少量的老酒,使其辛窜化气,邪亦因之而除,在临床上未见弊端之处。

4、《金匱》记载“诸病黄家,但利其小便”。可见利水退黄是治疗黄疸的基本大法。利小便虽能排除湿邪,但尿转清该停服,免致伤津耗气。如果用利水药退黄疗效不明显时,可在健脾利湿剂中加入适量的大黄,使其畅通大便,退黄立见功效,这与现代医学认为大黄能疏利胆道,排除病毒之功有关。如果通过积极治疗,黄疸不退,反而日益加深,症状加重,就应考虑为“急黄”,损人最急,切宜注意。

5、茵陈为苦平微寒之药,有清除脾胃湿热之功,对肝炎病毒有抑制作用,对肝损伤也有改善的作用,已成为治疗黄疸型肝炎的专用药。在临床观察中,对没有黄疸型的肝炎,但有脉弦,口苦胁痛的症状,说明肝胆有热。就“炎”的字面理解,“炎”属于热,在急性期间,当然应该清热利湿,在慢性期也多热蕴肝脏,其病邪深藏而致病,在外可无热象,但内仍有蕴热,故仍可用茵陈清泄肝胆之热。不论黄疸型肝炎,均可使用,特别是胃纳不佳之肝炎,在健胃药中加入适量的茵陈,可以增进食欲。

6、对柴胡的评价:肝主疏泄,性喜条达,它的生理特点是性急而善怒,如不遂其条达之性,势必反侮于肺或传之于脾,肝病患者

之所以能逞其横肆之威,系借助于胆腑,因胆为少阳相火,肝为厥阴风木,两者互为表里,肝性刚强,更兼胆为作伥,所以其威乃逞。吴师临床常重用柴胡,加入治疗肝炎方剂中,收到条达肝气的疗效。柴胡可入肝胆之经,疏气、解郁、散火、最能宣畅气血,有助于肝功能的改善,诚为治肝之圣药。明清以来,有人怀疑柴胡性烈散发,能伤肝阴,用柴胡不可过钱之说。考《神农本草经》载:柴胡“味苦平,主心腹,能去胃肠中结气,饮食积聚,寒热邪气,推陈致新,久服轻身明目益精。”把柴胡列为上品,从未见有柴胡辛热温散的记载。吴师行医 50 多年,用柴胡治疗肝炎,每用 4~5 钱未见伤阴耗津之弊,而是助于症状的改善,肝功能的恢复。这个问题,有待于同道们共同探讨。

7、有关输液的问题:肝炎病人在急性期,呕吐频作,不能进食,全身衰弱的阶段,给予输适量的葡萄糖液,可补充营养,增强利尿,排除毒素,增加肝糖元,保护肝细胞,促进肝细胞的再生是具有很大的作用。如果急性肝炎来势凶猛,肝脏损害严重时,也会累及肾脏,造成肾功能不全,产生浮肿现象。这时,除给予低盐饮食外,输液也应适当限制,以免益增水邪。不一定要给予输入大量的液体,而增加内湿。

如果是证见脘闷饱胀,泛恶拒饮,痰多而白,大便溏稀,四肢困倦,脉濡缓或滑,苔白腻等内湿现象严重者,也不一定给予输大量的液体,以免增加水邪内聚。至于饮食很好,小溲通顺,可不必输液。

四、谈谈护理问题

肝主怒,脾主思,怒郁伤肝,忧思伤脾,都会导致患者性情急躁而易发怒等不良情绪。在治疗中,医护人员及其家属应当尽量为患者造就良好条件,做到态度和蔼,体贴入微,关心备至,耐心解释病

情,消除恐惧心理和避免忧思郁结。安定情绪,心情舒畅可有利于肝病的康复。在治疗阶段,应劝告患者不要阅读有关肝炎的书籍,因为个别患者理解不深不透,把自己的某些症状与书本肝硬化、肝恶性病变的某些症状对照有些相似,怀疑自己为肝硬化,肝恶性病变,终日愁眉不展,失眠纳差,从而加重了病情。在我院住院的知识分子中屡见不少,造成治疗上很多困难。甚至有个别病人竟患上精神病。这是值得注意的。

五、谈卧床休息的问题

本病急性期,应注意卧床休息,特别是黄疸明显、肝区疼痛严重,更应注意限制活动。这样做,既可使肝脏的血流量增加,有利于肝细胞的恢复,也可避免病邪外传。1983年我院传染科病房有一肝炎患者,不听劝告,终日东奔西跑,最后导致病情恶化而死亡。这说明急性期卧床休息是相当重要的。黄疸消退、肝区疼痛及其它症状均有所减轻,就宜根据体力,下床适当散步,以促使气血运行通畅。祖国医学的经络学说是“痛则不通,通则不痛”和“阻则为病,停则死矣”,说明人体气血的运行,通畅是非常重要的。

六、谈肝炎的饮食问题

肝脏是消化系统中的一个重要组成部分,因此肝炎患者常出现一系列的消化道症状。所以,在肝炎治疗中饮食上的配合是十分重要的。

1、在黄疸前期,病人往往食欲不振,恶心厌油,这时应以少量多餐为原则,少食动物脂肪,忌食辛辣、海腥、酒类,选择含有一定的蛋白质、维生素,既易消化而又清淡之食物为好。

2、如食欲正常,胃肠功能良好,可多吃些蔬菜水果,小点可煮

些富有营养的绿豆或苡仁,以提高机体的免疫功能。

3、若纳呆,不思饮食致使肝糖元不足,可适当补充吃些葡萄糖或饴糖。

4、在腹胀欲呕期间,应少吃多餐,不可吃牛奶豆浆和甜食及其他产气食物,更切忌过早调养恣服滋补之品,以致滞腻脾胃,助长湿热内生。

5、醋能入肝,有散瘀活血治黄疸,抑制细菌和病毒之功,三餐适当助膳,既开脾助胃,又有利于肝细胞的修复。

6、有口渴者可饮用马蹄金(黄疸草)、车前草、菜豆壳、白茅根之类;有清热利湿之作用。其药源丰富,遍地皆有,又可减轻经济负担。有条件者可适当饮用蜂蜜,有助于肝炎的恢复。据《本草纲目》记载,蜂蜜能“和营卫、润脏腑、通三焦、调脾胃”,是良好的滋补品,其所含的抗生素与蚁酸有强大的杀菌作用。临床所见,实有改善肝胆的代谢。

台湾的报刊曾报导,肝炎病人不宜吃土豆、香蕉、芒果、咸鱼、酸菜等食物,这个问题也值得探讨的。

七、谈不宜过多服药

“肝藏血”、“肝为将军之官、谋虑出焉”。《内经》早就记载。说明肝脏在人体中具有重要的生理功能,现代医学认为,肝脏是人体的“化学工厂”,负担着各种体外物质的解毒作用和一部分内毒物的排泄功能。它的任务是十分重要而繁重的。因此不宜过多地服药,以免增加肝脏的负担,造成不良后果。一些公费医疗的病人,由于医药费不要自己负担,到处开药,既服中药汤剂,又吃西药:益肝灵、多糖蛋白、维生素丙、中成药鸡骨草丸、云芝肝太冲剂,肌注维丙胺、辅酶Q₁₀、又静滴葡萄糖,肝太乐,维生素C或水解蛋白,多种氨基酸等药物,结果肝功能不能改善。而农村的农民有些仅用一

些中药或草药治疗,肝功能很快就恢复了,这说明多用药是不利于肝炎的,又增加了经济负担。

八、谈食糖保肝的问题

我们南安地区对于食糖可以保肝的说法流传很广,影响很深,每逢肝炎的病人都长期给予大量的食糖,以求“保肝”。有的用开水泡服,有的调稀饭服,有的高浓度调牛奶及豆浆或绿豆汤、青草药汤服。由于吃糖过多,结果造成滞腻脾胃,使病人脘腹胀满,不思饮食,这种做法贻害不浅。

糖味甘,入中补土,土旺则运健而易化。红糖性温,宜于湿重;白糖性平,宜于热重。少量服用,确有健脾利湿,又可补充肝糖元的不足,促进肝细胞的再生之功。但糖乃粘腻之品,过服益增胃火湿土生热,使肝炎缠绵难愈,诚不利也。考《本草纲目》记载:“糖久食则助热,损齿生虫之害也”。说明糖类之物久服对人体是有害的。

九、谈降转氨酶的问题

转氨酶增多,现代医学认为是肝细胞坏死的征象。据各地报导,有用五味子、垂盆草、丹参、龙胆草等药单味治疗。笔者在临床观察中认为,单味使用,要有辨证论治的精神,不能对号入座,死搬硬套,如五味子是酸涩收敛的药物,用于降黄疸型急性肝炎的转氨酶,不但不降,反而有留邪之弊,应当慎用。我们应根据各人病因病机的不同,各人体质的差异,采用清热、利湿、舒肝、健脾、养血、理气、化湿、软坚等法,对降低转氨酶,恢复肝功能都取得良好的效果。

十、谈对肝炎复发的看法

病久体虚,虚则抗邪之力不足,使余邪深藏,有时虽无自觉症状,肝功能检查也正常,但极易因情绪抑郁,肝气不舒;暴饮暴食,早期恣意进补,损伤脾胃;劳逸过度,生理失常;房劳不节,肾精亏虚;起居失宜,寒温失调等诱因,皆能引起复发。对此必须加以重视,时刻注意摄生,同时思想要常处于乐观,清心恬静之中,没有欲念和患得患失的思想,防止情绪波动,以增强体内的抗邪功能。故《内经》有“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”的教导。

肝炎自觉症状消失,肝功能恢复正常后,尚应继续观察,每两个月查肝功能一次,连续检查 3~6 次,以便发现问题及时处理,免致余邪深藏,死灰复燃。

(周建宣 整理)

三、医案撷英

支气管炎

林×,女,4岁。1992年5月6日初诊。

患者咳嗽、喘气、吐痰,以晨起及夜间为重,伴有夜晚发热、出虚汗,每遇风寒时易发作,食欲减退,曾在某医院诊为“支气管哮喘”。用青霉素、洁霉素及抗咳喘药物治疗1周后,症状未见明显缓解,故来诊。

检查:双肺可闻及干罗音,胸片提示双肺纹理增粗。舌质淡红、苔薄白,脉浮弱。证属肺脾虚弱,痰湿蕴肺。治宜益气健脾,化痰止咳。处方:

黄芪10克	白术6克	防风3克
半夏6克	杏仁6克	苏子4.5克
川贝3克		

水煎服。每日1剂,分3次服。

服上方3剂后,上症明显好转,药已中病,按上方继服3剂,诸症悉除,随访半年未见复发。

按 支气管炎发病率高,严重影响着儿童健康。吴老认为本病

发生的原因在于稚阴稚阳之体，正气不足，肺脾亏虚，功能薄弱，腠理疏松，卫外不固，外邪乘虚侵袭。越是体质虚弱、年龄越小的儿童越易感染。故治以黄芪、白术、防风益气健脾，扶正固本为主药；佐以半夏、杏仁、苏子、川贝祛痰化湿，降逆平喘。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《江苏中医》复刊15周年特刊。

小儿痉咳

痉咳俗称百日咳,也称为疫咳,是小儿常见病之一。早期患儿嬉戏如常,大都未被家长重视。我在临床所见的病例,均属重症。

我治本病遵《内经》之旨:“五脏之久咳,……此皆聚于胃关于肺”。关者宜开,聚者宜散(散非发散,乃疏通之意),及注意生克关系,用鲜扁柏叶、大枣、冰糖治之,无不奏效。据清代黄宫绣《本草求真》载:鲜扁柏叶有养阴润肺燥土的作用;大枣补脾益气、润肺止咳;冰糖味甘色白,补脾益肺。肺清则肃有主,肺气开宣,气不上呛,而阵咳可止,自无关于肺之患;补脾益气和中,则脾健运,纳食增进,湿不内聚,生痰无源,而无聚于胃之害。且脾健则土能生金,子得母气,母子相得益彰,关于肺,聚于胃可解,而痉咳可止。

某年春,一个3岁小儿来诊,咳嗽顿作,连声不绝,咳时面赤耳红,最后须咳至有回缩音及吐出痰涎,咳始渐平。近来伴有咳血和鼻衄,屡经治疗未见好转。我嘱用鲜扁柏叶15克,大枣6枚,冰糖适量,水煎代茶频服。1剂后略有见效,连服6剂,痉咳止,纳食增进,活泼如常。

● 原载于《南方医话》,1991年12月。

扁桃体炎

黄×,男,12岁。1992年8月5日初诊。

患者3天前因外感而致高热,渐感咽痛,吞咽及张口困难,曾肌注青、链霉素,口服复方新诺明未见明显减轻而求治。

诊见:发热微恶寒,咽喉肿痛,小便短赤,大便秘结,舌质红、苔黄腻,脉数。检查:体温39℃,咽部充血,扁桃体肿Ⅱ°,脓性分泌物较多。血常规:白细胞 $21.5 \times 10^9/L$,中性86%,淋巴14%。证属肺经热毒壅盛。治宜清热解毒,利咽消肿。处方:

大蓟6克	银花6克	黄芩6克
桔梗6克	薄荷6克	牛蒡子6克
板蓝根12克	柴胡6克	土牛膝10克
大黄9克(后下)		

水煎服。服药2剂后,热退,便通痛减,张口改善,脓性分泌物明显减少。按上方大黄减至6克,继进2剂,诸症痊愈。

按 急性化脓性扁桃体炎属祖国医学“乳蛾”、“喉蛾”等范畴。吴老认为多因肺胃积热,复感风温,内外热毒搏结于喉、脉络受阻,津液受灼,痰结瘀阻而成。方中以柴胡、薄荷、牛蒡子疏散在表之风热;大蓟、银花、板蓝根、黄芩清热解毒,抗菌消炎;桔梗化痰散结;大黄通里攻下,直折火势,釜底抽薪,导热从大便而解;土牛膝清热解毒、活血逐瘀、消炎排脓。诸药合用,共奏清热解毒、凉血解毒、通腑泻热、活血化瘀。吴老强调,小儿易虚易实,用药应注意中病则止,以免伤正。服药期间尽量避免风寒,以免重感外邪。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江苏中医》复刊15周年特刊。

失 音

病例一

谢××，女，41岁。安溪县城人。

1995年2月22日初诊：自诉去年11月因扁桃体肿大施行手术，术后声音嘶哑，喉燥口干，大便干结，排出困难，眠食如常，余无所苦，屡经治疗，未见获效。

诊见：舌质红、苔微黄、干燥乏津，脉沉细数。吴师谓：证属肺燥津伤。治宜养阴清肺，生津润燥。方用：养阴清肺汤加味：

生地 15 克	麦门冬 9 克	白芍 9 克
丹皮 9 克	元参 9 克	银花 6 克
蝉蜕 6 克	麻黄 3 克	薄荷 6 克(后下)
杏仁 9 克	桔梗 6 克	荆芥 6 克(后下)
甘草 6 克	红花 3 克	桃仁 6 克
连翘 6 克		

另用鲜梨 1 粒、盐橄榄 3 粒、百合 15 克、甘草 6 克、胖大海 3 粒，水煎代茶频饮。

5月8日复诊：据云上药服 10 剂，每日 1 剂，水煎 2 遍，上下午分服。声音恢复，诸症霍然。患者大喜，特来称谢不已。

按 肺为燥邪所伤，津液被烁，阴液不能上承，咽喉失于滋润，故音哑喉燥口干，肺与大肠相表里，肺津不足，不能滋润大肠故大便干结，排出困难。方中麦门冬、元参、生地、丹皮养阴清热，凉血润

燥；甘草、银花、连翘清热解毒；蝉蜕、薄荷、荆芥、麻黄、桔梗宣肺达邪，利咽扬声；桃仁、杏仁润燥滑肠，疏肺除热；红花活血润燥，去久病之瘀积。诸药合用，具有养阴清肺，生津润燥之功。肺为娇脏，不耐寒热故失音。选方用药应以甘润最为适宜。用麻黄、荆芥之意，吴师云：此为轻宣之品，先贤言过：“上焦如羽，非轻不举”。失音虽已三月之久，仍需助以轻扬宣肺之药，非特不嫌其表发开腠，且有助于利咽喉，清肺热，鼓动声道而出声。实有相辅相成之功。不必犹豫，贻误病机。

病例二

李××，男，16岁。1994年4月29日初诊。

患者声音重浊不扬，咳嗽、痰稠色黄，喉干、口燥欲饮，伴有大便燥结难下已月余，屡服姜糖茶治疗未效，反而加剧而请教吴老。

诊见：精神好，发音一般，营养中等，舌质红、苔黄、脉数。证属痰热交阻，肺气失宣。治宜清热宣肺，化痰润燥。方用：

桔梗 6 克	前胡 9 克	杏仁 9 克
甘草 6 克	当归 15 克	陈皮 6 克
苏子 9 克	黄芩 9 克	元参 9 克
麦门冬 9 克	麻黄 3 克	荆芥 3 克

5月11日复诊：告曰：药服3剂，咳痰甚多，声音复原，大便畅通。嘱继服3剂后，停药观察。经随访半年，未见复发。

按 本例由于感受风热之邪，灼液成痰，痰热交阻壅遏于肺，肺失升降，气道不利，清肃失司，而致声音不能扬。肺中痰热蕴结，故咳嗽痰稠色黄，津液被灼故喉干，口燥欲饮；且肺与大肠相表里，肺气失宣故大便燥结难下。舌质红，舌苔黄，脉数乃痰热实邪之证。农村习惯凡遇感冒、咳嗽，不问寒热，皆饮以生姜、红糖。本例为外感风热，金实无声，其病属实，并非寒症，故屡治未效，反而加剧，此

为误治。中医辨证至为重要，非精细入微不可。方中：苏子清痰止咳；前胡、桔梗、陈皮宣通肺气，止咳消痰；元参、麦门冬、杏仁除肺热、祛痰止咳、润大肠燥结；当归润胃肠、止咳逆上气；甘草补脾润肺止咳；黄芩清肺理咳、祛痰；少助麻黄、荆芥轻宣肺气，利咽扬声。诸药合用，具有清热宣肺，化痰润燥之功，药仅3剂，声音复原。至于大便也随即畅通与宣肺提壅挈盖法也有一定的关系。

（周建宣 整理）

汗症治验两则

汗乃五液之一，津液代谢的产物。《灵枢·五津液别》：“天暑衣厚则腠理开故汗出”，明确指出此乃正常之出汗。如果不论春夏秋冬而长年汗出如洗者，乃病态也。《素问·宣明五气论》：“汗为心之液”，指出心血为津液所化，汗为津液所泄。故大汗不但散热过多而耗气，也会伤及津液而损于心血，因此对汗症之治疗，应引为重视。根据汗出的部位以及临床症状之不同，治法也各异。现就余带徒继承学术经验之验案，选介汗症治验两则如下：

一、桂枝汤合玉屏风散治疗颈项汗

戴××，女，52岁，康美镇梅星村人。1993年11月10日初诊。

患者素体亏虚，不耐风寒，每于严冬季节头部经常掣痛。5年来自发际至颈项部日夜汗出如洗，时作时止，屡治未效，因而失去治疗信心。2个月来时有微寒，时有微热，饮食无味，头晕目眩，心悸惊惕，体倦乏力，步履不隐，经门人诊断为阳气虚弱，卫外不固，自汗不止。治以牡蛎散两周未见好转而求余指教，续下当如何施治。

刻诊患者面色无华，神倦懒言，语音低微，颈项汗出如洗，舌质淡、苔薄白、脉沉缓。答曰：牡蛎散出自《和剂局方》，方中牡蛎敛阴止汗，浮小麦养心止汗，麻黄根为止汗要药，黄芪益气实表，诸药合用具有益气固表、敛阴止汗之功，用治本病两周不效者，当另行别议，不可贻误病机。综观症候群中有饮食无味，时有微寒，时有微

热，脉沉而缓、舌淡苔白，可能此为辨症症结所在。可就病久体虚，营卫不和，卫阳不振，中焦虚惫而致汗出不止，试从调和营卫，益气固表，补中生血着手，方用桂枝汤加重大枣用量，合玉屏风散治之。

桂枝 9 克	白芍 9 克	黄芪 10 克
白术 10 克	防风 6 克	生姜 3 片
甘草 6 克	大枣 12 枚(擘)	

水煎服。11 月 14 日复诊，服 3 剂汗出仍然如故。嘱继服 3 剂，观察后效。

11 月 17 日三诊，药后汗出仅染染而已，精神转佳。效不更方，嘱再服 3 剂。

11 月 20 日四诊，汗止、食欲增进，诸症若失，病人喜曰：病需药治，果然不错。嘱停药观察，慎避风寒，以自家之牲物作善后调养。经随访两月未见复发。

按 颈项属于头部，头为诸阳之会，精明之府，五脏六腑之精气皆上注于此。《内经》云：“六淫外感，脏腑内伤均可导致阳气阻塞，邪浊上距而为病。”本例患者素体亏虚，不耐风寒，故每于严冬则头部掣痛，此乃体虚营内卫外功能失调，气血不足以上荣，故腠理空疏，脉络失养，因而颈项部汗出如洗。门人诊以阳气虚弱，卫外不固，自汗不止，治以牡蛎散两周未效，此乃辨症尚未抓住要害。患者久病体虚营卫不和，腠理空疏，故时有微寒，时有微热。汗出过多，心阴被耗，中阳受损，故饮食无味，生血之源不足，因而头晕目眩，心悸惊惕，体倦乏力，步履不隐。改用桂枝汤重用大枣，合玉屏风散以调和营卫，益气固表，补中生血。盖取桂枝汤中之桂枝温经散寒，配芍药和阴，二药一散一收调和营卫，能使表邪得解、里气以和，姜枣补脾助桂芍以和营卫，大枣用至 12 枚系遵仲圣调补全身之意，甘草补中调和诸药，黄芪补气固表，白术健脾补中焦以资气血之源，佐以防风益表，而助黄芪御风。

二方合用，营卫调和，腠理致密，补中生血，其功益彰故汗止，

而诸症亦除。门人有所领悟，喜曰：5年之颈项汗，药仅12剂而愈，归功于辨证论治之正确，用药一味之差，则疗效迥异，药理之妙，实不可测度也。

二、黄芪五物汤合生脉散治疗上半身右侧出汗症

黄××，女，61岁，美林镇福溪村人。1994年12月2日初诊。

患者生育5胎，产后乏人照料，均亲自到河溪洗理衣物，初不为意，到40岁当年，上半身右侧肌肉每于气候变化即有酸痹不仁感，不论寒暑季节汗出漉漉然，经断续治疗，酸痹有所减轻，但汗出依然如故，至今已20多年。近年来汗出有所加重，且伴有盗汗，心悸气短，口干作渴，头晕不能自持。

诊见：面色无华，精神萎靡，舌淡尖红，苔少，脉来虚弱。门人分析此乃气血偏虚，寒邪阻络，腠理空疏，方用黄芪五物汤合生脉散治之。药用：

黄芪9克	白芍9克	桂枝4.5克(后下)
生姜3片	大枣10枚	太子参15克
麦门冬9克	五味子3克(打碎)	

连服10剂，症状依然。病人甚急，门人也烦恼不安，拟改弦易辙，求余指出治疗方药。答曰：药症合拍，试从原方部分药物用量作适当增加。黄芪可增至15克于气分中调其血；生姜增至15克以宣发其气，使脉络通畅，腠理致密；五味子善于补虚固脱，先贤东垣对此药甚取义，谓：“五味子补元气不足，收耗散之气，”可用至9克；桂枝辛温，方书虽有口干作渴忌用的记载，但配芍药可调和营卫，腠理致密，且时值寒冬可增至9克无妨；再益以白术15克补中宫土气以安内而生血，且善能燥湿止汗生津。嘱再服一周，以观后效。12月10日复诊，上半身右侧汗出止，诸症亦除。嘱以白术15克、黄芪15克煎汤代茶常服或合牲物炖服，以善其后。

按 本例上半身右侧肌肉酸痹不仁,汗出淋漓,系产后经常接触冷水之故。盖因产后气血偏虚,真气不能充养全身,腠理空疏,水湿之邪乘虚侵袭,流走经络,而致气血运行不畅,故每于气候变化肌肉酸痹不仁,久而久之,阳气受遏,遂致卫阳不固,汗出淋漓。《素问·宣明五气论》:“汗为心之液”,说明心血为汗液所生,汗出时间已久,既耗气也伤津液而耗心血,故出现盗汗、心悸、气短、口干作渴,头晕不能自持,舌淡尖红,脉来无力。先贤云:“右半身汗出多属血中之气虚”,治用黄芪五物汤合生脉散。遵《内经》:“邪入于阴则为痹,然血中之邪以阴气伤而得入,亦必以阳气通而复出”。黄芪五物汤出自《金匱要略》,为通阳要药,即桂枝汤去甘草之缓,加重黄芪之用量,于气分中调其血,更重用生姜以宣发其气,气行则血行,此夫唱妇随之理也,而营卫自调。合生脉散养心生津,敛汗补元。方中人参易太子参补气、益血、生津;麦门冬清心除烦,养胃生津;五味子补元敛汗;再益以白术补中宫土气以安内而生血,且能燥土止汗生津。仅将方中部份药物之用量作适当增加,而达到多年之汗症止,诸症亦瘥。门人教益甚深而喜曰:古人云:“药有君臣千变化”,斯言诚可信也。药理学之理论作用于临床,其理至深也。中医治病贵在辨证,重在立法处方,掌握药之用量。余曰:药之用量多寡,要因时、因人、因病而异,不能千篇一律,医者最宜熟读经书,自能融会贯通,举一反三,以应万变,临床得心应手,自不难矣。

● 原载于1995《第三届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会论文集》。

盗汗

戴某,男,12岁。1994年3月18日就诊。

患者盗汗已多年,时作时止,初不为意。近来夜夜发作,汗量甚多,汗出后头部及四肢冰冷且有畏寒感,上学走路乏力,听课无精打采,表现十分疲劳而求治。

证见:面色无华,舌红、少津,脉细数。门人诊为阴虚火扰,治以滋阴清热之当归六黄汤。处方:

当归 6 克	生地黄 6 克	熟地黄 6 克
黄芩 6 克	黄连 6 克	黄柏 6 克
黄芪 12 克		

水煎服。连服 1 周,盗汗仍然泠泠然而出,求教于余曰:当如何治之?答曰:盗汗多由于阴虚火扰,当归六黄汤为手足少阴药也,具有滋阴清热,固表敛汗之功,用之当效。不效应详加辨证论治。考诸症候有汗出后头部及四肢冰冷,且有畏寒感,此为阴损及阳表疏之阳虚症状。方中固表之药仅黄芪一味,力不胜邪,试就原方加肉桂 3 克,附子 6 克、龙牡各 9 克。续服 3 剂,果然盗汗渐减。再进 3 剂,盗汗理,精神转佳。

按 醒而出汗曰自汗,属阳虚;睡而出汗曰盗汗,属阴虚。阴虚熟睡卫外之阳乘虚陷入阴中,表液失其固卫,故泠泠然汗出,觉则阳气复而汗止矣。当归六黄汤为阴虚火扰发热盗汗而设。方中当归、熟地黄、生地黄滋阴养血;黄连、黄芩、黄柏泻火,更加黄芪补卫固表,使阴复则热退,卫强则汗止。然本例用本方治疗一周未见好转,审其原因。在于病久体虚,阴损及阳,故盗汗出后头部及四肢冰

冷,且有畏寒之阳虚症状,阳虚未复,卫阳不固,单纯使用当归六黄汤无效。法当既滋阴清热,又温阳固表,此阴阳相济之妙用也。于原方益以肉桂调和营卫,鼓舞气血,促使阳生阴长;附子温养元气,又可协同黄芪固表收敛盗汗;牡蛎退虚热,敛虚汗为固涩敛汗要药。诸药相伍,从而达到阴复热退,表固汗止之作用。正如张景岳先贤之“善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭。”是也。

(吴盛荣 整理)

头 汗

吴某某,男,39岁,美林镇省新村人。1990年12月7日就诊。

患者不论冬夏季节,头汗如浴,以前额为多,饮食时为最。余无不适,亦无所苦,工作如常已2年有余,经断续治疗未效,反而益增其汗。患者性嗜酒,饮酒必醉而后快。

诊见:面色如常,谈吐风趣有力,脉数,舌质红、苔黄燥。症属酒热聚胃迫其津液上蒸于头为汗。治宜清泄胃热,降火以敛汗。方用白虎汤加减:

生石膏 60 克	知母 9 克	葛花 9 克
甘草 6 克	黄芪 30 克	牛膝 15 克

水煎服。服3剂后汗止,嘱继服3剂巩固疗效。1991年1月20日携其亲戚来诊,告曰:头汗已愈,未见复作。

按 细审患者所治过之药,皆为桂枝汤,玉屏风散,芪附汤,参附汤等益气固表之药未效,反而益增其汗,正如先贤云:“气有余便是火”,益气反足以生火助汗。本病为素性嗜酒,且饮之过量,酒热聚胃积久化热,上蒸于头迫汗外出。头为诸阳之会,阳得热蒸,故汗出如浴;前额为阳明之经,故汗出特多;饮食入胃助以谷气,故汗出为最。《素问·经脉别论篇》云:“饮食饱甚,汗出于胃”,充分说明本例为胃热上蒸于头而为汗无疑,方用白虎汤加减治之而取效。方中石膏性寒能胜胃火,为清热降火要药,质重之品降火最速,故用大量。知母泻火,甘草和中且能于土中泻火,葛花消酒积,黄芪实皮毛益胃气,使重用石膏不致伤胃,以助敛汗,牛膝性善下行,协同石膏引火下趋而止头汗。白虎汤系仲景《伤寒论》治阳明病,大渴、大汗、

大热、脉洪大等四大症状而设。然本例仅见头部大汗而已，用之也取效非常，并未见弊端。可知白虎汤治疗四大症状的说法，不必尽苟，只要辨证准确，亦未尝不可使用。医者理也，中医治病重于辨证推理，不必拘泥于书本，只有这样，才不妨碍中医的发展。

● 原载于《福建中医药》，1991年第4期。

足 汗

黄某某,男,39岁,美林镇西美村人。1990年10月28日就诊。

患者每于下半夜,膝盖以下即烘热汗出如洗,虽严冬,汗出时该部也不能盖被已3年多。素有耕作水地,腰酸重着,肿胀,大便不实之病史。近日来下肢酸楚,足心微痛,行走乏力,不能久站而求治。

诊见:面色如常,神倦,脉沉缓无力,舌质淡胖、苔薄白。

· 综上症状,为肾虚湿着,命火失于温煦敷布所致。治宜温肾补脾。药用:

小茴 6 克	陈皮 6 克	肉桂 4.5 克(另炖)
砂仁 6 克	补骨脂 9 克	川朴 9 克
黄芪 20 克	牛膝 20 克	秦艽 15 克
白芍 15 克	青蒿 15 克	

水煎服。服5剂后,汗减大半;继服3剂,诸症尽除。

按 本例汗症,历时3年屡治不愈,细阅所有病历,诸医均用秦艽鳖甲散、黄芪鳖甲散、清骨散之类治疗未效。可知非骨蒸之汗。汗出于下半夜,阴中之阴时分,肾主事也。近日来足心痛,足心为涌泉穴肾经也,行走乏力,不能久站,亦与肾经有关。故从肾虚湿着、命火温煦之气失于敷布治之而取效。

方中补骨脂、肉桂、小茴、温补肾阳;陈皮、川朴、砂仁健脾化湿;黄芪合肉桂、益气固卫敛汗,故黄芪用大量;白芍合肉桂敛阴补肾而收汗;秦艽祛除阳明之湿,和血舒筋;青蒿有芳香之气,引诸药入络;牛膝善下行,领诸药直达病所。3年之疑,8剂而愈。总的经

验是,中医治病要不厌其烦,详问病史,参阅原服之处方,慎思明辨治疗才能丝丝入扣,收到预期的目的。

● 原载于《福建中医药》,1991年第4期。

产后血汗

吴某某,女,38岁,仓苍镇仓苍村人。1990年3月1日就诊。

患者于2月14日分娩1女婴,一切如常,越7日,上半身汗出如血水,战战然,倦甚。细查病情,已育四胎均女性,本胎又是女婴,因思想不通,彻夜不眠,纳减,头昏,心悸,虚烦。

诊见:面色少华,脉细数,舌尖红、少苔。症属思虑过度,心火亢炎,阴津暗耗,阳乘阴而外泄,发为皮肤血汗。治宜清心火兼调肺金。药用:

生地9克	元参9克	麦门冬9克
天门冬9克	桔梗9克	丹参9克
桑白皮9克	地骨皮9克	当归6克
五味子6克	蒲黄炭6克	丹皮炭6克
煮南星6克	姜半夏6克	炒枣仁15克
党参15克	黄芪30克	朱砂1.5克(另冲)

水煎服。服3剂后睡眠转佳;再服3剂血汗减少大半;继进3剂血汗止,诸症亦瘥。

按 产后血汗症属少见。本例患者生育5胎,素体本虚,且产后气血不足,复加忧虑过度,彻夜不眠,心火亢炎,而致营血亏损,阴津暗耗,阳乘阴而外泄,发为皮肤血汗。血者心之液也,皮毛者肺之合也,汗出于上半身为气不充,且有寒痰留滞经络之故。药用:生地、元参、麦门冬、天门冬补心肺而清上炎之火;丹参、当归补心血;五味子收敛心气而止汗;枣仁、朱砂清心养神;党参、黄芪补心气。有形之血不能自生,必得于阳气的温煦而后才能生,即所谓“阴生

阳长”，故本方黄芪5倍于当归，其意即促使生血迅捷也。地骨皮、桑白皮合天门冬、麦门冬养肺金，走皮毛而调肺气；煮南星、姜半夏祛寒痰，行经络；蒲黄炭、丹皮炭清血热而涩血；桔梗载药上行。由于用药得当，火清则神安营血足，即阳不乘阴；肺调则皮毛不泄，寒痰祛而经络畅通；涩血而血汗止。药仅9剂，诸症悉除。

● 原载于《福建中医药》，1991年第4期。

心 悸

王某,女,42岁。1993年7月26日初诊。

患者平素多愁善虑,经常失眠。长期以来心悸不宁,入夜为甚。少寐多梦,记忆减退,耳鸣如蝉声。2个月来盗汗连续不断,浸渍衣被。大便干结如羊粪。面色无华,神倦乏力,舌质淡、少苔,脉结代。证属营血亏虚,阴精暗耗。治宜补气益血、滋阴和阳。方用炙甘草汤加附子。处方:

党参 15 克	生地黄 15 克	阿胶 9 克(另熔)
大枣 6 粒	火麻仁 9 克	桂枝 6 克(后下)
炙甘草 15 克	麦门冬 15 克	附子 6 克
生姜 3 片		

水酒各半,药煎两遍,上下午分服。连服2周,诸症皆痊。

按 本例为农家妇女,经济较为困难平素多愁善虑,经常失眠,以致营血亏虚,阴精暗耗。心主神,心血不足则神不安,故心悸不宁;夜为阴时,故入夜为甚,少寐多梦也为心血不足,神不守舍之故。血虚不能荣于上,故耳鸣如蝉声。营血亏虚,阴不敛阳,心火扰动,逼津液外泄,故盗汗连续不断,浸渍衣被。血虚则津枯不能滋润大肠,故大便干结如羊粪。面色无华,神倦乏力,舌质淡、少苔,皆为营血亏虚之症。血虚则气少,且盗汗连续不断,汗为心液,心液伤不能荣于脉,故脉结代。综上诸症皆为病久正气大虚,无阳以宣其气,更无阴以养其心故也。

炙甘草汤为张仲景治疗虚劳不足、脉结代、心动悸之名方。方中党参、甘草、大枣甘温益气而复脉;生地黄、麦门冬、阿胶滋养营

血而宁心；火麻仁甘润补血而滑肠；桂枝通阳；生姜温胃；再益以小量附子以扶阳气而协同收敛盗汗；加酒以助药力也。诸药配伍，共奏补气益血，滋阴和阳之功。方中尤重在炙甘草一味，主持胃气以资脉之本源。有人谓：桂附辛热，似有不宜。殊不知，桂枝能通营卫而致津液；附子能鼓舞肾气蒸化津液，实妙不可言，故熟读经书至为重要。由于用药恰当，多年之疾，仅服2周之药而告愈。

本方用于现代医学的心律不齐、期外收缩以及老人性的习惯性便秘也有效。

（周建宣 整理）

渴饮不止症

吴××,男,64岁。1991年5月9日就诊。

患者禀赋不足,且年事已高,因高热住院治疗5天,汗出甚多,热解后继而出现口渴不已,喜热饮,以夜为甚,每夜须饮热开水约10磅左右也不能解其渴。尿频,排出清澈的尿量相当于摄入的开水量,已15天。伴有头晕、耳鸣、口干、舌燥、手足心热、大便燥结、不欲饮食等症。经中西药治疗,效果不显,而请吴师会诊。

证见:神倦、颧红、脉细数无力、舌质瘦薄、红绛无苔。化验检查:血象正常,尿糖未发现、血压16/12 kPa。脉症合参属于发汗太多,劫津耗液,阴虚火旺,阴损及阳,脾肾两亏之渴饮不止症。治宜健脾益气、温补肾阳,助以清热养阴。处方:

熟附子 15 克	白术 15 克	肉桂 4.5 克(研末另冲)
党参 15 克	淮山 15 克	黄芪 30 克
石羔 30 克		

水煎服。服3剂后口渴大减,每夜仅饮热开水5磅,尿量也随之大减。效不易辍,继服6剂,口渴理,诸症亦瘥。经随访半年一切白如。

按 本例素禀不足,且年事已高,过汗损伤津液,阴损及阳,脾肾两亏之症。脾阳虚衰,失其健运,故不欲饮食;不能化水液为津液,故口渴多饮。肾阴虚衰肾气失其蒸腾,故口渴多饮多尿;尿多津益伤,故出现头晕、耳鸣,口干、舌燥,手足心热、大便燥结,舌质瘦薄、红绛无苔、脉细数无力等一系列伤津症状。方中淮山、白术、党参、黄芪补脾益气,脾气旺盛,则运化有权,纳食正常,水液自然转

化为津液；熟附子、肉桂因患者禀赋不足，年事已高，吴师说，用量应稍大些，以壮其少火，鼓舞肾气。肾气充盈，则阳蒸阴化，津液自生，取其少火生气之义也。正如釜底无薪，锅盖干燥，釜底加薪，枯笼蒸溽。先贤张景岳云：“善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升而泉源不竭。再益以石膏清热养阴，缓益脾气，并可制其附子、肉桂，大热之性。本方阴中有阳，阳中有阴，相互为用，则阴生阳长，津液自生。故药服9剂，口渴理、诸症亦除。

余随侍吴师，见治疗失津症，每于阴药中加入适量之附子、肉桂，屡收良效。如果辨证准确无误，舌红绛无苔，对附子、肉桂也未尝不可应用。

（周建宣 整理）

胃热消谷善饥症(中消)

洪某,男,27岁。1987年11月15日初诊。

患者素性嗜酒及煎炒、炙烤食物。半年前因外感高热治愈后,继而出现胃脘灼热、口渴欲饮,小便频多,大便干结,多食善饥而形体消瘦等症状。尤以多食善饥为典型。日吃5~6餐,每餐饭量约2碗,仍不解其饥饿。就诊时也备来稀粥在诊室充饥,屡治未效,而求诊于吴老。

诊见:消瘦外观,神疲乏力,脉弦略数,苔黄少津。化验室检查:未发现尿糖、血糖。症属脾胃燥热,治宜清胃泻火为主,兼以滋阴润燥。处方:

知母9克	甘草6克	生石膏90克(打碎先煎)
黄连6克	苡仁15克	石斛15克
麦门冬9克	生地黄15克	太子参15克
葛根15克		

水煎服,3剂。

11月18日复诊:胃脘灼热明显减轻,多食善饥也有所改善。效不易辍,守上方继服3剂。

11月21日三诊:胃脘灼热消失,多食善饥大有改善,原方再进3剂。

11月24日四诊:诸症消失,精神转佳,停药观察。嘱用山药合猪肚炖服调理,以善其后。经随访一年,未见复发。

按 本例患者素性嗜酒,好食煎炒炙烤食物,燥热之邪本蕴结于胃中,复受外感高热之邪灼伤营阴,新久之热邪互结,消烁胃津,

因而高热退后,继而出现胃脘灼热、口渴欲饮,小便频多,大便干结,多食善饥而形体消瘦等一系列胃热症状。特别是多食善饥最为典型,在就诊时也备来稀粥在诊室充饥。正如《灵枢·经脉篇》指出:“胃足阳明之脉,……其有余于胃,则消谷善饥”,说明胃主腐熟水谷,胃中热则腐熟作用太过,善食易饥而形体消瘦。考诸医籍,本病《丹溪心法·消渴》指出为“中消”,《素问·腹中论》称为“消中”,《辨证论》称为“胃消”,发病原因皆为脾胃燥热所致。

方中石膏、知母清热养阴以治胃热消渴;甘草、苡仁和胃;石斛、麦门冬、生地、葛根滋阴清热,养胃生津润燥;黄连清热泻火;太子参益气生津。综上诸药,共奏清胃泻火,养胃生津,滋阴润燥之功。药证合拍,故效如桴鼓。吴老云:本方妙在重用生石膏,盖取其为清阳明经热之圣药,再伍以益气生津之太子参,使生石膏清热泻火而不碍胃伤正。先贤虽有胃弱无实热者忌用石膏之说,但临床实践证明,只要配伍适当,亦未尝不可使用。石膏为矿物药,性味甘辛而淡,有效成份不易煎出,必须打碎先煎,这点常被疏忽,应再四向病家申明,始能发挥药效,以免贻误病机。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《山西中医》,1996年第1期。

劳 热

林某,男,22岁。1987年7月15日就诊。

患者于1987年6月29日因脐周部反复作痛历时两周,以(1)机械性肠梗阻,(2)原因待查收住院。经治疗后腹痛不但不减,反而增剧而剖腹探查。病理活检诊断为肠结核。术后每于下午2时左右即发热,体温持续在38~39℃之间,至越早始退。用西药屡治未效而请吴老会诊。

证见:贫血外观,唇红颧赤,神疲懒言,肌肉消瘦,五心烦热,盗汗、自汗并作。舌质红、苔薄白,脉细数。证属内热耗伤气血,以致劳热骨蒸等证。治宜滋阴养血、清热除蒸、固表敛汗。方用黄芪鳖甲散(罗谦甫)加减:

黄芪 30 克	地骨皮 9 克	鳖甲 15 克(打碎)
秦艽 9 克	银柴胡 9 克	青蒿 9 克
太子参 15 克	麦门冬 9 克	白芍 9 克
知母 9 克	当归 6 克	白术 15 克
生地黄 15 克	乌梅 2 粒	甘草 6 克

水煎服。服3剂后午后发热体温在37.5~38℃之间,连服9剂,热退,盗汗、自汗均止,诸症亦瘳,精神转佳。善后嘱用归、芍、参、芪合甲鱼(鳖)炖服调理。经随访1年,身体正常。现在外省经营水暖器械。

按 本例肠结核患者,素体本亏,况兼剖腹手术,消耗气血,阴阳俱虚,复感受风邪,热伏于里,以致虚劳烦热。吴老云:夜热早凉,是邪伏阴分,遵古训阴分之症不能纯用滋阴,因滋阴则邪愈恋;又

不能用苦寒直折,因苦寒能化燥伤阴。治宜养阴透热并举,使阴复则可以制火,邪去则热自退,关键在于使阴分之邪,透出阳分而解。方取罗谦甫治劳热之名方黄芪鳖甲散加减。方中鳖甲、知母、生地黄、麦门冬、银柴胡滋阴清热,特别是鳖甲,滋阴清热,入络搜邪之力为著;青蒿、地骨皮、秦艽清虚热,除骨蒸,尤以青蒿有芳香之味,能引诸药入络,清热除蒸之效为佳;当归、白芍补血和血;黄芪、太子参、白术、甘草益气固卫止汗;乌梅酸涩能引诸药入骨、敛热止汗。合而用之,以凑养阴透热,固表止汗之功,是一张补阴阳、益气血治劳热之良方。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《山西中医》,1996 年第 1 期。

呕 吐

陈××,男,50岁。1988年7月14日初诊。

患者吃生冷食物或蔬菜稀饭入胃后约1小时许,遂即呕吐清水及痰涎,吐出物约为进食物之3倍。三餐赖小麦糊为膳食,始免吐出。病已历时3年,屡治未效,而求治于吴师。

诊见:消瘦外观、神疲、懒言,舌淡、苔白,脉滑。证属痰饮内阻、胃失和降。治宜温化痰饮、和胃降逆。方用吴师自拟的生姜鸡肉汤治之。

处方:生姜60克(带皮切片)、伏龙肝(灶心土)60克,煎取澄清液代水,童鸡一只宰后去毛及肠杂,合炖服,连服3剂。

8月10日复诊:告曰:症已愈,药效如神。7月21日至8月7日因公务出差到天津,三餐不但吃稀饭蔬菜没有问题,甚至连吃西瓜也未见吐水。善后嘱用伏龙肝、生姜、红糖各适量,代茶常服,以巩固疗效。经随访一年未见复发。

按《内经》云:“厥气上逆,唾吐清水”,此厥气系指逆乱之气,痰浊水邪是其中之一。痰饮水邪阻塞于胃则胃冷,胃冷则脾不运化,故停水积饮于胃中,导致胃失和降,反而上逆呕吐清水痰涎。因胃内本有停水积饮,故饮食入胃后吐出之水样物比原来进食之物约3倍之多。舌质淡、苔白,脉滑为痰饮水邪停留之征。《金匱》:“食已即吐者,大黄甘草汤主之”与本例二者同是食后即吐,但有所不同者,本案食后即吐,吐出物为清水痰涎,属寒证。《金匱》:“食已即吐,吐出物为谷物”,属热证。以吐出物为诊断依据,一寒一热,病因不同,治法各异,故辨证尤当审详。

方中：生姜温中降逆，消痰行水；伏龙肝为灶心土，土为万物之母，在人脏腑则以脾胃应之，故万物非土不能生，人身五脏六腑，非脾胃不养，是以伏龙肝久经火熬，能补人之脾胃，为温中止呕之圣药，对燥湿祛痰效用亦佳。病属虚证，故重用鸡肉血肉有情之品，温中补虚，扶羸益气。三药合用，具有温化痰饮，和胃降逆，扶羸补虚之功，药仅3剂，而3年之症愈。可谓药简效验，是一张别开生面扶正驱邪之食疗方剂。

（周建宣 整理）

便秘

病例一

王××,女,42岁。1993年12月8日就诊:大便秘结难下如羊粪,经常是4~5天一解;下腹隐痛,胃脘稍胀时觉头晕心悸,为时已久。面色无华、唇白,舌质淡、苔少,脉细涩。证属血虚津少,治宜养阴补血,生津润燥。方用炙甘草汤加附子:

炙甘草 9 克	大枣 6 粒	阿胶 9 克(另熔)
生姜 3 片	麦门冬 9 克	麻仁 9 克
党参 15 克	生地黄 30 克	肉桂 3 克(后下)
附子 9 克		

12月14日复诊:服药后大便每天一解,无羊粪样及腹痛、腹胀现象。嘱按原方继服7剂,以巩固疗效。经随访半年,未见复发。

按 大便秘结有虚秘、实秘之分,大都由于大肠传导功能失常,但与脾胃及肾脏的关系甚为密切。其发病原因,有燥热内结,津液不足;身体衰弱,气血不足及精神因素影响,气机郁滞等为常见。本案为血虚津少之便秘,面色无华、唇白,舌淡、苔少为血虚之征。血虚不足以上荣于头故头眩,血虚心失所养故心悸,血虚则津枯,不能滋润大肠,且有损及下焦精血,导致本元受亏。真阴一亏,则肠道更形干槁;真阳一亏,则不能蒸化津液,温润肠道,故大便排出困难如羊粪4~5天一下。此乃病及于肾,即《内经》所谓:“肾开窍于二阴”。

方中麦门冬、生地黄、阿胶、大枣、麻仁柔润之品以养阴补血润燥;党参补气益胃;生姜开胃温脾。吴师再三说明,本案用肉桂、附子系取其补水中之火,以鼓舞肾气,即少火生气之义,以蒸化津液、

不必顾虑桂附为辛热之品有碍于便秘。吴师云：炙甘草一味主持胃气，以资脉之本源，具有生血定悸、养阴润燥之功至为重要。诸药合用，以养阴补血，生津润燥，故大便秘结愈矣，而诸症亦瘥。

（周建宣 整理）

病例二 习惯性便秘（血虚便秘）

吴××，女，22岁。1988年7月26日初诊。习惯性便秘已5年，大便3~4天或5~6天一解，燥结难下。常有头晕、目眩、心悸之感，眠食如常。面色无华，唇爪皓白，舌质淡、少苔。证属血虚津少，治宜养血润燥。处方：

当归 15 克	川芎 9 克	酒芍 9 克
熟地 15 克	杏仁 9 克	桃仁 9 克
郁李仁 9 克	瓜蒌仁 9 克	火麻仁 9 克

7月29日复诊：药服3剂、大便畅通，每日1解。效不改方，原方再进3剂。

1990年9月1日携其母来诊告曰，习惯性便秘自治疗至今，大便每日应时而下，无燥结难解现象。

按 患者面色无华为血虚之征。血虚而心失所养故心悸，头目失养故头晕目眩。爪为肝之外候，阴血不足故指爪皓白。大便3~4天或5~6天1解，燥结难下，为血虚津少，不能滑润肠道所致。舌淡苔少、脉沉细均为阴血不足之候。

方中当归、川芎、酒芍、熟地补阴养血；杏仁、桃仁、郁李仁、火麻仁、瓜蒌仁滑润肠道。合而用之具有补虚养血，滑润肠道之功，5年之便秘，药仅6剂而告愈，至今已两年余未见复作。吴老云：归功于辨证论治的正确和“治病必究其原”之功绩。本方见吴老用于治疗年老或产后血虚之便秘也取捷效。

（周建宣 整理）

粪后便血

吴某,男,55岁。患者性嗜酒辛之物,患粪后血已3年有余,每于大便解出后而血始下,每天2~3次不等,血量多而稠,色暗黑。初并不以为意,近月来感口干、纳呆、干活失劲而求治。

诊见:面色失泽,神倦,舌淡、苔微黄,脉细。证属湿热下注大肠,久病营阴受伤。治宜清热燥湿,健脾养营。方用鸦胆子去壳,取完仁25粒,用桂圆肉分包,于清晨空腹一次性以桂圆肉煎汤送下。

疗效:服3天后,每天大便仅一次,血量较少。嘱继服一周,巩固疗效。患者因其他病来诊告曰:粪后血已愈将年,未见复发。

按 粪后血者,系指待大便解后而血始下。《金匱要略》谓:“远血也,指出血部位远离肛门者,多在小肠与胃,故粪便色黯黑”。《素问·阴阳别论》指出:“血色鲜稠宜凉血泻火,血色紫黯宜化湿毒。”本例患者病程已久,肛门出血在粪后,其色黯黑。查其病史,素嗜酒辛之物,此乃湿热下注大肠、损伤阴络之故也。久病多虚,故面色无华,神疲,舌淡、脉细。本案为久病营阴受伤,而湿热未清,为虚实参半之症也。方中鸦胆子入大肠经,清热燥湿;桂圆肉补脾养营。二药合用达到湿去热清,脾健营养,使血能归经而症愈。《中药学》指出:“鸦胆子每次用量宜在7粒左右,过服有败胃”之说,此应引为注意。然吴师治疗本病,每日用量为25粒,用桂圆肉包好,一次性于清晨空腹用桂圆肉汤送下,屡试屡验,并未见弊端。吴师再三强调,鸦胆子腐蚀性强,应用完仁,认真用桂圆肉包好,使直达肠中发挥作用,并可减少刺激。吴师说:本方用于治疗阿米巴痢疾有特效。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《现代中医》,1995年第4期。

眩 晕

陈某,女,42岁。1995年4月15日就诊。

患者素有眩晕史已多年,劳累即发,时作时止。近5天来发作加剧,如立舟之态,旋转不定,双眼不敢睁开,耳鸣头重如蒙,时有头汗出,胸闷欲呕,胃中似饥非饥,嘈杂不安,屡治未效,而请求吴师用中药治疗。

诊见:素体丰满,语声低微,舌质淡胖、苔白稍腻,脉象濡缓。血压:16/10 kPa。吴师曰:证属痰浊中阻,清阳不升。治宜化湿健脾,祛痰升阳。方用:

当归 9 克	酸枣仁 15 克	淮山 15 克
五味子 6 克	陈皮 6 克	半夏 9 克
茯苓 15 克	白术 9 克	天麻 9 克
炮姜 3 克		

3剂,水煎服。

4月18日复诊:诉曰:药效如神,一剂知,二剂已,三剂服完病遂霍然。善后嘱用健脾补肾之茯苓、白术、泽泻、当归、山茱萸、首乌煎汤常服。

按 眩是眼花,晕是头运的总称。常是突然发作的疾病。本病发生的原因,历代医家见解不一。临床所见大都由风、火、痰、虚等多种原因引起,以本虚标实为多;病变脏腑以肝、脾、肾为重点。至于治疗方面,多以平肝潜阳、滋肾填精、养血补脾为原则。如因痰、因火又宜参以涤痰降火之法。

本例临床辨证为痰浊中阻,脾阳不升。痰浊蒙蔽清阳,故眩晕耳鸣而头重如蒙;湿邪阻滞中焦、脾气壅遏,使脾之清阳不升,故胸闷欲呕,似饥非饥,胃内嘈杂不安。舌质淡胖、苔白稍腻,脉濡缓为痰浊内蕴之征。劳累即发作,发作时头部有微汗出均为虚象。

方中白术、陈皮、茯苓、半夏燥湿化痰,健脾和中,降逆止呕;天麻祛风虚眩晕,是熄风要药;淮山药补脾肾,去头风眼眩;枣仁补中益肝气,宁心安神;五味子滋肾益气,安神理汗;当归治风益气,补诸虚不足;炮姜温中补脾。诸药综合,具有化湿健脾、祛痰升阳之功。湿祛脾气升发,痰除浊降,气机通畅,清阳得升,眩晕除,诸症亦随之而解。

(周建宣 整理)

耳鸣、耳聋

王某,男,42岁。1994年3月10日就诊。

患者左耳突然失聪伴有耳鸣如潮声已10多天,余无所苦,但与人交接谈话颇感费力。经某医院五官科诊治未见好转,而求吴师治疗。

诊见:舌质红、苔黄,脉弦数。证属肝胆之火上扰,清窍被蒙。治宜疏泄肝胆之火,佐以开窍通络。处方:

柴胡 9 克	黄芩 9 克	升麻 6 克
葛根 9 克	车前子 15 克	石菖蒲 9 克
路路通 9 克		

水煎服。连服5剂,听力正常,耳鸣告止。

按 耳鸣、耳聋须分新久虚实,在临床上急性发作多属实证,慢性发作多属虚证,一般多与肝肾有关。足少阳经脉上入于耳,下络于肝,而属于胆,肝胆之火循经上壅于耳,清窍失灵,故突然耳聋、耳鸣、咽干口苦。舌质红、苔黄,脉弦数均为肝胆火旺之征。

方中柴胡、黄芩清泄肝胆之火;升麻、葛根、石菖蒲升清阳而通九窍;路路通入肝经,通畅经络;车前子泻小肠、膀胱湿热,使湿去热清;苍耳子宣通脉络,引诸药上行至巅而通窍。药证合拍,5剂而愈。

(周建宣 整理)

舌 痛

尤某,女,71岁。1993年11月3日就诊。

患者舌头灼热样痛已久,2年来经常反复发作,以入夜为甚,越是睡眠不足越厉害,接触酸咸食物则疼痛难忍,口燥咽干喜热饮,面色无华,舌尖红刺干燥,脉虚大。屡经中西医治疗不但未见获效,且形体愈益瘦削,面肢浮肿,而求治于吴老。

审其前医处方,大多投以泻火解毒,养阴清热之类药物。吴老云:此属虚火上炎。年高体弱,应急舟挽舵。治以甘温除热。处方:羊肉120克、大枣10粒、生姜5片、绿豆30克,加水适量,炖烂取服。日服1剂,连服1周而告愈。

按 舌痛为常见的疾病,病因大多为内热或阴虚。治疗以泻火解毒或养阴清热为法。本例患者舌头灼热样疼痛,尤以入夜为甚,夜为阴时,此乃阴虚火炎之症;口燥咽干,喜热饮,舌尖红刺干燥,也为阴虚之候。为何治以泻火解毒、养阴清热,而舌痛益甚,身体日见瘦削?吴老云:本例患者虽属阴虚火炎之候,然年事已高,面色无华,体质虚弱,用滋阴则滞腻脾胃,清热则苦寒伤胃,使生化之机日惫,无以营养百骸,洒陈脏腑,故形肉愈益瘦削,且面肢浮肿,趋于虚损之象。治宜甘温除热为法。

方中羊肉气味甘温专入脾,为血肉有情之品。遵《内经》:“形不足者,补之以气,精不足者,补之以味”的原则,用为君药,以治虚损之久热;大枣甘温补脾益气,养胃生津;生姜和胃健脾,配合大枣可调和营卫;再益以甘寒之绿豆,既资脾胃,又能解久病内蕴热毒之

邪,同时又可调和温性之药不致生火化热。诸药共奏,甘温除热,补益脾胃之功,营血生化之源足矣,则诸虚愈,而火自平。

(周建宣 整理)

临诊偶拾

多年前读张锡纯氏《衷中参西录》，对其一则误用藤黄治愈严重走马牙疳例，印象深刻，至今仍然萦回脑际。其大概情节如下：章某等人偶遇一走马牙疳病儿，起病3日，已牙龈腐化，门牙掉脱数枚，下唇溃穿，求其治疗。章某等先以证情危急，用白马乳凉饮，涂以人中白，内服白虎汤，或有可救，即为方与之。同行有老医倪某某谓之，用牛黄研末外敷腐烂之处，数日后，此儿竟已痊愈。因询所用何物，乃得速效如斯。则曰，用倪某某说，急购藤黄屑而渗之，果然一渗腐势即定，血水不流，渐以结腐落痂，只3日耳。内服白虎汤加减也仅3服耳，此儿之父母误听牛黄为藤黄，而竟治愈极重之危症，张氏认为这是一个值得探索的问题，故将其记载。

这种日常诊疗工作中的偶遇，如果观察细致，常可碰到。对此弃之，甚为可惜，而随手捡来有时便是宝贝。张氏有鉴于此，故记在其书中。近年，余在诊病中曾捡到“二物”，诊余记载之，以之献给此次会议。此或是“野人献曝”，但聊表老人一片心意。

一、活瘤治验

洪某某，男性48岁，左肩胛下生一活瘤约鸡蛋大，无任何痛苦，惟不能仰卧而已，故不思调治，此瘤初起如黄豆大，渐大如斯，发生至今多少年月也记不清楚，前因患缺血性头痛，请予调治。

药用：西洋参6克，黄芪60克、当归10克，丹参15克。每日1剂，水煎两遍，早晚分服。连服10多剂，头痛愈，其活瘤亦不知不觉

自消矣。余以为偶然矣。其后家乡吴某某,男性 52 岁,右耳后下方生一活瘤如桂圆大,余以上方治之数剂,亦消散矣。尔后临症每遇如斯病例,均以此方治之,亦收良效。

此瘤因未经病理切片及任何检查,但能生长,由小而大,故暂取名为活瘤。此瘤之成因,可见与气血运行不畅而流注有关,故用洋参、黄芪、当归补气益血,再佐以丹参活血通络,去除结气。诸药合用,气血得以周流而不息,而瘤消矣。

二、鼻息肉治验

吴某某,女性,52 岁。右鼻孔内发一如米粒大的肿物,初无痛苦,其后渐大,势将塞满鼻孔,呼吸有不适感,因家贫从未治疗过。其时余回乡探亲,求治于余。因思我乡拳师常用咸酸草为人治疗跌打损伤,疗效颇佳。故嘱其用此草叶搓揉塞鼻,取其活血散瘀之功,可塞数次试试。果见清涕直流,不花片钱,其息肉自消矣。

咸酸草为民间俗名,学名为酢浆草,属酢浆草科,多年生草本植物。生长于田间,庭园,路旁,全年均可采集,用之不竭,取之不尽。

三、咽喉验方

余家传一验方,名曰咽喉万应散,凡咽喉诸疾,不论久新,应手立验,余临证亦屡试屡验。吾祖曾视为宝贝,秘而不传,现将该方公诸于众。

白僵蚕 3 克	煅硼砂 1 克	百草霜 1 克
白丁香 10 克	白明矾 5 克	江子仁(去壳)9 粒
川黄连 3 克	煅文蛤 10 克	甘石粉 1 克
明牙硝 10 克	人中白 2 克	珍珠粉 3 克

大梅片 2 克 小牙皂 1 克 云琥珀 3 克
正麝香 2 克 玄明粉 10 克 明雄黄 2 克
蜚脚刺 2 克

上药合为极细末，贮于密闭的瓶中，放置阴凉干燥处，每用少许，吹于咽喉部。

● 原载于《中国泉州——东南亚中医药学术研讨会论文集》，1991 年。

凝脂翳

刘某,女,54岁。家庭妇女。右眼患角膜溃疡已3个月有余,经多方治疗未效而求治于吴老。

诊见:一般情况尚好,左眼正常,左眼充血流泪、羞明、疼痛、视物不清、头痛甚剧,角膜瞳孔区表层见两溃疡点如米粒大小。吴老诊断为肝经火盛,上乘于目,治宜泻肝清火,活血解毒。

方用:鲜车前草60克,洗净凉干绞汁,调蜂蜜适量,用益母草30克,煎汤泡服,每日饭后服1剂,并结合耳后上部小血管结扎治疗。

结扎法:将患侧耳后的小血管用手指轻轻推揉使其怒张,然后用酒精消毒,再将消毒过的针带线从小血管下穿过进行结扎,待痊愈后拆线。全病程仅结扎一次就可。

疗效:药服7天,配合小血管结扎而痊愈。

按 角膜溃疡,又名凝脂翳,俗称眼生珠。因风热毒邪外侵,肝经实火内炽,交互搏结于上所致。黑睛发翳,色白微黄,状若凝脂,故名曰凝脂翳,其症状为头眼剧痛,目赤羞明,泪热眵稠。吴师云:发展迅猛可溃穿黑睛,甚至失明,应当引以为戒,不可不慎。临床见吴师用本方治角膜溃疡多收良效。方中益母草辛苦微寒,入心包、肝二经、活血化瘀,清热消炎;蜂蜜入心、肺、脾、胃、大肠五经清热补中,解毒止痛;车前子甘寒入肝、肾、小肠三经、利水清热、平肝明目,补肾益精,甄权认为可去风毒,肝中风热,毒风冲眼,赤痛障翳,脑痛泪出。根据吴师多年的临床应用,认为确实是治眼疾之圣药,用其鲜草绞汁之义,盖取功效迅速也。再结合患侧耳后上部小血管

结扎疗法,乃根据现代医学机理的探讨和临床经验,这种良性刺激具有解毒、消炎、镇痛和增强免疫功能的效应。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《现代中医》,1995 年第 4 期。

嗜 睡

黄××,女,37岁。1995年5月22日就诊。

患者头重如裹、嗜睡、睡不知觉,精神不振已数天,伴四肢乏力,腹满纳差,大便稀溏,小溲短赤。每年夏天季节到来都如此。舌苔白稍腻,脉濡缓。吴老云:证属暑湿内阻,上扰清窍。治宜芳香化浊,理脾除湿。处方:

川芎 9 克	羌活 6 克	苍术 9 克
白芷 9 克	藿香 9 克	石菖蒲 9 克
郁金 6 克	半夏 9 克	

水煎服。药服3剂而愈。

按 本例嗜睡症吴老认为系感受暑湿,上犯巅顶,清窍为邪所阻遏,故头重如裹、嗜睡、睡不知觉,精神不振。脾司运化,而主四肢,湿浊中阻,脾阳为湿所困,故见四肢乏力,腹满纳差,大便稀溏,小溲短赤。舌苔白稍腻,脉濡缓为暑湿交阻之象。方中川芎、羌活清头目而去风湿;苍术、白芷芳香化湿,健脾开胃,透邪醒脑;藿香升清降浊,辟秽清神而消暑湿;石菖蒲、郁金辟秽开窍,清神益智;半夏燥湿去痰、健脾和胃。诸药共奏、芳香开窍、理脾除湿,而达到湿去窍开,嗜睡愈矣。

(周建宣 整理)

严重失眠症

陈××,男,27岁。1991年7月15日初诊。

患者严重失眠已将半年。发病前,因工作繁忙,用脑过度,曾冥思苦索一夜未睡,嗣后则日夜不眠,亦不呵欠。曾服中西药物均未见效而求治吴老。诊见头晕痛,口苦,舌质红、苔黄腻,脉弦数。证属肝火亢盛、上冲于心。治宜清肝泻火、镇心安神。方用自拟清肝安神汤:

夜交藤 15 克	合欢皮 12 克	珍珠母 30 克(先煎)
川连 9 克	胆草 9 克	川芎 9 克
白芷 9 克	郁金 12 克	甘草 6 克
龙齿 15 克(先煎)		

水煎服。药服 6 剂而病愈,高兴万分。随访未再复发。

按 失眠为临床常见证之一,然治疗实属棘手。由于病因不同,体质差异,病程久暂等因素,失眠的程度也轻重不等。一旦发生失眠,患者的精神容易紧张,情绪焦虑,恐惧,求寝之心越切,越是床第辗转难眠,如此恶性循环,甚至通宵目不交睫,服安眠药初尚有效,常服则失灵。吴老认为本案主要由于肝失条达,气郁化火所致,口苦、舌红、苔黄腻、脉弦数乃肝火之证。肝火上扰清窍,故头昏痛;肝火上扰心神,故日夜不眠。治疗时用自拟清肝安神汤,仅服 6 剂而愈。方中用胆草、川连大苦大寒清肝之火;郁金、川芎疏肝之郁;龙齿、珍珠母平肝镇心;夜交藤、合欢皮凉肝镇静安神;白芷协川芎祛风止痛,甘草调和诸药,标本兼顾,药证相合,故效如桴鼓。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《第一届全国疑难杂症诊治学术研讨会论文集》,南开大学出版社出版,1994年8月第1版。

夜游症

林××,男,30岁,农民。1991年8月10日初诊。

患者夜游已3年,每于工作紧张或情绪过于兴奋后,夜晚即发作。东张西望,床底寻物;时或一跃而起,外出行走。询之却茫然无知之所为,大声呼叫始能清醒。发病之后,全身疲软并伴有口苦,烦躁不安,食欲不振。舌质红、苔黄,脉弦。证属肝阴不足,肝阳上亢,肝火内炽,上扰心神所致。治宜平肝潜阳,宁心安神。处方:

刺五加 15 克	夜交藤 20 克	代赭石 30 克(先煎)
合欢皮 15 克	酸枣仁 15 克	磁石 20 克(先煎)
灵芝草 15 克	麦冬 20 克	柴胡 9 克
龙胆草 12 克	陈皮 9 克	钩藤 12 克(后下)
夏枯草 9 克	甘草 6 克	

水煎服,每日1剂。服药3剂后,夜游仅1次,诸症好转。药已中病,嘱按原方继服3剂,病告痊愈,未再复作。

按“夜游症”类似祖国医学的“心神不宁”、“神不守舍”。《灵枢·邪客篇》:“心者……精神之所舍也。”病邪犯心或精神刺激过度而出现的神志异常,均可导致“神不守舍”。吴师云:本例患者属肝阴不足肝火内炽、上扰心神所致,故治宜平肝潜阳,宁心安神。方中代赭石、钩藤平肝潜阳熄风为主药,辅以胆草、夏枯草、柴胡清心除烦;佐以麦冬、陈皮养阴和胃,再加磁石、夜交藤、合欢皮、酸枣仁以宁心安神;刺五加、灵芝草有提高机体的防御能力;甘草调和诸药。合而用之,使阴平阳秘,心安神宁,故仅服6剂而病愈。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江苏中医》,1993年增刊。

隆闭(前列腺肥大)

王××,男,65岁。退休干部。1993年11月5日初诊。

患者素体健壮,一年来时感腹部胀满,继而小便困难。近一个月来小便费力,须用10余分钟始能排出,尿量甚少,点滴而下,伴阴茎中时时作痛。经××医院诊断为前列腺肥大,用西药治疗效果不甚明显,而要求服中药治疗。

检查:形体肥胖,痛苦病容,时作叹息,舌质紫、有瘀点、苔微黄,脉细数。指肛检查前列腺肥大如桃核。

吴师谓:证属气虚阴盛,瘀浊互结。治宜补气活血散结,化气利水清热。处方:

黄芪 30 克	泽泻 12 克	白术 12 克
苡仁 15 克	茯苓 15 克	丹皮 12 克
赤芍 15 克	木通 9 克	桃仁 10 克
红花 6 克	石苇 15 克	扁蓄 15 克
甘草梢 9 克	肉桂 4.5 克(另炖)	

水煎服。连服3剂,排尿困难、小腹胀满及阴茎中痛均见明显好转,尿量增多。药已中病,遵吴师意,仍守原方再服7剂,小便通畅,诸症消失。善后嘱用此方配成丸剂常服,以资巩固。

按 隆闭是以排尿困难,甚则小便闭塞不通为主证的疾患。本病是一种常见老年疾病,属本虚标实。祖国医学认为其病机多与中气不足,肾虚不能气化,气滞血瘀,膀胱气化不利有关。吴师云:本案患者体质肥胖是气虚阴盛之象,气为血之师,气行则血行,气虚

则运行无力，久则气滞血瘀，所谓气虚则阳衰，无阳则阴无以化，湿浊肉蕴，瘀浊互结而成积块，阻塞于膀胱尿道之间，故小腹胀满，小便困难，点滴而下。此病虚中有实，故阴茎中时时作痛，舌质紫有瘀点、苔微黄、脉细数。治宜补气活血散结，化气利水清热。

方中重用黄芪补气升阳，补气可以升血活血，气升则湿浊除而水自降，活血则瘀积自消；伍以茯苓、白术以补脾燥湿，则小便利，正如李东垣所说的“脾病能使九窍不通”；泽泻可泻膀胱经之湿；茯苓、木通、石苇、扁蓄、清利水道；丹皮、桃仁、红花、赤芍、行瘀散结；甘草梢清热泻火而能直达茎中以止痛；再益以肉桂温行肾气，通血脉促气化，膀胱是津液之腑，气化得行而小便自通，具有至妙之处。诸药合用，共奏补气活血散结，化气利水清热，由于药与症符，故临床用于治疗隆闭取效迅速。

（周建宣 整理）

泌尿系结石

泌尿系结石属于祖国医学“砂淋”、“石淋”、“血尿”等范畴，临床屡见不少。审诸方书，发病的主要原因，大多由于肾和膀胱气化功能失职，或平素嗜酒，多食甘肥辛辣之食物或因情志抑郁、工作劳累引起气滞血瘀，湿热隐结下焦，日积月累，尿中浊质逐步凝结而成砂石。砂石塞于泌尿系统的通道，滞而不通则腰痛剧烈、尿频、尿急而涩痛，结石伤及血络则尿血，是常见的主要症状。临床治法不一，方药各异，虽不尽万全，然各有可取之处。如能扬长避短，则祖国医学大有作为。

吴师认为本病其本在于肾功能失调，其标在于湿热隐结于下焦，久积成瘀结为砂石。治法采取本标结合，用药选用既能扶正有益于肾经，又有利于通下排石。

桃仁一味，历代医家均用于破血行瘀，润燥滑肠。很少用于治疗泌尿系结石。吴师取其桃仁既能化瘀，又有滑下之功，泌尿系结石也是瘀积之一。做法：将桃仁去皮尖，用米皮糠、食盐各少许合炒至桃仁焦黄，然后去米皮糠、食盐，取桃仁研为粉末，每用15克，早晚开水调服。桃仁生用则破血力强，加糠盐过炒，得糠盐之气，不但可缓解其攻破迅猛之力，而且盐能补肾、糠能补脾，既能达到化瘀滑下，且能顾护先天、又壮后天，治疗泌尿系结石，万无一失。

如果结石多年屡攻不下，吴师云：再益火麻仁研为粉末，每次9克，用盐炒牛膝30克，煎汤送服。盖取火麻仁能刺激胃肠粘膜分泌增多，蠕动加快，牛膝性善下行而滑窍，加盐制炒，又可引入肾经，此效《证治准绳》牛膝汤治疗小便不通，茎中痛之义。吴师谓：医

者意也,如能熟读经书,加以会意,灵活变通,一药可应万变,治疗自可得心应手。

吴师治一病例,孙××,男,42岁。素有小便刺痛窘迫感。诊前突然右腰剧烈绞痛并放射至会阴部及右腹股沟,继而出现肉眼血尿。右腰部叩击痛明显,尿检:蛋白(++)、红血球((++++))、白血球(++)、X光拍片发现右输尿管下段有0.5×0.7厘米结石阴影,诊断为右输尿管结石。舌质红、舌苔黄、脉细弦。治以化瘀润下排石,方用糠盐合炒之桃仁粉末15克,每日2次,早晚用开水调服。服至第8天,突然右腰绞痛剧烈,坐立不安。嘱用盐炒牛膝30克煎汤饮服,翌早排出结石,诸症悉痊。X线腹平片复查,未见阳性结石。此方用于治疗肾结石、膀胱结石、尿道结石也有效。

(周建宣 整理)

淋 病

黄××,男,23岁,已婚,供销员。1991年11月14日初诊。

患者自诉于10天前到外地出差与异性发生关系,继感尿频、尿急、尿痛、尿道口红肿并有脓性分泌物流出。经医院采集尿道口分泌物涂片检查发现有淋病双球菌。经用多种抗炎药物无效。诊见:舌质红、苔黄腻,脉弦数。吴老辨证为下焦热毒,湿浊壅滞所致。治宜清热解毒,利湿化浊,祛瘀通淋:

土茯苓 30 克	生地 15 克	萆薢 15 克
炒穿山甲 12 克	皂刺 12 克	银花 10 克
连翘 12 克	黄连 9 克	木通 9 克
车前子 20 克	甘草 6 克	大黄 15 克(后下)
白花蛇舌草 30 克		

每日1剂,水煎2遍,早晚分服。第3遍煎汤浸洗患处,每次浸洗15分钟,共进5剂,患者排尿困难明显好转,再服5剂,临床症状全部消失。一个月后复查,实验室检查均正常,随访至今,未见复发。

按 淋病是由于性交不洁而引起的泌尿系统传染病,属于祖国医学“淋症”、“白浊”等范畴,吴老认为本病病机系感受恶秽之邪,邪毒蕴结下焦,以致膀胱气化不利,化生湿热而引起。故以清热解毒,利湿化浊,祛瘀通淋为其治疗大法。

方中白花蛇舌草、土茯苓清热解毒;生地、银花、连翘、黄连清下焦湿热、泻火毒;萆薢利湿化浊;大黄泻火通便,可使邪从大便而出;木通、车前子利水通淋,可使邪从小便而出;穿山甲、皂刺托里

清热,散瘀败毒;甘草调和诸药,并引诸药直达病所,止茎中疼痛。综观全方,清利结合,相辅相成,二便通利,邪有出路;同时加用外洗药物局部浸洗,内外兼治,故收获甚捷。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江苏中医》,1993 年增刊。

血 精

杨××,男,35岁。1991年11月6日初诊。

患者半年前出现精液带血,伴射精疼痛。经外科诊断为“精囊炎”。曾予多种抗生素治疗,效果不明显而求诊于吴老。精液带血伴有小便黄赤,轻度尿频,尿急尿痛,小腹坠胀隐痛,便秘,口干苦。舌质红、苔黄腻,脉弦滑。精液常规检查:见肉眼血精,色暗红,红细胞(++)。证属湿热内扰精室,灼伤血络而致血精。治宜清热解毒利湿,佐以凉血活血止血。处方:

金钱草 20 克	银花 6 克	连翘 9 克
虎杖 15 克	车前子 15 克	生地榆 15 克
丹皮 12 克	黑蒲黄 12 克	白茅根 15 克
知母 12 克	黄柏 9 克	甘草 9 克
白花蛇舌草 20 克		

水煎服。连服 12 剂后,诸症消失。精液常规检查正常。嘱服知柏地黄丸调理善后,半年后随访,未再复发。

按 血精一症,吴老认为多由于湿热之邪伤及精室血络而致。故方中以白花蛇舌草、金钱草为主,配银花、连翘清热解毒;虎杖为辅,配车前子、滑石利湿清热;佐以丹皮、生地榆、黑蒲黄、白茅根化瘀凉血止血;知母、黄柏滋阴降火,既防湿热内蕴伤阴,又治虚火内扰;使以甘草调和诸药。全方共奏,清热解毒利湿,凉血活血止血。由于药证合拍,故获良效。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江苏中医》,1993 年增刊。

肠梗阻二例

病例一

黄××,男,45岁。1991年12月5日初诊。

患者因化脓性胆囊炎行手术治疗,术后3天未排气,腹胀难忍,便秘伴有腹痛,恶心呕吐。腹部听诊,肠鸣音亢进,有气过水声,舌红少津,苔黄腻,脉滑数。X片报告:肠管高度充气,见梯状液平。西医诊断为急性肠梗阻。吴老辨证为瘀热内结,腑气不通。治宜通里攻下,理气化瘀。处方:

大黄 15 克(后下)	元明粉 15 克(冲)	枳实 12 克
炒莱菔子 12 克	桃仁 12 克	川朴 12 克
赤芍药 10 克		

水煎服。服1剂后,大便通畅,腹胀、腹痛明显好转。效不更方,守上方去元明粉、大黄减至10克,再进1剂,腹痛、呕吐均消失。继以健脾理气和胃之香砂六君子汤调治3剂,一切如常。

按 肠梗阻是外科急腹症的常见病、多发病。临床表现以痛、胀、呕、闭四大症为特征,类似祖国医学的“肠结”、“关格”。吴老认为,本病多因饮食不节、湿浊内阻或气滞血瘀而致胃气失降、大肠传导失职,而产生大便秘结、呕吐、腹痛等症。根据六腑为“传化之腑”,其功能“泻而不藏”、“降而不升”,以通降下行为顺的生理特点,吴老治以理气化瘀、通里攻下为基本大法。方中重用大黄、元明粉,意在急下泻热,通腑开结。吴老强调病机既明,治疗宜速战速

决,不可迁延失误。本方为泻实之剂,久服能伤正气,泻下痛止,说明急流挽舟已成,应予转舵,改用香砂六君子汤善后,而收全功。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《第一届全国疑难杂症诊治学术研讨会论文集》,南开大学出版社出版,1994年8月第1版。

病例二

吴××,男,63岁,码头镇诗南村人。1992年3月15日就诊:

患者上腹部痞满、呕吐由微而渐已10天,初不以为意,3日来呈持续性剧痛伴剧烈呕吐胃内容物,大便6天未解,经××医院X光透视诊断为肠梗阻。入院后给输液,并抽出胃内容物,腹痛未见减轻,因拒绝手术而求治。

证见:神疲乏力,表情痛苦,额汗淋漓,口干欲饮,腹部胀满拒按。体温 38.5°C ,白细胞 $13.5\times 10^9/\text{L}$,中性85%,淋巴15%。脉弦数,舌质红干、苔焦黄。证属热邪深固,秘结不解。治宜通腑泄热,急下存阴。药用朴硝30克即刻用温开水溶化顿服,以冀腑通痛止。药后果然肠鸣,矢气频传,解出恶臭之粪甚多,腹痛大减,呕吐告止,自觉腹中空虚,思食甚切,嘱以米汤少量多次频饮。

3月16日复诊,诸症若失,急流挽舟已成,年老体衰不可攻伐太过,嘱用芝麻油、蜂蜜各15毫升,每日一次,滋润补中,以善其后。

按 本例患者查其本性嗜酒,又喜食辛辣食物,大便秘结已6天,发病前又食糯米粽子,遂有腹痛、痞满、呕吐由微而渐至于剧烈发作。脉证合参为食滞久蕴化热,腑气不通,虽年过花甲、体质又虚,然痞满燥实俱全之阳明腑实证,非速下以救其急常能危及生命。遵仲圣“急下存阴”之训,及先贤成无己曰:“热于内,治以碱

寒”，毅然重用朴硝一味治之，盖取其药专力宏，迅速直达病所。《本草求真》云：“朴硝其性最寒，用治消物，故以硝名，凡五金八石用此俱能消除，况人身脏腑积聚乎。”门人惧而问之，“年老体衰，用此岂不伤人命矣”，告曰：此热邪深固，秘结不解之阳明腑实证，非攻不举，不能贻误病机，经云：“有故无殒，亦无殒也”此之谓欤。药后一剂而愈，果收良效，并无见碍，此乃药与症符，门人喜曰：先贤之言诚不谬也。中医治病，贵在慎思明辨，用药要有胆有识自能得心应手。

● 原载于《第二届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会论文集》，1993年9月。

肠 痙 挛

郑××,男,38岁,溪美镇崎峰村人。1991年5月19日就诊。

患者酒后外出,突被雨淋,越3日小腹隐隐冷痛,10多日来呈阵发性拘急剧痛,不可俯仰,呻吟床第,痛苦不安,不欲饮食,口不渴,小便清长,已5天未解大便。门人治以大承气汤加桃仁、生地,药后腹泻数次,腹痛未见减轻而求治。

证见:精神萎靡,痛苦病客,就诊时腹痛发作,额汗如珠,四肢逆冷。腹部可触及肠型,脉沉紧,舌质暗淡、苔薄白。证属下焦受寒,厥阴失疏。治宜温经散寒,嘱急用老姜,葱头各15克捣烂,合鸡蛋煎如饼,乘热敷于脐部,未几小腹痛略减,继用:

木香 6 克	附子 15 克	肉桂 4.5 克(另冲)
干姜 6 克	乌药 9 克	川椒 4.5 克
吴茱萸 9 克		

水煎服。药后腹痛缓解,效不易辍,继服1剂,腹痛理,大便通,能纳食,无所不适,给桂附理中丸10粒以善其后。

按 本例肠痙挛属于祖国医学“肠寒证”“拘急”、“拘挛”等范畴。盖因酒后全身血管扩张,复加雨淋,寒邪入侵腹中,气机阻滞,积于下焦,厥阴之气失疏。寒为阴邪,其性收引,故小腹拘急剧痛,不可俯仰,正如《素问·举痛论》所说:“寒气入经而稽迟,泣而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛。”脉沉紧,舌质暗淡、苔薄白,口不干渴,小便清长,四肢逆冷均是里寒症之征。至于大便5天不解,乃阴寒凝结,温运无力,非温不动,不属于食滞之腑气不通,故门人用大承气汤加味泻下后,大便仍然秘结,腹痛

未见减轻,遵《内经》训,“寒淫所胜平以辛热”说明逐寒邪,必先以辛热治之。

药用吴茱萸温中散寒为厥阴本药;附子大辛大热,火性迅速无不到,善於振奋阳气以救逆。陈修园谓:“附子为回阳救逆第一药”,故二药用量大於它药;肉桂取其有温煦之功,鼓舞气血,为气血寒滞要药;干姜温中散寒,回阳通脉,去脏腑沉寒痼冷,台乌药、小茴香、川椒温肾散寒;木香入肝经,调气止痛。诸药相伍,迅速直达下焦,因中其病所,寒邪去,腹痛除,故药仅2剂而愈。中医治病,贵在辨证,准确、用药精当也。

● 原载于《第二届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会论文集》,1993年9月。

右肝管结石合并感染

陈××,女,54岁,眉山乡山后村人。1991年元月26日就诊。

患者右上腹闷胀已8年,常因情志不遂或劳累过度而加重,近日来呈持续性发作伴阵发性加剧,痛引肩背,恶心呕吐,口苦且干,不欲饮食,大便干结,小便赤涩。经××医院B超诊断为右肝管结石合并感染,住院治疗效果不显而求治。

证见:精神不振,表情痛苦,额汗淋漓,巩膜及皮肤轻度黄染,腹部拒按。体温38.5℃,血象:白细胞 $15.3 \times 10^9/L$,中性82%,淋巴18%,脉弦,舌质红、苔黄厚。证属肝郁气滞,湿热内蕴,治宜清热通下,理气化痰。方用自拟“清胆消石汤”:

柴胡 9 克	五灵脂 9 克	生大黄 20 克(后下)
蒲黄 9 克	木香 9 克	朴硝 15 克(另冲)
金钱草 30 克	薏苡仁 15 克	

水煎服。服7剂后,天天泻下,腹痛明显减轻,精神转佳。效不更方,按原方大黄减到15克、朴硝减至10克继服7剂,诸症悉痊,停药观察。6月24日再到原检查医院作B超复查,肝胆未见异常,嘱用金钱草代茶常服,以消除残存湿热瘀结。随访年余,劳动正常。

按 本例为湿热久蕴不化,肝郁气滞,中清之腑通降失职,胆汁凝炼而成结石。遵《内经》“通则不痛,痛则不通”和“六腑以通为用”之旨,方用自拟“清胆消石汤”治之。方中朴硝软坚化石;大黄通腑逐秽、清利湿热去瘀生新;金钱草清肝利胆排石;柴胡疏肝理气;五灵脂、蒲黄理气行血止痛,现代药理表明,有明显缓解平滑肌痉挛的疼痛;木香疏肝解郁,调气止痛;益以薏苡仁健脾益胃,清热利

湿,可缓和朴硝、大黄泻下过剧而伤正。

根据笔者临床经验,凡肝结石,腹部剧痛,朴硝,大黄用量宜大,以通腑逐秽,推陈致新定乱致治,而达到迅速止痛且无见碍也。《内经》云:“知其要者,一言而终”是之谓也。

● 原载于《第二届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会论文集》,1993年9月。

寒积腹痛

林××,女,48岁。1993年4月1日就诊。

患者每于寒冬季节五更黎明以前,小腹卒然拘急作痛,喜按,得热饮后则放屁,腹痛遂即缓解。近3个月来,天天发作,神疲乏力,不耐劳动,脉沉弦,舌质淡红、苔薄白。吴师谓:此乃下焦受寒,厥阴之气失于疏泄之寒积腹痛症。治宜温肝散寒。方用暖肝煎加减:

小茴 6 克	当归 6 克	枸杞 9 克
台乌药 6 克	白芍 15 克	炙甘草 9 克
川椒 6 克	生姜 3 片	桂枝 6 克(后下)

4月4日复诊:服3剂后症状消失。为巩固疗效,嘱继服3剂。经随访,寒冬季节未再复发。

按 吴师云:五更黎明前为阴中之阴时分,寒积滞留于肠之间而致气机阻滞,寒为阴部,其性收引,阴得阴助,故于其时小腹卒然拘急作痛。正如《素问·举痛论》:“寒气入经而稽迟,泣而不行,……客于脉中则气不通,故卒然而痛。”得热饮后则阳气通,故放屁后腹痛遂即缓解。方中当归、枸杞温补肝肾;桂枝、小茴香、川椒、生姜、温肾散寒、台乌药行气顺气;白芍、炙甘草缓急止痛。綜上諸藥,以温补肝肾治其本,行气逐寒治其标,本标兼顾、温阳散寒,故小腹痛愈。

(周建宣 整理)

交媾感寒腹痛

男女交媾时或过后不慎感受寒邪而致小腹剧痛难忍，俗谓色寒痛是也。吴师临床五十余载屡见不少，自拟一方名曰：“回阳救逆汤”治之，疗效尚属不逊。方药为：

吴茱萸 15 克 附子 9 克 干姜 9 克
白芍 9 克 炙甘草 9 克 肉桂 6 克(研末另冲)

水煎 2 次，即服 1 次，隔 30 分钟后再服 1 次。药后腹痛可望遂即缓解。

交媾感寒腹痛与其它腹痛不同，大多急剧发作，痉挛样疼痛难忍，如治疗失当，貽误病机，常可导致昏厥之危险。交媾之后，阴精疲耗，腠理空虚，如宿露、餐风、淋雨或用冷水淋浴，寒邪乘虚而入，可直中阴经，阻滞气血运行，而致小腹剧痛难忍。如见头部冷汗淋漓，四肢厥逆而麻木、指甲青紫、囊缩、舌质兰、脉沉微之象，此属危候。吴师指出，治疗措施应该果断，非大辛大温开发之剂，难以回阳救逆，在这关键时刻，不可犹豫不决，即先贤陈修园氏指出“救危慎勿等旁观”，故本方重用吴茱萸，更辅以附子、干姜、肉桂、白芍以温阳敛阴而收扶危救急之效。

吴师治一病例，尤××，男，42 岁。患者于 1992 年 7 月 12 日午睡与其爱人性交，突然客至叩门，遂起床会客，其时气候炎热，暑气凌人，开电风扇至最高档。客归，用冷水淋浴，越早神疲乏力，全身关节疼痛。入夜小腹剧痛难忍。驱车请吴师诊治。症见：痛苦病容，面色苍白，指甲青紫，头部冷汗淋漓，四肢逆冷，囊缩屈身，双手按住小腹，呻吟不安，势欲休克之状，舌质兰，苔润，脉沉细微。吴师

曰：症属色寒腹痛(交媾感寒腹痛)之危候。治宜回阳救逆、散寒止痛。急用生姜、生葱各 30 克，合捣如泥，加酒少许，合鸡蛋煎如饼，乘热敷于脐部，未几腹痛有所缓解。继服回阳救逆汤，一剂知、二剂已、病遂霍然而愈。

(周建宣 整理)

阴寒腹痛合并便秘

陈××,男,38岁。1991年5月15日初诊。

患者下腹部绵绵冷痛,时作时止,痛时喜按喜热饮已10多天,无畏冷发热。近5日来呈阵发性拘急剧痛不可忍,四肢厥冷,小便清长,大便秘已5天未解。经××医院治疗未效而求治于吴老。

诊见:痛苦病容,四肢厥冷、腹部可触及肠型。舌质黯、苔薄白,脉沉弦。证属阴寒凝结,治宜温经散寒,辅以通下开秘。方用温脾汤加味治之。处方:

附子9克	干姜4.5克	川朴6克
甘草3克	吴茱萸6克	大黄9克(后下)
木香6克	小茴香6克	肉桂4.5克(另冲)
乌药9克	元明粉9克(另冲)	

嘱服1剂,观察疗效。5月16日复诊,药后大便通,腹痛理,原方去大黄、元明粉继服3剂。

5月19日三诊,一切如常,无所痛苦,嘱停药观察。

按 本例患者先是下腹部绵绵冷痛,时作时止,痛时喜按喜热饮,后是阵发性拘急剧痛不可忍,四肢厥冷,腹部可触及肠型,小便清长。吴老谓:此乃寒邪留滞于经脉,厥阴之气失疏之症。大便秘结5天未解为阴寒固结,气机不调,温运无力所致,此属阴结冷秘也。治用先贤许淑微之温脾汤为主,取其以温药下之方法,以去在肠间之沉寒痼冷,且能温通经脉而止腹痛之功。再益小茴香暖肝温肠;木香疏肝解郁调气理痛;川椒、吴茱萸温中散寒;乌药治气血凝滞;元明粉润燥通下。诸药合用,具有温寒理痛,温通开秘之作用。

由于药与症符,仅服3剂而腹痛理,大便通,如常人。

(周建宣 整理)

瘀血性头痛三例

病例一

黄××,男性,40岁。1971年5月5日初诊。

患者额顶头痛已十多年,发作经常在午后或入夜之时,一日数次或数日一次不定,多以气候转变或阴雨天为甚。痛时如锥如刺,或如刀割,痛苦难以形容,剧痛时头部须用力猛顶睡床的一侧。由于病程长,体质虚。经常性头晕眼花、四肢无力,对身体的健康和劳动影响很大。为解除头痛这一苦楚,经数家医院治疗均未获效。

诊见脉涩、舌质淡胖而晦、苔薄白、舌边有齿痕。证属病久体虚,久痛入络,气滞血瘀,(血管神经性头痛)。治宜活血通络,佐以升阳益气。方用通窍活血汤加减:

桃仁 9 克	红花 6 克	川芎 9 克
白芷 9 克	赤芍 9 克	生姜 6 片
红枣 6 枚	升麻 3 克	黄芪 30 克
全蝎 3 克	僵蚕 6 克	川蜈蚣 2 条
地鳖虫 6 克	老葱 6 克	

加入老酒少许,水煎服。

5月8日复诊:服上药1剂后,头痛随即缓解;3剂服完后症状若失。药已中病,效不更方,嘱继服3剂。

5月16日三诊,自感药效如神,自己再购服3剂,前后共服9剂,诸症告痊,精神充沛,劳动有劲。嘱用石橄榄30克、枸杞子15克,合老母鸡炖服,以巩固疗效。

1984年6月15因关节痛来诊,顺谈其顽固性头痛,自1971年治愈至今,未再发作,感激不已。

病例二

黄××,女性,57岁,县二轻局家属。1981年11月2日初诊。

患者头部左侧被碰伤已1年多,初无所痛苦,近来剧痛反复发作,以夜为甚,痛时如锥如刺,寝食俱废,痛苦莫可言状,但过后如常人,经××医院检查,疑为脑肿瘤,嘱往省医大附属一院进一步确诊。患者因其子在县二轻局工作,而携来我院求治。

诊见:脉涩、舌质晦、舌边有瘀点、苔黄。证属脑部外伤,脉络瘀阻(脑震荡后遗症头痛)。治宜通络化瘀。方用通窍活血汤加减:

桃仁 9 克	红花 6 克	川芎 6 克
白芷 9 克	赤芍 9 克	老葱 6 克
红枣 3 枚	生姜 3 片	全蝎 3 克
地鳖虫 9 克	僵蚕 9 克	川蜈蚣 2 条

水煎服。嘱服 3 剂。

1983年5月3日,其子潘××因患感冒来诊,述及他母亲头部剧痛,难以言状,服药 3 剂痛止。继服 3 剂后病除,至今未见复发,一切如常,理家有劲。

按 以上两例头痛,一为久病入络,气滞血瘀,(血管神经性头痛);一为脑部受伤,脉络瘀阻。(脑震荡后遗症)根据中医“痛则不通”的理论,两者均为瘀血内阻之头痛,治宜逐瘀活血之法。选用王清任善于治血的名方,通窍活血汤为主,方中麝香为开窍通闭之要药,因鉴于药源稀少,价格昂贵,故以白芷代替,并加入全蝎、蜈蚣、僵蚕、地鳖虫等搜剔风邪之虫类,开窍通络,镇痉止痛,以取速效。至于病久体虚,久痛入络,气滞血瘀头痛之例,再益以大量的黄芪以通阳补气,少量的升麻以升清阳,协同黄芪发挥更大的作用。善

后用滋阴补肾的石橄榄、柑杞子配合血肉有情的老母鸡炖服,巩固疗效。脑部受伤、脉络瘀阻头痛之例,因未见虚症,故不用补剂,以免留邪之弊。由于辨证明确,处理得当,效如桴鼓,是以辨证论治为我中医千古不灭的法则。

● (本文于1984年11月29日在晋江地区中医学会年会上宣读)

病例三

苏××,男,42岁,仑仑镇园美村人,1991年5月4日就诊。

患者系水暖器材厂工人,4年前因不慎右侧头部被机械碰伤,经治疗后痊愈。近半年来患部如电触感,固定不移,频繁发作,每周约1~2次,5日来症状加剧,头部如针刺,经到××医院神经科诊断为偏头痛性血管性头痛,屡用西药治疗未效而求治。就诊时正值发作,见其抱头呼痛,泪珠满面,痛苦不堪。纳食差,大便结,脉涩,舌质暗红、舌边有瘀点、苔黄。证属瘀阻经脉,治宜化瘀通络,方用自拟通络化瘀汤治之。药用:

细辛 9 克	地鳖虫 6 克	血竭 6 克(为末冲服)
川芎 9 克	升麻 6 克	大黄 15 克(酒炒)
黄芪 15 克		

水煎服。药服5剂头痛大减,偶尔发作,也较轻微。嘱再进5剂后停药观察。病情稳定,随访至今,未再复发。

按 头痛日久,已成痼疾。经云:“久病入络”非一般平淡药所能取效也。方中大黄性急能入血祛瘀,推陈致新,酒制以引上高巅,即李时珍:“沉者引之以酒,则浮而上至巅顶”之意;血竭性急,散瘀生新,为活血止痛圣药;川芎辛香走散,上升巅顶,理气活血;细辛辛热走窜,善搜脑风,鼓动活血化瘀之药,直达病所;地鳖虫祛瘀血,搜逐血络;升麻气味淡薄,轻清上升,取其轻举升浮作用,领诸

药上达头部；病久必虚用黄芪扶正益气，鼓动气血，且可使祛瘀血而不伤正。

方中重用细辛一味，取其辛热走窜，善搜脑风鼓动诸药直达病所，协力攻坚，一举而荡其积瘀以收良效。据一般文献记载，细辛用量为1~3克，而余处方用9克之多，盖取其有斩将夺关之功，尤如兵卒之急先锋也。只要辨证准确，用药恰当，配伍得宜，并无见碍，可不必顾虑也。

● 原载于《第二届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会论文集》，1993年9月。

闭经三例

病例一

陈××,女,18岁,学生。未婚。

1991年6月12日初诊。自述闭经已一年余,自16岁初潮至今未行。平素喜食冷饮,时有小腹疼痛感,四肢不温,白带量多,舌淡、苔白,脉沉。证属过食冷饮,血为寒凝,气机不畅,瘀阻冲任而致闭经,治宜温经散寒,活血通经。方用温经汤加减:

吴茱萸9克	当归9克	桂枝6克
干姜4.5克	香附10克	艾叶9克
附子6克	益母草15克	桃仁9克
红花9克	甘草6克	川芎9克

水煎服,每日1剂。连服10剂后,经前腹痛剧烈,月经量多,色紫黑有血块,血块排除后,则腹痛减轻,小腹冷感亦减。因血块已下,瘀血乃除,故以原方去益母草、桃仁、红花继服5剂,以巩固疗效,经随访一年,经期正常。

按 本例闭经,系因过食寒凉之饮,经脉不通所致,故吴老治疗时根据“血得热则行,得寒则凝”的原则,用温经汤加减,以温经散寒、活血调经。方用附子辛甘大热之性,走而不守,能引气药行十二经、引血药入血分,引发散药开腠理之能,以温补肾阳,助阳散寒;干姜温中散寒;桂枝温经通阳;肝主藏血、血为寒凝,故用吴茱萸温散肝经之寒邪;当归、白芍养血调经;川芎、香附、艾叶、陈皮行气活血调经;益母草、桃仁、红花活血祛瘀调经;甘草和中。综观全方具有温经通阳,散寒祛邪之作用,从而促进气血调畅,冲任调和,故经闭年余而痊愈。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江苏中医》,1993 年增刊。

病例二

陈××,女,32 岁。1991 年 9 月 18 日初诊。

患者闭经已二年。每次必用雌激素、黄体酮治疗,月经始能来潮,停药时则闭而不行。体重逐渐减轻,每月有周期性乳房胀闷,少腹胀痛,精神忧郁不乐,急躁易怒,纳谷不香。曾经多方医治不效,而求治吴老。

察其舌质紫、苔薄白,脉细涩。证属气滞血瘀经闭。治宜疏肝解郁,调气和血。方用柴胡疏肝汤加减:

柴胡 12 克	杭芍 15 克	丹参 12 克
当归 9 克	丹皮 9 克	香附 9 克
陈皮 9 克	桃仁 9 克	红花 6 克
茯苓 12 克	甘草 6 克	艾叶 6 克
生姜 5 片		

水煎服。经服上方 10 剂后,月经来潮、量少,色暗红有紫块,少腹胀痛减轻,精神较前舒畅,仍守原方继服 3 剂,病愈。一年后随访,月经正常。

按 吴老认为闭经发生的原因甚多,但总的来说,主要是有余和不足两方面,虚者多为肝肾亏损,阴血不足,甚至血枯阴竭,血海空虚,无血可下;实者多为气滞血瘀或痰湿郁滞,经血不得下行所致。本例患者,由于精神因素所致肝气郁结,气不行血,则血行不畅,瘀血内阻,胞脉不通,故月经不行。气以宣达为顺,气滞不宣,则精神抑郁、胸胁胀满、少腹胀痛。肝气反胃、胃气不和,则纳谷不香。舌质紫、脉细涩、均为肝郁气滞、瘀血内阻之象。方中用柴胡、丹皮、香附、陈皮舒肝解郁、行气调经;当归、杭芍养血调经;丹皮、桃仁、

红花活血祛瘀；桂枝、艾叶温经通脉；茯苓渗利下行；甘草、生姜主要在于调和胃气。全方共奏舒肝解郁、活血祛瘀、理气通经之效，从而达到气血调畅，冲任调和，经行而诸症自除。

（吴盛荣 整理）

- 原载于《第一届全国疑难杂症诊治学术研讨会论文集》，南开大学出版社出版，1994年8月第1版。

病例三

陈××，女，42岁。1995年6月20日就诊。

患者分娩胎次多，劳动强度大，体弱多病，先是月经日渐减少，继则经闭不行已半年，四肢乏力，精神不振，头晕心悸，二便正常，纳食尚可。面色无华，舌淡苔白，脉沉缓。吴师谓：证属血虚经闭，治宜补血调经。方用四物汤加味：

当归 9 克	川芎 9 克	熟地 15 克
酒芍 15 克	香附 9 克	淫羊藿 15 克

连服 2 周，月经遂即来潮。善后嘱用四物汤合猪瘦肉常炖服。

按 吴师云：由于阴虚血亏不足以供养机体，故四肢乏力，精神不振，头晕心悸，面色无华，舌淡苔白、脉沉缓，均为气血不足之征。幸纳食尚可，后天未衰，故药仅服 2 周，月经遂即来潮。方中熟地滋阴补血；当归和血生血；酒芍敛阴益血；川芎调和血气，合而用之成为调血养血之良方。吴师说：这不仅是妇科的常用方，也是治疗血病的基本方。本方用于治疗血虚经闭，故重用熟地、酒芍。益以香附行气血调月经。李时珍云：“可治月候不调，胎前产后百病”，可见香附为妇科要药。淫羊藿补肝肾，助阳益精，大明谓：“可治丈夫绝阳无子，女子绝阴无子”，说明补益精气之力，胜于他药。治疗疾病，功在遣方用药，故有用药如用兵之谓也。

（周建宣 整理）

倒 经 案

陈某,24岁,农民。1992年4月15日初诊。

患者每于经前2~3天,鼻衄如注,量多色鲜红,而行经量少,甚则经阻不行,恙已年余。伴见头痛且胀,面色红赤,心烦口干而苦,舌红、苔薄黄,脉弦数。证属肝火炽盛,冲气上逆,载血上行,溢出清窍。治宜柔肝清火,降逆止血。处方:

当归 9 克	白芍 12 克	生地 12 克
白茅根 15 克	牛膝 15 克	丹皮 9 克
菊花 6 克	大蓟 10 克	小蓟 10 克
代赭石 30 克(先煎)		

水煎服。1日1剂,连服6剂,鼻衄渐止。再进6剂,诸症痊愈。嘱用杞菊地黄丸,调治2个月,以巩固疗效。后经随访,未再复发。

按 倒经一症,吴老认为辨证应抓住气逆、火冲、血瘀三个要点。每届春令或秋燥之时,好发于阴虚阳旺之体,其由头痛肋胀,经行愆期而频发吐衄。其经行之际,暴怒伤肝,冲气上逆,或过食辛辣,血热上行而致之吐衄,临床亦不鲜见。治遵《内经》“热者清之”、“逆者平之”之旨。药用菊花、白芍甘平柔养、清肝熄风;丹皮、生地、白茅根清营泄热,凉血止溢;大小蓟佐生地、丹皮可增清热凉血之功;牛膝引血下行,与代赭石同用,可有降冲平逆之效。综观全方,清泄而不滋腻,降火而不苦寒,药虽平淡,切中病机。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《杏林新秀杂志》,1993年第4期。

经行眩晕

黄某,32岁,工人。1991年6月5日初诊。

患者每于经行即感头晕眼花,已将一年。今天上午经水来潮,色淡质清,下午即感头晕眼花伴有泛恶欲呕,体倦神疲懒言,纳食欠佳,舌质淡、苔薄白,脉细弱。证属脾气虚弱,化源不足,以致气血虚弱,治宜补气益血为法。方用八珍汤加味:

党参 12 克	杭芍 12 克	白术 12 克
茯苓 15 克	当归 9 克	熟地 15 克
川芎 12 克	黄芪 15 克	炙甘草 6 克
大枣 6 粒		

水煎服。3剂,每日1剂。服药3剂后,头晕眼花大减,药已中病,按上方再服3剂,诸症痊愈。

按 经行眩晕是妇女月经来潮则出现眩晕,重则如坐舟车中旋转不定,以致不能站立,严重的伴见恶心呕吐症状。本病例系素脾气虚弱,经行之时,脾气益虚,脾虚则生化之源不旺,以致血虚不能上奉于脑,因而引起眩晕,故治用补气益血之法。服药6剂,诸症消失。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《杏林新秀杂志》,1993年第4期。

崩漏(子宫功能性出血)

林××,女,45岁。1995年9月6日就诊。

患者不规则的子宫少量出血,淋漓不断,色紫黯成块,腥秽稠粘。腹胁胀痛已3月有余。经××医院妇科诊断为子宫功能性出血,给刮宫治疗后仍有少量黯红色血水淋漓而下,下腹部胀痛。素体肥胖健壮,精神好,纳食佳,二便通调,舌边有瘀点,唇色黯红而干,苔微黄。吴师谓证属瘀热漏下,治宜补血、凉血消瘀,辅以补脾益气生血。处方:

五灵脂 6 克	生蒲黄 6 克	黑侧柏 9 克
黑地榆 9 克	桃仁 6 克	红花 4.5 克
丹参 9 克	香附 9 克	黄芪 10 克
白术 9 克	茯苓 15 克	甘草 6 克

水煎服。9月15日复诊,上药服3剂后诸症俱愈,继后嘱用当归6克、白芍15克、党参15克、黄芪30克、煎汤常服,作为调养。

按 崩与漏同属于不规则的子宫出血,量多而阵下,大下的为崩;量少而持续不止,或止而复来的为漏。吴师云:崩漏与月经虽同属于子宫出血,但有明显的不同点,崩漏出血是不规则的,不时漏下或大下;月经的出血是有周期性的,这是崩与漏,崩漏与月经的主要辨别方法。治疗疾病应审证求因,有的放矢,做到药不虚发。

积瘀可生热,血热妄行也可使崩漏不止。吴师谓:本例属于瘀热漏下症,故不规则的子宫出血,量少淋漓不止,色紫黯成块,腥秽稠粘,腹胁胀痛,舌边有瘀点,唇色黯红而干,苔微黄,脉沉弦。患者素体健壮,故可用行血、凉血、消瘀直治。方中五灵脂,蒲黄行血消

瘀；桃仁、红花去瘀生新；侧柏、地榆凉血止血；丹参、香附活血理气调经是妇科要药。吴师认为前人誉“一味丹参，功同四物”，主要是指丹参能去瘀生新补血之义，至于功同四物实有些夸大不实。再益以黄芪、白术、茯苓、甘草补脾益气以生气血，且可防止行血去瘀太过而伤正气。诸药合用，俱有行血、消瘀、凉血止血之功，故药仅 3 剂而愈。至于防治要点，吴师说：经漏宜早治疗，以防血崩发作，血止勿忘补虚，药量宜重，轻者无济于事，应谨而慎之。

（周建宣 整理）

湿热带下(阴道滴虫)

陈××,女性。南安县美林公社西美大队人。

1978年11月26日初诊。

患者带下绵绵不绝,色黄稠粘腥臭,阴痒难堪,伴有胸胁郁闷不舒,口苦咽干,纳少,食后脘腹胀满,小溲短黄,便后不爽,为时已久。屡治未效,而来求治。诊其脉弦数,舌质红,苔黄。阴道分泌液涂片检查滴虫阳性。证属肝经湿热,治宜清热利湿,处方:

黄芩 12 克	柴胡 15 克	黄柏 9 克
苍术 9 克	车前子 9 克	泽泻 9 克
川楝 9 克	蛇床子 9 克	

嘱内服兼熏洗阴部,连用6剂。

12月4日复诊,告曰:用上药内服兼外洗阴部后,诸症消失。阴道分泌液涂片检查阴性。脉舌同上。继服原方3剂,以巩固疗效。

按 本例为肝经湿热的带下症。肝主疏泄,性喜条达,湿热壅结于肝经,使肝郁不畅,气机闭阻故胸胁郁闷不舒。湿阻中焦,脾失健运故见纳少,食后脘腹胀满、便后不爽。肝经湿热,脾虚气陷,内侵任带之脉,故带下黄粘而臭。湿热生虫,虫蚀阴部,故见阴痒。湿郁热伏,则口苦咽干、小便短赤。脉弦数,舌质红、舌苔黄,均为肝经湿热之症。

方中重用柴胡疏肝解郁;以黄芩,黄柏清热燥湿;泽泻、车前子,清利下焦湿热;用辛香的苍术燥湿健脾;蛇床子、川楝燥湿杀虫止痒。诸药内服外洗共奏疏肝解郁、清热燥湿、杀虫止痒而达到诸症悉痊之效。

● 原载于《南安医科简讯》,1980年第1期。

青 带

黄××,女,30岁。农民。1988年4月5日初诊。

患者主诉带下量多已将半年,色青、质粘稠,味腥臭,连绵不断。伴有头晕,四肢疲乏,胸闷胁痛。舌淡红、苔黄腻、脉弦数。此乃肝经湿热下注带脉,治宜调肝清热渗湿。方用逍遥散加减:

柴胡 9 克	栀子 9 克	黄芩 9 克
茵陈 15 克	杭芍 15 克	白术 15 克
茯苓 12 克	当归 6 克	甘草 6 克

水煎服。3剂,1日1剂。4月8日二诊:服上药3剂后,胸闷胁痛减轻,继服原方5剂,带下及臭秽之气大减。药中病机,效不更方,再守原方5剂。先后服药13剂,诸症消失,恢复健康。经随访,未再复发。

按 《傅青主女科》曰:“夫青带乃肝经湿热、肝属木、木色属青,带下流如绿豆汁。”《妇科易知录》也说:“肝经湿热停住中焦,走于胞宫,郁逆之气,积久腐化而成。”本例患者带下色青,连绵不断,且有腥臭,苔黄腻,脉弦数,脉症合参,此乃肝经湿热下注成带,盖湿热之由于肝经。因肝气之郁,郁而必逆。因此,在治疗方法上,宜调肝清热渗湿,故用逍遥散加减治之。方中柴胡、黄芩、栀子以疏肝解郁清热;茵陈、白术以利湿;茯苓、甘草以和中健脾;当归、杭芍以柔肝养血。全方重在疏肝,使肝气得清,则湿热自去,余症皆愈。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江西中医药》,1990年第1期。

滑 胎

陈某,女,30岁。1992年6月6日初诊。

患者自述连续流产已3胎,第一、二胎均为4个月孕期,第3胎为6个月孕期。屡用中西药保胎治疗无效而求治于吴老。此次停经已将两个月,昨天阴道少量出血,色淡,质稀伴腰背酸楚,小腹坠胀隐痛感,恶心呕吐,纳差,腹胀,大便溏薄。神疲嗜卧,面色苍白,舌淡苔黄,脉沉缓而弱。吴老辨证属脾阳虚衰,肾气不固,冲任失养,胎系不牢之故。治宜健脾固中,补肾安胎。处方:

党参 15 克	白术 15 克	莲子肉 15 克
糯米 15 克	杜仲 12 克	黄芪 12 克
苎麻根 12 克	砂仁 9 克	寄生 12 克
黄芩 9 克	菟丝子 12 克	旱莲草 15 克

水煎服。服3剂后阴道流血告止,腰酸少腹痛减轻。原方继服3剂后,诸症消失。嘱每月按原方服3剂,至分娩期,以固胎保育。后足月顺产一男婴,母子安康,高兴万分。

按 滑胎,《景岳全书·妇人规》称“数堕胎”。其病机与先天肾气之盛衰及后天脾胃之强弱有密切关系。因胎孕之形成主要靠母体先天肾气之盛衰,而长养胎儿则在于母体后天脾胃生化之气血供养。所以妊娠从胚胎乃至分娩,须由母体先天之肾气和后天之脾胃,互相资生,始能使胞络牢固胎有所养。肾为冲任之本,脾为气血生化之源,故治疗时,除应以补肾外,还必须并用健脾之品,使肾与脾,先天与后天相互促进,以固胎保育。方中莲子肉补脾且清君相

之火而因涩；苈麻根清热止血安胎；糯米、白术、砂仁健脾和胃；杜仲、菟丝子、桑寄生固肾；黄芩、旱莲草清热安胎。诸药合用，既补先天之肾，又健后天之脾，兼清子户之热而安胎，自无流产之虞。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《杏林新秀杂志》，1993 年第 4 期。

胞宫虚寒不孕症

不孕症系指夫妇同居2年以上,配偶生殖器官功能正常,未避孕而不受孕的疾病。其中结婚后始终未受孕者,称原发性不孕;曾发生过流产或生育而未避孕两年以上不孕者,称为继发性不孕。除先天性生理缺陷外,临床所见,由于胞宫虚寒而不孕者不少,它给人们带来了无限的痛苦。笔者有鉴于此,秉承先父治验,结合多年来致志于本病的研究,用自拟的暖宫促孕汤,以温补脾胃、暖宫散寒,结合辨证施治,往往获效。

本方药用吴茱萸、补骨脂、焦白术、伏龙肝各15克,肉桂6克(为末另冲),每服水煎两遍,待伏龙肝沉淀后,取汤上下午分服。随证施治:气虚加黄芪、党参;血虚加当归、白芍;气滞加柴胡、香附;血瘀加蒲黄、五灵脂;痰湿加半夏、苍术;腰酸加巴戟天、杜仲。服法:第一周、第二周每天服1剂,第三周、第四周每两天服1剂。根据临床所见,大多服四周后,可望妊子之喜。

胞宫虚寒之不孕症,笔者临床所见大多数患者素有脾肾阳虚,温运失职,故寒邪凝滞胞宫而不去,因而导致胞脉闭阻不通;肾阳虚则胎孕难以形成;脾阳虚则水谷精微无以给养,三者可互为因果而不孕。胞宫位于下焦,非大剂辛温之药,难以直达病所,故药用辛温之吴茱萸为君,取其辛能走散开发,温能通畅经脉。历代医家用量大极轻,如《本草求真》云:“多用损人元气”,唯独医圣张仲景对此药甚为重视,治呕而胸郁者的吴茱萸汤,用吴茱萸有一斤之多。可见如能对症下药,用量不必受书本所囿。笔者临床五十余年,用于治疗虚寒症,每用15克并未见弊端,且屡收良效。用此药要有胆

有识,可不必虞也。辅以补骨脂、肉桂实先天之肾气;伏龙肝、焦白术补后天之脾胃。胞宫寒邪祛除,则经脉通。肾气充实,则胎孕易成。脾胃得补则生化有源,母体健康自能有孕之喜。

岁在癸酉春日曾治一病例,洪××,26岁,结婚已6年,夫妻在一起,迄今未孕,经××医院妇产科检查,诊断为输卵管闭阻不通,曾连续治疗半年仍未效,而求治于我。证见面色无华,神疲懒言,经常性头晕眼花,腰酸腿软,四肢不温,小腹时常冷痛,经期错后,色淡量少,白带清稀。舌质淡、苔薄白,脉沉细。综上病情,证属脾肾阳虚,寒客胞宫;治以温补脾肾,暖宫散寒;方用自拟暖宫促孕汤加黄芪、党参、当归、白芍、杜仲、巴戟天治之。依法连服四周,当月妊子,足月顺产男婴,全家欢乐。

妊娠小便闭

黄××,女,28岁,农民。1988年7月20日初诊。

患者生育二胎,现妊娠五月,小便不出已3天,伴小腹胀痛、拒按。曾在当地卫生院用导尿管引流、打针服药治疗,小便仍不能自解,而求治于吴师。询其病前饮食如常,劳动无碍。现除小腹胀痛、小便不出外,其余均正常。诊时小腹膨胀,表情痛苦,舌质淡红、苔薄白,脉细数。脉证合参,吴师谓:此系血虚有热,气郁化燥,不能通调水道,气化不行所致。治宜养血润燥,行气解郁。方用当归贝母苦参汤治之。

处方:当归20克、贝母20克、苦参20克,水煎服。3剂,1日1剂。

7月23日二诊:家属来院代诉服上药2剂后,小便通,但不畅。服3剂后,小便畅通,诸症痊愈,患者高兴万分。后经随访,小便正常,未见复发。

按 本案患者由于怀孕以后,血虚有热,气郁化燥,不能通调水道,下输膀胱,遂致膀胱气化失宣而窒塞。方中用大量当归养血润燥,使血虚血燥得解;贝母行气解郁,使气郁得除,上窍宣通,肺气肃降,而小便能出;苦参能利湿热,除热结。三药合用,使血得润养,气化热除,而使小便自然通畅。此案理法方药中肯,故3剂而收全功。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《吉林中医药杂志》,1990年第3期。

乳泣治验

陈某,女,24岁。1988年3月15日初诊。

患者自述,怀孕已将八个月。近一个月来,乳汁自出,质清稀,每日量约30~40毫升左右。乳房柔软无胀感,伴神疲气短,面色苍白,食欲减少。舌淡苔薄,脉细弱。吴师云:证属气血虚弱,中气不足,胃气不固、乳汁失约之故。治宜补中益气,佐以固摄收敛。方拟补中益气汤加减:

黄芪 20 克	党参 20 克	熟地 20 克
白术 15 克	白芍 15 克	芡实 15 克
茯苓 15 克	当归 10 克	柴胡 10 克
五味子 10 克	陈皮 6 克	

水煎服。每日1剂,连服3剂,空腹时服。

3月18日二诊:服上药3剂后,乳汁自溢大减,余症好转。药已中病,效不更方,再守原方6剂,乳泣告止,诸症悉除。

按 孕妇乳汁自出称为“乳泣”。西医认为与内分泌紊乱,卵巢功能失调有关。中医对本病病因病机,从经络学说方面论述。妇人乳头属肝,乳房属胃,乳汁为气血所化生。本例患者系气血虚弱,中气不足,胃气不固,乳汁失约,故乳房柔软,乳汁自出而质清稀。中气不足,则神疲气短,面色苍白;胃气不固,则食欲不振。舌淡苔薄,脉细弱,均为气血虚弱之征。故吴老方拟补中益气汤加减。

方中取黄芪、党参、白术、茯苓补中益气;熟地、当归、白芍养血柔肝;柴胡疏肝解郁;陈皮健胃清痰利气;五味子、芡实收敛固涩。

诸药合用，共奏补气养血，固摄敛乳之效。故连服 9 剂，而获痊愈。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《江苏中医》，1989 年第 10 期。

产后高热

患者黄某某,女,26岁。农民。住院号151128。1985年5月17日初诊。

患者于1985年5月13日上午二胎分娩,因外阴部静脉曲张破裂,引起产后大出血休克而急诊入院。经采取急救措施后,血止,神志逐渐清醒,唯体温由进院 37.6°C ,上升至 $40.6\sim 40.7^{\circ}\text{C}$ 之间,持续5天不退,由妇产科邀请会诊。

现证:面色苍白,神疲懒言,全身乏力,不能自持,伴头晕目眩,口苦,咽干而不欲饮,寒热往来,脘腹胀满。二天来大便排出水样粪,日5~6次,粪液失禁,时自肛门遗出。脉细弦,舌质淡红、苔薄白。体检:乳房无炎症现象,腹部无压痛感,恶露无臭味。血常规:血红蛋白2克,白细胞8600,中性80%,淋巴18%,酸性球2%。大便常规:蛔虫卵少许,余未发现。

中医辨证:素体本虚,复加产后大量出血,阴血暴伤,血室骤然空虚,寒邪乘虚而入,客于少阳之经,而致少阳之气不和,营卫失调。故高热持续不退。

治宜调枢机和营卫而养阴血,使邪热循经而解。方用小柴胡汤加味。处方:

黄芪 30 克	柴胡 9 克	半夏 9 克
黄芩 9 克	党参 9 克	当归 6 克
甘草 6 克	生姜 3 片	大枣 3 枚

服3剂,每日1剂,水煎服。

5月20日复诊:药后微汗出,寒热除,体温降至 37.4°C ,唯水

样粪便如故。嘱按原方加木香,升麻各 6 克,补骨脂 9 克,继服 3 剂。

5 月 23 日三诊:体温 36.9℃,腹泻除,能纳食,自感虚衰而已,要求出院。

药用:

当归 9 克	川芎 9 克	杭芍 9 克
枸杞 9 克	补骨脂 9 克	熟地 15 克
党参 15 克	黄芪 15 克	桂枝 6 克
大枣 3 枚	炮姜 3 克	

配合牲物炖服,作为病后调养。

按 本例产后高热,从临床所见的一系列症状,系因失血过多,元气虚惫而产生的病理反应。其本在于虚,其邪在于少阳之经,正如《伤寒论》第 97 条指出:“血弱气尽,邪气因入,……正邪分争,寒热往来”。由于正虚不足以抗邪,故高热持续 5 天不退。根据治病必求于本的原则,方用小柴胡汤以转枢机,而调和营卫,和利阴阳,令邪热循经而散,再加当归、黄芪补益气血,以扶正驱邪,补骨脂、木香、升麻以温中举陷治粪液失禁。药服 6 剂,而高热退,能纳食,精神好,诸症有所改善,患者要求出院调养。方用十全大补汤加减,配合牲物炖服,以善其后。药取当归、川芎、熟地、杭芍以补血;党参、黄芪、大枣以补气;桂枝、补骨脂、炮姜以温补脾肾。方中有阴有阳之药物相配合,如先贤所谓:“阳得阴助而造化无穷,阴得阳升而泉源不竭”,再配以血肉有情之牲物以形补形,出院调养半个月后,再来复查,已能料理家务。今年元宵邂逅于溪美街告曰:劳动有劲,一切正常。

● 原载于《福建中医药》,1989 年第 5 期。

产后腹痛、狂妄

孙××,26岁,安溪县城厢南英村人。

1991年2月3日就诊:产后3天,恶露断绝,少腹剧痛不已,继后狂妄不安,歌笑啼哭,妄言乱语,神识不清,无高热现象。经多方治疗未效,家人甚为惶恐而求治。

诊见:症状同上,少腹拒按,脉涩,舌唇紫暗。证属瘀血内阻,治宜行气化瘀,方用大黄30克(轻煎)、血竭6克(为末冲服),服1剂恶血即下,腹痛减轻,可安卧。继服1剂,腹痛理,狂妄除,神志清如常人。

按 本例为产后恶露瘀积不下,上攻於心,而致精神错乱,狂妄不安,歌笑啼哭,妄言乱语,神志不清;下扰胞宫故少腹剧痛不已。方中重用大黄取其性急,有将军之称,能入血祛瘀推陈致新,如戡定祸乱至於太平,苏颂称“其效如神”。血竭性急迫,时珍谓:“散滞血诸痛,疗妇人血气”,《备要》谓“专除血痛,散瘀生新,为和血之圣药。”

本例发病急剧,故取二药之性急,且药专力宏,通利血脉迅捷,以直达病所,果遂心所愿。药仅2剂而痛除症愈,不可不谓药之神功也。

● 原载于《第二届中国泉州——东南亚中医药学术研讨会论文集》,1993年9月。

厌食症

陈×,男,7岁。1992年10月5日初诊。

患儿近1个月来食欲不振,饮食量大减,时拒食,口干喜饮,精神欠佳,夜寐易惊,大便秘结,2~3日1次。舌质红、苔厚黄,脉数。证属脾失健运,郁热内生。治宜消积化滞,健脾和胃。药用:

神曲 9 克	山楂 9 克	陈皮 6 克
内金 6 克	槟榔 6 克	大黄 6 克(后下)

水煎服。每日1剂,分2次服。

药进2剂,腑气畅通,食欲倍增。按原方改用大黄3克,再进2剂,饮食恢复正常,夜寐已安,诸症渐平。

按 小儿厌食症是以食欲不振,甚则拒食为主的一种常见病,临床常伴有形体消瘦,面色不华,脘腹胀满,神疲乏力等等。吴老认为本病关键在于小儿素禀脾虚,饮食不节,过食肥甘,损伤脾胃,造成脾失健运,积滞内停,胃纳失常而使患儿发生厌食甚至拒食。方中投大黄、槟榔以通腑导滞;陈皮健脾醒胃;神曲、山楂、内金消食和中。诸药合用,则积滞得去,脾健胃和则饮食恢复正常。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江苏中医》复刊15周年特刊。

秋 泻

黄×,男,3岁。1991年10月25日初诊。

患儿腹泻已3天,日泻数十次,经服PPA、多酶片、鞣酸蛋白等不效而求诊于吴老。症见发热 $T38.6^{\circ}\text{C}$,哭闹烦躁,唇红而干,舌上少津,两眼窝凹陷,呈“脱水貌”,大便如水样,气味酸臭,尿少而黄。大便镜检:脂肪球(++)。证属湿热内侵,迫于肠胃;津伤液脱,气阴亏损。治宜清利湿热,健脾止泻,补气摄阴生津。处方:

葛根 6 克	藿香 3 克	川连 2 克
川朴 3 克	苍术 6 克	白术 6 克
茯苓 6 克	淮山药 6 克	车前子 6 克
泽泻 3 克	神曲 3 克	麦芽 6 克
山楂 6 克		

水煎服。服药1剂后,患儿精神明显好转,发热退,尿量增多,大便次数明显减少。再服2剂,大便成形,食欲增加,诸症减轻。

按 小儿秋季腹泻属于祖国医学“泄泻”范畴。吴老认为婴幼儿脏腑娇嫩,气血未充,脾胃运化功能尚未健全。因秋冬之交气温从凉逐渐转冷,寒气偏胜,若喂养不当,寒气客于胃肠,故泄泻。如治不及时,或失治误治,极易造成脱水,形成津液亏损,气阴两伤之重证,甚至导致阴竭阳脱之虚脱证。轻者影响小儿的正常发育,重者可危及患儿生命。

方中葛根解肌达表,生津止渴,升阳止泻;藿香、川连芳香化湿,解毒散毒理气;苍术、川朴燥湿健脾;白术、茯苓、淮山药健脾利湿,理气和胃,是健脾的常用药物;泽泻、车前子利水渗湿;神曲、麦

芽、山楂行气消食。诸药相伍，使脾健运，清浊分，泻自止，而收取全功。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《江苏中医》复刊 15 周年特刊。

泄 泻

陈某,男,6/12岁。1994年7月14日初诊。

小儿腹泻已7天,日泻6~7次黄色水样粪伴粘液。体温持续在38~39.4℃,烦躁不安,烦渴欲饮,无汗,尿短而频。经小儿科治疗未见好转,今早请吴老会诊。神清,身热、脑后肤热独甚,腹部鼓胀,唇干、舌红、苔微黄,脉濡数。指纹紫,高达气关。证属暑湿为病,治宜清暑去湿。处方:

车前子6克	猪苓6克	泽泻6克
茯苓6克	苍术3克	砂仁1.5克
木香1.5克	川连1.5克	葛根3克
生姜1片	大枣1枚	

水煎服,2剂。

7月16日二诊:药服2剂后,小便清长,腹泻已理,烦渴欲饮亦止。唯体温仍在38.8℃。治宜清暑益气,养阴清热,佐以化湿。处方:

黄芪6克	太子参6克	麦门冬6克
葛根3克	地骨皮3克	青蒿3克
白芍3克	甘草1.5克	滑石6克
茯苓6克	车前子6克	木香1.5克
黄连1.5克		

3剂,水煎服。

7月19日三诊:药后热退、精神如常、痊愈出院。嘱用田蛙1只、麦门冬10克、盐橄榄1粒、西洋参3克炖服。以清余热,而善其

后。

8月2日,其祖父来院告曰,其孙儿出院后嬉戏如常。

按 本例为感受暑湿之邪而致病。吴老云:暑为阳邪,最易伤人,暑多挟湿为其特点,故暑季治泻,莫忘去湿,去湿必须理脾。暑伤其皮毛肺卫故身热,脑后肤热独甚,烦躁不安;湿伤脾胃,脾胃功能障碍故泄泻如水,腹部鼓胀,烦渴欲饮,尿短而频;暑湿郁于肌肤,故身热无汗。

方中猪苓、泽泻、车前子、茯苓利小便,去水湿,消暑气,清热解烦渴;葛根解肌清热,升举内陷之热邪;黄连苦寒清热、燥湿、调胃厚肠;苍术、砂仁、木香燥湿健脾;再益以姜枣顾护脾胃,使清热而不伤胃。诸药相伍,使暑清湿热分消,而泄泻止矣。泄泻既理,而热未退。吴老曰:乃暑热未清,湿邪未尽。盖因小儿稚阴稚阳,正虚邪恋,继当清暑益气,养阴清热,佐以化湿。由于治法得当,用药恰切,故收立竿见影之效。

(吴盛荣 整理)

慢性淋巴结肿大

陈某,男,26岁。1994年7月5日初诊。

患者素有扁桃体炎史,时作时止,经治疗后炎症消退,惟右下颌淋巴结肿大,屡治不消,为时已一年多。今天因咽喉肿痛,来院请求吴老一并治疗。

诊见:咽喉焮红,右下颌淋巴结肿如桃核大小,不红不热,推之活动,脉弦数。吴师云:证属热毒之邪外侵,与痰浊交阻于少阳,阳明之络,以致营卫不和,气血凝滞。宜从清热解毒着手,先治咽喉肿痛。方用:

板兰根 15 克	夏枯草 15 克	牛蒡子 9 克
桔梗 9 克	甘草 9 克	元参 9 克
连翘 9 克		

水煎服。服3剂后,咽喉肿痛愈。继治以清热化痰,软坚散结。方用:

桔核仁 15 克	黄连 6 克	升麻 9 克
牛蒡子 12 克	元参 9 克	牡蛎 15 克
昆布 15 克	穿山甲 9 克	夏枯草 9 克
浙贝 15 克	天花粉 15 克	

水煎服。连服15剂,每天1剂。

9月10日因其母咳血,携来诊治告曰:右下颌淋巴结肿大,遵医嘱连服15剂,现已摸触不到。何时消失,无从而知。

按 慢性淋巴结肿大,是临床常见疾病,常有慢性的原发病灶可查。如下颌淋巴结肿大,大都由头面部、口腔、龋齿的感染和扁桃

体炎所引起。若有上述疾患,应积极治疗,避免引发感染。慢性淋巴结肿大,一般虽无全身症状,但如久治不愈,也可化脓溃烂,造成麻烦。吴师谓:此病属于慢性疾病,治疗非一朝一夕所能见效,如果诊断无误,就应较长时间连续服药,处方不必更改。本病的症结,在于淋巴结肿大不消,故消痰散结软坚之药应高于他药的用量,始能发挥药效。

方中:黄连、升麻、元参清热解毒滋阴;牡蛎、昆布、牛蒡子、浙贝化痰软坚;桔核仁消坚散结;穿山甲散血通络、消肿软坚;夏枯草消癭瘤、散结气;天花粉排毒消肿;再辅以黄芪益气固本,既使本方久服不伤正气,又有助于消坚散结之作用。综上述药,具有清热化痰,软坚散结之效能,故药服15剂,不知不觉自行消散。吴师说,用药如用兵,制方之妙,在于药物组合,药分有灵,在于分量多寡,孰轻孰重,至为重要。要胸有成竹,有的放矢,治疗始能打中要害。

(周建宣 整理)

甲状腺瘤(肉瘰)

黄××,女,35岁。1993年3月5日初诊。

患者素有多愁善虑、忧思郁结史。长甲状腺瘤已两年多,因没有痛苦,故未引起注意。近一年来性情有所改变,表现为急躁易怒,并出现心悸、气短、多汗、头晕、全身乏力,四肢倦怠,上楼及下蹲无力等症状。经多方治疗未见改善,而求治于吴老。

证见:舌质红、苔薄黄,脉细数。轻度突眼,在结喉正中处有一圆形肿块,约核桃大。按之不痛,可以随吞咽动作而上下移动。吴师云:证属内伤七情,痰瘀互结。治宜理气解郁,化痰软坚。方用吴师自拟的消瘰散结汤治之。处方:

柴胡 9 克	青皮 9 克	浙贝 9 克
半夏 9 克	穿山甲 9 克	皂刺 6 克
海藻 9 克	昆布 9 克	黄药子 9 克
夏枯草 9 克	桔核仁 9 克	僵蚕 6 克
当归 9 克	川芎 9 克	黄芪 15 克

每日 1 剂,水煎 2 遍,早晚分服。嘱服两周后复查。

3 月 25 日复诊:自诉服药两周甲状腺瘤渐见消退,诸症有所改善。效不更方,嘱继服半月。

4 月 12 日三诊:甲状腺瘤消至龙眼果大,诸症基本消失。

5 月 7 日四诊:甲状腺瘤已消失,身体健康,无所不适,嘱停药观察。善后用满天星 30 克合青壳鸭蛋 1 粒,加食盐少许,不拘时间炖服,以巩固疗效。经随访一年,未见复发。

按 甲状腺瘤大多发生于女子,在结喉的正中处或偏左偏右。

属于祖国医学瘰病的范畴,因其肿块肉瘤,故在文献上称为肉瘰。本病的成因常由于内伤七情、肝郁气滞,津液运行受阻,凝集成痰,气滞日久导致血瘀。气痰瘀互结于颈前,渐成瘰病。本病是一种慢性病,治疗时间要长。根据吴师经验,如没有其它合并症,可不必更改处方,服至瘰瘤消散为止。

方中柴胡、青皮舒肝解郁;海藻、昆布消痰软坚,散结行水;穿山甲、皂刺消肿破症,散瘰结气;半夏、僵蚕、浙贝化痰散结,消肿散瘰;夏枯草、桔核仁、黄药子消瘰散结,解毒软坚;再益以当归、川芎、黄芪,吴师云:不但可以益气补血,防止久服消坚散结之药损伤正气,而且有助于加快消散瘰瘤之作用。如当归善于走散,调气活血,治疗气血凝滞,脉络不和有特效;川芎味薄气雄,性最疏通,走而不守,是理气活血生血之要药;黄芪有补气活血鼓舞正气以破症消瘰之效用。本方可以长服,妙在归、芎、芪这三味药物,既扶正,又驱邪之效能。吴师之立法、处方、用药严谨,实有独到之处。

(周建宣 整理)

带状疱疹二例

病例一

孙某,男,42岁。1992年7月3日就诊。

患者因夏天气候炎热,汗渍皮肤而发痒,经常用手搔痒。2天前右腰围及背部突然痒痛难受,皮肤发红,见有排列密集成群如带状的丘疹,水疱清彻如珠,米粒样大小。

诊见:症状如病史所述,除患部皮肤发红,灼热痒痛,余无所痛苦。舌尖红、苔微黄,脉略弦。证属:邪毒感染皮肤。

治宜:祛风燥湿,清热解毒、活血通经。

药用:络石藤(又名钳壁龙)取全草适量,火煨存性,研为细末,调醋外涂,干则再抹,1天数次。

疗效:连用2天,红退痒痛止,疱疹结痂而痊愈。

络石藤为夹竹桃科、常绿攀援木质藤本。茎圆形,多分枝,有气根,叶对生,椭圆形,或卵状披针形,老时革质全缘,4~6月开白花,聚散花序腋生,具香气,果实为二蓇葖果,圆柱状,成熟时裂开,内含多数种子。生于山野岩石或家园墙壁。此草有祛风清热,活血通经,解毒镇痛等功能,用于治疗关节痛、肌肉痹痛也有效。

病例二

林某,女,23岁。1992年10月17日就诊。

患者从山上砍柴归家后,即感全身有蚁走感,继后左侧胸部及

颈部见有成带或成簇的粟粒大疱疹，皮肤红赤，灼热，痒痛难忍。

诊见：症状如病史所述，面部潮红，体温正常，口渴思饮。舌质红、苔黄，脉弦数。

证属：湿热毒邪外侵，蕴结肌肤。

治宜：祛风利湿，清热解毒，散瘀止痛。

药用：鲜辣蓼（又名苦柱草）取适量捣烂绞汁调醋外抹，干则再涂，1 天数次。

辣蓼属辣蓼科，一年生草本。茎直立或下部伏地，分枝稀疏，节突起，茎面通常呈淡红紫色，叶互生，有短柄，广披针形而尖，叶面深绿色，有八字形的黑斑，托叶口缘生刺毛，秋日枝梢出花穗，向下垂，呈淡红色或白色，瘦果有三棱。生长于田野，路边，村旁湿地。

此草有祛风利湿，清热解毒，散热止痛，杀虫理痒等功能。用于治疗皮肤湿痒、顽癣，蛇咬伤，痢疾，肠炎也有效。

按 带状疱疹即祖国医学的“缠腰火丹”，“蛇串疮”，“蛇痹疮”俗名“飞蛇”。审诸方书，其病因皆为湿热毒邪内蕴所致。今 2 例均为外受毒邪而诱发。吴老认为患部皮肤发红为毒热壅于血分；水疱累累如珠为湿热凝聚，不得疏泄；痒痛不已为湿热搏结，阻遏经络。络石藤煨存性之意，是起燥湿作用，促使疱疹迅速吸收；醋具有杀邪毒，消肿痛，散瘀血，敛疮口等疗效。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《中草药杂志》1995 年第 2 期。

四、验方拾萃

葱肾汤治尿浊、水肿症

组成 鲜葱全株 30 克,猪肾 1 副。

用法 米泔水适量,食盐少许合炖服。

功能 补益肾气,通阳利水,分清化浊。

主治 由于肾阳虚衰而致之尿浊及水肿。

典型病例 孙某,男,37 岁。尿如米泔水,隔夜见沉淀如膏,上层如镜面已近 1 年,伴消瘦乏力,腰酸腿软,头晕耳鸣,能纳食而不充肌肤。诊见精神萎靡,面色无华,四肢不温,舌淡,脉沉。尿检未见异常。证属肾阳虚衰,气化不行,清浊失司。治宜补益肾气,通阳行水,分清化浊,方用葱肾汤,每日 1 剂,连服 5 剂后尿转清,诸症若失。

体 会

本方为吴老自拟之方,通过多年的临床实践,用于治疗肾阳虚衰而致之尿浊症、水肿症屡收良效。《灵枢·五乱》篇云:“清气在

阴，浊气在阳。”肾阳虚衰，气化不行，不能制约脂液下行故尿浊如膏。方用鲜葱辛温，取其中空以通阳化气，行水最急；猪肾能理肾气，通膀胱，以肾补肾，借其同气以引导之；米泔水和胃化滞，脾肾同治，先后天并补，更有助于利水分清化浊。因药证合拍，故收桴鼓之应。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《国医论坛》，1994 年第 4 期。

椿杞猪肚汤治小便混浊

组成

白椿根 20 克 甘杞子 15 克 金樱肉 15 克
芡实 15 克 地骨皮 15 克 龙眼根(二重皮)15 克
猪肚 1 个

用法 上药水煎,加食盐少许,合猪肚炖服。

功能 清热燥湿,补脾益肾,收敛固涩。

主治 小便混浊(膏淋)。兼治白带、遗精。

典型病例 陈某,女,50岁,自诉:小便混浊如米泔水,放置隔夜,见上层有如油状之镜面上浮,底层为豆花或脂膏样之沉淀物,洩行不畅,为时已3年,屡治未效而求治。证见:面色白,气短体倦,头晕耳鸣,腰酸软。食纳不佳。舌质淡红、苔微黄、稍滑,脉沉缓无力,小便检查:蛋白(++)、白细胞(+)。证属:脾肾气虚,湿热下注。治宜:清热燥湿,补脾益肾,收敛固涩。方用椿杞猪肚汤治之。服3剂后,症好转,继服6剂,诸证痊愈。

按 尿浊有虚实之分,虽久病有多虚之说,然吴老认为并不皆然。临床所见,往往有虚实交错,盖因湿浊之形成,多因湿热而致。陈修园氏遵经义列为热证。但尿浊后期,多因脾肾虚衰,不能制约脂液而下注,因而出现小便混浊。病程越长,湿热之邪越是留恋不去,故虚中常有挟实之象。因此治疗本病,补虚扶正,勿忘清热燥湿之品,以收全功。他根据多年的临床经验,制定一方名曰椿杞猪肚汤,应用于临床往往获效。方中白椿根既能清热燥湿,除浊,又能治崩漏,带下故用大量;地骨皮清热益精;金樱肉益肾固涩;龙眼根二

重皮入肾泻火,补脾收敛;甘杞子补肾益精;芡实入肝肾止遗涩精;猪肚血肉有情之品,以脏补脏。诸药相伍,共奏清热燥湿,补脾益肾,收敛固涩之效。

治疗期间忌辛辣之品,以及油腻、豆类、蛋品之物。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《95 首届中国保健医学科技研讨会论文汇编》
1995 年 9 月,辽宁丹东市。

旱莲养阴汤治热淋

组成

鲜旱莲草 30 克 鲜白茅根 30 克 鲜金丝草 15 克
鲜葱全株 15 克 生地黄 30 克 鲜车前草 30 克

用法 水煎加食盐少许代茶频服，每日 1 剂。

功能 养阴清热、凉血解毒。

主治 热淋（相当于西医的肾盂肾炎）。用于治疗尿血、血痢、肺出血、齿衄、鼻衄、吐衄也有效。

加减运用 治尿血加鲜茅花、鲜韭菜汁；治血痢加鲜凤尾草；治肺出血加仙鹤草、鲜扁柏叶；治齿衄加紫珠草、侧柏叶；治鼻衄加鲜栀子；治吐衄加鲜藕节。

典型病例 郑某，女 45 岁。患者于 5 天前左腰痛，继则尿频、尿痛、小便短涩，欲出未尽，伴排尿时有灼热感，小腹拘急引痛，纳差，神疲乏力，口干欲饮。舌质红、苔黄微腻，脉沉数。左腰有明显叩击痛感，小便检查：蛋白（++）、红细胞（++）、白细胞（+），管型少量。证属湿热邪毒，蕴结膀胱、气化不利、熏蒸于肾。治宜清热利湿，通淋解毒。方用旱莲养阴汤。每日服 1 剂，连服 6 剂，小便通利，诸症得除，小便复查正常。

按 本方为吴老治疗热淋，具有效验非常的验方，命名为旱莲养阴汤。方中旱莲草养阴清热，凉血止血，利水通淋；白茅根除伏热、清瘀血、利小便；车前草养阴清热，利水通淋；金丝草利小便、通淋闭、除烦热、清热凉血、止消渴；生地黄清热凉血，养阴润燥；生葱通阳活血，利水解毒，助以食盐入肾润下，养阴清热。诸药相伍，具

有养阴清热,利水通淋,凉血止血等功能。临床应用不但治热淋有良效,随症加减治疗尿血、血痢、肺出血、齿衄、鼻衄、吐衄也有良好的效果。凡属虚寒无实热之症状忌用,辨证用药尤当审详。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《95 首届中国保健医学科技研讨会论文汇编》, 1995 年 9 月, 辽宁丹东市。

温肾固摄汤治遗尿

组成

附子 3 克	党参 6 克	肉桂 1 克(另冲)
五味子 3 克	山茱萸 6 克	金樱肉 6 克
益智仁 6 克	补骨脂 3 克	内金 3 克
尿纸灰 1 克(冲服)		

用法 水煎服,每日 1 剂,可连服数剂。

功能 温补肾元、收敛固涩。

主治 睡中遗尿,小儿或成人均可,或老年人小便频数或失禁。

方解 本方系吴师为治疗小儿或成人睡中遗尿而设。

遗尿是指小便不能控制而自行排出的一种病证。睡中遗尿,醒后方知称为睡中遗尿,多见于小儿,但也有见到成人仍然遗尿。历代医学认为遗尿大都因虚,如《诸病源候论》说:“遗尿者,此为膀胱虚寒不能约水故也”,戴思恭说:“睡着遗尿者,此亦下元冷,小便不禁而然。”吴师遵古训谓:睡中尿出者,是其素禀阴气偏盛,阳气偏虚,膀胱与肾气俱冷,而夜卧阳气衰伏不能制阴。阴气独盛,则小便多而或不禁遗尿。总之,皆因下元亏虚,固摄无权之故。

方中:山茱萸补肾气,治小便频数;五味子敛肺滋肾,补虚固脱,养五脏补元气不足,收耗散精气;金樱肉固精秘气,治遗尿涩精气;补骨脂温阳补肾理遗尿;附子、肉桂补下焦虚寒;鸡内金入脾肺治小便频数;益智仁理元气,补肾虚缩小便;党参补中益气;尿纸灰收敛固涩,以气治气是自家疗法。综上诸药,具有温补肾阳,收敛固

涩，缩泉止遗之功。吴师的经验，本方不但用于治小儿及成人遗尿，而且老年人小便频数或失禁用之也屡收良效。

附 尿纸灰制法：取竹粗纸放置于小儿臀部处，俟遗尿浸湿纸张，然后取起晒干，用火燃烧后急用碗或盆盖密勿使炭化，待热气退尽，取出为末，收储备用。吴师云：此药单味每用3克。开水冲服，治疗小儿遗尿也有效。

（周建宣 整理）

排石汤治泌尿系结石

组成

金钱草 30 克	滑石 30 克	牛膝 30 克
海金砂 15 克	车前子 15 克	桃仁 15 克
熟地 15 克	冬葵子 15 克	甘枸杞 12 克
木香 9 克	木通 9 克	桂枝 9 克(后下)
附子 9 克	内金 9 克	

用法 每日 1 剂,水煎 2 次,上下午分服。

功能 清热利湿,通淋排石,化瘀行滞,水火平补。

主治 泌尿系结石。

方解 泌尿系结石属于祖国医学“石淋”、“砂淋”、“血淋”等范畴。发病的主要因素,是肾和膀胱气化功能失常及平素嗜酒,多食肥甘辛辣之食物,或因情志抑郁,工作劳累引起气滞血瘀,湿热蕴结下焦,日积月累,尿中浊质逐渐凝结而成砂石。方中金钱草、海金砂、冬葵子、内金、滑石利水通淋化石;车前子通肾气,利水道,强阴益精,久服轻身耐老;木通清心导赤,泻火通淋;桃仁清热化瘀;木香理气止痛;牛膝引药下行,使结石滑利而下;桂枝、附子温补肾阳,又可调和寒凉之品,使久服不致伤胃;熟地、枸杞补益肾阴而治本,共奏清热利湿、通淋排石、化瘀行滞、水火平补之功。

加减运用 有血尿者加白茅根、大蓟各 15 克;腰痛者加杜仲、狗脊各 12 克;小腹胀者加青皮 9 克、川楝 12 克;尿频涩痛者加石苇、瞿麦、扁蓄各 15 克;体虚者加黄芪、党参 15 克。服药期间每日用金钱草 60 克、王不留行叶 30 克,煎水代茶大量饮服。

方歌 排石金钱木香膝,车前滑地杞通俦;

葵桃桂附金砂内,泌尿春回病得瘳。

典型病例 谢某,男,46岁,1992年2月28日诊。

主诉:素有小便刺痛窘迫感,昨天突然腰部右侧剧烈疼痛,并向会阴部放射,继而出现肉眼血尿,右腰部明显叩击痛。尿检:蛋白(++),红血球(++++) ,白血球(+),X线拍片发现右肾下段有 $0.5\times 0.8\text{cm}$ 和 $0.6\times 0.8\text{cm}$ 之结石阴影。确诊为右肾结石。舌质红、苔黄腻,脉弦数。证属湿热瘀阻,结石内蕴,治宜清热利湿,化瘀排石。处方:

金钱草 30 克	牛膝 30 克	滑石 30 克
冬葵子 15 克	海金砂 15 克	车前子 15 克
白茅根 15 克	大蓟 15 克	熟地 15 克
杜仲 12 克	狗脊 12 克	枸杞 12 克
桃仁 9 克	桂枝 9 克	附子 9 克
内金 9 克	木通 9 克	木香 9 克

每日用金钱草 60 克、王不留行叶 30 克,水煎代茶大量饮服。

服至 15 剂,X线腹平片复查,见结石下移至输尿管。效不易辍,原方继服 7 剂后,排出结石 2 枚,大小与 X 线拍片阴影相符,症状亦随之消失。为巩固疗效嘱服补益气血和调理脾肾之品,以善其后,随访至今未见复发。

按语 吴光烈主任医师用自拟排石汤治疗泌尿结石疗效显著,药无虚发。治疗时间最短者 6 天,最长者 30 天。吴氏认为本病其本在于肾虚功能失调,其标在于湿热蕴结下焦,久积成瘀。根据“标本同治”的原则,故拟方着重清热利湿、化瘀排石为其常法,又注意肾虚扶正,平补水火,使排尿功能趋于正常。现代药理学证明,滑石有利尿抗菌消炎和滑利结石下行之作用,是主治石淋之要药;牛膝引导结石下行之作用强于其它药物。吴氏对此二药用量常在 30 克左右。吴氏强调如结石屡攻不下,应重用硝、黄、取朴硝咸寒

润下为软坚化石圣药,大黄推陈致新极其峻快如戡定祸乱至于太平。为防止剧烈下泻影响机体,可加入薏苡一味,以缓和之。吴氏认为本病早期多为实热证,应以清利湿热、通淋排石为主,切忌恣意进补,因气得补而愈胀,血得补而愈涩,热得补而愈炽,这对排石都是不利的。病程日久可致脾肾亏虚,应在清热利湿、通淋排石之基础上,兼补脾肾之虚,切不可拘泥“淋证”不可进补之说。此外,吴氏还强调每日应嘱病人用金钱草和王不留行叶煎汤大量饮服和跳跃活动,以有利于消除尿中之杂质及促进结石分离和下行。金钱草为排石名药,王不留行以性走而不守著称。当结石排出之时,可继续服用一些补益气血,调理脾肾之药物,以促进机体功能的恢复。

(周建宣 整理)

● 原载于《名医名方录》第四辑,1994年12月。

梨榄清音汤治失音

组成

盐橄榄 2 粒 百合 15 克 鲜梨(带皮)1 粒
蝉蜕 6 克 生地黄 15 克 五味子(打碎)6 克
麻黄 4.5 克 冰糖适量

用法 水煎代茶频饮,服至症状消失。

功能 补肺滋肾、清热养阴、生津润燥、宣肺扬音。

主治 新久失音,兼治肺虚干咳,咯痰带血。

方解 声音不扬,甚至嘶哑不能发出声音称为失音,致病的原因与肺肾有关。因声音出肺系而根于肾,故肾精充沛,肺气旺盛,则声音响亮,如果肺肾有病,皆能导致失音,正如《直指方》谓:“肺为声音之门,肾为声音之根。”若外邪阻塞肺窍或肺肾精气耗损于内,皆可导致声道之病。吴师根据临床 50 余年之经验,自拟的梨榄清音汤,用于属虚属实之失音,均收良效。

方中鲜梨清热养阴润燥;盐橄榄滋肾生津;五味子补元气不足,生津止渴;生地黄滋阴养血,生津润燥;百合补肺养阴,润燥止咳;蝉蜕解痉宣肺,扬哑清音;麻黄通九窍调血脉,宣肺气发声音;冰糖补脾润肺又可作为调味。诸药共奏补肺滋肾,清热养阴,生津润燥,宣肺扬音之效。吴师云:此方妙在麻黄、蝉蜕宣肺扬音,故新久失音用之均宜,麻黄虽气味辛温,其性轻扬为发汗之药,然方中的甘寒之鲜梨、生地黄、百合、又有酸收之五味子配伍,可免除发汗之虞,又可达到扬音之功。肺虚干咳,痰中带血多因肺肾精气耗伤于内,津液被烁,气失清肃,故用之亦收良效。

(周建宣 整理)

大蓟解毒汤治喉蛾

组成

鲜大蓟根 60 克 鲜土牛膝全株 60 克 鲜酢浆草 60 克

用法 上药洗净晾干，合捣取汁，加蜂蜜酌量调服，日服 1 剂，渣含于口内，良久吐出。

功能 清热消炎，凉血解毒，活血化瘀。

主治 急性喉蛾（相当于急性扁桃腺炎）。急性咽炎、口腔炎也适用。

加减运用 发热不退加鲜白花蛇舌草、鲜白茅根、鲜爵床草；咽喉痛甚加鲜蟛蜞菊、鲜山豆根；吞咽困难加鲜白田乌草；口渴甚者，多饮甘草、绿豆汤。

典型病例（略）

按 本方为吴老师临床 50 余年的经验方，治疗喉蛾（相当于现代医学的急性扁桃腺炎）疗效确切。方中大蓟根甘寒解毒、凉血止血、清热利尿；土牛膝清热消炎，活血行瘀，通利关节；酢浆草清热利水，活血行瘀，杀虫解毒。诸药合用，共奏清热消炎、凉血解毒、活血化瘀之功。临床验证用于治疗热毒壅盛而致的急性咽炎、口腔炎等咽喉疾患也有显著疗效。临床可因人、因病、因时而异，灵活加减运用。

本病常发生于青少年，春秋两季多见，劳累受凉等为常见诱因。发病急剧、咽痛、吞咽困难，伴周身不适为主要症状，蛾体红肿过大者可有呼吸、吞咽及语言障碍。吴老强调本病早期应以清热解毒、消炎利咽一治到底。如果迁延失治，以致脏腑失调，可引起心肌

炎、风湿热、急性关节炎、急性肾炎等并发症，应引为重视。

(吴盛荣 整理)

- 原载于纪念李时珍逝世 400 周年《全国医学学术论文集》，中国中医药出版社出版，1994 年 6 月第 1 版。

剑胆消痈汤治肺痈

组成

鲜金剑草 60 克,鲜地胆草 60 克,米泔水适量,蜂蜜少许。

用法 将草药洗净晾干,捣烂取汁,调第二遍米泔水适量,蜂蜜少许合搅匀,上下午分服。每日 1 剂,连服 3~5 日,可视病情而定。

功用 清热解毒,化瘀排脓,益气养阴。

主治 肺痈。由于风热犯肺之肺脓疡,肺坏疽,支气管扩张继发感染也适用。

加减运用 高热不退者加鲜旱莲草、球兰汁;胸痛者加全瓜蒌、丝瓜络;咳而气喘者加鲜蒲公英、鱼腥草、生薏苡;咳吐脓痰腥臭者加鲜苇茎、鲜紫花地丁;咳吐脓血者加鲜白茅根、生藕节、仙鹤草;口燥津伤者加瓜蒌根、麦门冬;气虚多汗者加黄芪、太子参。

注:能取汁者取汁,不能取汁者煎汤冲服。

典型病例(略)

按 本文系来自民间验方,吴老用于治疗肺痈有特效,命名为剑胆消痈汤。凡是由于风热犯肺之肺脓疡、肺坏疽、支气管扩张继发感染等疾病,用之也屡收良效。

方中民间青草药金剑草、地胆草,具有清热解毒、化瘀排脓之功,以鲜用为佳;米泔水甘凉益气生津、败脓解毒、化瘀排脓、益气养阴之效。如病情复杂,可根据不同阶段所表现之临床证状,随证加减。然肺痈多为实热症,在未成脓之时,应予清热解毒,积极治疗。如果咳则胸痛、吐痰腥臭,就应结合化瘀排脓,切勿早投补益之

品助邪。恢复期阶段常见舌红或绛，苔黄腻，脉滑数，口燥伤津者，或气虚多汗者，则宜治以益气养阴，清热解毒。本症切忌饮酒，临床见饮酒成癖者，预后往往不良。

（吴盛荣 整理）

- 原载于纪念李时珍逝世 400 周年《全国医学学术论文集》，中国中医药出版社出版，1994 年 6 月第 1 版。

茵扁鸡肉汤治暑伤元气

组成 茵陈 15 克 扁豆 20 克 雌童鸡 1 只 食盐少许。

用法 杀鸡去毛洗净，剖去肠杂，纳上药于腹中，加水适量炖服。

功能 清热利湿，健脾消暑，扶羸益气。

主治 暑伤元气，湿浊阻滞气机，腹胀纳呆，四肢酸软，体倦乏力。

典型病例 林某，男，42 岁。每于盛夏季节到来，体倦乏力，四肢酸软，胸闷身重，腹胀纳呆，精神不振。虽想参加劳动，但力不从心，身不由己。今年夏至后，上症重见而求治。症见：面色萎黄、语音低微、舌质淡、苔微黄腻、脉濡缓。证属暑伤元气，湿浊阻滞气机。治宜清热利湿，健脾消暑，扶羸益气。方用茵扁鸡肉汤治之。每天服 1 剂，连服 3 剂，症愈，体力恢复正常。

体会

本方为吴老 50 余年经验方，经临床验证，效如桴鼓。方中茵陈清热利湿，健脾开胃；扁豆清暑化湿，醒脾和胃；童鸡为血肉有情之品，扶羸益气。药简效宏，是一张另开生面，扶正驱邪之良好方剂。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《95 首届中国保健医学科技研讨会论文汇编》
1995 年 9 月，辽宁丹东市。

香薷清暑饮预防盛夏伤暑、中暑

组成

香薷 30 克 生地 20 克 党参 15 克
雌童鸡 1 只 凉粉草(又名仙草干)30 克

用法 将童鸡处死洗净,剖去肠杂,上药纳入鸡腹中,炖汤取服。预防伤暑或中暑,每于盛夏季节之前,每 3~5 天服一次,连服 3~5 剂。感受暑热之邪,低热缠绵不退,取汤频频饮服。

功能 清热解暑,养阴生津,扶羸益气。

主治 预防伤暑、中暑以及治疗感受暑热之邪而致低热缠绵不愈。

典型病例(略)

按 本方为吴老自拟的验方,用于预防盛夏伤暑,中暑或由于感受暑热之邪而致之低热缠绵难愈,具有良好的效果,命名为香薷清暑饮。暑为阳邪,《素问·五运行大论》:“其在天为热,在地为火……其性为暑。”说明暑邪来自夏季炎热季节,夏日感受暑邪之病症,轻者为伤暑,重者为中暑,其发病机理与自身的体质强弱有关。体质强者五运安和,六气均平,虽热日中劳动或长途奔走不病。体质弱者,五运有亏,六气不振,虽避暑高堂大厦反病。预防伤暑、中暑、保护劳力,在于提高机体抗病能力。方中香薷发汗清暑、利湿行水,为解表清暑要药。凉粉草清热解毒,养阴生津;生地清热凉血,养阴润燥;党参补中益气、生津止渴;黄芪补气固表,扶正驱邪;童

鸡血肉有情之品，扶羸益气。诸药合用，共奏清热解暑、养阴生津、扶羸益气，是暑天行之有效、别开生面、扶正驱邪之良好方剂。

（吴盛荣 整理）

● 原载于纪念李时珍逝世 400 周年《全国医学学术论文集》，中国中医药出版社出版，1994 年 6 月第 1 版。

加簸童鸡汤治发育不良

组成

酸枣树皮 30 克、山加簸根(又名肖梵天花)30 克、雄童鸡 1 只老酒适量。

用法 将雄童鸡处死,洗净剖去肠杂,上药纳入鸡腹中,水酒适量,加食盐少许炖服。

功能 活血通络,推陈致新。

主治 体萎不长、发育不良,以及室女经闭。

典型病例: 吴某,男,18 岁,患者已至成年阶段,身体萎小不长,四肢枯瘦,发育不良,能纳食而不充肌肤,不耐劳动,余无自觉症状。经粪检数次,未发现肠寄生虫卵。尿检未发现异常。面色黯淡无光,舌质晦、苔薄白,脉沉缓。证属经脉运行不畅,机体失养,发育不良。治宜活血通络,推陈致新。方用加簸童鸡汤治之。每星期服 1 剂,连服 3 剂,尔后渐见肌肉丰满,发育转佳。

按 本方民间用于治疗室女经闭,疗效显著。盖取酸枣树皮、山加簸根有通经活络,推陈致新之功,再益以血肉有情之雄童鸡,益气补血,使通经活络而不伤正气。吴师用于治疗男子年届发育阶段,身体萎少,发育不良也屡收良效。吴老谓:人体之强弱,与气血之盛衰有着密切之关系,气血旺盛,则身强力壮,气血衰少,则体弱不长。然气血之供养四肢百骸、五脏六腑,皆赖于血脉之运行通畅,始能把营气(营养物质)输布全身,正如《灵枢·邪客篇》:指出“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血,以营四末,内注五脏六腑”,也充分说明营气是整体生命功能的表现,运行通畅至为重要。凡年届

发育阶段,体萎不长,发育不良,本人又无任何症状和痛苦,均可考虑为经脉运行不畅,营气不足,机体失养,用本方可收良效。

(吴盛荣 整理)

- 原载于《95 首届中国保健医学科技研讨会论文汇编》, 1995 年 9 月,辽宁丹东市。

振阳起勃汤治疗阳萎

阳萎是男科的常见病,系指男子未到性功能衰退时期,出现阴茎不举或举而不坚,不能持久之病症。历代医家多责之于肾,如《诸病源候论》指出:“肾虚不能荣于阴器故萎也。”

吴老临床五十余载认为阳萎之起因,大多由于恣性纵欲,或少年误犯手淫,阴精被耗,命门火衰、精气虚寒,或败精阻窍气血凝滞,而致阴茎失荣。根据多年的临床经验以及借鉴先贤之治法,治以辛温走窜,调畅经络,自拟一方名曰“振阳起勃汤”屡收良效。药用:

洋参 6 克 川芎 9 克 仙茅 15 克

川蜈蚣 3 条(焙干研末另冲) 肉桂 4.5 克(研末另冲)

水煎合雄鸡炖服,每 2~3 天服 1 剂,以睡前为佳。

随症施治:腰膝酸软加杜仲、牛膝;头晕目眩加山茱萸、甘杞子;夜寐不宁加茯神、枣仁;小溲热赤加知母、黄柏;四肢不温加附子、干姜;梦遗失精加芡实、莲须。

方中川蜈蚣辛温走窜之力最为迅速,内而脏腑,外而经络,无所不到,凡气血凝聚之处皆能开,是调畅气血、疏通经络之妙药;川芎味薄气雄,性最疏通,走而不守,且能补五劳壮筋骨;肉桂温通经脉,鼓舞气血,祛除寒滞,二药协同蜈蚣发挥更大的走窜作用;仙茅益阳道,填精髓,助房事,为补阳温肾之要药;洋参大补元气,养阴生津,与温热药配伍,可免除伤阴之弊。诸药合用,共奏辛温走窜,调畅气血,补肾填精,养阴生津之功。人身气血充盛,肾精得养,阴茎得荣,从而达到阴茎勃起之效。然本方对老年先天禀赋已尽而阴

茎不举者不宜。

治疗阳萎除服药外,更重要一条是,常须注意开导工作,解除患者思想顾虑,这对缩短疗程具有重要意义。

甲戌正月余治一病例:黄××,男性,23岁,未婚,供销人员,少时有手淫史,每次须达射精而后快,初不为意,也无自觉症状。近一年来发现阴茎萎软不举,曾到××医院治疗,服过甲基睾丸素片及补肾壮阳之中药半年未见获效,婚期又在即,焦急万分而求治于余。症见营养中等,眠食如常,唯腰膝酸软,四末不温而已。舌质淡红、苔薄而白,脉沉细。证属气血凝滞,阴茎失荣;治以辛温走窜调畅气血;方用吴师自拟的振阳起勃汤加杜仲、附子、干姜合雄鸡炖服,连服15剂而收全功。今年元宵邂逅,据云已婚,性生活正常,其妻已妊子。

(周建宣 整理)

胃痛四味饮治胃脘痛

组成

小茴香 6 克 穿山龙(南蛇藤)15 克
虎杖 15 克 香附 6 克

用法 上药合猪瘦肉或猪排骨适量炖服,服时加老酒少许,每日一次,连服数次。

功能 健脾开胃、温中消胀、理气解郁、化瘀止痛。

主治 劳累过度而致脾胃虚弱,气滞血瘀之胃痛。

方解 胃痛是民间常叫的病名,以胃脘部近心窝处,不论饥饱或以饥饿时为甚,经常发生疼痛为主病。吴师说本病大多肝气乘胃为常见,如能及时治疗,注意摄生,是可以治愈的。

本方为治疗由于劳累过度,三餐无法按时就餐而致脾胃虚弱,气滞血瘀。常见症状为脘痛连胁、胀满暖气或泛酸嘈杂,喜暖喜按,按之则气得稍散,痛亦暂觉减轻,吴师鉴于农村劳动人民常有此病而设。方中小茴香健脾开胃,温中消胀;香附理气解郁,行血止痛;虎杖清热活血,化瘀收敛;穿山龙行气活血,消肿止痛。诸药相伍,共奏健脾开胃,理气解郁,活血化瘀之功。临床见吴老屡用屡效,药简效验、价廉,可广为推广。

(周建宣 整理)

红壳秫米糖粿治疗五更泄

五更泄又名晨泄,指黎明时作泄,多认为系肾虚所致,故也称为肾泄。吴光烈老中医根据临床所见,认为关键在于脾胃功能障碍,以甘缓补脾之红壳秫米糖粿治之,屡收良效。

典型病例

梁某,女,52岁。一年余来,每于黎明即泄清水或完谷不化或稀粥样粪便1~2次,无腹痛不适。虽经治疗但仍反复发作。审前医处方均治以温补命门,投以四神丸之类。诊见面色萎黄、神疲倦怠、四肢不温,舌淡苔白,脉沉缓。认为系脾胃虚弱、运化失职。治以甘缓补中、健脾和胃法。用红壳秫米糖粿,每日早晚各热服半小碗。3天后泄已止,嘱再服3天以巩固疗效,经随访未见复发。

红壳秫米糖粿的制法:取红壳秫米洗净晒干,磨粉收贮备用。用时取秫米粉少许,加水调和搓成丸子,放入开水内煮熟,加红糖适量乘热服之。

《内经》称“胃为水谷之海”,“脾主运化精微”,说明脾胃是人体受纳和运化的主要器官。本例五更泄,系脾胃虚衰,运化失职而致脾气不能升发,饮食消化、吸收发生障碍,使清浊不分,混杂而下,并入大肠而致泄。气血来源于精微之化生,运化失职致生化无源,故面色萎黄、神疲倦怠、四末不温,舌淡苔白,脉象沉缓皆为脾虚之象。

历代医家皆认为五更泄乃肾中阳气不足,命门火衰所致,治疗

不离补火生土之法。而吴老认为泄泻原因虽较复杂,但从临床所见,关键在于脾胃功能障碍,五更泄也不例外。由此提出凡治泄须理中焦,使脾健胃和,水谷腐熟,自不作滞为泄,运化有权则生化气血,以行营卫而体健。用红壳秫米糖粳是取红壳秫米味甘性温,有治脾胃不和、胃弱久泻之功;红糖有健脾和胃、补中生血之效,二者配合,缓中健脾,自可治愈泄泻,正合先贤李中梓“泄泻何止?治以甘缓”之意。本方价廉易得,是别开生面之治法;又是食疗之良方,值得推广。

(吴盛荣 整理)

益寿降压汤治高血压、高血脂症

组成

冬瓜子 15 克 威灵仙 9 克 首乌 15 克
桑寄生 9 克 蚕砂 6 克(另包) 山楂 15 克
桑枝 9 克 鼠曲草(佛耳草) 30 克

用法 每两天服 1 剂,服一个月为一疗程。

功能 滋补肝肾,祛风通络,宣畅五脏。

主治 阴虚阳亢及气阴两虚的高血压,亦可兼治高血脂症,动脉硬化症。

方解 高血压为中老年人的常见病和多发病,是一种以动脉硬化为主的全身性慢性疾患。成人如舒张压在 12 千帕以上,收缩压在 18.6 千帕以上,即属于高血压患者。临床常见症型以阴虚阳亢型及气阴两虚型为多,如能积极治疗控制血压水平,是可避免高血压危象,脑血管破裂等严重并发症。见吴师应用此方于临床,血压大都下降,自觉症状消失,其疗效也较持久而稳定。日常生活要节制喜怒哀乐,注意休息和锻炼,穿衣寒温要适宜,饮食应少盐、清淡,多吃蔬菜瓜果,切忌过量饮酒吸烟。

方中鼠曲草,据现代药理表明含有胡萝卜素、硫胺素、核黄素、抗坏血酸,能调中补气,消炎解毒,具有保护心血管,脑血管的作用。对治疗高血压有显著效果;冬瓜子补肝明目,清热利湿,消痰散结,益气耐老,令人悦泽;威灵仙通行十二经,搜逐诸风,消痰水,宣通五脏;首乌补肝肾,养血气,益精髓,令人延年益寿;桑寄生入肝肾,助筋骨,益血脉;蚕砂入肝、脾、胃三经,祛风燥湿,通络活络;桑

枝入肝经,通血气,利五脏,久服轻身,聪明耳目,令人光泽;山楂消积化痰,行瘀脱脂。诸药合用,具有滋补肝肾,祛风通络,宣畅五脏之功,令人耳目聪明,轻身耐老,延年益寿,故对治疗高血压及高血脂症、动脉硬化症有良好的疗效。

(吴盛荣 整理)

芩莲安胎饮治习惯性流产

药物组成

莲子肉 15 克 黑大豆 15 克 糯米 15 克
鲜苈麻根 30 克(布包) 鲜艾根 15 克(布包)

用法 上药加水适量煮烂,取去布包之苈麻根、艾根后,再加冰糖适量,于清晨空腹时服,每日 1 剂,连服 3~5 剂。用于习惯性流产者,每月于清晨空腹时连服 3~5 天。服至超过上次流产之月数。

功能 清热安胎、补脾益肾。

主治 胎漏、胎动不安、堕胎、小产。也可用于预防习惯性流产。

典型病例

例一 刘某,女,26 岁,工人。

患者怀孕三个半月,阴道间断出血将二个月,血色鲜红,有小血块伴腰酸腹痛。曾在乡村医生用药治疗,症状稍缓解,但仍有血出伴腰酸腹痛,四肢酸乏力,纳差。舌质淡、苔薄白,脉细滑。尿妊娠乳胶试验阳性。“B 超”检查胎儿发育正常,未见异常发现。现代医学诊为:先兆流产。中医辨证为:胎动不安。方用芩莲安胎饮,每日 1 剂,水煎服,服 3 剂后出血停止,仍有轻度腰酸,小腹胀满,纳差。仍守上方继服 6 剂,诸症消失。后经随访足月顺产一女婴,母女均安。

例二 郑某,女,25岁,连续流产已3胎,均在7个月孕期左右,无明显诱因,现已怀孕4个月,3天来阴道不时少量下血,色鲜红,腰酸,少腹绵绵作痛有下堕感,伴头晕耳鸣,神疲气短,纳少,心烦口渴,面色不华,舌质红、苔薄白、脉沉缓,中医辨证为脾肾虚衰,挟有血热之象。治宜清热安胎,固肾补脾。方用苈莲安胎饮治之。每月清晨空腹时连服3天,至8个月孕期,后经走访,足月顺产一男婴,母子平安,高兴万分感激不尽。

体 会

本方为吴光烈主任医师自拟之验方,用于治疗胎漏、胎动不安、堕胎、小产以及预防习惯性流产有奇效,命名为苈莲安胎饮。方中取苈麻根甘凉清热,安胎止血而通子户;艾根祛瘀止血,调经安胎;莲子肉味得中和,中和则上下安养,为脾家之要药。取其味涩能使气守不走,安养胎儿,固涩胎宫;黑大豆专入肾,味甘性平,色黑体润,豆形似肾,色黑又通于肾,不但补肾且能泽肌生津;糯米,冰糖补脾且其性粘可以胶固胞宫。诸药相伍,脾肾得补,火清胎安,自无流产之虞。

(吴盛荣 整理)

● 原载于《时珍国药研究》,1994年第5期。

芪桂鳗鱼汤治荨麻疹

组成

黄芪 30 克 桂枝 15 克 杭白芍 15 克

野生鳗鱼 150 克

用法 加生姜、食盐、老酒各少许调味，水适量，炖服。

功能 调和营卫，补气益血。

主治 急慢性荨麻疹。

典型病例 吴某，男，30 岁。患荨麻疹时作时止已多年，近半年来每于下午或夜晚即发作，此起彼伏，瘙痒不已，彻夜难眠，经中西医多方治疗未效而求治。诊见痒块周围红晕，舌淡，脉沉。证属血虚生风，营卫不固，治宜调和营卫，益气补血。方用芪桂鳗鱼汤治之。服 1 剂后瘙痒立止。患者信心百倍，因饱受痛苦，求速愈心切，连服 7 剂症除，随访多年未再发作。

体 会

荨麻疹是常见之皮肤疾患，但非常顽固，一经感患，反复发作，缠绵难愈。吴老根据多年的临床经验，认为本病的发作与营卫失调、气血不足有关，强调治疗本病和控制复发应从补益气血、调和营卫入手，以增强人体的抵抗力。芪桂鳗鱼汤中黄芪取其既有补气固表之效，有又活血生血之功以鼓舞正气，吴老云：凡皮肤久痒、久疮不愈，用之均收奇效，实为皮肤病之圣药；鳗鱼性走窜活跃，能潜藏水底，翔游水面，无所不到，其补血活血之力非它鱼类可比，为治

疗皮肤风痒、疮癰久治不愈之圣药。然须用野生始能奏效；桂枝温经散寒、解肌发表；芍药和血脉收阴气。二药相伍，调和营卫，能使表邪得解，里气以和。由于药中病机，故收立竿见影之效。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《国医论坛》，1994 年第 4 期。

补血理痒汤治疗血风疮

组成

生地 30 克	川芎 9 克	当归 9 克
皂角刺 6 克	刺蒺藜 15 克	黄芪 15 克
地肤子 15 克	鲜猪血 120 克	白芍 9 克

用法 上药加水适量煎汤,合猪血烩服。

功能 益气补血凉血,祛风清热止痒。

主治 血风疮(皮肤瘙痒症、丘疹性湿疹)。

疗效 经治疗 60 例,痊愈 48 例,好转 12 例。

典型病例 刘某,女,28 岁。自诉全身瘙痒,下肢为甚,已有 6 年。每天夜间睡醒后,即全身瘙痒不已,皮肤灼热,心烦急躁,夜寝不安,搔破之皮肤呈鲜红色,过后渗出物结为血痂。曾在外院诊为“皮肤瘙痒症”,经用激素,抗组织胺药、外擦肤轻松等治疗,未见明显效果,而要求服中药。诊见:体质消瘦、神疲,全身皮肤呈散在性血痂。纳呆、口苦、大便干结,数日一行,小便黄赤,舌红少苔,脉弦。诊为“血风疮”。证属湿热久蕴,血虚生风。治宜益气补血凉血,祛风清热止痒。方用补血理痒汤,嘱服 3 剂,病去七八,继服 3 剂,药进痒止,痊愈如常人,亦未再作。

体会

本案西医诊断为自家敏感性皮炎,中医辨证属“血风疮”范畴,

其发病原因乃因肝经血热、脾经湿热、肺经风热，交感而成。热蕴伤营、血虚生风而发于腠理之间。诸如丘疹性湿疹、痒疹、皮肤瘙痒症。方中盖取当归、川芎、白芍、生地补血凉血；黄芪益气固表；蒺藜疗风疮、止瘙痒；皂角刺疏清血中之风热，败毒杀虫，其刺锐利能直达病所为异，故称为痈疽未溃之神药；地肤子利尿之作用甚强，通过利尿之作用，清皮肤热气，且能使人润泽悦颜；合以猪血，补血生血，以血导血之义也。

（吴盛荣 整理）

● 原载于《时珍国药研究》，1995 年第 6 卷增刊。

马齿消肿汤治久年臃疮

组成 鲜马齿苋 60 克。

用法 洗净晾干捣烂。外敷患部，每日 1~2 次，可视病情轻重而定。

功能 散血泻热，消肿解毒。

主治 久年臃疮以及痈疽疔毒。阴户肿痒、痔疮出血、肛门肿痛，小儿火丹或毛虫螫人、赤痛不止诸症。

典型病例(略)

按 本方系民间验方，吴老临床 50 多年，用之无不得心应手，群众称为“仙方”。李时珍总结马齿苋之主要功能为“散血消肿”四字。苏颂曰：“多年恶疮，百方不瘥，或痛燥不已者，并捣烂马齿苋敷上，不过两三遍。”先贤之方，实不我欺也。马齿苋药源丰富，到处皆有，用之不竭，取之不尽，可指导患者自采用，广泛推广，以保护劳力，促进健康。马齿苋不但可治外科诸疾患，用于治疗消渴症、小便热淋也有见长。

臃疮俗称“裙边疮”、“色裤疮”、“臭脚筒”。好发于小腿内臃或外臃的慢性溃疡，初起多由于湿热下迫，瘀血凝滞于经脉所致。治疗不当或迁延失治，常可导致患部气血难于营运，疮口难以收敛，或愈合后因皮肤破伤又复发。甚则侵蚀及骨成附骨疽，并有癌变倾向，应予提高警惕，引为重视。

(吴盛荣 整理)

● 原载于纪念李时珍逝世 400 周年《全国医学学术论文集》，中国中医药出版社出版，1994 年 6 月第 1 版。

败脓祛腐散治蜈蚣疔

组成 明矾、铜青、煅龙眼花各 9 克,上药合为细末,收贮瓶中备用。

用法 用于治疗蜈蚣疔则取药粉少许合糯米饭捣涂。用于治疗其它脓疮可将药粉直接撒布或调茶油、鸡蛋油涂布。

功能 败脓祛腐,收敛生肌。

主治 蜈蚣疔(俗名软疔、蟾拱头)

兼治 久治不愈的脓疮或疔疮,鼻塞肉,眼睑糜烂等。

按 蜈蚣疔(俗名软疔、蟾拱头),多发于暑天,以小儿为多见。生于头部皮肤浅表之处如发际等,面部也偶有发生。吴师说:大多由于脓不早泄,引流不畅或处理不当,以致头皮窜空,屡治不愈,因而形成。如迁延失治患部常留有疤痕,影响美观。败脓祛腐散系吴光烈主任医师自拟的处方,临床应用 50 多年屡收全功。方中胆矾能医恶疮;铜青能蚀恶肉,凡脓疮久治不愈,脓液久流不清,用之凑效如神,辅以煅龙眼花收敛固涩,以止渗液,促使生肌迅速。

(周建宣 整理)

雄连收毒散治缠腰火丹

组成

雄黄 30 克 川连 30 克 冰片 5 克
骨碎补 90 克(煅存性) 竹茹 90 克(煅存性)

上药合为细末收贮备用。

用法 缠腰火丹初起调醋或茶汤涂抹,干则再反抹,一天数次,烂则调鸡蛋清或茶油、麻油均可。

功能 清热燥湿,解毒止痛。

主治 缠腰火丹又名火带疮、蛇串疮、蛇丹疮,俗名飞蛇,现代医学为带状疱疹。

方解 方中雄黄燥湿杀虫,疗疮解毒;黄连清热燥湿为疮疡解毒要药;冰片消肿止痛;竹茹清热凉血;骨碎补缠绕岩石、树上而生,吴师云:此药其形如蛇,故俗名树蛇,有活血止痛,祛湿杀虫之功,为治飞蛇之效药,以蛇治蛇,乃中医相形取治之义也,确有奇效。二药过煅存性促其水疱迅速吸收而愈疮面。

按 缠腰火丹常发生胸腹腰围及背部,面部也偶有所见。但以缠腰为多,故名缠腰火丹。本病初起,患处刺痛发红,继而出现米粒样水疱,疱液透明,累累如串珠,呈束带状排列如蛇形,得之瞬息,蔓延极快,故俗名为飞蛇。现代医学为带状疱疹,属于病毒性疾病,一般预后良好,经治疗后可迅速痊愈,结痂脱落不留疤痕。见诸方书,病因皆为心肝之火妄动以及湿热内蕴所致。吴师云:此类疾患大多由于自身皮肤不洁,衣衫失净,汗液浸渍,异物接触或污手摩身而发生。

本方为吴师之经验方，多年来应用于临床无不奏效，成为定型之方剂，故命名为雄连收毒散，用于涂抹缠腰火丹皮肤上，一天后痛止，两天后疱疹吸收而痊愈，如果感染严重高热不退，应结合内服清热解毒之药物，以免迁延失治。

吴师说：另一种与缠腰火丹相类似的疾患，水疱聚集于一处或数处，成簇发生，排列不成带状，俗名为“飞蜂”，用本方治之亦见显效。

（周建宣 整理）

樱苋消癆汤治癆癧

组成 金樱根 20 克、白刺苋根 20 克。

用法 加水适量合猪瘦肉烩服，每天 1 次。

功能 清热解毒，行气活血，软坚散瘀。

主治 癆癧（相当于现代医学的淋巴腺结核、淋巴结炎）。

方解 癆癧病名出自《灵枢·寒热篇》，又名鼠癭、老鼠疮、癧子颈等。小者为癭、大者为癧。癆癧可分为急性、慢性二类。急性多因热毒凝聚而结；慢性多因体虚气郁所生。吴师云：早期发现、早期治疗并不困难，患者及其家属常认为肿核、不痛不痒，而未引起注意，导致逐渐增大串生，久则结块，互相粘连，推之不移，若溃破则流稀薄之脓汁，此愈彼起，久不收口，可形成窦道或瘰管，治疗就比较麻烦。方中白刺苋清热解毒，软坚散结；金樱根行气活血、消核化瘀。二药合用，治疗癆癧初起，确有良效。吴老教导须持之以恒，不能一曝十寒。对于疮疡肿痛、痈疖、乳腺炎等症，用之也有疗效。

（周建宣 整理）

整理后记

为抢救和继承老中医药专家学术经验,中央人事部、卫生部、国家中医药管理局于1990年6月联合作出“关于紧急采取措施做好老中医药专家学术经验继承工作的决定”,我们荣幸地于1991年4月被省卫生厅遴选并报请中央人事部、卫生部、国家中医药管理局批准,确定我们为吴光烈老师的学术经验继承人。我们深感这是一项划时代的工作,是一次难得的机会,任务是艰巨的,但是我们有信心、有决心把吴老师的学术经验继承好。三年来,在老师的谆谆善诱的教导下,通过口传面授,临床带教及耳濡目染,细心揣摩和认真学习,对老师的学术见解和独到的临床经验及技术专长有了比较深刻的认识和掌握。在继承工作即将结束时,我们把随师学习的心得和临床收获写成继承结业论文集。这次在泉州市中医药学会副会长、泉州市中医院副院长林禾禧副主任中医师的鼓励下,再将老师业余撰写的部份学术论文汇集整理,命名为《吴光烈临床经验集》。

吴师为人醇厚,治学严谨,医术精湛,且具有高尚的医风医德,但他从不满足,对技术精益求精,对工作一丝不苟,对病人极端负责任。他常勉励学生说:“学医之道,以德为要”,“救死扶伤乃医生之天职,济世活人乃中医之优良传统”,“作为一个医生,医德不只是道德观念或意识形态的表现,而且是精神作用于物质,尽快解除病人的疾苦,获得健康的有效成份。因为病人得了病,心里承受着压力是很痛苦的,医生对待病人要象对待亲人一样,使病人心情舒畅,才有利于治疗”。他是这样说,也是这样做。吴师从事中医生涯

50 余载,在工作中体现一个“诚”字,即真诚待人,诚心、诚恳地为患者服务,不分贫富贵贱与职位高低,一视同仁,精心施治。他不但经常加班加点,耽误就餐和休息时间,而且诊余对上门求诊者从不推辞。每年数百封函诊,他均一一作复。他这种默默奉献、不计较报酬的精神,深得领导干部和广大人民群众的钦敬,对我们的影响极深,使我们获益匪浅,终生难忘。吴师是我们青年人的楷模。

吴师常说:“一人之才有限,而医术无穷,乐于学同道之所长,而补己之不足,以应万变之疾”。他谨遵经旨,师古不泥,博采众方,力图创新,并重视发掘民间草药,应用于临床,屡收良效。他经方新用有大黄甘草汤、小柴胡汤等的应用经验;异病同治有妙用麻黄汤治疗杂病及妙用细辛的经验;推陈出新有“胃宝”治疗胃脘痛的经验;一枝独秀有舒肝利胆汤、排石汤、大枣绿豆羊肉汤、田蛙麦冬橄榄汤等治验。这些都是阐前人之所未发,体现了吴老临证用药的独具匠心。

此书即将付梓,我们本着弘扬祖国传统医学为己任,对老一辈中医无私奉献的精神感慨万千,爰写此后记聊表寸心,并为自勉。由于我们水平有限,不能将吴师的学术思想、临床经验和体会全面地加以阐述,甚至还有错漏的地方,诚恳地敬请医界同仁,批评指正。

周建宣 吴盛荣 谨记

1995 年 12 月于南安市中医院